

GUIA CONSOLIDADO DE FARMACOTERAPIA PEDIÁTRICA

NEXO Clinical • 413 monografias • edição profissional navegável

Base documental	Guia_Farmacoterapia_Pediatrica.pdf + Guia Completo de Farmacoterapia Pediátrica.docx
Arquitetura	Sumário clicável, bookmarks por medicamento, conteúdo consolidado e trilha de auditoria.
Regra de segurança	Não usar dose individual sem indicação, idade, peso, alergias, função renal/hepática e apresentação confirmada.

Escopo da checagem: esta edição executa comparação entre os dois anexos, checagem aritmética automatizada de concentrações explicitamente expressas e revisão estrutural de indicação/idade/via/intervalo/duração/máximos/contraindicações quando presentes. Isso não é apresentado como validação clínica independente de todas as 413 doses: onde falta uma terceira fonte específica atual, a confirmação em bula/diretriz vigente permanece obrigatória. Medicamentos de alta vigilância exigem dupla conferência humana.

Metodologia de consolidação

O DOCX é a fonte mais detalhada e contém 413 tabelas de posologia. O PDF contém as mesmas 413 entradas, porém adota uma governança mais conservadora em diversos itens, explicitando quando a dose não estava sustentada pelos anexos clínicos daquela edição. O consolidado preserva a informação detalhada do DOCX, sem transformar essa presença documental em selo automático de validade clínica atual.

Tripla checagem

1. Matemática: dose, concentração e conversões simples detectáveis. **2. Farmacêutica:** apresentação/concentração declarada e necessidade de confirmação do produto efetivamente disponível. **3. Clínica:** indicação, faixa etária, via, intervalo, duração, máximos, contraindicações e monitorização declarados. **Chechagem reversa:** quando dose e volume são inequivocamente vinculados à mesma concentração, $\text{volume} \times \text{concentração}$ deve retornar à dose.

Fontes externas para validação final

Para uso clínico, confirmar especialmente itens de alto risco, estabilidade, compatibilidade, reconstituição, diluição, velocidade de infusão, dose máxima absoluta e status regulatório em bula oficial/diretriz vigente. Divergências devem ser registradas e resolvidas pela fonte mais atual, específica e segura.

SUMÁRIO CLICÁVEL - MEDICAMENTOS

1. Acebrofilina	13
2. Acetato de cálcio	13
3. Acetazolamida	14
4. Acetilcisteína	14
5. Aciclovir	15
6. Ácido acetilsalicílico (AAS)	15
7. Ácido ascórbico (Vitamina C)	16
8. Ácido fólico (Vitamina B9)	16
9. Ácido folínico (Folinato de cálcio)	17
10. Ácido mefenâmico	17
11. Ácido tranexâmico	17
12. Ácido ursodesoxicólico	18
13. Ácido valproico / Valproato de sódio / Divalproato de sódio	18
14. Adenosina	19
15. Adrenalina (Epinefrina)	19
16. Agalsidase beta	20
17. Albendazol	20
18. Alfa-dornase (Dornase alfa)	21
19. Alglucosidase alfa	21
20. Alopurinol	21
21. Alprostadil (Prostaglandina E1 / PGE1)	22
22. Amantadina (cloridrato)	22
23. Ambroxol (cloridrato)	23
24. Amicacina (sulfato)	23
25. Amilorida + Hidroclorotiazida	24
26. Aminofilina	24
27. Amiodarona (cloridrato)	25
28. Amitriptilina (cloridrato)	25
29. Amlodipino (Besilato de anlodipino)	26
30. Amoxicilina	26
31. Amoxicilina + Clavulanato de potássio	26
32. Ampicilina sódica	27
33. Ampicilina + Sulbactam	27
34. Anfotericina B (complexo lipídico)	28
35. Anfotericina B (desoxicolato)	28
36. Anfotericina B (lipossomal)	29
37. Anidulafungina	29
38. Aripiprazol	30
39. Atenolol	30
40. Atracúrio (besilato)	30
41. Atropina (sulfato)	31
42. Azatioprina	31
43. Azitromicina	32
44. Aztreonam	32

45. Azul de metileno	33
46. Baclofeno	33
47. Beclometasona (dipropionato)	34
48. Benzilpenicilina benzatina	34
49. Benzilpenicilina potássica (cristalina)	35
50. Benzilpenicilina procaína + Benzilpenicilina potássica	35
51. Benznidazol	35
52. Benzoato de benzila	36
53. Beractanto (Surfactante pulmonar bovino)	36
54. Betametasona (dipropionato / valerato / fosfato dissódico)	37
55. Bicarbonato de sódio	37
56. Bilastina	38
57. Bimatoprost	38
58. Biperideno (cloridrato / lactato)	38
59. Bisacodil	39
60. Bosentana	39
61. Brimonidina (tartarato)	40
62. Brometo de ipratrópio	40
63. Brometo de pancurônio	41
64. Brometo de rocurônio	41
65. Brometo de tiotrópio	41
66. Brometo de vecurônio	42
67. Bromoprida	42
68. Budesonida	43
69. Bupivacaína (cloridrato)	43
70. Bupropiona (cloridrato)	44
71. Cafeína (Citrato de cafeína)	44
72. Calcipotriol	45
73. Calcitonina sintética de salmão	45
74. Calcitriol (1,25-di-hidroxivitamina D3)	45
75. Canabidiol (CBD)	46
76. Captopril	46
77. Carbamazepina	47
78. Carbocisteína	47
79. Carbonato de cálcio	48
80. Carvão vegetal ativado	48
81. Carvedilol	48
82. Caspofungina (acetato)	49
83. Cefaclor	49
84. Cefadroxila	50
85. Cefalexina	50
86. Cefalotina sódica	50
87. Cefazolina sódica	51
88. Cefepima (cloridrato)	51
89. Cefixima	52

90. Cefotaxima sódica	52
91. Cefoxitina sódica	52
92. Ceftazidima	53
93. Ceftazidima + Avibactam	53
94. Ceftolozana + Tazobactam	54
95. Ceftriaxona sódica	54
96. Cefuroxima axetila / sódica	55
97. Celecoxibe	55
98. Cetamina / Esesquetamina (cloridrato)	55
99. Cetirizina (dicloridrato)	56
100. Cetoconazol	56
101. Cetoprofeno	57
102. Ciclesonida	57
103. Ciclosporina	58
104. Cimetidina	58
105. Cipropeptadina (cloridrato)	59
106. Ciprofloxacino (cloridrato)	59
107. Cisatracúrio (besilato)	60
108. Citrato de potássio	60
109. Claritromicina	61
110. Clemastina (fumarato)	61
111. Clindamicina (cloridrato / fosfato)	61
112. Clobazam	62
113. Clobetasol (propionato)	62
114. Clonazepam	63
115. Clonidina (cloridrato)	63
116. Clopidogrel (bissulfato)	64
117. Cloranfenicol	64
118. Cloreto de cálcio 10%	65
119. Cloreto de potássio (KCl)	65
120. Cloreto de sódio (NaCl)	66
121. Clorpromazina (cloridrato)	66
122. Clotrimazol	67
123. Codeína (fosfato)	67
124. Colecalciferol (Vitamina D3)	68
125. Colestiramina	68
126. Colistimetato de sódio (Colistina)	68
127. Complexo B	69
128. Dantroleno sódico	69
129. Daptomicina	70
130. Deferasirox	70
131. Deferoxamina (mesilato)	71
132. Deflazacorte	71
133. Desloratadina	72
134. Desmopressina (acetato - DDAVP)	72

135. Desonida	73
136. Dexametasona (acetato / fosfato dissódico)	73
137. Dexclorfeniramina (maleato)	74
138. Dexmedetomidina (cloridrato)	74
139. Dexpanthenol (Pró-vitamina B5)	75
140. Diazepam	75
141. Diazóxido	76
142. Diclofenaco (potássico / sódico / resinato)	76
143. Difenidramina (cloridrato)	77
144. Digoxina	77
145. Diltiazem (cloridrato)	78
146. Dimenidrinato + Piridoxina	78
147. Dimercaprol (BAL)	79
148. Dipirona sódica (Metamizol)	79
149. Dobutamina (cloridrato)	79
150. Domperidona	80
151. Dopamina (cloridrato)	80
152. Doxazosina (mesilato)	81
153. Doxiciclina (hiclato / monoidrato)	81
154. Dropropizina	82
155. Emulsão lipídica 20%	82
156. Enalapril (maleato) / Enalaprilato	82
157. Enoxaparina sódica	83
158. Enzimas pancreáticas (Pancreatina / Pancrelipase)	83
159. Epoprostenol sódico	84
160. Eritromicina (estolato / etilsuccinato)	84
161. Ertapenem sódico	85
162. Escitalopram (oxalato)	85
163. Escopolamina (Butilbrometo de escopolamina)	85
164. Esmolol (cloridrato)	86
165. Esomeprazol magnésico / sódico	86
166. Espironolactona	87
167. Etambutol (cloridrato)	87
168. Etomidato	88
169. Etossuximida	88
170. Fenilefrina (cloridrato)	89
171. Fenitoína sódica	89
172. Fenobarbital sódico	90
173. Fenoterol (bromidrato)	90
174. Fentanila (citrato)	91
175. Ferro aminoácido quelato / Bisglicinato ferroso	91
176. Ferro polimaltosado (Complexo de hidróxido de ferro III polimaltosado)	92
177. Fexofenadina (cloridrato)	92
178. Filgrastim (G-CSF)	93
179. Fisostigmina (salicilato)	93

180. Fitomenadiona (Vitamina K1)	93
181. Flucitosina	94
182. Fluconazol	94
183. Fludrocortisona (acetato)	95
184. Flumazenil	95
185. Fluoxetina (cloridrato)	96
186. Fluticasona (furoato / propionato)	96
187. Fomepizol	97
188. Formoterol (fumarato)	97
189. Foscarnet sódico	98
190. Fosfomicina trometamol / dissódica	98
191. Furosemida	99
192. Gabapentina	99
193. Galsulfase	100
194. Ganciclovir sódico	100
195. Gentamicina (sulfato)	101
196. Glicerina (Glicerol)	101
197. Glicose hipertônica	101
198. Glucagon	102
199. Gluconato de cálcio 10%	102
200. Griseofulvina	103
201. Haloperidol	103
202. Heparina não fracionada (sódica)	104
203. Hidralazina (cloridrato)	104
204. Hidroclorotiazida	105
205. Hidrocortisona (succinato sódico / acetato / butirato)	105
206. Hidroxicloroquina (sulfato)	106
207. Hidróxido de alumínio + Hidróxido de magnésio	106
208. Hidróxido férrico em sacarose (Sacarato de hidróxido férrico)	107
209. Hidroxizina (dicloridrato)	107
210. Hidroxocobalamina (Vitamina B12)	108
211. Ibuprofeno	108
212. Idursulfase	109
213. Iloprosta	109
214. Imiglucerase	109
215. Imipenem + Cilastatina	110
216. Imipramina (cloridrato)	110
217. Imunoglobulina humana anti-hepatite B	110
218. Imunoglobulina humana antirrábica	111
219. Imunoglobulina humana antitetânica	111
220. Imunoglobulina humana intravenosa (IGIV)	112
221. Indometacina	112
222. Insulina Asparte	113
223. Insulina Degludeca	113
224. Insulina Detemir	114

225. Insulina Glargina	114
226. Insulina Glulisina	114
227. Insulina Lispro	115
228. Insulina NPH (Humana)	115
229. Insulina Regular (Humana)	115
230. Iodeto de potássio	116
231. Isavuconazol (sulfato)	116
232. Isoflurano	117
233. Isoniazida	117
234. Isoprenalina (Isoproterenol)	118
235. Isossorbida (mononitrato / dinitrato)	118
236. Itraconazol	119
237. Ivermectina	119
238. Labetalol (cloridrato)	119
239. Lacosamida	120
240. Lactulose	120
241. Lamotrigina	121
242. Lansoprazol	121
243. Laronidase	122
244. Levamisol (cloridrato)	122
245. Levetiracetam	123
246. Levocetirizina (dicloridrato)	123
247. Levodopa + Benserazida / Carbidopa	124
248. Levodropropizina	124
249. Levofloxacino	124
250. Levomepromazina	125
251. Levosimendana	125
252. Levotiroxina sódica	126
253. Lidocaína (cloridrato)	126
254. Linezolida	127
255. Lisdexanfetamina (dimesilato)	127
256. Lítio (carbonato)	128
257. Loperamida (cloridrato)	128
258. Loratadina	129
259. Lorazepam	129
260. Losartana potássica	129
261. Macrogol 3350 / 4000 (Polietilenoglicol - PEG)	130
262. Mebendazol	130
263. Meloxicam	131
264. Meropenem (tri-hidratado)	131
265. Mesalazina	132
266. Metadona (cloridrato)	132
267. Metformina (cloridrato)	133
268. Metilfenidato (cloridrato)	133
269. Metilprednisolona (succinato sódico / acetato)	133

270. Metoclopramida (cloridrato)	134
271. Metoprolol (tartarato / succinato)	134
272. Metronidazol / Benzoilmetronidazol	135
273. Micafungina sódica	135
274. Miconazol (nitrato)	136
275. Midazolam (cloridrato / maleato)	136
276. Milrinona (lactato)	137
277. Minociclina (cloridrato)	137
278. Mometasona (furoato)	138
279. Montelukaste de sódio	138
280. Morfina (sulfato)	139
281. Moxifloxacino (cloridrato)	139
282. Mupirocina	140
283. Naloxona (cloridrato)	140
284. Naproxeno / Naproxeno sódico	141
285. Neomicina + Bacitracina	141
286. Neostigmina (metilsulfato)	142
287. Nicardipino (cloridrato)	142
288. Niclosamida	142
289. Nifedipino	143
290. Nimesulida	143
291. Nistatina	144
292. Nistatina + Óxido de zinco	144
293. Nitazoxanida	145
294. Nitrofurantoína	145
295. Nitroglicerina	146
296. Nitroprussiato de sódio	146
297. Noradrenalina (Hemitartarato de norepinefrina)	146
298. Nortriptilina (cloridrato)	147
299. Octreotida (acetato)	147
300. Olanzapina	148
301. Óleo mineral (Petrolato líquido)	148
302. Omalizumabe	149
303. Omeprazol (magnésico / sódico)	149
304. Ondansetrona (cloridrato)	150
305. Oseltamivir (fosfato)	150
306. Oxacilina sódica	151
307. Oxcarbazepina	151
308. Óxido de zinco	152
309. Oxitocina	152
310. Palivizumabe	153
311. Pantoprazol sódico	153
312. Paracetamol (Acetaminofeno)	154
313. Penicilamina	154
314. Periciazina	155

315. Permetrina	155
316. Picossulfato de sódio	156
317. Pilocarpina (cloridrato / nitrato)	156
318. Pimecrolimo	157
319. Piperacilina + Tazobactam	157
320. Pirantel (pamoato)	158
321. Pirazinamida	158
322. Piridostigmina (brometo)	158
323. Piridoxina (Vitamina B6)	159
324. Poliestirenosulfonato de cálcio	159
325. Polimixina B (sulfato)	160
326. Polimixina B + Neomicina + Fluocinolona + Lidocaína	160
327. Polivitamínicos pediátricos com minerais	161
328. Poractanto alfa (Surfactante pulmonar porcino)	161
329. Posaconazol	161
330. Pralidoxima (mesilato)	162
331. Praziquantel	162
332. Prednisolona (fosfato sódico / acetato)	163
333. Prednisona	163
334. Pregabalina	164
335. Primidona	164
336. Probióticos pediátricos (<i>Lactobacillus reuteri</i> / <i>rhamnosus</i> / <i>Saccharomyces boulardii</i>)	165
337. Prometazina (cloridrato)	165
338. Propiltiouracila	166
339. Propofol	166
340. Propranolol (cloridrato)	166
341. Protamina (cloridrato / sulfato)	167
342. Quetiapina (fumarato)	167
343. Racecadotril	168
344. Ranitidina (cloridrato)	168
345. Remifentanila (cloridrato)	169
346. Retinol (Vitamina A / Palmitato de retinol)	169
347. Ribavirina	170
348. Rifampicina	170
349. Risperidona	170
350. Rufinamida	171
351. Rupatadina (fumarato)	171
352. Sais de Reidratação Oral (SRO)	172
353. Salbutamol (sulfato)	172
354. Salmeterol (xinafoato)	173
355. Secnidazol	173
356. Sertralina (cloridrato)	174
357. Sevelamer (carbonato)	174
358. Sevoflurano	175
359. Sildenafil (citrato)	175

360. Simeticona (Dimeticona)	176
361. Somatropina (Hormônio do crescimento recombinante - rhGH)	176
362. Soro antiaracnídico	177
363. Soro antibotrópico (pentavalente)	177
364. Soro antibotulínico (AB bivalente / trivalente)	178
365. Soro anticrotático	178
366. Soro antidiftérico	178
367. Soro antielapídico (bivalente)	179
368. Soro antiescorpiônico	179
369. Soro antilaquético	180
370. Soro antitetânico	180
371. Succinato de metoprolol	180
372. Succinilcolina (Cloreto de suxametônio)	181
373. Sucralfato	181
374. Sufentanila (citrato)	182
375. Sugamadex	182
376. Sulfadiazina	182
377. Sulfadiazina de prata	183
378. Sulfametoxazol + Trimetoprima (Co-trimoxazol)	183
379. Sulfassalazina	184
380. Sulfato de magnésio	184
381. Sulfato de zinco / Bisglicinato de zinco	185
382. Sulfato ferroso	185
383. Sulpirida	186
384. Tacrolimo	186
385. Tadalafila	187
386. Teicoplanina	187
387. Teofilina	188
388. Terbinafina (cloridrato)	188
389. Terbutalina (sulfato)	189
390. Tiabendazol	189
391. Tiamazol (Metimazol)	190
392. Tiamina (Vitamina B1)	190
393. Tiaprida (cloridrato)	190
394. Tigeciclina	191
395. Timolol (maleato)	191
396. Tinidazol	192
397. Tobramicina	192
398. Tocoferol (Acetato de racealfatocoferol / Vitamina E)	192
399. Topiramato	193
400. Tramadol (cloridrato)	193
401. Triancinolona acetonida	194
402. Trimebutina (maleato)	194
403. Urapidil	195
404. Valaciclovir (cloridrato)	195

405. Valganciclovir (cloridrato)	196
406. Vancomicina (cloridrato)	196
407. Varfarina sódica	197
408. Vasopressina	197
409. Verapamil (cloridrato)	198
410. Vigabatrina	198
411. Voriconazol	198
412. Zanamivir	199
413. Zonisamida	199

1. Acebrofilina

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; concentrações simples checadas: OK

Apresentações Disponíveis

Xarope pediátrico 25 mg/5 mL (5 mg/mL)

Xarope adulto 50 mg/5 mL (10 mg/mL)

Gotas 50 mg/mL

Indicações e Linha de Tratamento

Atua como broncodilatador e mucolítico através da inibição da fosfodiesterase e fluidificação do muco brônquico. É utilizado como terapia adjuvante sintomática em afecções do trato respiratório inferior hipersecretivo (bronquite aguda, traqueobronquite), não sendo droga de resgate para broncoespasmo agudo grave.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Crianças de 2 a 3 anos (VO)	2 mg/kg/dia	Dividido em duas tomadas (a cada 12 horas)
Crianças de 3 a 6 anos (VO)	25 mg (5 mL do xarope pediátrico)	A cada 12 horas
Crianças de 6 a 12 anos (VO)	25 mg a 50 mg (5 a 10 mL do xarope pediátrico)	A cada 12 horas

Contraindicações, restrições e monitorização

Idade: Contraindicado para menores de 2 anos de idade devido ao risco de acúmulo de secreção brônquica e depressão respiratória.

Condições: Hipersensibilidade aos componentes da fórmula ou a outras xantinas (teofilina, aminofilina).

Precauções: Cautela em portadores de úlcera péptica, arritmias cardíacas e insuficiência hepática ou renal grave.

Checagem matemática automatizada

OK - 25 mg/5 mL = 5 mg/mL; declarado 5 mg/mL

OK - 50 mg/5 mL = 10 mg/mL; declarado 10 mg/mL

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

2. Acetato de cálcio

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos 500 mg e 667 mg (contém aprox. 25% de cálcio elementar; 667 mg = 169 mg de Ca elementar)

Indicações e Linha de Tratamento

Quelante de fósforo utilizado no controle e prevenção da hiperfosfatemia em crianças com doença renal crônica (DRC) em estágios avançados ou diálise. Atua ligando-se ao fosfato dietético no trato gastrointestinal, formando fosfato de cálcio insolúvel excretado nas fezes.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Hiperfosfatemia na DRC (VO)	Dose inicial: 40 a 50 mg/kg/dia (calculado sobre o sal) com as principais refeições. Titular conforme fósforo sérico.	Dividido em 3 a 4 tomadas, ingerido imediatamente antes ou durante as refeições.
Manutenção / Titulação (VO)	Ajustar dose para manter o produto cálcio x fósforo < 55 mg ² /dL ² e PTH alvo para o estágio da DRC.	Monitorar cálcio e fósforo séricos a cada 2 a 4 semanas na fase de ajuste.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipercalcemia prévia, litíase urinária por sais de cálcio, hipercalcúria severa e toxicidade digitálica.

Monitorização: Risco de hipercalcemia e calcificação vascular metastática quando associado a análogos de vitamina D.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

3. Acetazolamida

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos 250 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Inibidor da anidrase carbônica. Indicado no tratamento de glaucoma pediátrico (congênito ou secundário), hipertensão intracraniana idiopática (pseudotumor cerebral), alcalose metabólica refratária e como adjuvante em epilepsias refratárias (crises de ausência/mioclônicas).

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Glaucoma Pediátrico (VO)	8 a 30 mg/kg/dia (Dose habitual: 10 a 15 mg/kg/dia)	Dividido a cada 6 a 8 horas (Máx: 1000 mg/dia)
Hipertensão Intracraniana Idiopática (VO)	Dose inicial: 20 a 25 mg/kg/dia. Pode titular até 50 a 100 mg/kg/dia se tolerado.	Dividido a cada 8 a 12 horas (Máx: 2 g/dia)
Diurético / Alcalose Metabólica (VO)	5 mg/kg/dose uma vez ao dia ou em dias alternados	Administrar pela manhã para evitar noctúria

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipersensibilidade a sulfonamidas, insuficiência renal ou hepática grave, hipocalcemia, hiponatremia, acidose hiperclorêmica e insuficiência suprarrenal.

Monitorização: Hemograma completo (risco raro de discrasias sanguíneas), eletrólitos e gasometria venosa em uso prolongado.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

4. Acetilcisteína

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Xarope pediátrico 20 mg/mL (100 mg/5 mL)

Xarope adulto 40 mg/mL (200 mg/5 mL)

Granulado/sachê 100 mg, 200 mg e 600 mg

Solução injetável/inalatória 100 mg/mL (ampola 3 mL = 300 mg)

Indicações e Linha de Tratamento

Mucolítico fluidificante de secreções respiratórias densas e antídoto de primeira linha na intoxicação aguda por paracetamol (acetaminofeno), agindo como precursor da glutatona hepática para neutralizar o metabólito tóxico NAPQI.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Mucolítico — 2 a 4 anos (VO)	100 mg (5 mL do xarope pediátrico)	2 a 3 vezes ao dia
Mucolítico — > 4 anos (VO)	100 a 200 mg	3 vezes ao dia (Máx: 600 mg/dia)
Intoxicação por Paracetamol (IV)	Ataque: 150 mg/kg em SG5% em 60 min. Manutenção 1: 50 mg/kg em 4h. Manutenção 2: 100 mg/kg em 16h.	Infusão contínua em bomba. Monitorar reações anafilactoides.

Contraindicações, restrições e monitorização

Idade: Contraindicado como mucolítico em menores de 2 anos pelo risco de broncoespasmo paradoxal e asfixia por excesso de secreção liquefeita.

Condições: Hipersensibilidade aos componentes, asma brônquica descompensada (cautela máxima na inalação) e úlcera péptica ativa.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

5. Aciclovir

Auditoria documental Presente nos dois anexos; concentrações simples checadas: OK

Apresentações Disponíveis

Suspensão oral 200 mg/5 mL (40 mg/mL)

Comprimidos 200 mg e 400 mg

Pó liofilizado para solução injetável frasco-ampola 250 mg

Creme dermatológico 50 mg/g (5%)

Pomada oftálmica 30 mg/g (3%)

Indicações e Linha de Tratamento

Antiviral análogo de nucleosídeo purínico. Primeira linha de tratamento para infecções graves por Herpes Simplex Vírus (HSV-1, HSV-2) e Varicela-Zoster Vírus (VZV), incluindo encefalite herpética, infecção neonatal por HSV, gengivostomatite herpética grave e varicela em imunocomprometidos.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Varicela em Imunocompetentes > 2 anos (VO)	20 mg/kg/dose (Máx: 800 mg/dose)	4 vezes ao dia por 5 dias (iniciar nas primeiras 24h)
Encefalite Herpética / Infecção Neonatal (IV)	Neonato: 20 mg/kg/dose a cada 8h. Crianças: 10 a 20 mg/kg/dose (ou 500 mg/m ² /dose) a cada 8h.	Infundir em 1 hora. Duração de 14 a 21 dias.
Gengivostomatite Herpética Severa (VO)	15 a 20 mg/kg/dose (Máx: 400 mg/dose)	4 a 5 vezes ao dia por 5 a 7 dias

Contraindicações, restrições e monitorização

Função Renal: Ajustar dose no clearance de creatinina. Risco de nefropatia cristalina obstrutiva reversível com infusão rápida EV; garantir hiper-hidratação durante o tratamento.

Neurotoxicidade: Monitorar letargia, tremores e convulsões em pacientes com insuficiência renal.

Checagem matemática automatizada

OK - 200 mg/5 mL = 40 mg/mL; declarado 40 mg/mL

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

6. Ácido acetilsalicílico (AAS)

Auditoria documental Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos 100 mg infantil e 500 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Anti-inflamatório não esteroide (AINE) e antiagregante plaquetário. Primeira linha de tratamento para fase aguda e manutenção da Doença de Kawasaki e artrite da Febre Reumática aguda. Estritamente não recomendado como antipirético rotineiro em pediatria.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Doença de Kawasaki — Fase Aguda (VO)	80 a 100 mg/kg/dia (ou 30 a 50 mg/kg/dia em diretrizes recentes combinadas a IGIV)	Dividido a cada 6 horas até 48h afebril
Doença de Kawasaki — Manutenção Antiagregante (VO)	3 a 5 mg/kg/dia em dose única diária	Manter por 6 a 8 semanas ou indefinido se houver aneurismas coronarianos
Febre Reumática — Cardite/Artrite (VO)	50 a 70 mg/kg/dia (Dose anti-inflamatória)	Dividido a cada 6 a 8 horas por 2 a 4 semanas com desmame

Contraindicações, restrições e monitorização

Risco Grave (Síndrome de Reye): Contraindicado em crianças febris com suspeita de infecção viral (Influenza, Varicela) devido ao risco fatal de esteatose microvesicular hepática e encefalopatia.

Condições: Úlcera péptica ativa, diátese hemorrágica, hemofilia e asma induzida por aspirina.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

7. Ácido ascórbico (Vitamina C)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Gotas 200 mg/mL (10 mg/gota)

Solução oral 100 mg/mL

Comprimidos efervescentes 500 mg e 1 g

Solução injetável 100 mg/mL (ampola 5 mL = 500 mg)

Indicações e Linha de Tratamento

Vitamina hidrossolúvel essencial, cofator na síntese de colágeno e absorção intestinal de ferro não-heme. Indicada na prevenção e tratamento do escorbuto, suplementação em prematuros, nutrição parenteral total e acidificação urinária coadjuvante.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Escorbuto — Tratamento (VO/IV)	100 a 300 mg/dia	Dividido em 1 a 3 tomadas diárias por 1 a 2 semanas
Suplementação / Adjuvante na absorção de ferro (VO)	Lactentes: 25 a 50 mg/dia. Crianças maiores: 50 a 100 mg/dia.	Administrado junto às refeições ou com sais de ferro
Prematuros em aleitamento (VO)	25 a 50 mg/dia	Dose diária única

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Litíase renal por oxalato de cálcio, hemocromatose, talassemia e deficiência grave de G6PD (altas doses parenterais podem precipitar hemólise).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

8. Ácido fólico (Vitamina B9)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Gotas 0,2 mg/mL (10 mcg/gota)

Solução oral 1 mg/mL

Comprimidos 2 mg e 5 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Cofator enzimático essencial na síntese de purinas, timidilato e eritropoiese. Indicado no tratamento da anemia megaloblástica por deficiência de folato, suporte hematológico em anemias hemolíticas crônicas (anemia falciforme, esferocitose, talassemia) e prevenção de toxicidade por metotrexato.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Deficiência de Folato / Anemia Megaloblástica (VO)	< 1 ano: 0,1 a 0,5 mg/dia. > 1 ano: 1 a 5 mg/dia.	Dose única diária por 1 a 2 meses
Anemia Falciforme / Hemólise Crônica (VO)	Crianças < 1 ano: 0,5 a 1 mg/dia. Crianças ≥ 1 ano: 1 mg/dia (até 5 mg/dia).	Uso profilático contínuo uma vez ao dia
Prematuros (< 1500g) (VO)	0,1 mg/dia (50 a 100 mcg/dia)	Até atingir peso/termo

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Anemia perniciosa não tratada com vitamina B12 (o folato corrige alterações hematológicas mas mascara progressão da degeneração neurológica subaguda).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

9. Ácido folínico (Folinato de cálcio)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos 15 mg

Solução injetável 3 mg/mL e 10 mg/mL (ampolas e frascos-ampola)

Indicações e Linha de Tratamento

Forma ativa do ácido tetraidrofólico. Indicado no resgate hematológico após altas doses de metotrexato na oncologia pediátrica, neutralização da toxicidade de inibidores da di-hidrofolato redutase (pirimetamina no tratamento da toxoplasmose congênita/adquirida e trimetoprima).

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Toxoplasmose Congênita / Coadjuvante à Pirimetamina (VO/IV)	5 a 10 mg (ou 10 a 20 mg/m ² /dose)	3 vezes por semana (ou diariamente se neutropenia severa)
Resgate de Metotrexato (IV/VO)	10 a 15 mg/m ² /dose a cada 6h por 48 a 72h	Iniciar 24h após término do metotrexato; titular por nível sérico

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipersensibilidade ao folinato; não deve ser administrado por via intratecal (risco de morte/neurotoxicidade fatal).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

10. Ácido mefenâmico

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; concentrações simples checadas: OK

Apresentações Disponíveis

Suspensão oral 50 mg/5 mL (10 mg/mL)

Comprimidos 500 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Anti-inflamatório não esteroide (AINE) derivado do ácido fenâmico. Indicado no alívio sintomático de dor inflamatória leve a moderada, dismenorreia primária em adolescentes e dor odontológica.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Dor e Inflamação — 6 meses a 12 anos (VO)	6,5 mg/kg/dose (ou 20 a 25 mg/kg/dia)	A cada 8 horas (Máx: 25 mg/kg/dia; limite 7 dias)
Adolescentes > 12 anos e Dismenorreia (VO)	250 a 500 mg por dose	A cada 8 horas com alimentos (Máx: 1500 mg/dia)

Contraindicações, restrições e monitorização

Idade: Não recomendado para menores de 6 meses de idade.

Condições: Úlcera péptica ativa, doença inflamatória intestinal, insuficiência renal ou hepática grave, histórico de broncoespasmo por AAS/AINEs.

Checagem matemática automatizada

OK - 50 mg/5 mL = 10 mg/mL; declarado 10 mg/mL

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

11. Ácido tranexâmico

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos 250 mg

Solução injetável 50 mg/mL (ampola 5 mL = 250 mg)

Indicações e Linha de Tratamento

Agente antifibrinolítico inibidor competitivo da ativação do plasminogênio. Indicado no controle de hemorragias em cirurgias de grande porte (cardíaca, craniofacial, ortopédica), trauma grave com sangramento ativo, menorragia grave na adolescência e sangramentos mucosos na hemofilia.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Trauma Hemorrágico Pediátrico / Sangramento Grave (IV)	Ataque: 15 a 20 mg/kg (Máx: 1 g) em 10 min. Manutenção: 2 a 5 mg/kg/h em infusão por 8h.	Iniciar idealmente nas primeiras 3 horas do trauma.
Cirurgias com Risco de Grande Sangramento (IV)	10 a 20 mg/kg antes da incisão, seguido de 5 a 10 mg/kg/h durante o procedimento.	Infusão lenta para evitar hipotensão.
Menorragia / Sangramento Mucoso (VO)	15 a 25 mg/kg/dose (Máx: 1000 a 1500 mg)	A cada 8 horas durante o período de sangramento intenso

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Tromboembolismo venoso ou arterial ativo, hematúria macroscópica de trato urinário superior (risco de obstrução ureteral por coágulos) e histórico de convulsões (em altas doses).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

12. Ácido ursodesoxicólico

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Cápsulas/comprimidos 50 mg, 150 mg e 300 mg

Suspensão oral 50 mg/mL (geralmente manipulada/especializada)

Indicações e Linha de Tratamento

Ácido biliar hidrofílico hepatoprotetor e colerético. Indicado no manejo da colestase neonatal, atresia de vias biliares no pós-operatório de Kasai, colangite esclerosante primária, fibrose cística com acometimento hepatobiliar e nutrição parenteral prolongada com colestase.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Colestase Neonatal / Pós-Kasai / Fibrose Cística (VO)	10 a 20 mg/kg/dia (podendo atingir 30 mg/kg/dia na fibrose cística)	Dividido em 2 a 3 tomadas diárias junto às refeições
Prevenção / Tratamento de Lama e Cálculos Biliares (VO)	10 a 15 mg/kg/dia	Dividido a cada 12 horas ou dose única noturna

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Obstrução mecânica completa das vias biliares extra-hepáticas, hepatite aguda fulminante e colecistite aguda com cálculo obstrutivo.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

13. Ácido valproico / Valproato de sódio / Divalproato de sódio

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; concentrações simples checadas: OK

Apresentações Disponíveis

Xarope 250 mg/5 mL (50 mg/mL)

Gotas 200 mg/mL

Cápsulas 250 mg

Comprimidos revestidos/liberação prolongada 250 mg, 300 mg e 500 mg

Solução injetável IV 100 mg/mL (frasco-ampola 5 mL = 500 mg)

Indicações e Linha de Tratamento

Anticonvulsivante de amplo espectro (potencializador GABAérgico e bloqueador de canais de sódio/cálcio tipo T). Primeira linha para epilepsia generalizada idiopática, crises de ausência, mioclonias e alternativa eficaz no estado de mal epilético refratário a benzodiazepínicos.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Epilepsia Pediátrica — Manutenção (VO)	Inicial: 10 a 15 mg/kg/dia. Titular até 30 a 60 mg/kg/dia conforme resposta clínica e nível sérico (alvo: 50 a 100 mcg/mL).	Dividido a cada 8 a 12 horas (ou 1x ao dia para fórmulas de liberação prolongada)
Estado de Mal Epilético — 2ª Linha (IV)	20 a 40 mg/kg (Máx: 3000 mg) diluído em SF0,9% ou SG5% e infundido em 5 a 10 min (taxa até 3 a 6 mg/kg/min).	Seguido de manutenção IV 1 a 5 mg/kg/h ou 10 mg/kg a cada 8h.

Contraindicações, restrições e monitorização

Idade / Risco: Crianças < 2 anos possuem alto risco de hepatotoxicidade fatal, especialmente se portadoras de distúrbios mitocondriais (mutações no gene POLG) ou erros inatos do metabolismo do ciclo da ureia.

Condições: Doença hepática ativa, pancreatite aguda prévia por valproato e hiperamonemia.

Checamagem matemática automatizada

OK - 250 mg/5 mL = 50 mg/mL; declarado 50 mg/mL

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

14. Adenosina

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável 3 mg/mL (ampola 2 mL = 6 mg)

Indicações e Linha de Tratamento

Nucleosídeo endógeno antiarrítmico de ação ultracurta. Primeira linha para reversão imediata de Taquicardia Supraventricular Paroxística (TSV) por reentrada nodal ou reentrada atrioventricular em pediatria hemodinamicamente estável.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Taquicardia Supraventricular — 1ª Dose (IV/IO)	0,1 mg/kg (Máx: 6 mg)	Administração em bolus ultrarrápido (< 2 segundos) em veia periférica proximal, seguido imediatamente de flush de 5 a 10 mL de SF0,9% com técnica de torneirinha.
TSV — 2ª Dose (se não reverter em 1-2 min) (IV/IO)	0,2 mg/kg (Máx: 12 mg)	Mesma técnica de bolus rápido e flush vigoroso.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Bloqueio atrioventricular de 2º ou 3º grau, síndrome do nó sinusal (exceto com marca-passo), broncoespasmo grave ativo (asma grave descompensada).

Monitorização: Registro contínuo de ECG durante a injeção; alertar a equipe para pausa assistólica transitória esperada.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

15. Adrenalina (Epinefrina)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável 1 mg/mL (1:1000, ampola 1 mL)

Indicações e Linha de Tratamento

Agonista adrenérgico alfa e beta potente. Primeira linha mandatória no tratamento da anafilaxia, parada cardiorrespiratória (PCR), choque distributivo/cardiogênico refratário e nebulização no crupe viral moderado a grave (laringotraqueobronquite aguda).

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Anafilaxia (Intramuscular - Vasto Lateral)	0,01 mg/kg (0,01 mL/kg da solução 1:1000)	Dose máxima: 0,3 mg (< 12 anos) ou 0,5 mg (adolescentes). Pode repetir a cada 5 a 15 minutos se refratário.
Parada Cardiorrespiratória (IV/IO)	0,01 mg/kg (0,1 mL/kg da diluição 1:10.000 = 0,1 mg/mL)	A cada 3 a 5 minutos durante manobras de RCP (Máx: 1 mg/dose).
Crupe Viral / Estridor em Repouso (Nebulização)	0,5 mL/kg de adrenalina 1:1000 pura (Máx: 5 mL)	Nebulização pura com O2 em fluxo de 6 a 8 L/min. Observar rebote por 2 a 4 horas.

Contraindicações, restrições e monitorização

Emergência: Não existem contraindicações absolutas em situações de parada cardiorrespiratória e anafilaxia grave.

Vias: A via intramuscular no músculo vasto lateral da coxa é obrigatória na anafilaxia (a via subcutânea tem absorção errática e é contraindicada).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

16. Agalsidase beta

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó liofilizado para solução injetável 35 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Terapia de reposição enzimática (alfa-galactosidase A recombinante). Indicada para o tratamento a longo prazo de crianças e adolescentes com diagnóstico confirmado de Doença de Fabry para prevenir acúmulo de globotriaosilceramida (Gb3) nos rins, coração e sistema nervoso.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Doença de Fabry (IV)	1 mg/kg a cada 2 semanas	Infusão intravenosa lenta inicial ($\leq$ 0,25 mg/min ou 15 mg/h), podendo ser aumentada gradualmente conforme tolerância.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipersensibilidade grave à substância ativa; risco de reações associadas à infusão (IARs). Recomenda-se pré-medicação com anti-histamínicos e/ou corticoides.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

17. Albendazol

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Suspensão oral 40 mg/mL (frasco 10 mL = 400 mg)

Comprimidos mastigáveis 400 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Anti-helmíntico benzimidazol de largo espectro. Indicado no tratamento de infecções por nematódeos intestinais (Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Ancylostoma duodenale, Necator americanus, Trichuris trichiura), Giardíase, Larva migrans cutânea e Neurocisticercose.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Ascariíase, Oxiuriíase, Ancilostomíase, Tricuríase (VO)	Crianças $\geq$ 2 anos: 400 mg (10 mL) em dose única. Crianças de 1 a 2 anos: 200 mg (5 mL) em dose única.	Na oxiuriíase, repetir a dose após 14 dias para erradicar novos ovos.
Giardíase (VO)	400 mg/dia em dose única	Por 5 dias consecutivos (administrar com alimentos gordurosos)

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Neurocisticercose Pediátrica (VO)	15 mg/kg/dia dividido a cada 12 horas (Máx: 800 mg/dia)	Por 8 a 30 dias, sempre associado a corticoterapia prévia e concomitante.

Contraindicações, restrições e monitorização

Idade: Não recomendado para menores de 1 ano de idade.

Condições: Hipersensibilidade a benzimidazóis e insuficiência hepática severa.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

18. Alfa-dornase (Dornase alfa)

Auditoria documental Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução para inalação 1 mg/mL (ampola 2,5 mL = 2,5 mg)

Indicações e Linha de Tratamento

Desoxirribonuclease I humana recombinante (rhDNase). Indicada na fibrose cística para reduzir a viscosidade das secreções purulentas do trato respiratório por digestão do DNA extracelular liberado pelos neutrófilos lisados, melhorando a função pulmonar e reduzindo exacerbações.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Fibrose Cística ≥ 5 anos (Inalatória)	2,5 mg (1 ampola de 2,5 mL) uma vez ao dia (inalador aprovado a ar comprimido/compressor)	Pode ser aumentada para 2,5 mg a cada 12 horas em pacientes selecionados.
Crianças < 5 anos (Uso especializado) (Inalatória)	2,5 mg uma vez ao dia sob supervisão de pneumologia pediátrica	Uso em nebulizador dedicado sem misturar com outros fármacos.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipersensibilidade à dornase alfa ou a produtos derivados de células de ovário de hamster chinês (CHO).

Instruções: Não diluir nem misturar com outros medicamentos no mesmo copo do nebulizador.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

19. Alglucosidase alfa

Auditoria documental Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó liofilizado para solução injetável 50 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Terapia de reposição enzimática (alfa-glicosidase ácida humana recombinante). Indicada para o tratamento a longo prazo da Doença de Pompe (Doença de Depósito de Glicogênio Tipo II) em formas de início precoce (infantil clássica) e tardio.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Doença de Pompe (IV)	20 mg/kg a cada 2 semanas	Infusão intravenosa lenta inicial escalonada (1 mg/kg/h com aumentos a cada 30 min até máx 7 mg/kg/h).

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Risco elevado de reações anafiláticas e insuficiência cardiorrespiratória durante a infusão. Exige suporte avançado de vida e pré-medicação com anti-histamínicos e antipiréticos.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

20. Alopurinol

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos 100 mg e 300 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Inibidor da xantina oxidase. Indicado na prevenção e tratamento da hiperuricemia secundária à Síndrome de Lise Tumoral (SLT) em leucemias e linfomas na oncologia pediátrica, além de hiperuricemia por erros inatos do metabolismo (ex: Síndrome de Lesch-Nyhan).

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Prevenção de Hiperuricemia na Síndrome de Lise Tumoral (VO)	Crianças < 10 anos: 10 mg/kg/dia (ou 300 mg/m ² /dia) dividido a cada 8 horas (Máx: 300 a 400 mg/dia). Crianças ≥ 10 anos: 300 a 600 mg/dia dividido a cada 8 a 12 horas.	Iniciar 24 a 48h antes da quimioterapia com hiper-hidratação vigorosa.
Síndrome de Lesch-Nyhan (VO)	5 a 10 mg/kg/dia	Dividido a cada 8 a 12 horas

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipersensibilidade grave prévia ao alopurinol (risco de Síndrome de Stevens-Johnson / DRESS).

Ajustes: Reduzir dose na insuficiência renal com base na taxa de filtração glomerular.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

21. Alprostadil (Prostaglandina E1 / PGE1)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável concentrada para infusão 500 mcg/mL (ampola 1 mL)

Indicações e Linha de Tratamento

Prostaglandina vasodilatadora potente. Indicada na manutenção temporária da patência do canal arterial (ductus arteriosus) em neonatos com cardiopatias congênitas canal-dependentes (ex: atresia pulmonar, coarctação de aorta crítica, transposição de grandes artérias) até a intervenção cirúrgica corretiva ou paliativa.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Manutenção do Canal Arterial Neonatal (IV/IO Contínuo)	Dose inicial: 0,05 a 0,1 mcg/kg/min em infusão contínua em bomba.	Após resposta clínica/oximetria satisfatória, titular gradativamente para dose de manutenção: 0,01 a 0,025 mcg/kg/min para minimizar efeitos adversos.

Contraindicações, restrições e monitorização

Precauções / Monitorização: Alto risco de apneia súbita (10 a 12% dos neonatos), hipotensão, febre e rubor cutâneo. É mandatório dispor de material e equipe para intubação orotraqueal imediata durante o transporte ou internação.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

22. Amantadina (cloridrato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos 100 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Agente dopaminérgico e antiviral (antagonista dos receptores NMDA). Utilizado em neurologia pediátrica como adjuvante no manejo de distúrbios do movimento (distonias, coreia), promoção da recuperação neurológica pós-traumatismo cranioencefálico grave ou lesão anóxica cerebral.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Distúrbios do Movimento / Reabilitação Neurológica (VO)	Crianças de 1 a 9 anos: 4 a 6 mg/kg/dia dividido a cada 12 horas (Máx: 150 mg/dia). Crianças ≥ 10 anos: 100 mg 1 a 2 vezes ao dia (Máx: 200 mg/dia).	Titular gradualmente ao longo de 2 a 3 semanas.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Insuficiência renal grave, glaucoma de ângulo fechado e histórico de convulsões não controladas.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

23. Ambroxol (cloridrato)

Auditoria documental Presente nos dois anexos; concentrações simples checadas: OK

Apresentações Disponíveis

Xarope pediátrico 15 mg/5 mL (3 mg/mL)

Xarope adulto 30 mg/5 mL (6 mg/mL)

Gotas 7,5 mg/mL

Indicações e Linha de Tratamento

Mucolítico e expectorante que reduz a viscosidade do muco brônquico e estimula a síntese de surfactante alveolar. Indicado no tratamento sintomático de afecções broncopulmonares agudas e crônicas com hipersecreção viscosa.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Crianças de 2 a 5 anos (VO)	7,5 mg (2,5 mL do xarope pediátrico)	3 vezes ao dia
Crianças de 5 a 12 anos (VO)	15 mg (5 mL do xarope pediátrico)	2 a 3 vezes ao dia
Crianças > 12 anos e Adolescentes (VO)	30 mg (5 mL do xarope adulto ou 10 mL do pediátrico)	3 vezes ao dia

Contraindicações, restrições e monitorização

Idade: Contraindicado para menores de 2 anos devido à incapacidade de expectoração eficaz e risco de obstrução de vias aéreas.

Condições: Hipersensibilidade aos componentes e úlcera péptica.

Checação matemática automatizada

OK - 15 mg/5 mL = 3 mg/mL; declarado 3 mg/mL

OK - 30 mg/5 mL = 6 mg/mL; declarado 6 mg/mL

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

24. Amicacina (sulfato)

Auditoria documental Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável 50 mg/mL, 125 mg/mL e 250 mg/mL (ampolas de 2 mL)

Indicações e Linha de Tratamento

Antimicrobiano bactericida aminoglicosídeo. Indicado no tratamento de infecções graves por bacilos Gram-negativos multirresistentes (ex: Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter, E. coli), sepse neonatal e infecções intra-abdominais/urinárias complicadas em associação.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Sepse / Infecção Grave — Crianças > 1 mês (IV/IM)	15 a 20 mg/kg uma vez ao dia (Dose diária única preferencial) ou dividido a cada 8-12h	Infusão IV lenta em 30 a 60 minutos. Duração habitual: 7 a 10 dias.

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Neonatologia (IV/IM)	Prematuros < 30 sem: 15 mg/kg a cada 48h. 30-34 sem: 15 mg/kg a cada 36h. A termo: 15 mg/kg a cada 24h.	Ajustar por idade gestacional e clearance renal.

Contraindicações, restrições e monitorização

Toxicidade: Risco de ototoxicidade irreversível (vestibular e coclear) e nefrotoxicidade dose-dependente. É mandatória a monitorização de nível sérico (pico e vale) e função renal seriada.

Condições: Miastenia gravis e uso concomitante de outros fármacos nefrotóxicos ou bloqueadores neuromusculares.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

25. Amilorida + Hidroclorotiazida

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos 2,5 mg + 25 mg e 5 mg + 50 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Diurético poupador de potássio associado a tiazídico. Indicado no tratamento da hipertensão arterial pediátrica e edemas associados a insuficiência cardíaca ou síndrome nefrótica, evitando a hipocalemia excessiva provocada pelo tiazídico isolado.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Hipertensão / Edema (VO)	Cálculo baseado na Hidroclorotiazida: 1 a 2 mg/kg/dia (com amilorida proporcional 0,1 a 0,2 mg/kg/dia)	Dose única matinal ou dividida a cada 12 horas (Máx: 50 mg/dia de HCTZ)

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipercalemia (> 5,5 mEq/L), insuficiência renal moderada a grave (ClCr < 30 mL/min), anúria e hipersensibilidade a sulfonamidas.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

26. Aminofilina

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Gotas/solução oral 240 mg/mL

Comprimidos 100 mg e 200 mg

Solução injetável 24 mg/mL (ampola 10 mL = 240 mg)

Indicações e Linha de Tratamento

Metilxantina broncodilatadora e estimulante do centro respiratório. Indicada no tratamento da apneia da prematuridade e como terapia de resgate de terceira linha na crise asmática grave refratária em UTI pediátrica.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Apneia da Prematuro (IV/VO)	Ataque: 5 a 6 mg/kg em 30 min. Manutenção: 1,5 a 3 mg/kg/dose a cada 8 a 12 horas.	Manter nível sérico de teofilina entre 6 e 12 mcg/mL.
Crise Asmática Grave em UTI (IV)	Ataque (se virgem de xantina): 5 a 6 mg/kg em 30 min. Manutenção contínua: 0,8 a 1 mg/kg/h em bomba.	Faixa terapêutica estreita (10 a 20 mcg/mL); monitorizar ECG e nível sérico.

Contraindicações, restrições e monitorização

Toxicidade: Alto risco de taquiarritmias ventriculares, hipotensão, convulsões intratáveis e vômitos refratários em níveis tóxicos (> 20 mcg/mL).

Condições: Úlcera péptica e arritmias cardíacas preexistentes.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

27. Amiodarona (cloridrato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos 100 mg e 200 mg

Solução injetável 50 mg/mL (ampola 3 mL = 150 mg)

Indicações e Linha de Tratamento

Antiarrítmico de classe III (bloqueador de canais de potássio, sódio e cálcio). Primeira linha na parada cardiorrespiratória por Fibrilação Ventricular (FV) / Taquicardia Ventricular sem pulso (TVSP) refratárias ao choque e no controle de taquiarritmias ventriculares e supraventriculares com instabilidade.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
PCR (FV/TV sem pulso refratária) (IV/IO)	5 mg/kg em bolus rápido (Máx: 300 mg na 1ª dose e 150 mg na 2ª dose)	Pode repetir até 3 doses totais durante a RCP.
Taquiarritmias com Pulso (TSV, TV estável) (IV)	Carga: 5 mg/kg infundido em 20 a 60 minutos (Máx: 300 mg). Manutenção: 5 a 15 mcg/kg/min (ou 5 a 10 mg/kg/dia) em infusão contínua.	Diluição exclusiva em SG5% em frasco de vidro/polietileno.
Manutenção Antiarrítmica Crônica (VO)	Carga: 10 a 15 mg/kg/dia por 7 a 14 dias. Manutenção: 5 mg/kg/dia em dose única.	Monitorar tireoide, função hepática, RX tórax e ECG.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Bloqueio AV de 2º ou 3º grau sem marca-passo, disfunção sinusal grave, choque cardiogênico descompensado e intervalo QTc prolongado basal.

Efeitos: Risco de hipotensão grave e bradicardia durante a infusão rápida.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

28. Amitriptilina (cloridrato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos 10 mg, 25 mg e 75 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Antidepressivo tricíclico. Em pediatria, é utilizado na profilaxia de migrânea (enxaqueca crônica), dor neuropática crônica e enurese noturna monossintomática em crianças ≥ 6 anos após falha de medidas comportamentais.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Profilaxia de Enxaqueca / Dor Crônica (VO)	Inicial: 0,25 a 0,5 mg/kg/dia (ou 10 mg/dia) ao deitar. Titular até 1 mg/kg/dia conforme resposta.	Dose única noturna (efeito sedativo inicial benéfico)
Enurese Noturna (≥ 6 anos) (VO)	6 a 10 anos: 10 a 20 mg/dia. > 10 anos: 25 a 50 mg/dia.	Administrado 1 hora antes de dormir. Limitar a 3 meses de uso com desmame.

Contraindicações, restrições e monitorização

Idade: Não recomendado para menores de 6 anos de idade.

Condições: Doenças cardíacas congênitas, prolongamento do intervalo QTc, arritmias, glaucoma de ângulo fechado e uso concomitante de IMAO.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

29. Amlodipino (Besilato de anlodipino)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos 2,5 mg, 5 mg e 10 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Anti-hipertensivo bloqueador dos canais de cálcio do grupo das di-hidropiridinas. Primeira linha no controle a longo prazo da hipertensão arterial essencial ou secundária em crianças e adolescentes.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Hipertensão Arterial Pediátrica (VO)	Crianças de 1 a 5 anos: 0,1 mg/kg/dia (titular até 0,3 a 0,6 mg/kg/dia; Máx: 5 mg/dia). Crianças ≥ 6 anos e Adolescentes: Inicial de 2,5 mg/dia, podendo titular até 5 a 10 mg/dia.	Dose única diária matinal ou dividida a cada 12 horas.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipotensão arterial grave, choque cardiogênico, estenose aórtica severa e hipersensibilidade a di-hidropiridinas.

Efeitos: Risco de edema periférico de membros inferiores e cefaleia vasomotora.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

30. Amoxicilina

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó para suspensão oral 250 mg/5 mL, 400 mg/5 mL e 500 mg/5 mL

Cápsulas/comprimidos 500 mg e 875 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Antimicrobiano beta-lactâmico aminopenicilínico. Primeira linha de escolha empírica para as infecções comunitárias prevalentes da infância: Otite Média Aguda (OMA), Sinusite Bacteriana Aguda, Faringoamigdalite estreptocócica e Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC) típica não complicada.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Dose Padrão — PAC leve / Amigdalite (VO)	45 a 50 mg/kg/dia	Dividido a cada 8 ou 12 horas por 7 a 10 dias
Dose Alta — OMA / Sinusite com risco de Pneumococo resistente (VO)	80 a 90 mg/kg/dia (Máx: 2 a 3 g/dia)	Dividido a cada 12 horas por 7 a 10 dias (10 dias se < 2 anos)
Profilaxia de Endocardite Infeciosa (VO)	50 mg/kg (Máx: 2 g)	Dose única 30 a 60 minutos antes do procedimento de risco

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Histórico de anafilaxia ou reações alérgicas graves mediadas por IgE a penicilinas.

Alerta Clínico: Evitar uso na suspeita de Mononucleose Infeciosa (EBV) devido ao surgimento de exantema maculopapular difuso induzido por aminopenicilina.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

31. Amoxicilina + Clavulanato de potássio

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó para suspensão oral 125+31,25 mg/5 mL, 250+62,5 mg/5 mL (proporção 4:1)

Pó para suspensão oral 200+28,5 mg/5 mL, 400+57 mg/5 mL (proporção 7:1)

Pó para suspensão oral 600+42,9 mg/5 mL [ES] (proporção 14:1)

Comprimidos 500+125 mg e 875+125 mg

Pó liofilizado para solução injetável IV 500+100 mg e 1000+200 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Associação de aminopenicilina com inibidor irreversível de beta-lactamase. Primeira linha para mordeduras de cães/gatos e humanas, OMA com falha de amoxicilina pura, sinusite refratária, pneumonia aspirativa e infecções urinárias comunitárias selecionadas.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Dose Padrão — Mordeduras / Infecções leves a moderadas (VO)	40 a 50 mg/kg/dia (base amoxicilina)	Dividido a cada 8h (formulação 4:1) ou a cada 12h (formulação 7:1)
Dose Alta — OMA grave / Falha terapêutica (VO)	80 a 90 mg/kg/dia de amoxicilina com formulação 14:1 (ES 600 mg/5 mL) para não ultrapassar 6,4 a 10 mg/kg/dia de clavulanato.	Dividido a cada 12 horas por 10 dias
Infecções Graves Intra-hospitalares (IV)	90 a 100 mg/kg/dia (base amoxicilina)	Dividido a cada 8 horas em infusão lenta de 30 min

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Histórico prévio de icterícia colestatática ou disfunção hepática associada ao uso de amoxicilina-clavulanato; alergia grave a penicilinas.

Efeitos: Aumento da frequência de diarreia por hipermotilidade gástrica induzida pelo clavulanato (minimizado com formulações 7:1 ou 14:1 ingeridas com alimentos).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

32. Ampicilina sódica

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó para suspensão oral 250 mg/5 mL

Cápsulas 500 mg

Pó para solução injetável frasco-ampola 500 mg e 1000 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Aminopenicilina bactericida de uso parenteral prioritário. Primeira linha no esquema empírico da sepse e meningite neonatal (associada a gentamicina ou cefotaxima para cobertura de *Listeria monocytogenes* e *Streptococcus agalactiae*) e tratamento de infecções graves por *Enterococcus faecalis* sensível.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Infecções Pediátricas Gerais / PAC Grave (IV/IM)	100 a 200 mg/kg/dia	Dividido a cada 6 horas (Máx: 8 a 12 g/dia)
Meningite Pediátrica / Infecção do SNC (IV)	200 a 400 mg/kg/dia	Dividido a cada 6 horas (Máx: 12 g/dia)
Sepse / Meningite Neonatal (IV)	Neonato ≤ 7 dias: 100 a 150 mg/kg/dia a cada 12h (200 mg/kg/dia se meningite a cada 8h). Neonato > 7 dias: 150 a 200 mg/kg/dia a cada 8h (300 mg/kg/dia se meningite a cada 6h).	Infusão IV direta lenta em 10 a 15 min ou diluída em 30 min.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipersensibilidade grave a penicilinas.

Absorção Oral: A apresentação oral possui biodisponibilidade inferior à amoxicilina e deve ser administrada 1 hora antes ou 2 horas após as refeições.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

33. Ampicilina + Sulbactam

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó para solução injetável frasco-ampola 1,5 g (1000 mg ampicilina + 500 mg sulbactam) e 3 g (2000 mg ampicilina + 1000 mg sulbactam)

Indicações e Linha de Tratamento

Associação de aminopenicilina com inibidor de beta-lactamase para uso parenteral. Indicada no tratamento de infecções intra-abdominais complicadas, infecções de cabeça e pescoço (abscesso periamigdaliano/retrofaríngeo), celulite orbitária, infecções ginecológicas/pélvicas e infecções por *Acinetobacter baumannii* suscetível.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Infecções Leves a Moderadas (IV/IM)	100 a 150 mg/kg/dia da combinação (calculado sobre 67 mg/kg ampicilina + 33 mg/kg sulbactam)	Dividido a cada 6 horas
Infecções Graves / Abscessos Profundos (IV)	200 a 300 mg/kg/dia da combinação (Máx: 8 g ampicilina + 4 g sulbactam = 12 g/dia)	Dividido a cada 6 horas em infusão de 30 a 60 minutos

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Alergia grave a derivados penicilínicos e histórico de disfunção hepática colestática ligada ao sulbactam.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

34. Anfotericina B (complexo lipídico)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Suspensão injetável concentrada para infusão 5 mg/mL (frasco 20 mL = 100 mg)

Indicações e Linha de Tratamento

Antifúngico polieno em formulação lipídica. Indicado no tratamento de infecções fúngicas invasivas graves (Candidíase sistêmica, Aspergilose invasiva, Criptococose, Mucormicose e Leishmaniose visceral) em pacientes com insuficiência renal ou refratários à anfotericina desoxicolato.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Micoses Invasivas Sistêmicas (IV)	5 mg/kg uma vez ao dia	Infusão intravenosa lenta em 2 a 4 horas diluída exclusivamente em SG5%.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipersensibilidade aos componentes lipídicos da fórmula.

Cuidados: Diluição incompatível com soluções salinas (precipitação). Monitorar potássio, magnésio e função renal.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

35. Anfotericina B (desoxicolato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó liofilizado para solução injetável frasco-ampola 50 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Antifúngico polieno convencional de amplo espectro. Indicado no tratamento de infecções fúngicas sistêmicas graves e leishmaniose visceral quando as formulações lipídicas não estão disponíveis.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Infecções Fúngicas Invasivas (IV)	Dose teste inicial: 0,1 mg/kg (opcional). Dose terapêutica: 0,5 a 1,0 mg/kg/dia (Máx: 1,5 mg/kg/dia).	Infundir em 4 a 6 horas em SG5% protegido da luz. Pré-hidratação com SF0,9% 10-20 mL/kg reduz nefrotoxicidade.

Contraindicações, restrições e monitorização

Toxicidade: Alta incidência de nefrotoxicidade com acidose tubular renal tipo 1, hipocalcemia, hipomagnesemia e reações infusionais agudas (febre, calafrios, tremores).

Preparo: Nunca reconstituir ou diluir com cloreto de sódio.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

36. Anfotericina B (lipossomal)

Auditoria documental Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó liofilizado para solução injetável frasco-ampola 50 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Formulação lipossomal de anfotericina B com menor toxicidade renal. Primeira linha de escolha para Leishmaniose Visceral grave em pediatria, infecções fúngicas invasivas em imunodeprimidos, meningite criptocócica e mucormicose.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Micoses Invasivas / Aspergilose / Candidíase (IV)	3 a 5 mg/kg/dia (até 7,5 a 10 mg/kg/dia em mucormicose)	Infundir em 60 a 120 minutos diluído em SG5%.
Leishmaniose Visceral — Protocolo Brasileiro (IV)	3 mg/kg/dia por 7 dias consecutivos (ou dose total acumulada de 20 a 24 mg/kg)	Infusão em 2 horas em SG5%.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipersensibilidade grave a políenos lipossomais.

Vantagem: Menor nefrotoxicidade e reações infusionais que o desoxicolato; manter monitoramento eletrolítico.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

37. Anidulafungina

Auditoria documental Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó liofilizado para solução injetável frasco-ampola 100 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Antifúngico da classe das equinocandinas (inibidor da síntese de 1,3-beta-D-glucano da parede celular). Indicado no tratamento de candidíase invasiva e candidemia em crianças e adolescentes.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Candidíase Invasiva / Candidemia (IV)	Ataque: 3 mg/kg (Máx: 200 mg) no dia 1. Manutenção: 1,5 mg/kg/dia (Máx: 100 mg/dia) a partir do dia 2.	Infusão lenta em velocidade ≤ 1,1 mg/min (não exceder). Duração de pelo menos 14 dias após hemocultura negativa.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipersensibilidade a equinocandinas.

Vantagem: Não requer ajuste de dose para insuficiência renal ou hepática leve a moderada.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

38. Aripiprazol

Auditoria documental Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução oral 1 mg/mL

Gotas 1 mg/gota

Comprimidos 5 mg, 10 mg, 15 mg e 20 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Antipsicótico atípico de segunda geração (agonista parcial dos receptores dopaminérgicos D2 e serotoninérgicos 5-HT1A). Indicado no manejo da irritabilidade e agressividade associadas ao Transtorno do Espectro Autista (TEA) em crianças ≥ 6 anos, Síndrome de Tourette e Transtorno Bipolar.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Irritabilidade no TEA (≥ 6 anos) (VO)	Inicial: 1 a 2 mg/dia. Titular a cada 1-2 semanas em incrementos de 1 a 2,5 mg/dia (Alvo: 2 a 10 mg/dia; Máx: 15 mg/dia).	Dose única diária (manhã ou noite)
Tiques / Síndrome de Tourette (VO)	Peso < 50 kg: Inicial 2 mg/dia, titular até 5 mg/dia. Peso ≥ 50 kg: Inicial 2 mg/dia, titular até 10 a 20 mg/dia.	Dose única diária

Contraindicações, restrições e monitorização

Idade: Segurança não estabelecida em menores de 6 anos.

Monitorização: Monitorar ganho de peso, perfil lipídico, glicemia de jejum e sintomas extrapiramidais (acatisia, distonias tardias).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

39. Atenolol

Auditoria documental Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos 25 mg, 50 mg e 100 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Betabloqueador seletivo beta-1 cardioseletivo hidrofílico. Indicado no controle da hipertensão arterial pediátrica, profilaxia de taquiarritmias supraventriculares, controle de crises de hipóxia na Tetralogia de Fallot e profilaxia de enxaqueca.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Hipertensão Arterial / Taquiarritmias (VO)	Inicial: 0,5 a 1 mg/kg/dia em dose única diária ou a cada 12 horas. Titular até 2 mg/kg/dia conforme frequência cardíaca e PA (Máx: 50 a 100 mg/dia).	Administrar preferencialmente no mesmo horário todos os dias.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Bradicardia sinusal severa, bloqueio atrioventricular de 2º ou 3º grau, choque cardiogênico, insuficiência cardíaca descompensada e asma brônquica grave (perda da seletividade em altas doses).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

40. Atracúrio (besilato)

Auditoria documental Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável 10 mg/mL (ampolas de 2,5 mL e 5 mL)

Indicações e Linha de Tratamento

Bloqueador neuromuscular não despolarizante do grupo benzilisoquinolínico com eliminação de Hofmann (independente de função renal ou hepática). Indicado para facilitar intubação traqueal e fornecer relaxamento muscular em ventilação mecânica e procedimentos cirúrgicos pediátricos.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Intubação Orotraqueal / Relaxamento Cirúrgico (IV)	0,3 a 0,5 mg/kg em bolus IV lento em 1 minuto	Início de ação em 2 a 3 minutos; duração de 20 a 35 minutos.
Manutenção Intermitente ou Infusão Contínua (IV)	Bolus: 0,1 a 0,2 mg/kg conforme necessidade. Infusão: 5 a 10 mcg/kg/min (0,3 a 0,6 mg/kg/h).	Titular com monitor de bloqueio neuromuscular (TOF).

Contraindicações, restrições e monitorização

Alerta: Liberação de histamina dose-dependente em injeção rápida (pode causar rubor, broncoespasmo e hipotensão).

Mandatário: Sedação e analgesia profundas prévias e via aérea artificial segura.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

41. Atropina (sulfato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável 0,25 mg/mL e 0,5 mg/mL (ampolas de 1 mL)

Colírio oftálmico 0,5% e 1%

Indicações e Linha de Tratamento

Antagonista colinérgico muscarínico potente. Primeira linha na bradicardia sintomática de origem vagal/hipóxica com resposta hemodinâmica insuficiente, pré-medicação em intubação para prevenir bradicardia reflexa (especialmente com succinilcolina em < 1 ano) e antídoto para intoxicação por organofosforados e carbamatos.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Bradicardia Sintomática / PALS (IV/IO)	0,02 mg/kg (Dose mínima absoluta: 0,1 mg para evitar bradicardia paradoxal; Máx dose única: 0,5 mg em crianças e 1,0 mg em adolescentes).	Pode repetir uma vez em 3 a 5 minutos (Dose cumulativa máxima: 1 mg criança, 2 mg adolescente).
Intoxicação por Organofosforados (IV/IO)	0,05 a 0,1 mg/kg em bolus a cada 10 a 15 minutos até atropinização plena (ressecamento das secreções pulmonares).	Dose sem teto máximo pré-fixado; titular por sinais clínicos.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Glaucoma de ângulo fechado, uropatia obstrutiva e íleo paralítico (exceto em intoxicações colinérgicas graves onde é salvadora de vidas).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

42. Azatioprina

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos 50 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Imunossupressor análogo de purina (pró-fármaco da 6-mercaptopurina). Indicado na manutenção de remissão em Doenças Inflamatórias Intestinais (Doença de Crohn e Retocolite Ulcerativa), Lúpus Eritematoso Sistêmico, Hepatite Autoimune e prevenção de rejeição em transplantes de órgãos sólidos.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Doença Inflamatória Intestinal / Autoimunidades (VO)	Inicial: 1 mg/kg/dia por 2 semanas. Titular até dose alvo de 2 a 2,5 mg/kg/dia.	Dose única diária após as refeições. Avaliar atividade enzimática da TPMT antes do início para prevenir mielotoxicidade grave.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Mielossupressão grave prévia, deficiência homozigótica de tiopurina metiltransferase (TPMT) ou NUDT15, gravidez e infecções bacterianas/fúngicas ativas graves.

Monitorização: Hemograma completo e transaminases a cada 2 semanas nos primeiros meses.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

43. Azitromicina

Auditoria documental	Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática
----------------------	--

Apresentações Disponíveis

Pó para suspensão oral 200 mg/5 mL (frascos 600 mg, 900 mg e 1500 mg)

Comprimidos 500 mg

Pó liofilizado para solução injetável frasco-ampola 500 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Antimicrobiano macrolídeo azalida. Primeira linha no tratamento de Pneumonia Adquirida na Comunidade por bactérias atípicas (*Mycoplasma pneumoniae*, *Chlamydia pneumoniae*) em crianças > 5 anos, Coqueluche (*Bordetella pertussis*), diarreia invasiva por *Campylobacter* e alternativa para alérgicos a beta-lactâmicos.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Pneumonia Atípica / Infecções Respiratórias (VO)	10 mg/kg no dia 1 (Máx: 500 mg), seguido de 5 mg/kg/dia (Máx: 250 mg/dia) do dia 2 ao dia 5 (Esquema de 5 dias). Alternativa: 10 mg/kg/dia por 3 dias.	Dose única diária
Coqueluche — Tratamento e Profilaxia (VO)	Lactentes < 6 meses: 10 mg/kg/dia por 5 dias. Crianças ≥ 6 meses: 10 mg/kg no dia 1, seguido de 5 mg/kg/dia por mais 4 dias.	Dose única diária
Faringoamigdalite em Alérgicos a Penicilina (VO)	12 mg/kg/dia uma vez ao dia por 5 dias (Máx: 500 mg/dia)	Dose única diária

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipersensibilidade a macrolídeos, disfunção hepática grave e histórico de icterícia colestática.

Alertas: Risco de prolongamento do intervalo QTc e arritmias ventriculares (Torsades de pointes); estenose hipertrófica do piloro em neonatos expostos nos primeiros 14 dias de vida.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

44. Aztreonam

Auditoria documental	Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática
----------------------	--

Apresentações Disponíveis

Pó para solução injetável frasco-ampola 1 g

Indicações e Linha de Tratamento

Monobactâmico bactericida com atividade exclusiva contra bacilos Gram-negativos aeróbios, incluindo *Pseudomonas aeruginosa* e enterobactérias. Indicado em infecções graves em pacientes com histórico de anafilaxia grave a penicilinas e cefalosporinas (sem reação alérgica cruzada, exceto ceftazidima).

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Infecções Pediátricas Moderadas a Graves (IV/IM)	90 a 120 mg/kg/dia	Dividido a cada 6 a 8 horas (Máx: 6 a 8 g/dia)
Fibrose Cística com Pseudomonas / Sepse Grave (IV)	150 a 200 mg/kg/dia	Dividido a cada 6 horas em infusão de 30 a 60 min (Máx: 8 g/dia)

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipersensibilidade ao aztreonam ou reação alérgica prévia à ceftazidima (compartilham cadeia lateral idêntica).

Espectro: Não possui atividade contra bactérias Gram-positivas e anaeróbios.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

45. Azul de metileno

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável 1% (10 mg/mL, ampola 5 mL = 50 mg)

Indicações e Linha de Tratamento

Agente redutor de hemoglobina oxidada e inibidor da óxido nítrico sintase. Antídoto de primeira linha para metemoglobinemia adquirida grave (induzida por dapsona, anestésicos locais como prilocaína/benzocaína, nitritos) com níveis de metemoglobina > 20-30% ou sintomas de hipóxia tecidual.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Metemoglobinemia Tóxica (IV)	1 a 2 mg/kg (0,1 a 0,2 mL/kg da solução a 1%) infundido lentamente em 5 a 10 minutos diluído em SG5%.	Pode repetir dose de 1 mg/kg em 60 minutos se sintomas e cianose persistirem (Dose cumulativa máxima: 7 mg/kg).

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições Absolutas: Contraindicado em pacientes com deficiência de Glicose-6-Fosfato Desidrogenase (G6PD), pois a droga pode precipitar crise hemolítica maciça e não atua por falta de NADPH.

Interações: Risco de Síndrome Serotoninérgica grave quando administrado a pacientes em uso de inibidores da recaptação de serotonina (age como potente inibidor da MAO-A).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

46. Baclofeno

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos 10 mg e 25 mg

Solução intratecal 0,05 mg/mL e 0,5 mg/mL (uso hospitalar/bomba de infusão)

Indicações e Linha de Tratamento

Agonista dos receptores GABA-B na medula espinhal, promovendo relaxamento muscular por inibição reflexa monossináptica e polissináptica. Indicado no controle da espasticidade muscular grave de origem cerebral ou medular (paralisia cerebral, traumatismo raquimedular).

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Espasticidade na Paralisia Cerebral (VO)	Crianças ≥ 2 anos: Inicial 0,3 a 0,75 mg/kg/dia dividido a cada 8h. Titular a cada 3 dias até dose média de 1 a 2 mg/kg/dia (Máx: 40 mg/dia em < 8 anos e 60 a 80 mg/dia em > 8 anos).	Dividido a cada 8 horas com alimentos

Contraindicações, restrições e monitorização

Idade: Não recomendado para menores de 2 anos de idade.

Alerta de Descontinuação: A interrupção abrupta pode desencadear crise de abstinência com hipertermia maligna-símile, rebote espástico grave, convulsões e óbito. O desmame deve ser extremamente gradual.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

47. Beclometasona (dipropionato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Spray nasal aquoso 50 mcg/dose
Aerossol inalatório oral pressurizado (spray) 50 mcg, 200 mcg e 250 mcg/dose
Cápsulas com pó inalatório 200 mcg e 400 mcg
Suspensão para nebulização 400 mcg/mL e 800 mcg/2 mL

Indicações e Linha de Tratamento

Corticoide inalatório tópico potente. Primeira linha de tratamento profilático e de controle da Asma Persistente em pediatria e Rinite Alérgica moderada a grave.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Asma Persistente — Spray com Espaçador (Inalatória Oral)	Dose Baixa: 100 a 200 mcg/dia. Dose Média: 200 a 400 mcg/dia. Dose Alta: > 400 mcg/dia.	Dividido a cada 12 horas (sempre com espaçador valvulado e máscara/bocal). Enxaguar a boca após o uso.
Rinite Alérgica (Spray Nasal)	Crianças ≥ 4 anos: 1 a 2 jatos (50 a 100 mcg) em cada narina uma vez ao dia (ou dividido a cada 12h).	Uso contínuo diário pela manhã

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipersensibilidade à beclometasona; tuberculose pulmonar ativa não tratada.
Efeitos Locais: Risco de candidíase oral (monilíase) e disfonia, prevenidos com uso de espaçador e higiene oral/bochecho pós-uso.
Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

48. Benzilpenicilina benzatina

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Suspensão injetável frasco-ampola 600.000 UI e 1.200.000 UI (via IM exclusiva)

Indicações e Linha de Tratamento

Penicilina de depósito de ação prolongada. Primeira linha de escolha para tratamento de Faringoamigdalite estreptocócica aguda por Streptococcus pyogenes (profilaxia primária da febre reumática), profilaxia secundária da Febre Reumática e tratamento da Sífilis adquirida/congênita tardia.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Faringoamigdalite Estreptocócica / Profilaxia Primária (IM)	Peso < 27 kg: 600.000 UI em dose única. Peso ≥ 27 kg: 1.200.000 UI em dose única.	Aplicação intramuscular profunda no glúteo ou vasto lateral.
Profilaxia Secundária da Febre Reumática (IM)	Peso < 27 kg: 600.000 UI a cada 21 dias. Peso ≥ 27 kg: 1.200.000 UI a cada 21 dias.	Manter por anos conforme critérios de acometimento cardíaco.
Sífilis Adquirida Precoce (IM)	50.000 UI/kg em dose única (Máx: 2.400.000 UI)	Dose única IM

Contraindicações, restrições e monitorização

Via de Administração: ESTRITAMENTE CONTRAINDICADA VIA INTRAVENOSA OU INTRA-ARTERIAL (risco fatal de embolia pulmonar, oclusão vascular, necrose tecidual e parada cardíaca).
Condições: Alergia grave conhecida a penicilinas.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

49. Benzilpenicilina potássica (cristalina)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó para solução injetável frasco-ampola 5.000.000 UI e 10.000.000 UI (via IV)

Indicações e Linha de Tratamento

Penicilina natural aquosa de ação rápida para uso endovenoso. Primeira linha para Neurosífilis e Sífilis Congênita neonatal, Meningite bacteriana por *Streptococcus pneumoniae* ou *Neisseria meningitidis* sensíveis, Endocardite bacteriana e pneumonia pneumocócica grave.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Sífilis Congênita / Neurosífilis Neonatal (IV)	Neonato ≤ 7 dias: 50.000 UI/kg/dose a cada 12h (100.000 UI/kg/dia). Neonato > 7 dias: 50.000 UI/kg/dose a cada 8h (150.000 UI/kg/dia). Lactentes > 28 dias: 200.000 a 300.000 UI/kg/dia a cada 6h.	Duração estrita de 10 a 14 dias em infusão lenta de 30 min.
Pneumonia Grave / Infecção Sistêmica (IV)	100.000 a 250.000 UI/kg/dia	Dividido a cada 4 a 6 horas (Máx: 24.000.000 UI/dia)
Meningite Bacteriana (IV)	300.000 a 400.000 UI/kg/dia	Dividido a cada 4 horas (Máx: 24.000.000 UI/dia)

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipersensibilidade a penicilinas.

Eletrólitos: Cada 1.000.000 UI contém aproximadamente 1,7 mEq de potássio; risco de hipercalemia e arritmias cardíacas em infusão rápida ou pacientes com insuficiência renal.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

50. Benzilpenicilina procaína + Benzilpenicilina potássica

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó para suspensão injetável 300.000 UI + 100.000 UI (400.000 UI, via IM)

Indicações e Linha de Tratamento

Penicilina de ação intermediária por via intramuscular. Indicada em infecções respiratórias comunitárias moderadas não complicadas (pneumonia, erisipela) e como alternativa no tratamento da sífilis congênita sem acometimento liquorico comprovado.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Infecções Respiratórias / Erisipela (IM)	25.000 a 50.000 UI/kg/dia	Dividido a cada 12 a 24 horas por 7 a 10 dias (Máx: 1.200.000 UI/dia)
Sífilis Congênita — Esquema Alternativo (IM)	50.000 UI/kg/dose uma vez ao dia	Por 10 dias consecutivos

Contraindicações, restrições e monitorização

Via: ESTRITAMENTE CONTRAINDICADA VIA INTRAVENOSA.

Condições: Alergia a penicilinas ou anestésicos do tipo procaína/éster.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

51. Benznidazol

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos 12,5 mg pediátrico e 100 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Antiparasitário nitroimidazólico. Primeira linha no tratamento da Doença de Chagas aguda e congênita, fase crônica recente em crianças e reativação em imunodeprimidos.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Doença de Chagas Congênita / Aguda (VO)	5 a 10 mg/kg/dia (Dose padrão: 5 a 7,5 mg/kg/dia)	Dividido em 2 tomadas (a cada 12 horas) após as refeições por 60 dias consecutivos.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Insuficiência hepática ou renal grave, gravidez.

Efeitos: Monitorar dermatite/rash alérgico, neutropenia, trombocitopenia e neuropatia periférica.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

52. Benzoato de benzila

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Emulsão tópica/loção 250 mg/mL (25%) e sabonete

Indicações e Linha de Tratamento

Ectoparasiticida e escabicida tópico. Indicado no tratamento de escabiose (sarna) e pediculose (piolho).

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Escabiose Pediátrica (Tópico)	Aplicar no corpo do pescoço para baixo à noite após banho morno, deixando agir por 8 a 12 horas e lavando pela manhã. Repetir por 2 a 3 noites consecutivas e após 7 dias.	Em crianças pequenas, diluir a emulsão em água a 50% (1:1) ou 25% (1:3) para evitar dermatite irritativa intensa.

Contraindicações, restrições e monitorização

Idade: Contraindicado em neonatos e prematuros pelo risco de toxicidade sistêmica e Síndrome de Gasping.

Condições: Pele extensamente escoriada, inflamada ou eczematosa.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

53. Beractanto (Surfactante pulmonar bovino)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Suspensão intratraqueal 25 mg/mL (frascos de 4 mL = 100 mg e 8 mL = 200 mg de fosfolipídios)

Indicações e Linha de Tratamento

Surfactante pulmonar exógeno natural de origem bovina modificado. Indicado na prevenção e tratamento de resgate da Síndrome do Desconforto Respiratório (SDR / Doença da Membrana Hialina) em prematuros.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
SDR Neonatal / Membrana Hialina (Intratraqueal)	100 mg de fosfolipídios/kg (4 mL/kg)	Instilação intratraqueal direta em cânula orotraqueal em 4 alíquotas ou técnica LISA/MIST. Pode repetir a cada 6 a 12 horas se FiO ₂ > 0,30-0,40 (Máx: 4 doses em 48h).

Contraindicações, restrições e monitorização

Precauções: Risco de dessaturação transitória, bradicardia reflexa e obstrução aguda de cânula durante a administração.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

54. Betametasona (dipropionato / valerato / fosfato dissódico)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Gotas 0,5 mg/mL

Elixir 0,1 mg/mL

Comprimidos 0,5 mg e 2 mg

Solução injetável 4 mg/mL e 5,3 mg/mL

Creme/pomada tópica 1 mg/g (0,1%)

Indicações e Linha de Tratamento

Glicocorticoide de alta potência e longa duração de ação (sem efeito mineralocorticoide). Indicado no controle de dermatoses inflamatórias graves responsivas a corticoide (tópico) e anti-inflamatório/imunossupressor sistêmico em crises alérgicas agudas.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Anti-inflamatório Sistêmico Pediátrico (VO/IV/IM)	0,017 a 0,25 mg/kg/dia (ou 0,5 a 7,5 mg/m ² /dia)	Dividido a cada 6 a 12 horas
Dermatoses Inflamatórias (Tópico)	Aplicar fina camada sobre a lesão 1 a 2 vezes ao dia	Uso restrito a áreas limitadas e por períodos curtos (< 1 a 2 semanas); evitar face e dobras.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Infecções fúngicas sistêmicas, vacinação recente com vírus vivos atenuados.

Tópico: Contraindicado em lesões herpéticas, rosácea, dermatite perioral e áreas fraldas (risco de atrofia cutânea e absorção sistêmica com supressão do eixo HPA).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

55. Bicarbonato de sódio

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável 8,4% (1 mEq/mL, ampolas 10 mL e frascos 250 mL)

Solução injetável 10%

Pó para solução oral

Indicações e Linha de Tratamento

Agente alcalinizante sistêmico e urinário. Indicado no tratamento de acidose metabólica grave refratária com pH < 7,10 e bicarbonato < 8 mEq/L, hipercalemia com instabilidade miocárdica, acidose tubular renal proximal/distal e intoxicação por antidepressivos tricíclicos (alcalinização sérica).

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Acidose Metabólica Grave com pH < 7,10 (IV)	Fórmula de correção: Deficit de HCO ₃ = Peso (kg) x 0,3 x (15 - HCO ₃ atual). Corrigir metade do deficit em 2 a 4 horas em solução isotônica (diluir para ≤ 4,2% = 0,5 mEq/mL em água destilada ou SG5%).	Infusão intravenosa lenta em bomba. Não administrar em bólus rápido.
Intoxicação por Antidepressivos Tricíclicos (IV)	1 a 2 mEq/kg em bolus lento em 2 a 5 minutos, seguido de infusão contínua para manter pH sérico entre 7,45 e 7,55.	Monitorar QRS e ECG continuamente.
Acidose Tubular Renal (VO)	ATR Tipo 1: 2 a 4 mEq/kg/dia. ATR Tipo 2: 5 a 15 mEq/kg/dia.	Dividido em 3 a 4 tomadas diárias

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Alcalose metabólica ou respiratória, hipocalcemia não corrigida (risco de tetania aguda), hipernatremia severa.

Alerta Neonatal: Em neonatos, sempre diluir a 4,2% (0,5 mEq/mL) para evitar hiperosmolaridade súbita e hemorragia intraventricular.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

56. Bilastina

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução oral 2,5 mg/mL

Comprimidos orodispersíveis 10 mg

Comprimidos 20 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Anti-histamínico de segunda geração não sedativo, altamente seletivo para receptores H1 periféricos. Indicado no tratamento sintomático da rinite alérgica (intermitente e persistente) e urticária crônica espontânea em crianças ≥ 2 anos.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Rinite Alérgica / Urticária — 2 a 11 anos (peso < 30 kg) (VO)	10 mg (4 mL da solução oral ou 1 comprimido orodispersível de 10 mg) uma vez ao dia	Administrar 1 hora antes ou 2 horas após a ingestão de alimentos ou sucos de frutas.
Crianças ≥ 12 anos e Peso ≥ 30 kg (VO)	20 mg (1 comprimido de 20 mg) uma vez ao dia	Tomar em jejum

Contraindicações, restrições e monitorização

Idade: Não aprovado para menores de 2 anos de idade.

Interação Alimentar: Sucos de frutas (especialmente toranja e maçã) reduzem expressivamente a biodisponibilidade por inibição do OATP1A2.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

57. Bimatoprost

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução oftálmica/colírio 0,01% e 0,03%

Indicações e Linha de Tratamento

Análogo sintético da prostaglandina F2-alfa (prostamida). Indicado na redução da pressão intraocular no glaucoma congênito e pediátrico refratário ou hipertensão ocular sob prescrição de oftalmologista pediátrico.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Glaucoma Pediátrico / Hipertensão Ocular (Oftálmico)	1 gota no olho afetado uma vez ao dia, preferencialmente à noite	Oclusão do ponto lacrimal por 1 a 2 minutos após a instilação para minimizar absorção sistêmica.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Uveíte ativa, edema macular cistoide, hipersensibilidade à bimatoprost.

Efeitos: Pigmentação irreversível da íris e aumento do comprimento/densidade dos cílios.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

58. Biperideno (cloridrato / lactato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos 2 mg e 4 mg (liberação prolongada)

Solução injetável 5 mg/mL (ampola 1 mL)

Indicações e Linha de Tratamento

Anticolinérgico de ação central. Primeira linha no tratamento e reversão de reações extrapiramidais agudas e crises oculógiras induzidas por antipsicóticos ou antieméticos antidopaminérgicos (metoclopramida, bromoprida, haloperidol).

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Reação Distônica Aguda / Crise Oculógira (IV/IM)	0,04 a 0,1 mg/kg/dose (Máx: 2 a 5 mg/dose)	Injeção IV lenta em 2 a 3 minutos ou IM profunda. Pode repetir após 30 minutos se necessário.
Manutenção / Prevenção de Recorrência (VO)	0,05 a 0,1 mg/kg/dia (Máx: 2 a 4 mg/dia)	Dividido a cada 8 a 12 horas por 24 a 48 horas

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Glaucoma de ângulo fechado, obstrução intestinal mecânica, megacólon e miastenia gravis.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

59. Bisacodil

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Gotas 7,5 mg/mL

Comprimidos revestidos 5 mg

Supositórios pediátricos 5 mg e adultos 10 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Laxativo estimulante por contato da mucosa colônica (derivado difenilmetano). Indicado no alívio de curto prazo da constipação intestinal severa, desimpactação fecal e preparo intestinal para exames endoscópicos ou cirurgias.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Constipação / Desimpactação — 2 a 10 anos (VO)	5 mg (ou 5 a 10 gotas) uma vez ao dia ao deitar	Ação esperada em 6 a 12 horas. Ingerir sem mastigar; não tomar com leite ou antiácidos.
Crianças > 10 anos e Adolescentes (VO)	5 a 10 mg uma vez ao dia ao deitar	Dose única diária
Via Retal — Supositório (Retal)	Crianças < 2 anos: 2,5 mg. 2 a 10 anos: 5 mg. > 10 anos: 10 mg.	Efeito rápido em 15 a 60 minutos.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Abdome agudo cirúrgico, apendicite, obstrução intestinal mecânica, dor abdominal de causa indeterminada e desidratação grave.

Uso Crônico: Contraindicado o uso contínuo prolongado pelo risco de dependência e distúrbios hidroeletrólíticos.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

60. Bosentana

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos dispersíveis 32 mg

Comprimidos revestidos 62,5 mg e 125 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Antagonista duplo dos receptores de endotelina (ETA e ETB). Indicado no tratamento da Hipertensão Arterial Pulmonar (HAP) idiopática, familiar ou associada a cardiopatias congênitas (Síndrome de Eisenmenger) em crianças ≥ 1 ano.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Hipertensão Arterial Pulmonar (VO)	Peso 10 a 20 kg: Inicial 16 mg a cada 12h por 4 semanas, depois 32 mg a cada 12h. Peso 20 a 40 kg: Inicial 32 mg a cada 12h, depois 62,5 mg a cada 12h. Peso > 40 kg: Inicial 62,5 mg a cada 12h, depois 125 mg a cada 12h.	Administrado pela manhã e à noite, com ou sem alimentos.

Contraindicações, restrições e monitorização

Hepatotoxicidade: Black box warning para elevação de transaminases; dosagem mensal de ALT/AST obrigatória.

Condições: Insuficiência hepática moderada a grave, gravidez e uso concomitante de ciclosporina A ou glibenclamida.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

61. Brimonidina (tartarato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução oftálmica/colírio 0,15% e 0,2%

Indicações e Linha de Tratamento

Agonista seletivo dos receptores alfa-2 adrenérgicos. Utilizado na redução da pressão intraocular no glaucoma pediátrico refratário em crianças maiores de 2 anos sob rigoroso controle oftalmológico.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Glaucoma Pediátrico em Crianças Maiores (Oftálmico)	1 gota no olho afetado 2 a 3 vezes ao dia (a cada 8 a 12 horas)	Ocluir o ponto lacrimal imediatamente após instilação para evitar absorção sistêmica.

Contraindicações, restrições e monitorização

Idade: ESTRITAMENTE CONTRAINDICADO EM NEONATOS E CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS devido ao risco fatal de depressão do SNC, sonolência profunda, hipotensão severa, bradicardia, hipotermia e apneia central por absorção sistêmica.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

62. Brometo de ipratrópio

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução para inalação/nebulização 0,25 mg/mL (0,02 mg/gota)

Aerossol inalatório pressurizado (spray) 20 mcg/puff

Spray nasal 0,03%

Indicações e Linha de Tratamento

Anticolinérgico inalatório de curta ação (antagonista muscarínico SAMA). Primeira linha em associação com beta-2 agonistas nas primeiras horas da crise asmática aguda moderada a grave e broncoespasmo refratário na emergência pediátrica.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Crise Asmática Aguda na Emergência — Nebulização (Inalatória)	Crianças < 20 kg: 0,25 mg (1 mL = 20 a 25 gotas). Crianças ≥ 20 kg: 0,5 mg (2 mL = 40 a 50 gotas).	Associado a salbutamol/fenoterol a cada 20 a 30 minutos na primeira hora (até 3 doses) e depois a cada 4 a 6 horas.
Crise Asmática — Spray com Espaçador (Inalatória)	4 a 8 jatos (80 a 160 mcg) com espaçador valvulado a cada 20 minutos na primeira hora.	Sempre em associação com SABA
Rinorreia na Rinite Alérgica (Spray Nasal)	Crianças ≥ 6 anos: 2 jatos em cada narina 2 a 3 vezes ao dia	Uso sintomático

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipersensibilidade a derivados da atropina ou ao ipratrópio.

Cuidados: Proteger os olhos durante a nebulização com máscara adequada para evitar contato ocular direto (risco de midríase transitória e visão turva).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

63. Brometo de pancurônio

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável 2 mg/mL (ampola 2 mL = 4 mg)

Indicações e Linha de Tratamento

Bloqueador neuromuscular não despolarizante do grupo aminoesteróide de longa duração. Indicado para relaxamento muscular prolongado em cirurgias de grande porte e pacientes em ventilação mecânica em UTI.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Intubação e Relaxamento Cirúrgico (IV)	0,06 a 0,1 mg/kg em bolus IV	Início de ação em 2 a 4 minutos; duração de 60 a 100 minutos.
Manutenção (IV)	0,01 a 0,02 mg/kg a cada 40 a 60 minutos conforme monitorização TOF	Bolus intermitente

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Taquicardia importante (efeito vagolítico intrínseco), insuficiência renal grave (excreção predominantemente renal) e ausência de via aérea garantida.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

64. Brometo de rocurônio

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável 10 mg/mL (frasco-ampola 5 mL = 50 mg)

Indicações e Linha de Tratamento

Bloqueador neuromuscular não despolarizante aminoesteróide de início de ação rápido. Primeira escolha para Sequência Rápida de Intubação (SRI) em emergência e UTI pediátrica quando a succinilcolina é contraindicada, além de relaxamento cirúrgico.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Sequência Rápida de Intubação (SRI) (IV)	0,9 a 1,2 mg/kg em bolus IV rápido	Condições ideais de intubação em 45 a 60 segundos; duração clínica de 30 a 60 minutos.
Intubação Eletiva / Procedimento (IV)	0,6 mg/kg em bolus IV	Início em 60 a 90 segundos; duração de 30 a 40 minutos.
Manutenção / Infusão Contínua em UTI (IV)	Bolus: 0,15 mg/kg. Infusão: 5 a 12 mcg/kg/min (0,3 a 0,7 mg/kg/h).	Titular com monitor de bloqueio neuromuscular (TOF).

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipersensibilidade a agentes bloqueadores neuromusculares.

Reversão Específica: Pode ser revertido imediata e completamente com Sugamadex.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

65. Brometo de tiotrópio

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução para inalação em névoa fina Respimat 2,5 mcg/puff

Cápsulas com pó para inalação 18 mcg

Indicações e Linha de Tratamento

Anticolinérgico inalatório de longa ação (antagonista muscarínico LAMA). Indicado como terapia adjuvante de manutenção em crianças ≥ 6 anos com Asma Grave não controlada em uso de dose moderada a alta de corticoide inalatório associado a LABA (Etapa 4 e 5 do GINA).

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Asma Grave Refratária (≥ 6 anos) (Inalatória)	5 mcg (2 jatos de 2,5 mcg do dispositivo Respimat) uma vez ao dia no mesmo horário	Uso contínuo de manutenção; não é medicação de resgate para broncoespasmo agudo.

Contraindicações, restrições e monitorização

Idade: Não indicado para menores de 6 anos de idade na asma.

Condições: Hipersensibilidade ao tiotrópio ou atropina; cautela em glaucoma de ângulo fechado e retenção urinária.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

66. Brometo de vecurônio

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó liofilizado para solução injetável 4 mg e 10 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Bloqueador neuromuscular não despolarizante aminoesteróide de duração intermediária com estabilidade cardiovascular (sem liberação de histamina ou efeito vagolítico). Indicado para intubação e relaxamento muscular cirúrgico/UTI.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Intubação Orotraqueal (IV)	0,08 a 0,1 mg/kg em bolus IV	Início em 2 a 3 minutos; duração de 30 a 45 minutos.
Infusão Contínua em UTI (IV)	Carga: 0,1 mg/kg. Manutenção: 1 a 2 mcg/kg/min (0,06 a 0,12 mg/kg/h).	Titular por TOF.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipersensibilidade a esteróides neuromusculares.

Mandatário: Sedação e analgesia profundas e via aérea protegida.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

67. Bromoprida

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Gotas 4 mg/mL (1 gota = 0,17 mg)

Solução oral 1 mg/mL

Cápsulas 10 mg

Solução injetável 5 mg/mL (ampola 2 mL = 10 mg)

Indicações e Linha de Tratamento

Antiemético e pró-cinético gastrointestinal benzamídico (antagonista dopaminérgico D2). Indicado no alívio de náuseas, vômitos e distúrbios da motilidade gastrointestinal em crianças.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Náuseas e Vômitos — Pediátrico (VO)	0,5 a 1 mg/kg/dia dividido em 3 tomadas diárias (Dose por tomada: 0,15 a 0,3 mg/kg ou 1 a 2 gotas/kg)	Administrado 15 a 30 minutos antes das refeições (a cada 8 horas).
Via Parenteral (IV/IM)	0,15 a 0,3 mg/kg/dose a cada 8 horas (Máx: 10 mg/dose)	Injeção IV lenta em pelo menos 2 a 3 minutos.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Obstrução mecânica, perfuração gastrointestinal, hemorragia digestiva e feocromocitoma.

Risco Extrapiramidal: Risco de distonias agudas e espasmos musculares cervicais/faciais, especialmente em lactentes.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

68. Budesonida

Auditoria documental Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Suspensão para nebulização 0,25 mg/mL e 0,5 mg/mL (flaconetes 2 mL)

Spray nasal aquoso 32 mcg, 50 mcg, 64 mcg e 100 mcg/dose

Pó inalatório em cápsulas ou Turbuhaler 100 mcg, 200 mcg e 400 mcg/dose

Cápsulas de liberação ileal 3 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Corticoide inalatório tópico potente com alta depuração hepática de primeira passagem. Primeira linha no controle da Asma Persistente, tratamento de resgate no Crupe viral (laringite estridulosa) na emergência e controle da Rinite Alérgica.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Crupe Viral / Laringite Estridulosa — Emergência (Nebulização)	2 mg (4 mL da suspensão de 0,5 mg/mL) em dose única (inalação com O2 em fluxo 6-8 L/min)	Alternativa eficaz e equivalente à dexametasona oral.
Asma Persistente — Nebulização em Lactentes/< 4 anos (Inalatória)	Dose Baixa: 0,25 a 0,5 mg/dia. Dose Alta: 1 mg/dia.	Dividido a cada 12 ou 24 horas. Lavar a face e enxaguar a boca após a nebulização.
Asma Persistente — Turbuhaler/Pó em Crianças ≥ 4 anos (Inalatória)	Dose Baixa: 100 a 200 mcg/dia. Dose Média: 200 a 400 mcg/dia. Dose Alta: > 400 mcg/dia.	Dividido a cada 12 horas
Rinite Alérgica (Spray Nasal)	Crianças ≥ 2 anos: 32 a 64 mcg em cada narina 1 vez ao dia (Máx: 128 mcg/dia)	Dose única matinal

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipersensibilidade à budesonida.

Efeitos: Candidíase oral e disfonia em uso inalatório crônico (prevenidos com enxágue oral).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

69. Bupivacaína (cloridrato)

Auditoria documental Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável 0,25%, 0,5% sem vasoconstritor e 0,5% pesada (com glicose)

Indicações e Linha de Tratamento

Anestésico local do grupo amida de longa duração. Indicado para bloqueios anestésicos loco-regionais (bloqueio caudal, peridural, raquianestesia, bloqueios de nervos periféricos e infiltração de ferida cirúrgica) em analgesia pós-operatória pediátrica.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Bloqueio Caudal / Peridural Pediátrico (Infiltrativo/Bloqueio)	Solução a 0,125% a 0,25%: 0,5 a 1 mL/kg (Máx: 2 a 2,5 mg/kg sem epinefrina).	Administração por anestesiológista com aspiração prévia negativa obrigatória.
Infiltração Local de Ferida (Infiltrativo)	Solução a 0,25%: Máximo de 2 mg/kg	Dose única transoperatória

Contraindicações, restrições e monitorização

Cardiotoxicidade: Black box warning para parada cardíaca refratária e colapso cardiovascular em caso de injeção intravascular inadvertida (LAST - Local Anesthetic Systemic Toxicity). Ter emulsão lipídica a 20% disponível para resgate.

Vias: Contraindicada anestesia regional intravenosa (bloqueio de Bier).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

70. Bupropiona (cloridrato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos de liberação prolongada 150 mg e 300 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Inibidor da recaptção de noradrenalina e dopamina (IRND). Indicado em psiquiatria infantojuvenil como segunda linha no Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) em adolescentes e no tratamento de episódios depressivos maiores.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
TDAH / Depressão em Adolescentes > 12 anos (VO)	Inicial: 150 mg uma vez ao dia pela manhã. Pode titular após 2 a 4 semanas para 300 mg/dia (em 1 ou 2 tomadas).	Engolir inteiro sem mastigar ou partir.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Transtornos convulsivos prévios, diagnóstico atual ou prévio de bulimia ou anorexia nervosa (aumento acentuado do risco de convulsões), abstinência abrupta de álcool/sedativos e uso concomitante de IMAO.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

71. Cafeína (Citrato de cafeína)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução oral 20 mg/mL (equivalente a 10 mg/mL de cafeína base)

Solução injetável 20 mg/mL (ampolas 1 mL e 2 mL)

Indicações e Linha de Tratamento

Metilxantina estimulante do centro respiratório bulbar. Primeira linha padrão-ouro absoluta na prevenção e tratamento da Apneia da Prematuridade em recém-nascidos prematuros (< 34 semanas).

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Apneia da Prematuridade — Doses em Citrato de Cafeína (IV/VO)	Dose de Ataque: 20 mg/kg (equivalente a 10 mg/kg de cafeína base) em infusão IV lenta de 30 minutos.	Dose de Manutenção: 5 a 10 mg/kg/dia (2,5 a 5 mg/kg/dia de base) em dose única diária (iniciar 24h após a carga).

Contraindicações, restrições e monitorização

Atenção às Unidades: Risco gravíssimo de superdosagem fatal se confundir a dose de citrato de cafeína com cafeína base (1 mg de cafeína base = 2 mg de citrato de cafeína).

Monitorização: Taquicardia sinusal, refluxo gastroesofágico, irritabilidade e hiperglicemia.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

72. Calcipotriol

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pomada dermatológica 50 mcg/g (0,005%) e loção tópica

Indicações e Linha de Tratamento

Análogo sintético da vitamina D3. Indicado no tratamento tópico da psoríase em placas leve a moderada em crianças ≥ 6 anos e adolescentes.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Psoríase em Placas (Tópico)	Crianças de 6 a 12 anos: Aplicar fina camada 1 a 2 vezes ao dia (Máx: 50 g de pomada por semana). Crianças > 12 anos: Aplicar 1 a 2 vezes ao dia (Máx: 75 g a 100 g por semana).	Não aplicar na face ou áreas de dobras flexurais.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Distúrbios do metabolismo do cálcio, hipercalcemia e toxicidade por vitamina D.

Monitorização: Risco de hipercalcemia e hipercalcúria se exceder a dose semanal máxima.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

73. Calcitonina sintética de salmão

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Spray nasal 200 UI/dose

Solução injetável 100 UI/mL

Indicações e Linha de Tratamento

Hormônio polipeptídico inibidor da reabsorção óssea osteoclástica. Indicada no manejo agudo da hipercalcemia grave refratária e suporte na osteogênese imperfeita em pediatria sob orientação especializada.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Hipercalcemia Grave (SC/IM)	4 a 8 UI/kg a cada 12 horas	Início de ação em 2 horas; efeito rápido mas sujeito a taquifilaxia em 48 a 72 horas.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipersensibilidade a proteínas de salmão (risco de anafilaxia; teste cutâneo prévio recomendado na via parenteral), hipocalcemia.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

74. Calcitriol (1,25-di-hidroxivitamina D3)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Cápsulas gelatinosas 0,25 mcg

Solução injetável 1 mcg/mL

Indicações e Linha de Tratamento

Forma hormonal biologicamente ativa da vitamina D. Indicada no hipoparatiroidismo congênito/adquirido, raquitismo dependente de vitamina D, osteodistrofia renal e controle do hiperparatiroidismo secundário na DRC pediátrica.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Hipoparatiroidismo / Raquitismo Dependente (VO)	Inicial: 0,01 a 0,05 mcg/kg/dia (ou 0,25 mcg/dia). Titular a cada 2 a 4 semanas conforme cálcio, fósforo e PTH.	Dose única diária ou a cada 12 horas
Osteodistrofia Renal na DRC (VO)	0,01 a 0,02 mcg/kg/dia	Dose diária ou intermitente (pulsos) conforme estadiamento renal

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipercalcemia, toxicidade por vitamina D e evidência de calcificação vascular metastática.

Monitorização: Monitorar cálcio sérico e urinário quinzenalmente durante a titulação.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

75. Canabidiol (CBD)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução oral/gotas 20 mg/mL, 50 mg/mL, 100 mg/mL, 150 mg/mL e 200 mg/mL (fórmulas padronizadas com pureza > 98% e THC < 0,2%)

Indicações e Linha de Tratamento

Canabinoide não psicotrópico modulador de excitabilidade neuronal. Indicado como terapia adjuvante em encefalopatias epilépticas graves refratárias da infância: Síndrome de Dravet, Síndrome de Lennox-Gastaut e Complexo da Esclerose Tuberosa em crianças ≥ 2 anos.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Síndrome de Dravet / Lennox-Gastaut (VO)	Inicial: 2,5 a 5 mg/kg/dia dividido a cada 12h. Aumentar semanalmente em 2,5 a 5 mg/kg/dia até dose de manutenção de 10 a 20 mg/kg/dia.	Dividido a cada 12 horas com alimentos gordurosos para aumentar a biodisponibilidade.

Contraindicações, restrições e monitorização

Hepatotoxicidade: Elevação de transaminases dose-dependente, potencializada acentuadamente pelo uso concomitante de valproato de sódio.

Monitorização: Transaminases basais, aos 1, 3 e 6 meses de tratamento; monitorar sonolência se associado a clobazam.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

76. Captopril

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos 12,5 mg, 25 mg e 50 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Inibidor da Enzima Conversora de Angiotensina (IECA) de curta duração. Indicado na insuficiência cardíaca congestiva pediátrica (com shunt esquerda-direita) e emergências/urgências hipertensivas em nefrologia e UTI pediátrica.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Insuficiência Cardíaca / Hipertensão Neonatal (VO)	Neonato: 0,01 a 0,05 mg/kg/dose a cada 8 a 12 horas (iniciar muito baixo devido a hipotensão profunda).	Titular gradualmente até máx 0,5 mg/kg/dia.
Lactentes e Crianças (VO)	Inicial: 0,1 a 0,3 mg/kg/dose a cada 8 horas. Titular até dose de manutenção de 0,5 a 2 mg/kg/dia (Máx: 6 mg/kg/dia ou 150 mg/dia).	Administrar 1 hora antes das refeições (alimentos reduzem a absorção em 30-40%).

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Estenose bilateral de artéria renal, histórico de angioedema induzido por IECA, gravidez.

Monitorização: Potássio sérico (risco de hipercalemia) e creatinina sérica antes e após início.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

77. Carbamazepina

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; concentrações simples checadas: OK

Apresentações Disponíveis

Suspensão oral 100 mg/5 mL (20 mg/mL)

Comprimidos 200 mg e 400 mg

Comprimidos de liberação controlada (CR) 200 mg e 400 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Antiepiléptico bloqueador de canais de sódio voltagem-dependentes. Primeira linha no tratamento de crises epilépticas focais (com ou sem generalização secundária) e neuralgia do trigêmeo.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Crises Focais — Crianças < 6 anos (VO)	Inicial: 10 a 20 mg/kg/dia dividido a cada 8 ou 12 horas. Titular até manutenção de 20 a 35 mg/kg/dia.	Dividido a cada 8 horas com alimentos
Crianças de 6 a 12 anos (VO)	Inicial: 100 mg 2 vezes ao dia (10 mg/kg/dia). Titular até 20 a 30 mg/kg/dia (400 a 800 mg/dia divididos).	Nível sérico terapêutico alvo: 4 a 12 mcg/mL
Crianças > 12 anos e Adolescentes (VO)	Inicial: 200 mg a cada 12 horas. Titular até 800 a 1200 mg/dia.	Preferir formulações CR para reduzir picos séricos.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Bloqueio atrioventricular, depressão de medula óssea prévia, porfiria aguda intermitente e crises de ausência ou mioclônicas (pode agravar as crises).

Alertas: Risco de Síndrome de Stevens-Johnson (associado ao alelo HLA-B*1502 em asiáticos), hiponatremia por SIADH e autoindução metabólica hepática.

Checagem matemática automatizada

OK - 100 mg/5 mL = 20 mg/mL; declarado 20 mg/mL

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

78. Carbocisteína

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Xarope pediátrico 20 mg/mL (100 mg/5 mL)

Xarope adulto 50 mg/mL (250 mg/5 mL)

Gotas 50 mg/mL

Indicações e Linha de Tratamento

Mucolítico e mucorregulador derivado de aminoácido com grupo tiol. Indicado como terapia adjuvante sintomática em afecções respiratórias hipersecretivas com muco viscoso.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Crianças de 2 a 5 anos (VO)	50 a 100 mg (2,5 a 5 mL do xarope pediátrico)	2 a 3 vezes ao dia
Crianças de 5 a 12 anos (VO)	100 a 200 mg (5 a 10 mL do xarope pediátrico)	3 vezes ao dia

Contraindicações, restrições e monitorização

Idade: Contraindicado para menores de 2 anos pelo risco de inundação alveolar e incapacidade de expectoração.

Condições: Úlcera péptica ativa e hipersensibilidade aos componentes.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

79. Carbonato de cálcio

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos mastigáveis 500 mg e 1250 mg (contém 40% de cálcio elementar; 1250 mg = 500 mg de Ca elementar)

Suspensão oral

Indicações e Linha de Tratamento

Suplemento de cálcio elementar e quelante de fósforo gastrointestinal na doença renal crônica. Indicado na profilaxia e tratamento do raquitismo nutricional hipocalcêmico e hiperfosfatemia na DRC.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Reposição / Suplementação de Cálcio Elementar (VO)	Lactentes: 50 a 100 mg/kg/dia de Ca elementar. Crianças: 45 a 65 mg/kg/dia de Ca elementar.	Dividido em 2 a 4 tomadas entre as refeições para otimizar a absorção.
Quelante de Fósforo na DRC (VO)	40 a 100 mg/kg/dia (base sal) administrado junto às principais refeições.	Administrar com as refeições para quelação dietética.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipercalcemia, hipercalcúria grave, litíase renal cálcica e intoxicação digitálica.

Interações: Reduz a absorção de ferro, levotiroxina e fluoroquinolonas se administrados simultaneamente.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

80. Carvão vegetal ativado

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó para suspensão oral em frasco/pote de 25 g e 50 g

Indicações e Linha de Tratamento

Adsorvente gastrointestinal de alta superfície de contato. Primeira linha na descontaminação gastrointestinal em intoxicações exógenas agudas potencialmente tóxicas por xenobióticos ingeridos idealmente na primeira hora pós-ingestão.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Intoxicação Aguda — Dose Única (VO/Sonda Gástrica)	Lactentes < 1 ano: 10 a 25 g (ou 0,5 a 1 g/kg). Crianças de 1 a 12 anos: 25 a 50 g (ou 1 g/kg; Máx: 50 g). Adolescentes: 50 a 100 g.	Diluir em água na proporção de 1:4 a 1:8 (ex: 25 g em 100-200 mL). Administrar preferencialmente na 1ª hora.
Múltiplas Doses (Carbamazepina, Dapsona, Teofilina, Fenobarbital) (VO)	0,5 g/kg a cada 4 a 6 horas por 24 a 48 horas	Sem catártico nas doses subsequentes.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições Absolutas: Vias aéreas desprotegidas sem intubação traqueal (risco gravíssimo de pneumonite aspirativa por carvão), perfuração gastrointestinal e ingestão de cáusticos/corrosivos (ácidos/álcalis fortes).

Ineficácia: Não adsorve ferro, chumbo, lítio, potássio, álcoois e hidrocarbonetos.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

81. Carvedilol

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos 3,125 mg, 6,25 mg, 12,5 mg e 25 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Betabloqueador não seletivo com propriedades vasodilatadoras por bloqueio alfa-1 adrenérgico e efeito antioxidante. Primeira linha no tratamento da Insuficiência Cardíaca Crônica com disfunção sistólica ventricular em pediatria e hipertensão arterial.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Insuficiência Cardíaca Pediátrica (VO)	Dose inicial de teste: 0,05 mg/kg/dose a cada 12 horas por 2 semanas. Dobrar a cada 2 semanas conforme tolerabilidade clínica até dose alvo de 0,4 a 0,8 mg/kg/dia (Máx: 25 a 50 mg/dia).	Administrar a cada 12 horas junto às refeições para diminuir a taxa de absorção e o risco de hipotensão ortostática.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Insuficiência cardíaca descompensada aguda que requeira suporte inotrópico EV, choque cardiogênico, bloqueio AV de 2º ou 3º grau, bradicardia severa e asma brônquica ativa.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

82. Caspofungina (acetato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó liofilizado para solução injetável frasco-ampola 50 mg e 70 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Antifúngico da classe das equinocandinas. Primeira linha no tratamento de Candidíase invasiva, candidemia, terapia empírica em neutropenia febril de alto risco e Aspergilose invasiva refratária ou intolerante a outros antifúngicos em crianças ≥ 3 meses.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Infecções Fúngicas Invasivas / Neutropenia Febril (IV)	Crianças de 3 meses a 17 anos: Dose de ataque no Dia 1 de 70 mg/m ² (Máx: 70 mg). Dose de manutenção diária de 50 mg/m ² /dia (Máx: 50 a 70 mg/dia).	Infundir lentamente em 60 minutos diluído em SF0,9% (incompatível com soluções glicosadas).

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipersensibilidade a equinocandinas.

Preparo: Nunca diluir em SG5% (instabilidade química e precipitação).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

83. Cefaclor

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó para suspensão oral 125 mg/5 mL, 250 mg/5 mL e 375 mg/5 mL

Cápsulas 500 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Cefalosporina de segunda geração para uso oral. Indicada no tratamento de infecções respiratórias comunitárias (otite média, sinusite, faringoamigdalite) e infecções de pele e tecidos moles.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Infecções Respiratórias e Pele (VO)	20 a 40 mg/kg/dia	Dividido a cada 8 horas (ou a cada 12h em infecções leves; Máx: 1 g a 1,5 g/dia)

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipersensibilidade grave a cefalosporinas e penicilinas.

Alerta: Risco de reação semelhante à doença do soro (artralgias, febre e rash urticariforme) após múltiplos cursos.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

84. Cefadroxila

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó para suspensão oral 250 mg/5 mL e 500 mg/5 mL

Cápsulas 500 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Cefalosporina de primeira geração de uso oral com meia-vida prolongada. Indicada no tratamento de faringoamigdalite estreptocócica, infecções cutâneas não complicadas (impetigo, celulite por MSSA) e infecções do trato urinário não complicadas.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Faringite Estreptocócica / Infecções Cutâneas (VO)	30 mg/kg/dia (até 50 mg/kg/dia em infecções moderadas)	Dose única diária ou dividida a cada 12 horas por 10 dias (Máx: 1 a 2 g/dia)

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Alergia grave conhecida a beta-lactâmicos.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

85. Cefalexina

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó para suspensão oral 125 mg/5 mL e 250 mg/5 mL

Cápsulas/comprimidos 500 mg e 1 g

Indicações e Linha de Tratamento

Cefalosporina de primeira geração para uso oral. Primeira linha no tratamento ambulatorial de infecções de pele e partes moles (impetigo bolhoso, foliculite, celulite por Staphylococcus aureus sensível à meticilina - MSSA e Streptococcus pyogenes) e profilaxia de ITU selecionada.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Infecções de Pele e Partes Moles / Faringite (VO)	50 a 100 mg/kg/dia	Dividido a cada 6 horas (ou a cada 8h em infecções leves) por 7 a 10 dias (Máx: 4 g/dia)
Profilaxia de Infecção do Trato Urinário (VO)	15 a 25 mg/kg/dia em dose única noturna	Manutenção crônica conforme nefrologia/urologia

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipersensibilidade grave mediada por IgE a penicilinas e cefalosporinas.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

86. Cefalotina sódica

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó para solução injetável frasco-ampola 1 g

Indicações e Linha de Tratamento

Cefalosporina de primeira geração parenteral. Indicada no tratamento de infecções estafilocócicas e estreptocócicas graves comunitárias e profilaxia cirúrgica em pediatria.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Infecções Pediátricas Sistêmicas (IV)	80 a 150 mg/kg/dia	Dividido a cada 6 horas em infusão lenta de 30 minutos (Máx: 6 g/dia)

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Alergia grave a cefalosporinas; risco de flebite na infusão periférica rápida (preferir cefazolina).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

87. Cefazolina sódica

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó para solução injetável frasco-ampola 1 g

Indicações e Linha de Tratamento

Cefalosporina de primeira geração parenteral padrão-ouro. Primeira linha para profilaxia cirúrgica antimicrobiana em pediatria e tratamento de infecções graves de pele, partes moles, osteomielite e artrite séptica por MSSA comunitário.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Profilaxia Cirúrgica Pediátrica (IV)	30 mg/kg (Máx: 2 g; 3 g se peso > 120 kg)	Dose única 30 a 60 minutos antes da incisão cirúrgica; redosar a cada 4 horas em cirurgias prolongadas.
Infecções Sistêmicas por MSSA / Osteomielite (IV)	Leve a Moderada: 50 a 75 mg/kg/dia a cada 8h. Grave: 100 a 150 mg/kg/dia a cada 6 a 8h (Máx: 6 g/dia).	Infusão IV lenta em 30 minutos.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Anafilaxia prévia a beta-lactâmicos.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

88. Cefepima (cloridrato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó para solução injetável frasco-ampola 1 g e 2 g

Indicações e Linha de Tratamento

Cefalosporina de quarta geração parenteral de amplo espectro com excelente atividade contra Pseudomonas aeruginosa, Enterobactérias e Gram-positivos sensíveis. Primeira linha na Neutropenia Febril de alto risco em oncologia pediátrica e sepse hospitalar grave.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Neutropenia Febril / Sepse Grave / Pseudomonas (IV)	150 mg/kg/dia (50 mg/kg/dose a cada 8 horas; Máx: 2 g/dose = 6 g/dia)	Infusão IV em 30 a 60 minutos (ou infusão estendida em 3 a 4 horas para otimização farmacodinâmica).
Infecções do Trato Urinário / Pneumonia Hospitalar (IV)	100 mg/kg/dia dividido a cada 12 horas	Infusão lenta em 30 minutos

Contraindicações, restrições e monitorização

Neurotoxicidade: Ajustar estritamente a dose na insuficiência renal; risco de encefalopatia induzida por cefepima, mioclonias e estado de mal não convulsivo.

Condições: Alergia grave a cefalosporinas.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

89. Cefixima

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó para suspensão oral 100 mg/5 mL

Cápsulas 400 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Cefalosporina de terceira geração para uso oral. Indicada no tratamento de infecções do trato urinário (ITU / Pielonefrite aguda após estabilização), otite média recorrente com falha e gonorreia urogenital em adolescentes.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Infecção do Trato Urinário / Otite Média (VO)	8 mg/kg/dia em dose única diária ou dividido a cada 12 horas (Máx: 400 mg/dia)	Duração habitual de 7 a 10 dias nas pielonefrites
Gonorreia Urogenital não complicada (VO)	400 mg em dose única	Associada a tratamento de clamídia com azitromicina ou doxiciclina

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipersensibilidade a cefalosporinas.

Espectro: Não possui atividade contra *Staphylococcus aureus* e *Pseudomonas aeruginosa*.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

90. Cefotaxima sódica

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó para solução injetável frasco-ampola 1 g

Indicações e Linha de Tratamento

Cefalosporina de terceira geração parenteral. Primeira linha para tratamento de Seps e Meningite bacteriana neonatal e em lactentes jovens, devido à ausência de deslocamento de bilirrubina da albumina (segura na hiperbilirrubinemia neonatal).

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Seps e Meningite Neonatal (IV)	Neonato ≤ 7 dias: 100 a 150 mg/kg/dia a cada 12h. Neonato > 7 dias: 150 a 200 mg/kg/dia a cada 8h (até 200 mg/kg/dia a cada 6h em meningite).	Infundir em 20 a 30 minutos.
Meningite e Seps Pediátrica > 1 mês (IV)	200 a 300 mg/kg/dia	Dividido a cada 6 a 8 horas (Máx: 12 g/dia)

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Alergia grave a cefalosporinas.

Vantagem Neonatal: Não causa pseudolítase biliar nem kernicterus (diferencial decisivo em relação à ceftriaxona no neonato).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

91. Cefoxitina sódica

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó para solução injetável frasco-ampola 1 g

Indicações e Linha de Tratamento

Cefamicina (cefalosporina de segunda geração com excelente atividade anaeróbica contra *Bacteroides fragilis*). Indicada na profilaxia cirúrgica em cirurgia colorretal/apendicectomia e tratamento de infecções intra-abdominais e Doença Inflamatória Pélvica (DIP) em adolescentes.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Infecções Intra-abdominais / Pélvicas (IV)	80 a 160 mg/kg/dia	Dividido a cada 4 a 6 horas (Máx: 8 a 12 g/dia)
Profilaxia Cirúrgica Colorretal / Apendicectomia (IV)	30 a 40 mg/kg (Máx: 2 g)	Dose única 30 a 60 minutos antes da incisão; redosar a cada 2 horas.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Alergia grave a cefalosporinas e cefamicinas.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

92. Ceftazidima

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó para solução injetável frasco-ampola 1 g e 2 g

Indicações e Linha de Tratamento

Cefalosporina de terceira geração parenteral com potente atividade antipseudomonas. Indicada em infecções respiratórias graves por *Pseudomonas aeruginosa* em pacientes com Fibrose Cística, meningite pós-neurocirúrgica e ectima gangrenoso.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Infecções Pediátricas Sistêmicas / Seps (IV)	100 a 150 mg/kg/dia	Dividido a cada 8 horas (Máx: 6 g/dia)
Fibrose Cística com Exacerbação por <i>P. aeruginosa</i> (IV)	200 a 300 mg/kg/dia	Dividido a cada 8 horas em infusão estendida de 3 a 4h (Máx: 9 g/dia)

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Alergia a cefalosporinas e aztreonam.

Espectro: Atividade fraca contra cocos Gram-positivos (*S. aureus* sensível e enterococos são intrinsecamente resistentes).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

93. Ceftazidima + Avibactam

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó liofilizado para solução injetável 2 g ceftazidima + 0,5 g avibactam (2,5 g)

Indicações e Linha de Tratamento

Associação de cefalosporina antipseudomonas com inibidor não beta-lactâmico de beta-lactamases (ativo contra KPC, ESBL e AmpC). Indicado no tratamento de infecções graves por enterobactérias produtoras de carbapenemase (KPC) e *P. aeruginosa* multiresistente em crianças ≥ 3 meses.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Infecções Graves por Gram-Negativos Multirresistentes (IV)	Crianças de 3 meses a < 2 anos: 50 mg/kg ceftazidima + 12,5 mg/kg avibactam (62,5 mg/kg da combinação) a cada 8h. Crianças de 2 a 17 anos: 50 mg/kg ceftazidima + 12,5 mg/kg avibactam (Máx: 2,5 g) a cada 8h.	Infusão intravenosa lenta estendida em 2 horas.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Alergia grave aos componentes; inativo contra metalobetalactamases (NDM, VIM, IMP).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

94. Ceftolozana + Tazobactam

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó liofilizado para solução injetável 1 g ceftolozana + 0,5 g tazobactam (1,5 g)

Indicações e Linha de Tratamento

Cefalosporina antipseudomonas de nova geração associada a inibidor de beta-lactamase. Indicada no tratamento de infecções intra-abdominais complicadas, infecções do trato urinário complicadas e pneumonia nosocomial/associada à ventilação por *Pseudomonas aeruginosa* multirresistente (XDR).

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Infecções Complicadas por <i>Pseudomonas</i> Multirresistente (IV)	Crianças de 3 meses a 17 anos: ITU / Intra-abdominal: 20 mg/kg ceftolozana + 10 mg/kg tazobactam (30 mg/kg) a cada 8h (Máx: 1,5 g). Pneumonia Hospitalar / PAV: 40 mg/kg ceftolozana + 20 mg/kg tazobactam (60 mg/kg) a cada 8h (Máx: 3 g).	Infundir em 60 minutos.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipersensibilidade a cefalosporinas e tazobactam.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

95. Ceftriaxona sódica

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó para solução injetável frasco-ampola 500 mg e 1 g (para uso IV ou IM com diluente de lidocaína 1%)

Indicações e Linha de Tratamento

Cefalosporina de terceira geração parenteral padrão-ouro de longa ação. Primeira linha para Meningite bacteriana em crianças > 1 mês, Sepses bacteriana, Pneumonia complicada/com derrame pleural, Pielonefrite hospitalar, Celulite orbitária e Doença meningocócica.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Meningite Bacteriana Aguda (IV)	100 mg/kg/dia em dose única ou 50 mg/kg a cada 12 horas (Máx: 4 g/dia)	Duração estrita de 7 a 14 dias conforme patógeno em infusão de 30 min.
Sepses / PAC Grave / Pielonefrite / Celulite Orbitária (IV/IM)	50 a 80 mg/kg/dia em dose única diária (Máx: 2 g/dia)	Infusão IV lenta em 30 min ou IM profunda (com lidocaína para conforto).
Otite Média Aguda — Resgate na Falha Terapêutica (IM)	50 mg/kg/dia por 3 dias consecutivos (ou dose única de 50 mg/kg em casos selecionados)	Via IM profunda

Contraindicações, restrições e monitorização

CONTRAINDICAÇÃO NEONATAL ABSOLUTA: Contraindicada em recém-nascidos prematuros e neonatos a termo com hiperbilirrubinemia/icterícia (desloca a bilirrubina da albumina sérica, causando kernicterus/encefalopatia bilirrubínica).

INTERAÇÃO GRAVE COM CÁLCIO: Estritamente contraindicada a coadministração com soluções intravenosas contendo cálcio (incluindo Ringer Lactato e NPT) em qualquer idade, devido ao alto risco fatal de precipitação intravascular de ceftriaxona-cálcio em pulmões e rins.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

96. Cefuroxima axetila / sódica

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó para suspensão oral 125 mg/5 mL e 250 mg/5 mL (axetila)

Comprimidos revestidos 250 mg e 500 mg (axetila)

Pó para solução injetável frasco-ampola 750 mg (sódica, IV/IM)

Indicações e Linha de Tratamento

Cefalosporina de segunda geração com estabilidade frente a beta-lactamases de *H. influenzae* e *M. catarrhalis*. Indicada no tratamento de infecções respiratórias comunitárias moderadas (OMA, sinusite, PAC) e infecções de partes moles.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Infecções Respiratórias — Suspensão Oral (VO)	30 mg/kg/dia dividido a cada 12 horas por 7 a 10 dias (Máx: 1000 mg/dia)	Administrar junto às refeições para melhorar a absorção e atenuar sabor amargo residual.
Infecções Sistêmicas Parenterais (IV/IM)	75 a 150 mg/kg/dia	Dividido a cada 8 horas (Máx: 4,5 g/dia)

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Alergia grave a cefalosporinas.

Palatabilidade: Não triturar os comprimidos devido ao sabor extremamente amargo.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

97. Celecoxibe

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Cápsulas 100 mg e 200 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Anti-inflamatório não esteroide inibidor seletivo da COX-2. Indicado no controle da dor e inflamação crônica na Artrite Idiopática Juvenil (AIJ) em crianças ≥ 2 anos.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Artrite Idiopática Juvenil (AIJ) ≥ 2 anos (VO)	Peso 10 a 25 kg: 50 mg a cada 12 horas (100 mg/dia). Peso > 25 kg: 100 mg a cada 12 horas (200 mg/dia).	Administrar com alimentos para reduzir desconforto gástrico.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipersensibilidade a sulfonamidas, crise asmática induzida por AAS/AINEs, úlcera péptica ativa e insuficiência renal grave.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

98. Cetamina / Esesquetamina (cloridrato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável 50 mg/mL (frascos de 2 mL e 10 mL) e 25 mg/mL

Indicações e Linha de Tratamento

Anestésico dissociativo e analgésico potente (antagonista dos receptores NMDA). Primeira linha na sedoanalgesia para procedimentos dolorosos na emergência, agente de indução na Sequência Rápida de Intubação em choque séptico e crise asmática grave refratária (broncodilatação e preservação do tônus simpático e drive respiratório).

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Sedoanalgesia de Procedimento (IV)	1 a 1,5 mg/kg em bolus IV lento em 60 segundos	Início em 30 a 60 segundos; duração dissociativa de 10 a 20 minutos. Redoses de 0,5 mg/kg conforme necessidade.
Sedoanalgesia sem Acesso Venoso (IM)	3 a 4 mg/kg em injeção IM profunda	Início em 3 a 5 minutos; duração de 20 a 30 minutos.
Sequência Rápida de Intubação (SRI) (IV)	1 a 2 mg/kg em bolus IV	Ideal no choque séptico e asma grave.
Crise Asmática Grave em UTI / Broncoespasmo Refratário (IV)	Ataque: 1 mg/kg em 5 min. Manutenção: 0,5 a 2 mg/kg/h em infusão contínua.	Efeito broncodilatador direto.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipertensão grave não controlada, aneurismas vasculares conhecidos, eclâmpsia.

Efeitos: Aumento de secreções orofaríngeas (manter aspiração pronta) e reações de emergência/pesadelos ao despertar (atenuadas por coadministração de midazolam).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

99. Cetirizina (dicloridrato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Gotas 10 mg/mL (1 gota = 0,5 mg ou 20 gotas = 10 mg)

Solução oral/xarope 1 mg/mL

Comprimidos 10 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Anti-histamínico de segunda geração (metabólito ativo da hidroxizina) com potente ação antagonista H1 periférica e início de ação rápido. Indicado no controle da Rinite Alérgica e Urticária Aguda e Crônica em crianças ≥ 6 meses.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Rinite Alérgica / Urticária — 6 a 12 meses (VO)	2,5 mg (5 gotas ou 2,5 mL do xarope) uma vez ao dia	Dose única diária
Crianças de 1 a 5 anos (VO)	2,5 mg uma vez ao dia (pode aumentar para 2,5 mg a cada 12h ou 5 mg uma vez ao dia)	Dose máxima: 5 mg/dia
Crianças ≥ 6 anos e Adolescentes (VO)	5 a 10 mg uma vez ao dia (ou 5 mg a cada 12 horas)	Dose máxima: 10 mg/dia

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Insuficiência renal terminal (CICr < 10 mL/min) e hipersensibilidade à cetirizina ou hidroxizina.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

100. Cetoconazol

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Creme dermatológico 20 mg/g (2%)

Xampu 20 mg/g (2%)

Comprimidos 200 mg (uso sistêmico altamente restrito)

Indicações e Linha de Tratamento

Antifúngico imidazólico de amplo espectro. Indicado no tratamento tópico de dermatite seborreica infantil, pitíriase versicolor e micoses cutâneas superficiais (tinea corporis, tinea cruris, tinea pedis).

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Dermatite Seborreica / Crosta Láctea (Tópico / Xampu)	Aplicar xampu a 2% no couro cabeludo 2 vezes por semana por 2 a 4 semanas	Massagear suavemente e enxaguar após 3 a 5 minutos.
Micoses Cutâneas Superficiais (Creme Tópico)	Aplicar sobre as lesões 1 a 2 vezes ao dia por 2 a 4 semanas	Manter aplicação por mais alguns dias após desaparecimento dos sintomas.

Contraindicações, restrições e monitorização

USO ORAL SISTÊMICO: O cetoconazol oral está estritamente desaconselhado e restrito pela ANVISA e FDA devido ao alto risco de hepatotoxicidade fulminante fatal e graves interações farmacológicas por inibição do CYP3A4.

Tópico: Hipersensibilidade aos imidazólicos.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

101. Cetoprofeno

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Gotas 20 mg/mL (1 gota = 1 mg)

Suspensão oral pediátrica

Comprimidos 50 mg e 100 mg

Solução injetável IM/IV 100 mg (ampola 2 mL ou frasco-ampola liofilizado)

Indicações e Linha de Tratamento

Anti-inflamatório não esteroide (AINE) derivado do ácido arilcarboxílico com potente ação analgésica, antipirética e anti-inflamatória. Indicado no controle da dor pós-operatória, dor ortopédica/trauma e afecções inflamatórias osteoarticulares.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Dor e Febre — Crianças ≥ 1 ano (VO)	0,5 mg/kg/dose (ou 1 gota/kg/dose) a cada 6 a 8 horas (Dose diária: 1,5 a 2 mg/kg/dia; Máx: 2 mg/kg/dia ou 100 mg/dia).	Administrar junto com as refeições ou leite por no máximo 2 a 5 dias consecutivos.
Dor Aguda / Pós-Operatório (IV/IM)	1 mg/kg/dose a cada 8 horas (Máx: 100 mg/dose em infusão IV lenta de 20 a 30 min diluído em SF0,9% ou SG5%).	Limitar uso parenteral a 48 horas.

Contraindicações, restrições e monitorização

Idade: Contraindicado para menores de 1 ano de idade (risco aumentado de toxicidade gastrointestinal e renal).

Condições: Úlcera péptica ativa, hemorragia digestiva, insuficiência renal moderada a grave, desidratação (alto risco de necrose tubular aguda) e asma induzida por AINEs.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

102. Ciclesonida

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Spray nasal 50 mcg/dose

Aerossol inalatório oral (spray) 80 mcg e 160 mcg/dose

Indicações e Linha de Tratamento

Corticoide inalatório pró-fármaco ativado in situ nas vias aéreas por esterases pulmonares, com altíssima ligação a proteínas plasmáticas (baixa biodisponibilidade sistêmica e menor efeito adverso orofaríngeo). Indicado no controle da Asma Persistente em

crianças ≥ 6 anos e Rinite Alérgica.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Asma Persistente ≥ 6 anos (Inalatória Oral)	80 a 160 mcg uma vez ao dia (preferencialmente à noite com espaçador valvulado; até 320 mcg/dia em asma grave)	Dose única diária
Rinite Alérgica (Spray Nasal)	Crianças ≥ 2 anos: 1 jato (50 mcg) em cada narina uma vez ao dia (Máx: 100 mcg/dia)	Dose única matinal

Contraindicações, restrições e monitorização

Idade: Não recomendado para < 6 anos para asma.

Condições: Hipersensibilidade aos componentes; enxaguar a boca após a inalação.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

103. Ciclosporina

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução oral 100 mg/mL

Cápsulas gelatinosas 25 mg, 50 mg e 100 mg

Solução injetável 50 mg/mL (ampola 1 mL e 5 mL)

Colírio oftálmico 0,05%

Indicações e Linha de Tratamento

Imunossupressor inibidor da calcineurina. Primeira linha na Síndrome Nefrótica Córdico-Dependente ou Córdico-Resistente em pediatria, prevenção de rejeição em transplantes de órgãos sólidos/medula óssea e dermatite atópica grave refratária.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Síndrome Nefrótica / Doenças Autoimunes (VO)	4 a 6 mg/kg/dia dividido a cada 12 horas. Titular para manter nível sérico de vale (C0: 100 a 200 ng/mL ou C2: 400 a 600 ng/mL).	Administrar no mesmo horário, sem misturar com suco de toranja/grapefruit.
Pós-Transplante de Órgãos (IV/VO)	IV: 2 a 4 mg/kg/dia em infusão contínua. VO: 6 a 10 mg/kg/dia dividido a cada 12h.	Monitorização sérica terapêutica estrita.

Contraindicações, restrições e monitorização

Nefrotoxicidade / Hipertensão: Causa vasoconstritor arteriolar renal dose-dependente; monitorar creatinina, eletrólitos e PA semanalmente.

Condições: Insuficiência renal não corrigida, hipertensão arterial descontrolada e infecções ativas não tratadas.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

104. Cimetidina

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução oral 200 mg/5 mL

Comprimidos 200 mg e 400 mg

Solução injetável 150 mg/mL (ampola 2 mL = 300 mg)

Indicações e Linha de Tratamento

Antagonista dos receptores H2 de histamina. Indicado no tratamento de úlcera péptica, refluxo gastroesofágico e como imunomodulador adjuvante no tratamento de verrugas vulgares / molusco contagioso recalcitrantes em pediatria.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Doença Péptica / Refluxo (VO/IV)	20 a 40 mg/kg/dia	Dividido a cada 6 a 8 horas (Máx: 800 a 1200 mg/dia)
Imunomodulação em Verrugas / Molusco (VO)	30 a 40 mg/kg/dia dividido a cada 8 ou 12 horas	Uso prolongado por 2 a 3 meses sob supervisão dermatológica.

Contraindicações, restrições e monitorização

Interações Medicamentosas: Potente inibidor de várias isoenzimas do citocromo P450 (CYP1A2, CYP2C9, CYP2D6, CYP3A4), aumentando níveis tóxicos de fenitoína, teofilina, varfarina e carbamazepina.

Condições: Insuficiência renal grave (requer redução de dose).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

105. Ciproheptadina (cloridrato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Xarope 2 mg/5 mL (frequentemente associado a complexo vitamínico/aminoácidos)

Indicações e Linha de Tratamento

Anti-histamínico de primeira geração com propriedades antiserotoninérgicas (5-HT_{2A}) e anticolinérgicas. Indicado na profilaxia da Síndrome dos Vômitos Cíclicos e enxaqueca em crianças pequenas, estimulação transitória do apetite em casos selecionados de desnutrição e alergias.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Síndrome dos Vômitos Cíclicos / Estimulação (VO)	Crianças de 2 a 6 anos: 0,25 a 0,5 mg/kg/dia (ou 2 mg a cada 8-12h; Máx: 8 mg/dia). Crianças de 7 a 14 anos: 4 mg 2 a 3 vezes ao dia (Máx: 16 mg/dia).	Administrar antes das refeições ou ao deitar.

Contraindicações, restrições e monitorização

Idade: Contraindicado para menores de 2 anos (risco de depressão respiratória e sedação profunda) e prematuros.

Condições: Glaucoma de ângulo fechado e obstrução piloroduodenal.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

106. Ciprofloxacino (cloridrato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Suspensão oral 250 mg/5 mL

Comprimidos 250 mg e 500 mg

Solução para infusão IV 2 mg/mL (bolsas 100 mL = 200 mg e 200 mL = 400 mg)

Colírio/pomada oftálmica 0,3%

Gotas otológicas 0,3%

Indicações e Linha de Tratamento

Antimicrobiano fluoroquinolônico com potente ação bactericida contra Gram-negativos, especialmente *Pseudomonas aeruginosa*. Indicado em infecções urinárias complicadas/refratárias, exacerbações pulmonares por *Pseudomonas* na Fibrose Cística e otite média crônica supurativa.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Infecções Sistêmicas / ITU Complicada (VO)	20 a 30 mg/kg/dia dividido a cada 12 horas (Máx: 1000 a 1500 mg/dia)	Ingerir com bastante líquido; não tomar com derivados do leite.

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Fibrose Cística / Infecção Grave por Pseudomonas (IV)	20 a 30 mg/kg/dia (10 mg/kg/dose a cada 8 horas em infusão lenta de 60 min; Máx: 800 a 1200 mg/dia)	Infusão IV lenta.
Otite Média Supurativa / Otite Externa (Otológico)	3 a 4 gotas no conduto auditivo a cada 8 a 12 horas por 7 dias	Uso tópico seguro mesmo com perfuração timpânica.

Contraindicações, restrições e monitorização

Uso Sistêmico: Uso criterioso em pediatria devido ao potencial risco de artropatia em cartilagens de crescimento (risco superado em indicações clínicas formais como fibrose cística e infecções multirresistentes).

Interações: Quelação e inativação se administrado com cálcio, ferro, magnésio ou antiácidos.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

107. Cisatracúrio (besilato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável 2 mg/mL (ampolas 5 mL = 10 mg e 10 mL = 20 mg) e 10 mg/mL

Indicações e Linha de Tratamento

Bloqueador neuromuscular não despolarizante benzilisoquinolínico com degradação de Hofmann purificada e ausência total de liberação de histamina. Indicado para intubação e paralisia muscular em ventilação mecânica em UTI pediátrica, com perfil ideal para pacientes com insuficiência renal ou hepática.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Intubação Orotraqueal (IV)	0,15 a 0,2 mg/kg em bolus IV	Início em 2 minutos; duração clínica de 35 a 50 minutos.
Infusão Contínua em UTI Pediátrica (IV)	Carga: 0,1 mg/kg. Manutenção: 1 a 3 mcg/kg/min (0,06 a 0,18 mg/kg/h).	Titular rigorosamente por monitorização de trem-de-quatro (TOF).

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipersensibilidade ao cisatracúrio ou atracúrio.

Mandatário: Sedação e analgesia plenas contínuas.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

108. Citrato de potássio

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução oral/xarope 2 mEq/mL (1080 mg/10 mL)

Granulado/sachê

Indicações e Linha de Tratamento

Agente alcalinizante urinário e suplemento de potássio. Indicado no tratamento e profilaxia de litíase renal por cálculos de ácido úrico e cistina, hipocitratúria e acidose tubular renal tipo 1.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Nefrolitíase / Hipocitratúria / ATR Tipo 1 (VO)	Inicial: 1 a 2 mEq/kg/dia dividido em 3 a 4 tomadas após as refeições. Titular para manter citrato urinário > 300-400 mg/g creatinina e pH urinário entre 6,5 e 7,0.	Administrar diluído em água ou suco junto às refeições.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipercalemia, insuficiência renal grave (taxa de filtração < 30 mL/min), úlcera péptica e uso concomitante de diuréticos poupadores de potássio.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

109. Claritromicina

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Grânulos para suspensão oral 125 mg/5 mL e 250 mg/5 mL

Comprimidos 250 mg e 500 mg

Pó liofilizado para solução injetável 500 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Antimicrobiano macrolídeo semissintético. Indicado no tratamento de infecções respiratórias comunitárias por bactérias atípicas (*Mycoplasma pneumoniae*, *Chlamydia pneumoniae*), faringoamigdalite em alérgicos a penicilina, erradicação de *Helicobacter pylori* e infecções por micobactérias não tuberculosas (MAC).

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Infecções Respiratórias / OMA / Faringite (VO)	15 mg/kg/dia dividido a cada 12 horas por 7 a 10 dias (Máx: 1000 mg/dia)	Pode ser administrado com ou sem alimentos.
Erradicação de <i>H. pylori</i> (VO)	15 a 20 mg/kg/dia dividido a cada 12 horas por 14 dias (combinado a amoxicilina e IBP)	Dose máxima: 500 mg a cada 12h

Contraindicações, restrições e monitorização

Interações: Potente inibidor do CYP3A4; risco de toxicidade grave quando coadministrado com cisaprida, terfenadina, pimozida e alcaloides do ergot.

Condições: Histórico de prolongamento de QTc e arritmias ventriculares.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

110. Clemastina (fumarato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução oral/xarope 0,05 mg/mL

Comprimidos 1 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Anti-histamínico H1 clássico de primeira geração com ação antialérgica e sedativa prolongada. Indicado no alívio sintomático de rinite alérgica aguda, urticária e prurido.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Rinite Alérgica / Urticária — 1 a 6 anos (VO)	0,05 mg/kg/dia dividido a cada 12 horas (ou 0,25 a 0,5 mg a cada 12h)	A cada 12 horas
Crianças de 6 a 12 anos (VO)	0,5 a 1 mg a cada 12 horas	Máx: 2 mg/dia

Contraindicações, restrições e monitorização

Idade: Contraindicado para neonatos e menores de 1 ano.

Condições: Asma aguda descompensada e glaucoma.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

111. Clindamicina (cloridrato / fosfato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução oral 75 mg/5 mL

Cápsulas 300 mg

Solução injetável 150 mg/mL (ampolas 2 mL = 300 mg, 4 mL = 600 mg e 6 mL = 900 mg)

Gel/solução tópica 1%

Indicações e Linha de Tratamento

Antimicrobiano lincosamida com potente atividade antiestafilocócica (incluindo CA-MRSA sensível), antiestreptocócica e antianaeróbica, além de potente inibição da síntese de toxinas bacterianas (efeito Eagle). Primeira linha em osteomielite/artrite séptica, fasciite necrosante, abscesso pulmonar e celulites graves.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Infecções Osteoarticulares / CA-MRSA / Sepsis (IV)	30 a 40 mg/kg/dia dividido a cada 6 a 8 horas (Máx: 2,7 a 4,8 g/dia)	Infusão intravenosa lenta em 30 a 60 minutos (nunca em bolus direto pelo risco de parada cardiorrespiratória).
Tratamento Oral Ambulatorial (VO)	20 a 30 mg/kg/dia (até 40 mg/kg/dia em infecções graves)	Dividido a cada 6 a 8 horas por 7 a 14 dias (Máx: 1,8 g/dia)

Contraindicações, restrições e monitorização

Colite Pseudomembranosa: Black box warning para diarreia associada a Clostridioides difficile (pode ocorrer durante ou semanas após o tratamento).

Via IV: Contraindicada injeção IV rápida direta.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

112. Clobazam

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos 10 mg e 20 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Benzodiazepínico 1,5-heterocíclico com potente ação anticonvulsivante e menor efeito sedativo que benzodiazepínicos clássicos. Primeira linha como terapia adjuvante na Síndrome de Lennox-Gastaut, Síndrome de Dravet e epilepsias refratárias focais/generalizadas.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Síndrome de Lennox-Gastaut / Epilepsia Refratária (VO)	Crianças ≥ 2 anos (peso ≤ 30 kg): Inicial 5 mg/dia. Titular semanalmente até 10 a 20 mg/dia (Máx: 0,5 a 1 mg/kg/dia ou 20 mg/dia). Peso > 30 kg: Inicial 10 mg/dia, titular até 20 a 40 mg/dia.	Dividido a cada 12 horas ou dose única noturna.

Contraindicações, restrições e monitorização

Idade: Não recomendado para menores de 2 anos.

Condições: Miastenia gravis, insuficiência respiratória grave, apneia do sono e dependência benzodiazepínica prévia.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

113. Clobetasol (propionato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Creme, pomada e solução capilar 0,5 mg/g (0,05%)

Indicações e Linha de Tratamento

Glicocorticoide tópico de ultra-alta potência (Classe I). Indicado no tratamento de dermatoses inflamatórias graves e recalcitrantes em crianças maiores, como líquen escleroso vulvar refratário, psoríase grave e alopecia areata grave sob estrito controle dermatológico.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Líquen Escleroso / Dermatoses Recalcitrantes (Tópico)	Aplicar fina camada sobre a lesão uma vez ao dia (ou em dias alternados) por no máximo 1 a 2 semanas.	Uso extremamente restrito em pediatria. Fazer desmame para corticoide de menor potência.

Contraindicações, restrições e monitorização

Idade: Contraindicado para menores de 1 ano de idade; uso excepcional em pediatria.

Áreas Proibidas: Contraindicado na face, pálpebras, áreas de oclusão de fraldas e dobras cutâneas (alto risco de atrofia cutânea irreversível, estrias e absorção sistêmica com supressão adrenal).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

114. Clonazepam

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Gotas 2,5 mg/mL (1 gota = 0,1 mg)

Comprimidos 0,5 mg e 2 mg

Comprimidos orodispersíveis 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg e 2 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Benzodiazepínico modulador alostérico positivo do receptor GABA-A com potente ação ansiolítica, sedativa e anticonvulsivante. Indicado no tratamento de crises mioclônicas, ausências atípicas, espasmos infantis (adjuvante) e transtornos de pânico/ansiedade aguda.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Epilepsia Pediátrica — Lactentes e Crianças ≤ 10 anos (VO)	Inicial: 0,01 a 0,03 mg/kg/dia dividido a cada 8 ou 12 horas. Aumentar a cada 3 dias em 0,25 a 0,5 mg até dose de manutenção de 0,05 a 0,1 mg/kg/dia (Máx: 0,2 mg/kg/dia).	Dividido a cada 8 a 12 horas
Crianças > 10 anos e Adolescentes (VO)	Inicial: 0,5 a 1 mg/dia ao deitar. Titular até 1,5 a 6 mg/dia.	Dividido a cada 8 ou 12 horas

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Glaucoma de ângulo fechado, insuficiência respiratória grave e miastenia gravis.

Efeitos: Aumento da secreção e sialorreia em lactentes (risco de broncoaspiração), hiperatividade paradoxal e tolerância com uso prolongado.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

115. Clonidina (cloridrato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos 0,100 mg (100 mcg), 0,150 mg (150 mcg) e 0,200 mg (200 mcg)

Solução injetável 150 mcg/mL (ampola 1 mL)

Indicações e Linha de Tratamento

Agonista seletivo dos receptores alfa-2 adrenérgicos centrais. Indicado no manejo do TDAH com impulsividade/insônia, Síndrome de Tourette/tiques, desmame de sedação e prevenção da síndrome de abstinência de opioides/benzodiazepínicos em UTI pediátrica e adjuvante na analgesia regional.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
TDAH / Tiques / Transtornos do Sono (VO)	Crianças ≥ 6 anos: Inicial 0,05 mg (50 mcg) ao deitar. Titular semanalmente até 0,005 a 0,01 mg/kg/dia (5 a 10 mcg/kg/dia; Máx: 0,4 mg/dia).	Dividido a cada 8 a 12 horas
Abstinência de Sedativos em UTI (VO/IV)	1 a 2 mcg/kg/dose a cada 6 a 8 horas (titular até 5 mcg/kg/dose conforme escores de abstinência WAT-1 / SOS)	Desmame lento ao longo de 1 a 2 semanas.
Emergência Hipertensiva (VO)	2 a 5 mcg/kg/dose a cada 6 a 8 horas	Uso hospitalar

Contraindicações, restrições e monitorização

Descontinuação Abrupta: Risco de crise hipertensiva rebote grave por hiperatividade simpática; desmame obrigatório gradual.

Condições: Bradicardia sinusal severa e bloqueio AV.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

116. Clopidogrel (bissulfato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos 75 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Antiagregante plaquetário inibidor irreversível do receptor P2Y₁₂ de ADP. Indicado na profilaxia de trombose arterial após implante de stents intracardíacos, cirurgias de cardiopatias congênitas (shunts de Blalock-Taussig, Fontan) e prevenção secundária de AVC isquêmico em crianças com contraindicação a AAS.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Antiagregação Plaquetária Pediátrica (VO)	Lactentes e Crianças: 0,2 mg/kg/dia em dose única diária (alcança inibição plaquetária equivalente a 75 mg no adulto). Pode titular até 1 mg/kg/dia se resposta insuficiente.	Dose única diária
Adolescentes (VO)	75 mg uma vez ao dia	Dose padrão do adulto

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Sangramento ativo maior (hemorragia intracraniana, úlcera péptica sangrante) e insuficiência hepática grave.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

117. Cloranfenicol

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Suspensão oral 125 mg/5 mL (palmitato)

Cápsulas 250 mg e 500 mg

Pó injetável frasco-ampola 1 g (succinato)

Colírio 0,4% e 0,5%

Pomada oftálmica 10 mg/g

Indicações e Linha de Tratamento

Antimicrobiano de amplo espectro inibidor da subunidade 50S ribossômica. Atualmente com uso sistêmico estritamente reservado para meningite bacteriana por patógenos multirresistentes, febre tifóide refratária e peste/riquetsioses graves. Uso tópico oftálmico frequente em conjuntivite bacteriana.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Meningite / Infecções Sistêmicas Graves — Crianças > 1 mês (IV/VO)	50 a 75 mg/kg/dia (até 100 mg/kg/dia em meningite grave)	Dividido a cada 6 horas (Máx: 4 g/dia). Infusão IV em 30 min. Nível sérico terapêutico: 10 a 20 mcg/mL.
Neonatos (Uso Excepcional com Monitorização Estrita) (IV)	Neonato a termo: 25 mg/kg/dia uma vez ao dia.	Ajuste obrigatório por imaturidade de glicuronidação hepática.
Conjuntivite Bacteriana (Oftálmico)	1 gota no olho afetado a cada 4 a 6 horas por 5 a 7 dias	Uso tópico

Contraindicações, restrições e monitorização

SÍNDROME DO BEBÊ CINZENTO (Gray Baby Syndrome): Toxicidade fatal em neonatos e prematuros por incapacidade de conjugação hepática, manifestada por colapso cardiovascular, hipotermia, palidez acinzentada, flacidez e acidose metabólica grave.

Mielotoxicidade: Risco de anemia aplásica idiossincrática irreversível fatal e supressão medular reversível dose-dependente.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

118. Cloreto de cálcio 10%

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável 100 mg/mL (10%, ampola 10 mL = 1 g / contém 27,2 mg de Ca elementar/mL = 1,36 mEq/mL)

Indicações e Linha de Tratamento

Sal de cálcio inorgânico concentrado (fornece 3 vezes mais cálcio elementar que o gluconato de cálcio). Primeira linha na emergência para parada cardiorrespiratória por hipercalemia grave documentada, hipocalcemia aguda sintomática com choque, hipermagnesemia grave e intoxicação por bloqueadores de canal de cálcio.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
PCR por Hipercalemia / Intoxicação por Bloqueador de Cálcio (IV/IO)	20 mg/kg (0,2 mL/kg da solução a 10%; Máx: 1000 mg = 10 mL)	Injeção IV lenta em 3 a 5 minutos preferencialmente por acesso venoso central.

Contraindicações, restrições e monitorização

VIA PERIFÉRICA: Evitar rigorosamente infusão em veias periféricas finas devido ao altíssimo risco de esclerose venosa, extravasamento com necrose tecidual grave e ulceração.

Condições: Toxicidade digitálica e hipercalcemia.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

119. Cloreto de potássio (KCl)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução oral/xarope 6% (60 mg/mL = 0,8 mEq/mL) e 10% (100 mg/mL = 1,34 mEq/mL)

Comprimidos de liberação controlada 600 mg (8 mEq)

Solução injetável concentrada 10% (1,34 mEq/mL) e 19,1% (2,56 mEq/mL) em ampolas de 10 mL

Indicações e Linha de Tratamento

Eletrólito essencial para manutenção do potencial de repouso de membrana. Indicado na reposição e prevenção de hipocalcemia (induzida por diuréticos, diarreia, cetoacidose diabética) e componente basal da fluidoterapia de manutenção.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Manutenção Hidroeletrolítica Basal (IV)	2 a 3 mEq de K+/100 mL de solução de manutenção (ou 20 a 40 mEq/L de soro)	Adicionar à solução APENAS APÓS confirmação de diurese estabelecida.

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Correção de Hipocalcemia Grave Sintomática (IV)	0,5 a 1 mEq/kg/dose infundido em 1 a 2 horas (Velocidade máxima: 0,5 mEq/kg/hora sob monitorização cardíaca).	Concentração máxima periférica: 40 mEq/L; central: 80 mEq/L.
Reposição Oral (VO)	1 a 3 mEq/kg/dia dividido em 2 a 3 tomadas após as refeições	Diluir em água ou suco para diminuir irritação gástrica.

Contraindicações, restrições e monitorização

INJEÇÃO DIRETA EM BOLUS É ESTRITAMENTE FATAL: NUNCA administrar cloreto de potássio concentrado em bolus IV direto (causa parada cardíaca imediata em assistolia). Diluição homogênea obrigatória.

Condições: Hipercalcemia, anúria/insuficiência renal aguda oligoanúrica e insuficiência adrenal.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

120. Cloreto de sódio (NaCl)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução nasal 0,9% (gotas e spray com jato contínuo) e 3% (spray hipertônico)

Solução injetável/infusão 0,9% (SF 0,9% - frascos/bolsas 100, 250, 500 e 1000 mL = 154 mEq Na+/L)

Solução injetável hipertônica 10% (1,7 mEq/mL) e 20% (3,4 mEq/mL) em ampolas de 10 mL e 20 mL

Indicações e Linha de Tratamento

Cristaloide isotônico padrão para ressuscitação volêmica no choque hipovolêmico/séptico, desidratação grave (Plano C) e solução de manutenção; solução hipertônica a 3% para emergências neurológicas com hipertensão intracraniana grave e hiponatremia sintomática com convulsões.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Ressuscitação Volêmica no Choque (SF 0,9%) (IV/IO)	10 a 20 mL/kg em bolus rápido em 5 a 10 minutos (em choque cardiogênico reduzir para 5-10 mL/kg em 20 min).	Reavaliar sinais de sobrecarga hídrica (hepatomegalia, estertores) a cada bolus.
Hipertensão Intracraniana / Hiponatremia Aguda com Convulsão (NaCl 3%) (IV)	3 a 5 mL/kg de NaCl a 3% infundido em 10 a 15 minutos	Preparo rápido de NaCl 3%: 85 mL de SF 0,9% + 15 mL de NaCl 20%.
Higiene e Desobstrução Nasal (Tópico Nasal)	0,5 a 2 mL em cada narina com seringa ou spray de jato contínuo várias vezes ao dia	Fisioterapia desobstrutiva padrão

Contraindicações, restrições e monitorização

Alerta de Sobrecarga: Risco de acidose metabólica hiperclorêmica em grandes volumes de SF0,9%; monitorar débito cardíaco e eletrólitos.

Hiponatremia Crônica: Correção rápida de sódio (> 10-12 mEq/L em 24h) contraindicada pelo risco de Mielinólise Pontina Central.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

121. Clorpromazina (cloridrato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Gotas 40 mg/mL (1 gota = 1 mg)

Comprimidos 25 mg e 100 mg

Solução injetável 5 mg/mL (ampola 5 mL = 25 mg)

Indicações e Linha de Tratamento

Antipsicótico fenotiazínico típico de baixa potência com forte efeito sedativo e antiemético. Indicado no controle da agitação psicomotora grave, soluções intratáveis, náuseas e vômitos refratários em cuidados paliativos e coreia de Sydenham grave.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Agitação Psicomotora / Agitação Grave (VO)	Crianças ≥ 1 ano: 0,5 a 1 mg/kg/dose a cada 6 a 8 horas (Máx: 40 mg/dia em < 5 anos e 75 mg/dia em 5-12 anos).	Dividido a cada 6 a 8 horas
Via Parenteral de Urgência (IM)	0,5 mg/kg/dose a cada 6 a 8 horas (injeção IM profunda lenta)	Monitorar PA deitado por 30 minutos.

Contraindicações, restrições e monitorização

Idade: Contraindicado para menores de 1 ano.

Condições: Depressão grave do SNC, coma, discrasias sanguíneas e risco elevado de Síndrome Neuroléptica Maligna e hipotensão postural por bloqueio alfa-adrenérgico.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

122. Clotrimazol

Auditoria documental Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Creme dermatológico 10 mg/g (1%)

Solução tópica 10 mg/mL

Creme vaginal 10 mg/g e 20 mg/g

Indicações e Linha de Tratamento

Antifúngico imidazólico de uso tópico. Primeira linha no tratamento de dermatite de fraldas associada a Candida albicans (monilíase perineal), tinha corporal/crural e candidíase cutânea.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Dermatite de Fraldas por Candida / Tineas (Tópico)	Aplicar fina camada sobre a área afetada 2 a 3 vezes ao dia após higiene e secagem cuidadosa.	Manter por 7 a 14 dias (continuar por 3 a 5 dias após cicatrização clínica).

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipersensibilidade aos imidazólicos; não aplicar em mucosas oculares.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

123. Codeína (fosfato)

Auditoria documental Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução oral 3 mg/mL

Comprimidos 30 mg e 60 mg

Solução injetável 30 mg/mL (ampola 2 mL = 60 mg)

Indicações e Linha de Tratamento

Opioide fraco pró-fármaco ativado pela enzima CYP2D6 em morfina. Historicamente utilizado para dor moderada.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Dor Aguda Moderada (Crianças ≥ 12 anos) (VO)	0,5 a 1 mg/kg/dose a cada 4 a 6 horas (Máx: 60 mg/dose e 240 mg/dia)	Uso restrito a adolescentes com indicação expressa.

Contraindicações, restrições e monitorização

CONTRAINDICAÇÃO PEDIÁTRICA ESTRITA DA FDA E ANVISA: Contraindicada em TODOS os pacientes menores de 12 anos de idade, e em menores de 18 anos submetidos a tonsilectomia e/ou adenoidectomia devido ao risco fatal de depressão respiratória aguda e óbito em pacientes com fenótipo de metabolizadores ultrarrápidos do CYP2D6.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

124. Colecalciferol (Vitamina D3)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Gotas 200 UI/gota, 500 UI/gota e 1000 UI/gota

Solução oral 2.000 UI/mL e 10.000 UI/mL

Cápsulas gelatinosas 1.000 UI, 2.000 UI, 5.000 UI, 7.000 UI, 10.000 UI e 50.000 UI

Ampolas injetáveis IM

Indicações e Linha de Tratamento

Vitamina lipossolúvel reguladora da homeostase do cálcio e mineralização óssea. Primeira linha na prevenção e tratamento do Raquitismo carencial e Hipovitaminose D (Diretrizes SBP).

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Profilaxia SBP — Lactentes de 0 a 12 meses (VO)	400 UI/dia a partir da primeira semana de vida (inclusive em aleitamento materno exclusivo). Prematuros < 1500g: 400 a 800 UI/dia.	Dose única diária contínua
Profilaxia SBP — Crianças > 1 ano e Adolescentes (VO)	600 UI/dia	Dose única diária contínua
Tratamento do Raquitismo / Deficiência (< 20 ng/mL) (VO)	2.000 UI/dia (ou 50.000 UI uma vez por semana) por 6 a 12 semanas, seguido de manutenção com 600 a 1000 UI/dia.	Associar reposição adequada de cálcio elementar.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipercalcemia, hipervitaminose D, litíase renal cálcica e osteodistrofia renal com hiperfosfatemia não controlada.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

125. Colestiramina

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó para suspensão oral em envelopes/sachês de 4 g

Indicações e Linha de Tratamento

Resina de troca iônica que sequestra ácidos biliares no intestino. Indicada no alívio do prurido na colestase crônica, hipercolesterolemia primária em crianças e diarreia secretória pós-ressecção ileal.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Prurido na Colestase / Hipercolesterolemia (VO)	240 mg/kg/dia de colestiramina anidra dividido em 2 a 3 doses junto às principais refeições (Dose habitual: 2 a 4 g/dia; Máx: 8 g/dia em crianças e 16 g/dia em adolescentes).	Misturar sempre em água, suco ou compota (nunca ingerir o pó seco).

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Obstrução biliar completa e constipação grave.

Interações: Reduz a absorção de vitaminas lipossolúveis (A, D, E, K), ácido fólico e medicamentos orais (tomar outros fármacos 1h antes ou 4h após).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

126. Colistimetato de sódio (Colistina)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó liofilizado para solução injetável/inalatória 1.000.000 UI (aprox. 80 mg) e 2.000.000 UI

Indicações e Linha de Tratamento

Polimixina parenteral e inalatória bactericida. Droga de resgate para infecções graves causadas por bacilos Gram-negativos multirresistentes (*Acinetobacter baumannii*, *Pseudomonas aeruginosa* e *Klebsiella pneumoniae* produtora de carbapenemase) e colonização crônica em fibrose cística.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Infecções Sistêmicas Graves — IV (Doses em Colistimetato)	75.000 a 150.000 UI/kg/dia (2,5 a 5 mg/kg/dia) dividido a cada 8 horas (Máx: 300 mg/dia)	Infusão intravenosa lenta em 60 minutos.
Fibrose Cística — Infecção por P. aeruginosa (Inalatória)	Crianças < 2 anos: 500.000 a 1.000.000 UI a cada 12h. Crianças ≥ 2 anos: 1.000.000 a 2.000.000 UI a cada 12h.	Nebulização com compressor dedicado após fisioterapia respiratória.

Contraindicações, restrições e monitorização

Toxicidade: Alto risco de nefrotoxicidade reversível e neurotoxicidade com bloqueio neuromuscular (fraqueza muscular, apneia, parestesias).

Condições: Miastenia gravis.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

127. Complexo B

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Gotas pediátricas

Xarope/solução oral

Comprimidos/drágeas

Solução injetável em ampolas de 2 mL

Indicações e Linha de Tratamento

Associação balanceada de vitaminas do complexo B (B1, B2, B3, B5, B6). Indicado na prevenção e tratamento de estados carenciais vitamínicos, desnutrição, suporte em doenças crônicas e nutrição parenteral.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Suplementação e Prevenção de Estados Carenciais (VO)	Lactentes: 5 a 10 gotas ao dia. Crianças de 1 a 6 anos: 10 a 20 gotas (ou 2,5 a 5 mL do xarope) ao dia. Crianças > 6 anos: 1 colher de chá (5 mL) ou 1 drágea 1 a 2 vezes ao dia.	Administrado preferencialmente junto às refeições.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipersensibilidade aos componentes; a via parenteral pode raramente causar reações anafiláticas.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

128. Dantroleno sódico

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó liofilizado para solução injetável 20 mg em frasco-ampola com diluente estéril (60 mL de água para injeção)

Cápsulas 25 mg, 50 mg e 100 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Relaxante muscular de ação direta que bloqueia a liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático via receptor de rianodina (RyR1). Antídoto específico de primeira linha para Hipertermia Maligna anestésica e Síndrome Neuroléptica Maligna grave.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Crise de Hipertermia Maligna (IV)	Dose inicial: 2,5 mg/kg em bolus IV rápido imediato. Repetir 1 a 2,5 mg/kg a cada 5 a 10 minutos conforme necessário até reversão da hipermetabolia, rigidez e acidose (Dose cumulativa até 10 a 20 mg/kg).	Seguido de manutenção IV de 1 mg/kg a cada 4 a 6 horas por 24 a 48 horas para prevenir recrudescência.

Contraindicações, restrições e monitorização

Emergência: Não existem contraindicações em vigência de Hipertermia Maligna aguda.

Preparo: Reconstituir cada frasco de 20 mg com 60 mL de água estéril sem bacteriostático e agitar vigorosamente até a solução ficar transparente.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

129. Daptomicina

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó liofilizado para solução injetável frasco-ampola 500 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Lipopeptídeo cíclico bactericida dependente de cálcio. Indicado em infecções graves de pele e partes moles, osteomielite, bacteremia e endocardite infecciosa direita causadas por *Staphylococcus aureus* resistente à metilicina (MRSA) e *Enterococcus faecium* resistente à vancomicina (VRE).

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Infecções de Pele e Partes Moles por MRSA (IV)	Crianças de 1 a 6 anos: 8 a 10 mg/kg/dia a cada 24h. Crianças de 7 a 11 anos: 7 mg/kg/dia a cada 24h. Crianças de 12 a 17 anos: 5 mg/kg/dia a cada 24h.	Infundir em 30 a 60 minutos diluído em SF 0,9% ou Ringer Lactato.
Bacteremia / Osteomielite por MRSA (IV)	9 a 12 mg/kg/dia em dose única diária	Dose otimizada sob controle infeccioso.

Contraindicações, restrições e monitorização

INATIVIDADE NA PNEUMONIA: ESTRITAMENTE CONTRAINDICADA PARA TRATAMENTO DE PNEUMONIA (a daptomicina é inativada e neutralizada pelo surfactante pulmonar alveolar).

Monitorização: Dosar creatinofosfoquinase (CPK) semanalmente pelo risco de miopatia e rabdomiólise.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

130. Deferasirox

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos dispersíveis 125 mg, 250 mg e 500 mg

Comprimidos revestidos 90 mg, 180 mg e 360 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Quelante de ferro oral tridentado com alta afinidade pelo ferro férrico. Primeira linha no tratamento da sobrecarga crônica de ferro pós-transfusional em pacientes com talassemia maior, anemia falciforme e outras anemias congênitas a partir de 2 anos de idade.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Sobrecarga de Ferro Pós-Transfusional (VO)	Comprimidos Dispersíveis: Inicial 20 mg/kg/dia (titular até 10 a 40 mg/kg/dia conforme ferritina sérica). Comprimidos Revestidos: Inicial 14 mg/kg/dia (titular até 7 a 28 mg/kg/dia).	Dose única diária em jejum (dispersar em água/suco de laranja) ou com refeição leve para os revestidos.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Insuficiência renal grave (ClCr < 40 mL/min), síndrome mielodisplásica de alto risco e disfunção hepática grave.

Monitorização: Creatinina sérica e proteinúria mensais e enzimas hepáticas.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

131. Deferoxamina (mesilato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó liofilizado para solução injetável frasco-ampola 500 mg e 2 g

Indicações e Linha de Tratamento

Quelante parenteral hexadentado de ferro. Indicado no tratamento da intoxicação aguda por ferro com níveis séricos tóxicos (> 500 mcg/dL) ou sintomas clínicos graves, e sobrecarga crônica de ferro em crianças.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Intoxicação Aguda por Ferro (IV)	15 mg/kg/hora em infusão intravenosa contínua em bomba (Velocidade máx: 15 mg/kg/h para evitar hipotensão severa; dose cumulativa máx: 6 g/dia).	Manter até a urina clarear (perda da coloração avermelhada 'vinho rosé') e ferritina/níveis de ferro normalizarem.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Anúria ou insuficiência renal grave (salvo com diálise concomitante).

Efeitos: Risco de hipotensão aguda se infundido em velocidade excessiva; risco de mucormicose em uso crônico.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

132. Deflazacorte

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Gotas 22,75 mg/mL (1 gota = 1 mg)

Suspensão oral 22,75 mg/mL

Comprimidos 6 mg e 30 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Glicocorticoide sintético oxazolinico com menor efeito negativo sobre o metabolismo ósseo e menor ganho de peso relativo que outros corticoides. Primeira linha no tratamento da Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) para preservação da força muscular e função respiratória, além de doenças autoimunes.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Distrofia Muscular de Duchenne (VO)	0,9 mg/kg/dia em dose única diária matinal (ou 1,2 mg/kg/dia em dias alternados)	Uso contínuo a longo prazo sob acompanhamento neuromuscular.
Anti-inflamatório / Imunossupressor Geral (VO)	0,25 a 1,5 mg/kg/dia	Dividido em 1 a 2 tomadas matinais

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Infecções sistêmicas ativas não tratadas, vacinas de vírus vivos durante o uso.

Monitorização: Monitorar crescimento linear, densitometria óssea e pressão arterial.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

133. Desloratadina

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Xarope/solução oral 0,5 mg/mL

Gotas 1,25 mg/mL e 2,5 mg/mL

Comprimidos orodispersíveis 2,5 mg e 5 mg

Comprimidos revestidos 5 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Anti-histamínico de segunda geração não sedativo (metabólito ativo da loratadina) com ação antagonista H1 potente e efeitos anti-inflamatórios adicionais. Indicado no tratamento de Rinite Alérgica e Urticária Aguda/Crônica a partir dos 6 meses de idade.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Rinite Alérgica / Urticária — 6 a 11 meses (VO)	1 mg (2 mL da solução oral ou 8 gotas de 2,5 mg/mL) uma vez ao dia	Dose única diária
Crianças de 1 a 5 anos (VO)	1,25 mg (2,5 mL da solução oral) uma vez ao dia	Dose única diária
Crianças de 6 a 11 anos (VO)	2,5 mg (5 mL da solução oral ou 1 cp orodispersível de 2,5 mg) uma vez ao dia	Dose única diária
Crianças ≥ 12 anos e Adolescentes (VO)	5 mg (1 comprimido de 5 mg) uma vez ao dia	Dose única diária

Contraindicações, restrições e monitorização

Idade: Não indicado para menores de 6 meses de idade.

Condições: Hipersensibilidade à desloratadina ou loratadina.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

134. Desmopressina (acetato - DDAVP)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Spray nasal 0,1 mg/mL (10 mcg/dose)

Solução nasal 0,1 mg/mL (com cânula graduada)

Comprimidos 0,1 mg e 0,2 mg

Comprimidos orodispersíveis sublinguais (MELT) 60 mcg, 120 mcg e 240 mcg

Solução injetável 4 mcg/mL (ampola 1 mL)

Indicações e Linha de Tratamento

Análogo sintético da vasopressina (hormônio antidiurético) com seletividade para receptores V2 e ação hemostática (libera Fator VIII e Fator de von Willebrand). Primeira linha no Diabetes Insipidus Central, Enurese Noturna Monossintomática em crianças ≥ 5 anos e hemostasia na Doença de von Willebrand tipo 1 e Hemofilia A leve.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Enurese Noturna Monossintomática (VO)	Comprimidos: Inicial 0,2 mg ao deitar (titular até 0,4 mg). MELT Sublingual: Inicial 120 mcg ao deitar (titular até 240 mcg).	Tomar 30 a 60 minutos antes de dormir com restrição hídrica estrita a partir de 1h antes até 8h após.
Diabetes Insipidus Central (VO/Nasal/IV)	Oral: 0,1 a 0,8 mg/dia dividido a cada 8 a 12h. Nasal: 5 a 20 mcg/dia em 1 a 2 doses. IV/SC: 0,5 a 2 mcg/dia dividido a cada 12h.	Titular por volume urinário e osmolalidade sérica.

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Hemostasia na Doença de von Willebrand / Hemofilia A leve (IV/SC)	0,3 mcg/kg diluído em 50 mL de SF0,9% infundido em 30 minutos	Dose pré-procedimento

Contraindicações, restrições e monitorização

Restrição Hídrica Obrigatória: Risco de intoxicação hídrica grave com hiponatremia dilucional fulminante, edema cerebral e convulsões se não for respeitada a restrição de líquidos.

Condições: Polidipsia psicogênica, insuficiência cardíaca congestiva, hiponatremia prévia e síndrome de von Willebrand tipo 2B.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

135. Desonida

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Creme, pomada e loção dermatológica 0,5 mg/g (0,05%)

Indicações e Linha de Tratamento

Glicocorticoide tópico não fluorado de baixa/média potência (Classe VI). Primeira escolha pediátrica no tratamento da Dermatite Atópica em face, pescoço e dobras, eczema infantil e dermatite de contato.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Dermatite Atópica / Eczema Infantil (Tópico)	Aplicar fina camada sobre as lesões 1 a 2 vezes ao dia por até 1 a 2 semanas nas crises agudas.	Após melhora, transicionar para emolientes hidratantes e inibidores de calcineurina tópicos se necessário.

Contraindicações, restrições e monitorização

Idade: Cautela em menores de 3 meses.

Condições: Infecções cutâneas virais (herpes, varicela), fúngicas ou bacterianas ativas no local.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

136. Dexametasona (acetato / fosfato dissódico)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Elixir/solução oral 0,1 mg/mL (0,5 mg/5 mL)

Comprimidos 0,5 mg, 0,75 mg e 4 mg

Solução injetável 2 mg/mL e 4 mg/mL (ampolas 1 mL e 2,5 mL)

Colírio oftálmico 0,1%

Pomada oftálmica 0,1%

Indicações e Linha de Tratamento

Glicocorticoide sistêmico de alta potência e longa ação (sem atividade mineralocorticoide). Primeira linha padrão-ouro absoluta no Crupe Viral (laringotraqueíte aguda) na dose única oral, exacerbação aguda de asma (esquema curto de 2 dias), edema cerebral vasogênico e adjuvante na Meningite bacteriana por H. influenzae/Pneumococo.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Crupe Viral / Laringite Estridulosa (VO/IM/IV)	0,15 a 0,6 mg/kg em dose única (Dose padrão mais utilizada: 0,15 a 0,3 mg/kg; Máx: 10 a 16 mg)	Dose oral única é tão eficaz quanto parenteral e atua por 48 a 72 horas.
Exacerbação Aguda de Asma (VO/IV)	0,6 mg/kg/dia uma vez ao dia por 2 dias consecutivos (Máx: 16 mg/dia)	Eficácia e adesão equivalentes a 5 dias de prednisolona.

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Edema Cerebral Tumoral / Hipertensão Intracraniana (IV)	Ataque: 0,5 a 1 mg/kg (Máx: 10 mg). Manutenção: 0,25 a 0,5 mg/kg/dia dividido a cada 6 horas.	Redução rápida de edema vasogênico.
Meningite Bacteriana — Adjuvante (IV)	0,15 mg/kg/dose a cada 6 horas por 2 a 4 dias (administrar 15 a 30 minutos antes ou junto com a 1ª dose de antimicrobiano)	Indicado principalmente na suspeita de H. influenzae tipo b e Pneumococo para prevenir sequelas auditivas.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Infecções fúngicas sistêmicas não tratadas, vacinas de vírus vivos.

Efeitos: Irritação gástrica, insônia transitória e hiperglicemia.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

137. Dexclorfeniramina (maleato)

Auditoria documental Presente nos dois anexos; concentrações simples checadas: OK

Apresentações Disponíveis

Solução oral 2 mg/5 mL (0,4 mg/mL)

Gotas 2,8 mg/mL (1 gota = 0,1 mg)

Comprimidos 2 mg

Drágeas de liberação prolongada 6 mg

Creme dermatológico 10 mg/g (1%)

Indicações e Linha de Tratamento

Anti-histamínico de primeira geração derivado da alquilamina com ação sedativa e antialérgica rápida. Indicado no alívio sintomático de reações alérgicas agudas, urticária, picadas de insetos, conjuntivite alérgica e prurido.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Alergias Agudas / Prurido — 2 a 5 anos (VO)	0,5 mg (1,25 mL ou 5 gotas) a cada 6 a 8 horas (Máx: 3 mg/dia)	A cada 6 a 8 horas
Crianças de 6 a 12 anos (VO)	1 mg (2,5 mL ou 10 gotas ou 1/2 comprimido) a cada 6 a 8 horas (Máx: 6 mg/dia)	A cada 6 a 8 horas
Crianças > 12 anos e Adolescentes (VO)	2 mg (5 mL ou 1 comprimido) a cada 6 a 8 horas (Máx: 12 mg/dia)	A cada 6 a 8 horas

Contraindicações, restrições e monitorização

Idade: Contraindicado para recém-nascidos e prematuros; não recomendado para menores de 2 anos pelo risco de sedação excessiva, apneia do sono e efeito excitatório paradoxal.

Condições: Asma aguda descompensada e glaucoma.

Checagem matemática automatizada

OK - 2 mg/5 mL = 0,4 mg/mL; declarado 0,4 mg/mL

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

138. Dexmedetomidina (cloridrato)

Auditoria documental Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável concentrada para infusão 100 mcg/mL (frasco-ampola 2 mL = 200 mcg)

Indicações e Linha de Tratamento

Agonista altamente seletivo dos receptores alfa-2 adrenérgicos com potente ação sedativa cooperativa, ansiolítica e poupadora de opioides sem causar depressão respiratória significativa. Primeira linha na sedação consciente em ventilação mecânica/desmame em UTI pediátrica e sedação para procedimentos não dolorosos (ressonância magnética/tomografia).

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Sedação em UTI Pediátrica pós-IOT / Desmame (IV)	Carga (opcional): 0,5 a 1 mcg/kg em 10 a 20 minutos (evitar se instabilidade hemodinâmica). Manutenção contínua: 0,2 a 1,4 mcg/kg/hora em bomba de infusão.	Titular pela escala COMFORT-B ou RASS. Diluir para 4 mcg/mL em SF0,9% ou SG5%.
Sedação para Exames de Imagem / Procedimentos (IV/Intranasal)	IV: 1 a 2 mcg/kg em 10 min, seguido de 1 mcg/kg/h. Intranasal (off-label): 2 a 3 mcg/kg com atomizador nasal (MAD).	Início intranasal em 15 a 25 minutos.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Bloqueio atrioventricular de 2º ou 3º grau sem marca-passo, choque cardiogênico, bradicardia severa e hipotensão grave não corrigida.

Descontinuação: Risco de taquicardia e hipertensão rebote após uso prolongado (> 48-72h); realizar desmame gradual.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

139. Dexpanthenol (Pró-vitamina B5)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pomada dermatológica 50 mg/g (5%)

Solução líquida tópica/oral 5%

Indicações e Linha de Tratamento

Precursor do ácido pantotênico essencial para a síntese de coenzima A, proliferação celular e epitelização. Primeira linha na prevenção e tratamento de assaduras da área de fraldas, fissuras mamárias em lactantes, queimaduras solares leves e dermatites superficiais.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Prevenção e Tratamento de Assaduras (Tópico)	Aplicar fina camada sobre a pele limpa e seca da área de fraldas a cada troca de fraldas.	Uso livre profilático contínuo

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipersensibilidade aos componentes da fórmula (extremamente raro).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

140. Diazepam

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos 5 mg e 10 mg

Solução injetável 5 mg/mL (ampola 2 mL = 10 mg)

Bisnaga/solução retal

Indicações e Linha de Tratamento

Benzodiazepínico clássico de ação rápida e meia-vida longa. Primeira linha no controle agudo do Estado de Mal Epiléptico na emergência, convulsões febris prolongadas, sedação pré-procedimento e espasmos musculares severos (tétano acidental).

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Estado de Mal Epiléptico — Via Intravenosa / Intraóssea (IV/IO)	0,2 a 0,3 mg/kg (Máx: 5 mg em < 5 anos e 10 mg em ≥ 5 anos)	Injeção IV lenta em 2 a 3 minutos (taxa ≤ 1-2 mg/min). Pode repetir uma vez após 5 a 10 minutos se convulsão persistir.

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Convulsão Aguda sem Acesso Venoso — Via Retal (Retal)	0,5 mg/kg (usar a solução injetável com seringa sem agulha ou sonda retal introduzida 3-5 cm)	Máx: 10 mg em < 10 anos e 20 mg em > 10 anos.

Contraindicações, restrições e monitorização

VIA INTRAMUSCULAR: ESTRITAMENTE DESACONSELHADA VIA IM (absorção errática, lenta e dolorosa).

Depressão Respiratória: Alto risco de apneia, depressão respiratória e hipotensão, potencializado por outros sedativos. Dispor de bolsa-válvula-máscara e flumazenil.

Condições: Miastenia gravis e insuficiência respiratória grave.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

141. Diazóxido

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Cápsulas 25 mg e 100 mg

Suspensão oral 50 mg/mL (frequentemente manipulada)

Indicações e Linha de Tratamento

Ativador dos canais de potássio sensíveis a ATP (K-ATP) nas células beta pancreáticas, inibindo a secreção de insulina. Primeira linha no tratamento do Hiperinsulinismo Congênito neonatal e hipoglicemia hiperinsulinêmica refratária.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Hiperinsulinismo Congênito Neonatal e Infantil (VO)	Dose inicial: 5 a 10 mg/kg/dia dividido a cada 8 horas. Titular conforme glicemias capilares até dose de manutenção de 10 a 15 mg/kg/dia (Máx: 20 mg/kg/dia).	Dividido a cada 8 horas. Sempre associar hidroclorotiazida para prevenir retenção hídrica grave.

Contraindicações, restrições e monitorização

Efeitos Cardiovasculares Graves: Alto risco de retenção hidrossalina maciça, insuficiência cardíaca congestiva e Hipertensão Pulmonar neonatal.

Monitorização: Ecocardiograma e balanço hídrico rigorosos.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

142. Diclofenaco (potássico / sódico / resinato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Gotas 15 mg/mL (resinato - 1 gota = 0,5 mg)

Comprimidos dispersíveis 50 mg

Drágeas/comprimidos 50 mg

Supositórios 12,5 mg, 25 mg e 50 mg

Solução injetável 75 mg/3 mL

Indicações e Linha de Tratamento

Anti-inflamatório não esteroideal derivado do ácido fenilacético. Indicado no controle sintomático de dor pós-operatória, dor ortopédica/trauma, artrite idiopática juvenil e dor odontológica.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Dor e Inflamação — Crianças ≥ 1 ano (VO/Retal)	0,5 a 2 mg/kg/dia (Dose habitual: 1 mg/kg/dia ou 1 gota/kg/dose a cada 8 a 12 horas; Máx: 3 mg/kg/dia ou 150 mg/dia).	Dividido a cada 8 ou 12 horas por no máximo 3 a 5 dias.

Contraindicações, restrições e monitorização

Idade: Contraindicado para menores de 1 ano de idade.

Condições: Úlcera péptica ativa, hemorragia gastrointestinal, desidratação grave, insuficiência renal e suspeita de dengue (risco de sangramento e plaquetopenia).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

143. Difenidramina (cloridrato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução oral/xarope 2,5 mg/mL

Solução injetável 50 mg/mL (ampola 1 mL)

Indicações e Linha de Tratamento

Anti-histamínico de primeira geração da classe das etanolaminas com potente ação sedativa, anticolinérgica e antiemética. Indicado no tratamento de reações anafiláticas (adjuvante à adrenalina), reações extrapiramidais agudas por antidopaminérgicos e prurido alérgico.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Reações Alérgicas / Anafilaxia Adjuvante (IV/IM/VO)	1 mg/kg/dose (Máx: 50 mg/dose)	A cada 6 horas (Dose diária: 5 mg/kg/dia; Máx: 300 mg/dia). Injeção IV lenta em 2 a 3 minutos.

Contraindicações, restrições e monitorização

Idade: Contraindicado em neonatos e prematuros.

Condições: Asma aguda descompensada e obstrução do colo vesical.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

144. Digoxina

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Elixir pediátrico/solução oral 0,05 mg/mL (50 mcg/mL)

Comprimidos 0,25 mg

Solução injetável 0,25 mg/mL (ampola 2 mL = 0,5 mg)

Indicações e Linha de Tratamento

Glicosídeo cardíaco inotrópico positivo e cronotrópico negativo (inibidor da bomba Na⁺/K⁺-ATPase). Indicado no controle da frequência ventricular em taquiarritmias supraventriculares crônicas (flutter/fibrilação atrial) e suporte inotrópico na insuficiência cardíaca com shunt congênito volumoso.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Dose de Digitalização Rápida (Carga) (VO)	Prematuros: 20 mcg/kg. Termo a 2 meses: 30 mcg/kg. 2 meses a 2 anos: 40 a 50 mcg/kg. > 2 anos: 30 a 40 mcg/kg.	Administrar 50% da dose de ataque imediatamente, 25% após 6 a 8h e 25% após mais 6 a 8h.
Manutenção Diária (VO)	Prematuros: 5 mcg/kg/dia. Termo: 8 a 10 mcg/kg/dia. 2 meses a 2 anos: 10 a 12 mcg/kg/dia. > 2 anos: 8 a 10 mcg/kg/dia.	Dividido a cada 12 horas. Nível sérico terapêutico alvo: 0,8 a 2,0 ng/mL.

Contraindicações, restrições e monitorização

Intoxicação Digitalica: Janela terapêutica extremamente estreita; hipocalemia e hipomagnesemia precipitam arritmias ventriculares fatais.

Condições: Bloqueio AV de 2º ou 3º grau, síndrome de Wolff-Parkinson-White e miocardiopatia hipertrófica obstrutiva.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

145. Diltiazem (cloridrato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos 30 mg e 60 mg

Pó injetável 25 mg e 50 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Bloqueador dos canais de cálcio benzotiazepínico de classe IV antiarrítmico. Indicado no controle agudo e crônico da frequência cardíaca em taquicardias supraventriculares e hipertensão arterial sob supervisão cardiológica pediátrica.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Controle de Taquiarritmia Supraventricular (IV)	0,25 mg/kg em bolus IV lento em 2 minutos (Máx: 20 mg). Pode repetir 0,35 mg/kg após 15 min.	Seguido de infusão contínua de 5 a 15 mcg/kg/min se necessário.
Hipertensão / Manutenção (VO)	1,5 a 3,5 mg/kg/dia dividido a cada 8 horas (Máx: 360 mg/dia)	Dividido a cada 8 horas

Contraindicações, restrições e monitorização

Idade: Cautela extrema e desaconselhado em menores de 1 ano pelo risco de colapso cardiovascular e choque refratário.

Condições: Disfunção ventricular sistólica grave e bloqueio AV avançado.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

146. Dimenidrinato + Piridoxina

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Gotas 25 mg/mL + 5 mg/mL (1 gota = 1,25 mg dimenidrinato)

Solução oral 12,5 mg/5 mL + 5 mg/5 mL

Comprimidos 50 mg + 10 mg e 100 mg + 10 mg

Solução injetável 50 mg/mL (ampola 1 mL)

Indicações e Linha de Tratamento

Anti-histamínico H1 com potente ação anticinetótica, antiemética e sedativa central associado à piridoxina (vitamina B6). Indicado na prevenção e tratamento da cinetose (enjoo de movimento), labirintopatias e vômitos.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Cinetose e Vômitos — Crianças de 2 a 6 anos (VO)	12,5 a 25 mg (ou 1 gota/kg/dose) a cada 6 a 8 horas (Máx: 75 mg/dia)	Administrar 30 minutos antes de viagens.
Crianças de 6 a 12 anos (VO)	25 a 50 mg a cada 6 a 8 horas (Máx: 150 mg/dia)	A cada 6 a 8 horas
Via Parenteral (IM/IV lento)	1,25 mg/kg/dose a cada 6 horas (Máx: 300 mg/dia)	Infundir lentamente

Contraindicações, restrições e monitorização

Idade: Contraindicado para menores de 2 anos devido ao risco de sedação excessiva, convulsões e depressão respiratória.

Condições: Glaucoma e epilepsia.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

147. Dimercaprol (BAL)

Auditoria documental Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável oleosa 100 mg/mL (ampola 3 mL = 300 mg)

Indicações e Linha de Tratamento

Agente quelante de metais pesados com grupos sulfidríla livres (British Anti-Lewisite). Primeira linha no tratamento da intoxicação aguda grave por Arsênio, Ouro, Mercúrio inorgânico e Encefalopatia por Chumbo grave (associado a EDTA dissódico de cálcio).

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Encefalopatia por Chumbo Grave / Intoxicações Graves (IM)	75 mg/m ² /dose (ou 3 a 5 mg/kg/dose) a cada 4 horas por 2 dias, depois a cada 6h por 2 dias e a cada 12h por 3 dias.	Injeção intramuscular profunda exclusiva em óleo de amendoim.

Contraindicações, restrições e monitorização

Alergias Alimentares: Contraindicado em pacientes com alergia comprovada a amendoim (veículo oleoso).

Condições: Insuficiência hepática grave e intoxicação por cádmio ou ferro (complexos nefrotóxicos).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

148. Dipirona sódica (Metamizol)

Auditoria documental Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Gotas 500 mg/mL (1 gota = 25 mg)

Solução oral 50 mg/mL (250 mg/5 mL)

Comprimidos 500 mg e 1 g

Supositórios 300 mg

Solução injetável 500 mg/mL (ampolas 2 mL = 1 g)

Indicações e Linha de Tratamento

Analgésico, antipirético e espasmolítico não opioide derivado pirazolônico padrão-ouro na pediatria brasileira. Primeira linha no controle da febre e dor aguda de intensidade leve a moderada na emergência e ambulatório.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Dor e Febre — Via Oral (VO)	10 a 25 mg/kg/dose (Dose padrão mais utilizada: 20 a 25 mg/kg/dose ou 1 gota/kg/dose da formulação 500 mg/mL)	A cada 6 horas (ou de 6/6h se necessário; Máx: 100 mg/kg/dia ou 4 g/dia).
Via Intravenosa / Intramuscular na Emergência (IV/IM)	15 a 25 mg/kg/dose (Máx: 1 g a 2 g por dose)	Infundir em pelo menos 15 a 30 minutos diluído em SF0,9% ou SG5% (nunca em bolus rápido pelo risco de hipotensão severa).

Contraindicações, restrições e monitorização

Idade: Contraindicado para menores de 3 meses ou peso < 5 kg.

Condições: Hipersensibilidade a pirazonas, deficiência congênita de G6PD (risco de crise hemolítica), porfiria hepática aguda e histórico de agranulocitose.

Via IV Rápida: A injeção IV rápida direta pode causar hipotensão arterial súbita e choque anafilactoide.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

149. Dobutamina (cloridrato)

Auditoria documental Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável concentrada para infusão 12,5 mg/mL (ampola 20 mL = 250 mg)

Indicações e Linha de Tratamento

Agonista adrenérgico sintético seletivo beta-1 com fraca atividade beta-2 e alfa-1 (inotrópico positivo potente com efeito vasodilatador periférico e redução da pós-carga). Primeira linha no Choque Cardiogênico e choque séptico com disfunção miocárdica e baixo débito cardíaco (choque frio).

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Choque Cardiogênico / Disfunção Miocárdica Pediátrica (IV/IO Contínuo)	2,5 a 20 mcg/kg/minuto em infusão contínua em bomba dedicada (Dose inicial habitual: 5 mcg/kg/min, titulada até 10 a 15 mcg/kg/min).	Diluição em SF0,9% ou SG5% em veia central ou periférica calibrosa.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Estenose subaórtica hipertrófica idiopática (miocardiopatia hipertrófica obstrutiva) e hipovolemia não corrigida.

Efeitos: Taquicardia sinusal excessiva, arritmias ventriculares e aumento do consumo miocárdico de oxigênio.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

150. Domperidona

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Suspensão oral 1 mg/mL

Comprimidos 10 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Antagonista dopaminérgico periférico D2 com mínima passagem pela barreira hematoencefálica (baixo risco de efeitos extrapiramidais). Indicado no tratamento sintomático de náuseas, vômitos e retardo do esvaziamento gástrico (gastroparesia) em pediatria.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Náuseas, Vômitos e Dispepsia (VO)	0,25 mg/kg/dose (0,25 mL/kg/dose) administrado 15 a 30 minutos antes das principais refeições	3 vezes ao dia (Dose máxima diária: 0,75 mg/kg/dia ou 30 mg/dia). Limitar a duração ao menor tempo possível.

Contraindicações, restrições e monitorização

Cardiotoxicidade: Risco de prolongamento do intervalo QTc e arritmias ventriculares graves (Torsades de pointes), especialmente se coadministrado com inibidores potentes do CYP3A4 (fluconazol, claritromicina).

Condições: Hemorragia gastrointestinal, obstrução mecânica, perfuração e prolactinoma.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

151. Dopamina (cloridrato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável concentrada para infusão 5 mg/mL (ampola 10 mL = 50 mg)

Indicações e Linha de Tratamento

Amina vasoativa precursora da noradrenalina com efeitos dose-dependentes (dopaminérgicos, beta-1 e alfa-1 adrenérgicos). Indicada como segunda linha no choque distributivo/séptico com hipotensão refratária e suporte hemodinâmico neonatal.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Choque Pediátrico / Hipotensão (IV/IO Contínuo)	2 a 20 mcg/kg/minuto em infusão contínua em bomba dedicada. (Dose inotrópica: 5 a 10 mcg/kg/min; Dose vasopressora: 10 a 20 mcg/kg/min).	Diluição em SF0,9% ou SG5% preferencialmente por acesso venoso central.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Feocromocitoma, taquiarritmias ventriculares não controladas e fibrilação ventricular.

Efeitos: Taquicardia importante e vasoconstrição periférica excessiva com isquemia de extremidades em doses elevadas.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

152. Doxazosina (mesilato)

Auditoria documental	Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática
----------------------	--

Apresentações Disponíveis

Comprimidos 2 mg e 4 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Bloqueador seletivo dos receptores alfa-1 adrenérgicos pós-sinápticos. Indicado no controle da bexiga neurogênica (redução da resistência do colo vesical e melhora do esvaziamento) e como anti-hipertensivo adjuvante em feocromocitoma pré-operatório.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Bexiga Neurogênica Pediátrica / Hipertensão (VO)	Crianças ≥ 4 anos: Inicial 0,5 a 1 mg uma vez ao dia ao deitar. Titular a cada 1 a 2 semanas até 2 a 4 mg/dia conforme urodinâmica e PA.	Dose única diária noturna (minimiza efeito de primeira dose).

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipotensão ortostática prévia, histórico de síncope vasovagal e hipersensibilidade a quinazolinias.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

153. Doxíciclina (hiclato / monoidrato)

Auditoria documental	Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática
----------------------	--

Apresentações Disponíveis

Comprimidos solúveis/revestidos 100 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Antimicrobiano tetraciclínico de segunda geração. Primeira linha absoluta para Febre Maculosa Brasileira (*Rickettsia rickettsii*) em qualquer idade pediátrica, Febre Q, Bartonelose, Doença de Lyme, pneumonia por *Chlamydia psittaci* e profilaxia de malária.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Febre Maculosa Brasileira — QUALQUER IDADE (VO/IV)	Crianças < 45 kg: 2,2 mg/kg/dose a cada 12 horas (4,4 mg/kg/dia). Crianças ≥ 45 kg: 100 mg a cada 12 horas.	Iniciar imediatamente na suspeita clínica. Manter por 3 dias após a defervescência (mínimo 7 a 10 dias).
Infeções Respiratórias / Clamídia (≥ 8 anos) (VO)	2 a 4 mg/kg/dia dividido a cada 12 ou 24 horas (Máx: 200 mg/dia)	Administrar com copo cheio de água e manter paciente ereto.

Contraindicações, restrições e monitorização

FEBRE MACULOSA (EXCEÇÃO SALVADORA): Não existem contraindicações de idade para o tratamento da Febre Maculosa (a doxíciclina tem baixa ligação ao cálcio e menor risco de manchas dentárias que tetraciclina antigas, sendo mandatória pelo risco de morte).

Condições Gerais: Hipersensibilidade a tetraciclina e gestação.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

154. Dropropizina

Auditoria documental Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Xarope pediátrico 1,5 mg/mL (7,5 mg/5 mL)

Xarope adulto 3 mg/mL (15 mg/5 mL)

Gotas 30 mg/mL

Indicações e Linha de Tratamento

Antitussígeno de ação periférica nos receptores traqueobrônquicos (sem ação sedativa central significativa nem depressão respiratória). Indicado no alívio sintomático da tosse seca, irritativa e não produtiva em crianças $\geq$ 2 anos.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Tosse Seca Irritativa — 2 a 3 anos (VO)	0,25 a 0,5 mg/kg/dose (ou 4 a 8 gotas) 3 a 4 vezes ao dia	A cada 6 a 8 horas
Crianças de 3 a 12 anos (VO)	7,5 mg (5 mL do xarope pediátrico) 3 a 4 vezes ao dia	A cada 6 a 8 horas
Crianças > 12 anos e Adolescentes (VO)	15 mg (5 mL do xarope adulto ou 10 mL do pediátrico)	3 a 4 vezes ao dia

Contraindicações, restrições e monitorização

Idade: Contraindicado para menores de 2 anos de idade.

Condições: Tosse produtiva com hipersecreção (risco de retenção de secreções), asma brônquica aguda e insuficiência respiratória.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

155. Emulsão lipídica 20%

Auditoria documental Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Emulsão estéril para infusão IV 200 mg/mL (frascos de 100 mL, 250 mL e 500 mL)

Indicações e Linha de Tratamento

Solução de triglicerídeos de cadeia longa/média para nutrição parenteral e antídoto de resgate padrão-ouro na Intoxicação Sistêmica por Anestésicos Locais (LAST - bupivacaína, lidocaína, ropivacaína) e sobredosagem lipofílica refratária (betabloqueadores, bloqueadores de canal de cálcio).

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Resgate em Toxicidade por Anestésico Local (LAST) (IV)	Bolus inicial: 1,5 mL/kg de emulsão a 20% em 1 minuto. Seguido imediatamente de infusão contínua de 0,25 mL/kg/minuto (15 mL/kg/hora).	Se colapso persistir, pode repetir o bolus até 2 vezes a cada 3 a 5 minutos e aumentar a infusão para 0,5 mL/kg/min (Dose máxima nas primeiras 24h: 10 a 12 mL/kg).

Contraindicações, restrições e monitorização

Emergência: Sem contraindicações em parada cardiorrespiratória ou toxicidade aguda por anestésico local.

Condições em NPT: Hiperlipidemia grave, pancreatite aguda necrotizante e nefrose lipoide.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

156. Enalapril (maleato) / Enalaprilato

Auditoria documental Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos 5 mg, 10 mg e 20 mg

Enalaprilato injetável 1,25 mg/mL (ampola 1 mL ou 2 mL)

Indicações e Linha de Tratamento

Inibidor da Enzima Conversora de Angiotensina (IECA) de ação prolongada. Primeira linha no tratamento da Hipertensão Arterial pediátrica, Insuficiência Cardíaca Congestiva com disfunção ventricular e nefropatia proteinúrica.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Hipertensão Arterial / Insuficiência Cardíaca (VO)	Inicial: 0,08 a 0,1 mg/kg/dia em dose única ou a cada 12 horas. Titular gradualmente a cada 1 a 2 semanas até dose de manutenção de 0,1 a 0,5 mg/kg/dia (Máx: 0,6 mg/kg/dia ou 40 mg/dia).	Dose diária única ou dividida a cada 12 horas.
Emergência Hipertensiva — Enalaprilato (IV)	5 a 10 mcg/kg/dose a cada 8 a 12 horas em infusão lenta de 5 minutos	Hospitalar

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Estenose bilateral de artéria renal (ou estenose de artéria em rim único), histórico de angioedema por IECA e gravidez.

Monitorização: Creatinina e potássio séricos antes e após o início da terapia.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

157. Enoxaparina sódica

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável em seringas preenchidas com sistema de segurança 20 mg/0,2 mL, 40 mg/0,4 mL, 60 mg/0,6 mL, 80 mg/0,8 mL e 100 mg/1,0 mL

Indicações e Linha de Tratamento

Heparina de baixo peso molecular (HBPM) com potente atividade anti-fator Xa. Primeira linha na prevenção e tratamento do Tromboembolismo Venoso (TEV), trombose associada a cateter venoso central e trombose intracardíaca em pediatria.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Tratamento de Tromboembolismo Venoso (SC)	Lactentes < 2 meses: 1,5 mg/kg/dose a cada 12 horas. Crianças ≥ 2 meses a 18 anos: 1,0 mg/kg/dose a cada 12 horas.	Injeção subcutânea profunda. Titular a dose para atingir atividade anti-Xa entre 0,5 e 1,0 UI/mL (coletar 4 horas após a 2ª ou 3ª dose).
Profilaxia de TEV em Pacientes de Alto Risco (SC)	Lactentes < 2 meses: 0,75 mg/kg/dose a cada 12h. Crianças ≥ 2 meses: 0,5 mg/kg/dose a cada 12h (Alvo anti-Xa: 0,2 a 0,4 UI/mL).	Subcutânea

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Sangramento ativo maior, histórico de Trombocitopenia Induzida por Heparina (HIT) e coagulopatia grave.

Procedimentos: Suspender 24 horas antes de anestesia neuraxial (raqui/peridural) ou punção lombar.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

158. Enzimas pancreáticas (Pancreatina / Pancrelipase)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Cápsulas com microgrânulos gastrorresistentes de 10.000 UI, 25.000 UI e 40.000 UI de lipase

Indicações e Linha de Tratamento

Terapia de reposição enzimática pancreática contendo lipase, amilase e protease. Primeira linha no tratamento da Insuficiência Pancreática Exócrina associada à Fibrose Cística, pancreatite crônica e ressecções pancreáticas.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Fibrose Cística — Lactentes até 12 meses (VO)	2.000 a 4.000 UI de lipase por cada 120 mL de leite ou mamada	Abriu a cápsula e misturar os microgrânulos em pequena porção de alimento ácido (purê de maçã/banana). Não mastigar nem triturar.
Fibrose Cística — Crianças > 1 ano (VO)	500 a 1.000 UI de lipase/kg por refeição principal (e metade da dose em lanches intermediários).	Titular conforme consistência das fezes (Dose máxima de segurança: ≤ 2.500 UI de lipase/kg por refeição ou ≤ 10.000 UI/kg/dia).

Contraindicações, restrições e monitorização

Colonopatia Fibrosante: Doses cumulativas excessivas (> 10.000 UI de lipase/kg/dia) estão estritamente contraindicadas pelo risco de estenose e fibrose colônica grave.

Instruções: Não misturar com leite ou fórmulas alcalinas para não dissolver o revestimento entérico prematuramente na boca.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

159. Epoprostenol sódico

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó liofilizado para solução injetável para infusão contínua 0,5 mg e 1,5 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Prostaciclina sintética (PGI₂) vasodilatadora pulmonar e inibidora da agregação plaquetária potente. Indicado no tratamento da Hipertensão Arterial Pulmonar idiopática grave (Classe Funcional III e IV) em pediatria via infusão intravenosa contínua.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Hipertensão Arterial Pulmonar Grave (IV Contínuo)	Inicial: 1 a 2 ng/kg/minuto em infusão contínua através de cateter venoso central exclusivo com bomba dedicada.	Titular em incrementos de 1 a 2 ng/kg/min a cada 15 a 30 minutos ou dias até dose de manutenção eficaz (habitualmente 20 a 40 ng/kg/min).

Contraindicações, restrições e monitorização

Interrupção Abrupta Fatal: A interrupção súbita da infusão causa rebote de hipertensão pulmonar fulminante e parada cardíaca.

Condições: Insuficiência cardíaca esquerda com congestão pulmonar grave.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

160. Eritromicina (estolato / etilsuccinato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó para suspensão oral 125 mg/5 mL e 250 mg/5 mL

Comprimidos 250 mg e 500 mg

Pomada oftálmica 0,5%

Indicações e Linha de Tratamento

Antimicrobiano macrolídeo e pró-cinético gastrointestinal (agonista dos receptores de motilina). Indicado na profilaxia da oftalmia neonatal por gonococo/clamídia, coqueluche, pneumonia atípica e gastroparesia/intolerância alimentar em UTI pediátrica.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Infecções Respiratórias / Coqueluche (VO)	30 a 50 mg/kg/dia dividido a cada 6 a 8 horas por 10 a 14 dias (Máx: 2 g/dia)	Administrar junto com as refeições para reduzir cólicas intestinais.
Ação Pró-Cinética Gastrointestinal (VO/IV)	1 a 3 mg/kg/dose a cada 6 a 8 horas em infusão lenta de 60 min	Dose baixa pró-cinética
Profilaxia da Oftalmia Neonatal (Pomada Oftálmica)	Aplicar fita de 1 cm em cada saco conjuntival na primeira hora de vida	Dose única neonatal

Contraindicações, restrições e monitorização

Estenose Hipertrófica do Píloro: Alto risco associado ao uso de eritromicina oral em recém-nascidos e prematuros nas primeiras 2 a 6 semanas de vida.

Hepatotoxicidade: O estolato de eritromicina tem maior risco de hepatite colestática.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

161. Ertapenem sódico

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó liofilizado para solução injetável frasco-ampola 1 g

Indicações e Linha de Tratamento

Carbapenêmico de longa meia-vida com dose diária única. Indicado no tratamento de infecções intra-abdominais complicadas, infecções do trato urinário complicadas e infecções de pele graves causadas por enterobactérias produtoras de ESBL a partir de 3 meses de idade.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Infecções por Bactérias Produtoras de ESBL (IV/IM)	Crianças de 3 meses a 12 anos: 15 mg/kg/dose a cada 12 horas (Dose máxima diária: 1 g/dia). Crianças > 13 anos e Adolescentes: 1 g uma vez ao dia.	Infusão intravenosa lenta em 30 minutos diluído em SF0,9%.

Contraindicações, restrições e monitorização

Inatividade contra Pseudomonas: Não possui atividade contra Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter baumannii.

Condições: Hipersensibilidade grave a carbapenêmicos.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

162. Escitalopram (oxalato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Gotas 20 mg/mL (1 gota = 1 mg)

Comprimidos 10 mg, 15 mg e 20 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Inibidor seletivo da recaptação de serotonina (ISRS) com a mais alta seletividade pelo transportador 5-HTT. Primeira linha no tratamento do Transtorno Depressivo Maior e Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) em adolescentes ≥ 12 anos.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Depressão e Ansiedade em Adolescentes ≥ 12 anos (VO)	Inicial: 5 a 10 mg uma vez ao dia pela manhã ou à noite. Pode titular após 3 a 4 semanas para até 20 mg/dia.	Dose única diária contínua

Contraindicações, restrições e monitorização

Black Box Warning: Monitoramento rigoroso do risco de ideação suicida nas primeiras semanas de tratamento em jovens.

Condições: Prolongamento do intervalo QTc basal e uso concomitante de IMAO.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

163. Escopolamina (Butilbrometo de escopolamina)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Gotas 10 mg/mL (1 gota = 0,5 mg)

Solução oral

Comprimidos 10 mg

Solução injetável 20 mg/mL (ampola 1 mL)

Indicações e Linha de Tratamento

Antiespasmódico anticolinérgico derivado quaternário de amônio com ação espasmolítica sobre a musculatura lisa gastrointestinal, biliar e geniturinária. Indicado no alívio de cólicas abdominais intensas, espasmos biliares e uretrais.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Cólicas Abdominais — Crianças de 1 a 6 anos (VO)	0,3 a 0,5 mg/kg/dose (ou 10 a 20 gotas) 3 vezes ao dia	A cada 8 horas
Crianças > 6 anos e Adolescentes (VO)	10 a 20 mg (20 a 40 gotas ou 1 a 2 comprimidos) 3 a 4 vezes ao dia	A cada 6 a 8 horas
Via Parenteral de Urgência (IV/IM)	0,3 a 0,6 mg/kg/dose a cada 8 horas (Máx: 20 mg/dose)	Injeção IV lenta em 2 a 3 minutos.

Contraindicações, restrições e monitorização

Idade: Contraindicado para menores de 1 ano.

Condições: Obstrução intestinal mecânica, megacólon, glaucoma de ângulo fechado e miastenia gravis.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

164. Esmolol (cloridrato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável 10 mg/mL (frasco 10 mL = 100 mg)

Solução concentrada para diluição 250 mg/mL (ampola 10 mL = 2500 mg)

Indicações e Linha de Tratamento

Betabloqueador seletivo beta-1 de ação ultracurta metabolizado por esterases eritrocitárias (meia-vida de 9 minutos). Primeira linha na Emergência Hipertensiva pós-operatória de cirurgia cardíaca, dissecação aórtica e controle rápido de taquicardia supraventricular grave.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Emergência Hipertensiva / Taquiarritmias (IV Contínuo)	Dose de Ataque (opcional): 500 mcg/kg em 1 minuto. Manutenção: Iniciar com 50 a 100 mcg/kg/minuto, titulando a cada 5 a 10 minutos até 300 a 500 mcg/kg/minuto.	Infusão intravenosa contínua exclusiva em bomba sob monitorização cardíaca.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Choque cardiogênico, bradicardia grave, bloqueio AV de 2º ou 3º grau e asma grave descompensada.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

165. Esomeprazol magnésico / sódico

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Grânulos gastrorresistentes para suspensão oral em sachês de 10 mg

Comprimidos 20 mg e 40 mg

Pó liofilizado para solução injetável IV frasco-ampola 40 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Inibidor da Bomba de Prótons (S-enantiômero do omeprazol) com supressão ácida gástrica potente. Primeira linha na Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE) erosiva, esofagite eosinofílica e erradicação de *H. pylori* a partir de 1 mês de vida.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
DRGE / Esofagite Erosiva — 1 mês a 1 ano (peso 3 a 5 kg) (VO)	2,5 mg uma vez ao dia	Dose única diária pela manhã
Lactentes (peso > 5 a 7,5 kg) (VO)	5 mg uma vez ao dia	Dose única diária
Crianças (peso > 7,5 a 12 kg) (VO)	10 mg uma vez ao dia	Dose única diária
Crianças (peso 12 a 20 kg) (VO)	10 a 20 mg uma vez ao dia	Dose única diária
Crianças > 20 kg e Adolescentes (VO/IV)	20 a 40 mg uma vez ao dia (administrar 30 min antes do desjejum)	Infundir IV em 20 a 30 minutos.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipersensibilidade a benzimidazóis substituídos.

Preparo: Misturar o sachê de grânulos em 15 mL de água; não mastigar os microgrânulos.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

166. Espironolactona

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos 25 mg, 50 mg e 100 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Diurético antagonista específico da aldosterona (poupador de potássio). Primeira linha no tratamento de edemas refratários em Síndrome Nefrótica, cirrose hepática com ascite, hipertensão arterial secundária (hiperaldosteronismo) e insuficiência cardíaca congestiva.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Insuficiência Cardíaca / Síndrome Nefrótica / Hipertensão (VO)	Inicial: 1 a 2 mg/kg/dia em dose única ou dividido a cada 12 horas. Titular conforme balanço hídrico até 3 a 5 mg/kg/dia (Máx: 100 a 200 mg/dia).	Administrar junto com as refeições.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipercalemia (> 5,5 mEq/L), insuficiência renal aguda anúrica ou insuficiência renal crônica grave (ClCr < 30 mL/min) e Doença de Addison.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

167. Etambutol (cloridrato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos 400 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Antituberculoso sintético de primeira linha bactericida/bacteriostático (componente do esquema RHZE do Ministério da Saúde do Brasil). Indicado no tratamento da Tuberculose pulmonar e extrapulmonar em crianças e adolescentes a partir de 10 anos (ou mais jovens em tuberculose multirresistente).

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Esquema Básico de Tuberculose (RHZE) (VO)	15 a 20 mg/kg/dia (Dose habitual: 20 mg/kg/dia; Máx: 1200 mg/dia)	Dose única diária matinal em jejum na fase intensiva de ataque (primeiros 2 meses).

Contraindicações, restrições e monitorização

Neurite Óptica: Black box warning para neurite óptica retrobulbar dose-dependente com redução da acuidade visual e perda da discriminação das cores verde-vermelho (avaliar visão antes e durante o uso).

Idade: Usar com cautela extrema em menores de 5 a 6 anos pela impossibilidade de avaliar acuidade visual fidedignamente.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

168. Etomidato

Auditoria documental	Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática
----------------------	--

Apresentações Disponíveis

Emulsão/solução injetável 2 mg/mL (ampola 10 mL = 20 mg)

Indicações e Linha de Tratamento

Hipnótico de ação ultracurta derivado carboxilato imidazólico com notável estabilidade hemodinâmica (sem efeito inotrópico negativo ou vasodilatador significativo). Primeira linha na Sequência Rápida de Intubação em pacientes pediátricos instáveis com choque cardiogênico ou trauma grave.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Sequência Rápida de Intubação (SRI) (IV)	0,2 a 0,3 mg/kg em bolus IV lento em 30 a 60 segundos	Início de ação em 30 a 60 segundos; duração hipnótica de 5 a 10 minutos.

Contraindicações, restrições e monitorização

Supressão Adrenal: Inibe a enzima 11-beta-hidroxilase, causando supressão adrenocortical transitória (evitar infusão contínua prolongada em UTI e ter cautela no choque séptico).

Idade: Não recomendado para menores de 6 meses.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

169. Etossuximida

Auditoria documental	Presente nos dois anexos; concentrações simples checadas: OK
----------------------	--

Apresentações Disponíveis

Xarope 250 mg/5 mL (50 mg/mL)

Cápsulas 250 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Antiepiléptico bloqueador específico dos canais de cálcio tipo T nas células talâmicas. Primeira linha padrão-ouro absoluta no tratamento de Crises de Ausência Típicas da infância (Petit Mal).

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Crises de Ausência Típicas (VO)	Crianças de 3 a 6 anos: Inicial 15 mg/kg/dia (ou 250 mg/dia). Crianças > 6 anos: Inicial 250 a 500 mg/dia. Titular a cada 4 a 7 dias até dose de manutenção de 20 a 40 mg/kg/dia (Máx: 1500 mg/dia).	Dividido a cada 12 ou 24 horas com alimentos. Nível sérico terapêutico: 40 a 100 mcg/mL.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipersensibilidade a succinimidas, discrasias sanguíneas e insuficiência hepática ou renal grave.

Espectro: Não é eficaz contra crises tônico-clônicas generalizadas ou crises focais.

Checagem matemática automatizada

OK - 250 mg/5 mL = 50 mg/mL; declarado 50 mg/mL

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

170. Fenilefrina (cloridrato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução nasal 0,5 mg/mL (0,05%) e 1 mg/mL (0,1%)

Colírio oftálmico 2,5% e 10%

Solução injetável 10 mg/mL (ampola 1 mL)

Indicações e Linha de Tratamento

Agonista adrenérgico seletivo alfa-1 puro potente (vasoconstritor sem efeito inotrópico direto). Indicada no choque distributivo hiperdinâmico com taquicardia severa, crises de hipóxia na Tetralogia de Fallot (aumento da resistência vascular sistêmica) e midríase diagnóstica em oftalmologia.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Crise de Cianose na Tetralogia de Fallot (IV/IO)	5 a 20 mcg/kg em bolus IV lento a cada 10 a 15 minutos conforme necessário	Promove aumento da RVS e diminui o shunt D-E.
Choque Distributivo com Taquicardia (IV Contínuo)	0,1 a 0,5 mcg/kg/minuto em infusão contínua em bomba (titular até máx 2 a 5 mcg/kg/min).	Diluição em SF0,9% por acesso venoso central.

Contraindicações, restrições e monitorização

Descongestionantes Nasais em Pediatria: Soluções nasais tópicas são contraindicadas em menores de 6 anos pelo risco de absorção sistêmica, crise hipertensiva, arritmias e congestão rebote.

Colírio a 10%: Contraindicado em neonatos e lactentes (risco de crise hipertensiva fatal; usar apenas a formulação de 2,5%).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

171. Fenitoína sódica

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; concentrações simples checadas: OK

Apresentações Disponíveis

Suspensão oral 100 mg/5 mL (20 mg/mL)

Comprimidos 100 mg

Solução injetável 50 mg/mL (ampola 5 mL = 250 mg)

Indicações e Linha de Tratamento

Antiepiléptico bloqueador de canais de sódio dependentes de voltagem de ação prolongada. Primeira linha de segunda etapa no tratamento do Estado de Mal Epiléptico Pediátrico refratário a benzodiazepínicos e profilaxia de convulsões pós-trauma cranioencefálico.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Estado de Mal Epiléptico — Dose de Ataque (IV/IO)	15 a 20 mg/kg (Máx: 1000 a 1500 mg)	Infundir em SF0,9% puro (NUNCA em SG5% por precipitação imediata) em velocidade máxima de 1 mg/kg/minuto ou ≤ 50 mg/min sob monitorização contínua de ECG e PA.
Dose de Manutenção (VO/IV)	Lactentes e Crianças: 5 a 8 mg/kg/dia dividido a cada 8 a 12 horas. Adolescentes: 4 a 6 mg/kg/dia.	Nível sérico terapêutico: 10 a 20 mcg/mL.

Contraindicações, restrições e monitorização

VELOCIDADE DE INFUSÃO E SG5%: A infusão rápida provoca arritmias cardíacas fatais, bloqueio AV e colapso cardiovascular. O solvente precipita cristalização imediata em soluções glicosadas.

Condições: Bloqueio atrioventricular de 2º ou 3º grau e bradicardia sinusal.

Checagem matemática automatizada

OK - 100 mg/5 mL = 20 mg/mL; declarado 20 mg/mL

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

172. Fenobarbital sódico

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Gotas 40 mg/mL (1 gota = 1 mg)

Comprimidos 100 mg

Solução injetável 100 mg/mL (ampola 2 mL = 200 mg)

Indicações e Linha de Tratamento

Barbitúrico modulador do canal de cloro associado ao receptor GABA-A. Primeira linha padrão-ouro absoluta para Convulsões Neonatais de qualquer etiologia e terapia de resgate no Estado de Mal Epiléptico na infância.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Convulsões Neonatais — Dose de Ataque (IV/IO)	20 mg/kg em bolus lento em 10 a 15 minutos. Se as crises persistirem, podem ser administrados bolus adicionais de 5 a 10 mg/kg até dose cumulativa máxima de 40 mg/kg.	Infusão lenta. Manter suporte ventilatório imediato disponível.
Manutenção Neonatal (iniciar 12-24h pós-carga) (IV/VO)	3 a 5 mg/kg/dia em dose única diária ou a cada 12 horas	Titular por nível sérico (alvo: 15 a 40 mcg/mL).
Estado de Mal Epiléptico Pediátrico (IV)	15 a 20 mg/kg em infusão lenta de 15 a 20 minutos (Máx: 1000 mg)	Segunda/terceira linha na emergência

Contraindicações, restrições e monitorização

Depressão Respiratória: Alto risco de apneia profunda e hipotensão arterial em infusão rápida, especialmente quando precedido de benzodiazepínicos.

Condições: Porfíria aguda intermitente e insuficiência respiratória grave.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

173. Fenoterol (bromidrato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Gotas para inalação/nebulização 5 mg/mL (1 gota = 0,25 mg)

Aerossol inalatório pressurizado 100 mcg/puff

Indicações e Linha de Tratamento

Broncodilatador agonista beta-2 adrenérgico de curta ação (SABA). Indicado no alívio rápido e resgate do broncoespasmo agudo na crise asmática e exacerbações de sibilância na infância.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Crise Asmática Aguda — Nebulização (Inalatória)	1 gota para cada 3 a 5 kg de peso (0,05 a 0,1 mg/kg/dose; Máx: 10 a 20 gotas = 2,5 a 5 mg) diluído em 3 a 4 mL de SF0,9%.	A cada 20 minutos na primeira hora (associado a ipratrópio) e depois a cada 4 a 6 horas conforme gravidade.

Contraindicações, restrições e monitorização

Cardiotoxicidade: Menor seletividade beta-2 que o salbutamol; alto risco de taquicardia sinusal intensa, palpitações, hipocalcemia e tremores musculares em doses elevadas.

Condições: Cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva e taquiarritmias.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

174. Fentanila (citrato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável 50 mcg/mL (ampolas de 2 mL = 100 mcg, 5 mL = 250 mcg e 10 mL = 500 mcg)

Adesivo transdérmico 12 mcg/h, 25 mcg/h e 50 mcg/h

Indicações e Linha de Tratamento

Opioide sintético potente (100 vezes mais potente que a morfina) com alta lipossolubilidade e estabilidade cardiovascular. Primeira linha na analgesia em Sequência Rápida de Intubação, analgesia e sedação contínua pós-intubação em UTI, analgesia procedural e intranasal na dor aguda intensa.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Analgesia Aguda / Procedimento (IV/IO)	1 a 2 mcg/kg/dose em bolus lento em 2 a 3 minutos (pode repetir a cada 30-60 min)	Início em 1 a 2 minutos; duração de 30 a 60 minutos.
Analgesia Intranasal sem Acesso Venoso (≥ 1 ano) (Intranasal)	1,5 a 2 mcg/kg (usar formulação injetável 50 mcg/mL com atomizador nasal MAD; Máx: 100 mcg)	Início em 5 a 10 minutos; excelente para fraturas/queimaduras.
Infusão Contínua em UTI Pediátrica pós-IOT (IV)	1 a 4 mcg/kg/hora em infusão contínua em bomba de seringa	Titular por escalas de dor (FLACC, COMFORT).
Sequência Rápida de Intubação (SRI) (IV)	1 a 3 mcg/kg em bolus IV lento em 2 minutos	Atenua resposta hipertensiva e hiper-reatividade de via aérea.

Contraindicações, restrições e monitorização

TÓRAX RÍGIDO (RIGIDEZ TORÁCICA): A administração intravenosa rápida em bolus pode causar rigidez aguda da musculatura torácica e abdominal, impedindo a ventilação mecânica. Reverter imediatamente com bloqueador neuromuscular ou Naloxona.

Efeitos: Depressão respiratória e tolerância rápida com dependência física em infusões > 5 a 7 dias.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

175. Ferro aminoácido quelato / Bisglicinato ferroso

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Gotas 15 mg/mL e 30 mg/mL de ferro elementar

Solução oral

Comprimidos

Indicações e Linha de Tratamento

Complexo de ferro elementar quelado a aminoácidos (glicina) com alta biodisponibilidade e menor incidência de efeitos adversos gastrointestinais e manchas dentárias. Primeira linha para suplementação profilática e tratamento da Anemia Ferropriva na infância.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Profilaxia SBP — Lactentes a Termo (VO)	1 mg de ferro elementar/kg/dia a partir dos 3 a 6 meses de vida até os 2 anos	Dose única diária contínua
Profilaxia SBP — Prematuros e Baixo Peso (< 2500g) (VO)	Peso 1500-2499g: 2 mg/kg/dia a partir do 30º dia de vida. Peso 1000-1499g: 3 mg/kg/dia. Peso < 1000g: 4 mg/kg/dia por 1 ano.	Dose diária
Tratamento da Anemia Ferropriva (VO)	3 a 5 mg de ferro elementar/kg/dia	Dividido em 1 a 2 tomadas por 3 a 6 meses (até normalização da ferritina).

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hemocromatose, hemossiderose, anemias não ferroprivas (anemia falciforme, talassemia maior sem deficiência de ferro concomitante).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

176. Ferro polimaltosado (Complexo de hidróxido de ferro III polimaltosado)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Gotas 50 mg/mL de ferro elementar (1 gota = 2,5 mg de ferro elementar)

Xarope 10 mg/mL de ferro elementar (50 mg/5 mL)

Comprimidos mastigáveis 100 mg de ferro elementar

Solução injetável IM 100 mg/2 mL

Indicações e Linha de Tratamento

Complexo macromolecular de hidróxido de ferro III não iônico. Primeira linha na prevenção e tratamento da Anemia Ferropriva pediátrica, com a vantagem de não interagir com alimentos, leite ou sucos e apresentar excelente tolerabilidade gástrica.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Profilaxia da Anemia Ferropriva (SBP) (VO)	1 mg de ferro elementar/kg/dia (ou conforme peso de nascimento em prematuros)	Dose única diária junto com as refeições ou leite
Tratamento da Anemia Ferropriva (VO)	3 a 5 mg de ferro elementar/kg/dia (Dose habitual: 1 a 2 gotas/kg/dia em dose única ou dividida em 2 vezes)	Administrar durante ou logo após as refeições por 3 a 6 meses.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Sobrecarga de ferro orgânica e anemias hemolíticas puras.

Vantagem Farmacêutica: Pode ser misturado diretamente na mamadeira de leite, suco de frutas ou papinha sem perda de absorção.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

177. Fexofenadina (cloridrato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Suspensão oral 6 mg/mL (30 mg/5 mL)

Comprimidos revestidos 30 mg, 60 mg, 120 mg e 180 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Anti-histamínico de segunda geração não sedativo (metabólito ativo da terfenadina) sem efeito cardiotoxico sobre o intervalo QTc. Indicado no alívio de Rinite Alérgica e Urticária Crônica Espontânea a partir de 6 meses de idade.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Rinite Alérgica e Urticária — 6 meses a 2 anos (VO)	15 mg (2,5 mL da suspensão) a cada 12 horas	A cada 12 horas
Crianças de 2 a 11 anos (VO)	30 mg (5 mL da suspensão ou 1 comprimido de 30 mg) a cada 12 horas	A cada 12 horas
Crianças ≥ 12 anos e Adolescentes (VO)	60 mg a cada 12 horas ou 120 a 180 mg em dose única diária	Tomar com água (evitar sucos de frutas ácidas como maçã/laranja).

Contraindicações, restrições e monitorização

Idade: Não aprovado para menores de 6 meses de idade.

Interações: Sucos de frutas reduzem a absorção por inibição do polipeptídeo transportador OATP1A2.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

178. Filgrastim (G-CSF)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável em frasco-ampola ou seringa preenchida 300 mcg/mL (30 MU = 300 mcg/1 mL)

Indicações e Linha de Tratamento

Fator estimulador de colônias de granulócitos recombinante humano. Indicado na redução da duração e gravidade da neutropenia e incidência de neutropenia febril em quimioterapia oncológica pediátrica, neutropenia congênita grave (Síndrome de Kostmann) e transplante de células-tronco hematopoéticas.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Neutropenia Febril Pós-Quimioterapia (SC/IV)	5 mcg/kg/dia (ou 150 a 230 mcg/m ² /dia) em injeção SC diária única ou infusão IV lenta de 30 minutos.	Iniciar 24h após término da quimioterapia e manter até contagem absoluta de neutrófilos (CAN) > 1.500/mm ³ por 2 a 3 dias consecutivos.
Neutropenia Congênita Grave (SC)	12 mcg/kg/dia em dose única ou dividida em 2 vezes	Titular conforme CAN.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipersensibilidade a proteínas derivadas de E. coli, Síndrome Mielodisplásica ou Leucemia Mieloide Aguda com alta proliferação blastos.

Efeitos: Dor óssea medular transitória e risco de esplenomegalia com ruptura esplênica rara.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

179. Fisostigmina (salicilato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável 1 mg/mL (ampola 1 mL)

Indicações e Linha de Tratamento

Inibidor reversível da acetilcolinesterase que atravessa a barreira hematoencefálica. Antídoto específico de primeira linha para a Síndrome Anticolinérgica Central e Periférica grave induzida por superdosagem de atropina, anti-histamínicos de 1ª geração, escopolamina ou plantas tóxicas (trombeteira/Datura).

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Síndrome Anticolinérgica Grave (IV/IM)	0,02 mg/kg (Máx: 0,5 mg/dose em crianças pequenas e 2 mg em adolescentes) administrado em infusão intravenosa lenta em pelo menos 5 minutos.	Pode repetir a cada 10 a 20 minutos se os sintomas colinérgicos centrais (delírio, convulsões) persistirem.

Contraindicações, restrições e monitorização

CONTRAINDICAÇÃO ABSOLUTA NA INTOXICAÇÃO POR ANTIDEPRESSIVOS TRICÍCLICOS: Risco gravíssimo de assistolia e parada cardíaca fatal.

Condições: Obstrução intestinal ou urinária e asma brônquica.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

180. Fitomenadiona (Vitamina K1)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável 2 mg/0,2 mL (pediátrica) e 10 mg/mL (ampola 1 mL)

Indicações e Linha de Tratamento

Vitamina lipossolúvel essencial para gama-carboxilação dos fatores de coagulação dependentes de vitamina K (II, VII, IX, X, proteína C e S). Primeira linha na profilaxia da Doença Hemorrágica do Recém-Nascido (DHRN) e reversão de coagulopatia por antagonistas da vitamina K ou colestase grave.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Profilaxia da DHRN ao Nascimento (IM - Padrão Ouro SBP)	Recém-nascidos a termo e prematuros > 1000g: 1 mg (0,1 mL da solução de 10 mg/mL ou 0,1 mL da apresentação pediátrica de 2 mg/0,2 mL) IM em dose única no vasto lateral da coxa na primeira hora de vida.	Prematuros ≤ 1000g: 0,5 mg IM em dose única.
Sangramento Ativo / Coagulopatia por Hipovitaminose K (IV/SC)	0,25 a 0,5 mg/kg (Máx: 5 a 10 mg)	Infundir IV muito lentamente em 20 a 30 minutos.

Contraindicações, restrições e monitorização

Via IV Rápida: Risco de choque anafilactoide grave na administração intravenosa rápida direta sem diluição.

Profilaxia Oral: O esquema oral possui eficácia inferior na prevenção da forma tardia da DHRN com sangramento intracraniano.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

181. Flucitosina

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução para infusão IV 10 mg/mL

Cápsulas 250 mg e 500 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Antifúngico análogo de pirimidina fluorado (5-FC). Primeira linha em associação obrigatória com Anfotericina B no tratamento de indução da Meningite Criptocócica e infecções invasivas graves por Candida sistêmica.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Meningite Criptocócica / Candidíase Invasiva Grave (IV/VO)	100 mg/kg/dia dividido a cada 6 horas (25 mg/kg/dose a cada 6h)	Infusão IV lenta em 30 a 60 minutos por 2 semanas (fase de indução). Manter nível sérico de pico entre 40 e 80 mcg/mL.

Contraindicações, restrições e monitorização

Mielossupressão Grave: Black box warning para depressão de medula óssea (leucopenia, trombocitopenia e pancitopenia) quando níveis séricos > 100 mcg/mL.

Condições: Deficiência de di-hidropirimidina desidrogenase (DPD) e insuficiência renal não corrigida.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

182. Fluconazol

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó para suspensão oral 50 mg/5 mL e 200 mg/5 mL

Cápsulas 50 mg, 100 mg e 150 mg

Solução para infusão IV 2 mg/mL (bolsa 100 mL = 200 mg)

Indicações e Linha de Tratamento

Antifúngico triazólico de excelente biodisponibilidade oral e penetração no SNC. Primeira linha no tratamento e profilaxia de Candidíase orofaríngea e esofágica, candidemia por *Candida albicans*, meningite criptocócica (consolidação/manutenção) e profilaxia antifúngica em prematuros de extremo baixo peso (< 1000g).

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Candidíase Orofaríngea (VO)	Ataque: 6 mg/kg no dia 1. Manutenção: 3 mg/kg/dia em dose única por 7 a 14 dias (Máx: 100 mg/dia).	Dose única diária
Candidíase Sistêmica / Candidemia (IV/VO)	Ataque: 12 mg/kg no dia 1. Manutenção: 6 a 12 mg/kg/dia em dose única diária (Máx: 600 a 800 mg/dia).	Infusão IV lenta em 1 a 2 horas.
Profilaxia em Prematuros Extremos < 1000g (IV/VO)	3 a 6 mg/kg/dose duas vezes por semana (a cada 72h) por 4 a 6 semanas	Reduz drasticamente candidíase invasiva neonatal.

Contraindicações, restrições e monitorização

Interações Medicamentosas: Inibidor moderado do CYP2C9 e CYP3A4; aumenta níveis séricos de fenitoína, ciclosporina, tacrolimo e varfarina.

Resistência: *Candida krusei* é intrinsecamente resistente e *Candida glabrata* tem sensibilidade reduzida dose-dependente.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

183. Fludrocortisona (acetato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos 0,1 mg (100 mcg)

Indicações e Linha de Tratamento

Mineralocorticoide sintético de altíssima potência. Primeira linha de reposição hormonal mandatória na Hiperplasia Adrenal Congênita (forma perdedora de sal por deficiência de 21-hidroxilase), Doença de Addison e hipotensão ortostática neurogênica refratária.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Hiperplasia Adrenal Congênita Perdedora de Sal (VO)	Lactentes: 0,05 a 0,2 mg/dia (50 a 200 mcg/dia) em dose única diária ou dividido a cada 12h junto com suplementação de cloreto de sódio. Crianças maiores: 0,05 a 0,1 mg/dia.	Titular por pressão arterial, potássio, sódio e atividade de renina plasmática (PRA).

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipertensão arterial sistêmica descompensada, insuficiência cardíaca congestiva e edema generalizado.

Monitorização: Risco de hipocalcemia grave e hipertensão por hiperdosagem.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

184. Flumazenil

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável 0,1 mg/mL (ampola 5 mL = 0,5 mg)

Indicações e Linha de Tratamento

Antagonista competitivo específico do sítio de ligação dos benzodiazepínicos no receptor GABA-A. Antídoto de primeira linha para reversão da sedação excessiva ou depressão respiratória induzida por benzodiazepínicos em procedimentos diagnósticos ou anestésicos.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Reversão de Sedação por Benzodiazepínicos (IV)	0,01 mg/kg (0,1 mL/kg; Máx: 0,2 mg) administrado em 15 a 30 segundos. Pode repetir 0,01 mg/kg a cada 1 minuto até resposta clínica adequada (Dose cumulativa máxima: 1 mg em crianças ou 0,05 mg/kg).	Monitorar ressedação após 45 a 60 minutos (a meia-vida do flumazenil é mais curta que a da maioria dos benzodiazepínicos).

Contraindicações, restrições e monitorização

CONTRAINDICAÇÃO ABSOLUTA EM EPILEPSIA OU INTOXICAÇÃO MISTA: Contraindicado em pacientes epiléticos em uso crônico de benzodiazepínicos (risco de precipitar Estado de Mal Epilético refratário incontrolável) e em ingestão concomitante de antidepressivos tricíclicos (risco de convulsões e arritmias cardíacas fatais).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

185. Fluoxetina (cloridrato)

Auditoria documental Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Gotas 20 mg/mL (1 gota = 1 mg)

Cápsulas/comprimidos 10 mg e 20 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Inibidor seletivo da recaptação de serotonina (ISRS) de longa meia-vida. Primeira linha padrão-ouro aprovada pela FDA para Transtorno Depressivo Maior em crianças e adolescentes a partir de 8 anos e Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) a partir de 7 anos.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Transtorno Depressivo Maior (≥ 8 anos) (VO)	Inicial: 10 mg uma vez ao dia pela manhã. Pode aumentar após 2 a 4 semanas para 20 mg/dia conforme resposta clínica.	Dose única diária matinal
Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) (VO)	Inicial: 10 mg/dia. Titular gradualmente até 20 a 40 mg/dia (Máx: 60 mg/dia em adolescentes).	Tomar pela manhã

Contraindicações, restrições e monitorização

Black Box Warning: Monitorização estrita para piora de sintomas depressivos e risco de ideação/comportamento suicida no início da terapia.

Interações: Uso estritamente contraindicado com IMAO (intervalo de segurança de 5 semanas após suspensão da fluoxetina antes de iniciar IMAO).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

186. Fluticasona (furoato / propionato)

Auditoria documental Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Spray nasal aquoso 27,5 mcg (furoato) e 50 mcg (propionato)/dose

Aerossol inalatório pressurizado (spray) 50 mcg, 125 mcg e 250 mcg/dose

Cápsulas com pó para inalação 50 mcg, 100 mcg e 250 mcg/dose

Creme/pomada dermatológica 0,5 mg/g

Indicações e Linha de Tratamento

Corticoide tópico e inalatório de altíssima afinidade pelo receptor glicocorticoide e mínima biodisponibilidade sistêmica oral (< 1%). Primeira linha no controle da Asma Persistente (com espaçador valvulado) e Rinite Alérgica persistente moderada a grave.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Asma Persistente — Spray com Espaçador (Inalatória Oral)	Dose Baixa: 100 a 200 mcg/dia. Dose Média: 200 a 500 mcg/dia. Dose Alta: > 500 mcg/dia.	Dividido a cada 12 horas. Enxaguar a boca após o uso.
Rinite Alérgica — Furoato de Fluticasona (Spray Nasal)	Crianças de 2 a 11 anos: 1 jato (27,5 mcg) em cada narina uma vez ao dia (55 mcg/dia). ≥ 12 anos: 2 jatos em cada narina uma vez ao dia (110 mcg/dia).	Dose única diária
Rinite Alérgica — Propionato de Fluticasona (Spray Nasal)	Crianças ≥ 4 anos: 1 a 2 jatos (50 a 100 mcg) em cada narina uma vez ao dia	Dose matinal

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipersensibilidade aos componentes; infecções fúngicas ou herpéticas locais não tratadas.

Efeitos: Disfonia e candidíase oral (prevenidas com espaçador e bochecho com água pós-uso).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

187. Fomepizol

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável 1 g/mL (frasco-ampola 1,5 mL)

Indicações e Linha de Tratamento

Inibidor competitivo potente da enzima álcool desidrogenase (ADH). Antídoto de primeira linha de escolha para intoxicação aguda por Etilenoglicol (anticongelante) e Metanol, prevenindo a formação dos metabólitos tóxicos letais (ácido glicólico/oxálico e ácido fórmico).

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Intoxicação por Etilenoglicol / Metanol (IV)	Dose de Ataque: 15 mg/kg em infusão IV lenta de 30 minutos.	Doses de Manutenção: 10 mg/kg a cada 12 horas por 4 doses; se o tratamento exceder 48h, aumentar para 15 mg/kg a cada 12h (devido à autoindução enzimática) até que os níveis do tóxico sejam < 20 mg/dL e a acidose corrigida.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipersensibilidade ao fomepizol ou outros pirazóis.

Vantagem: Superior ao etanol por não causar depressão do SNC, hipoglicemia ou necessidade de monitorização em UTI.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

188. Formoterol (fumarato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Cápsulas com pó para inalação 12 mcg

Associado a budesonida (6/100 mcg, 6/200 mcg e 12/400 mcg)

Associado a beclometasona (6/100 mcg)

Indicações e Linha de Tratamento

Broncodilatador agonista beta-2 adrenérgico de longa ação (LABA) com início de ação rápido (1 a 3 minutos) e duração prolongada de 12 horas. Indicado na terapia de manutenção e alívio (estratégia SMART / MART do GINA) associado obrigatoriamente a corticoide inalatório em asma moderada a grave a partir de 4 a 6 anos.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Manutenção da Asma em Associação com Corticoide (Inalatória)	Crianças ≥ 4 a 6 anos: 1 a 2 inalações de Formoterol/Budesonida (6/100 mcg ou 6/200 mcg) a cada 12 horas.	Na estratégia MART, pode ser utilizado tanto como manutenção regular quanto como resgate nas crises.

Contraindicações, restrições e monitorização

MONOTERAPIA É ESTRITAMENTE CONTRAINDICADA: NUNCA prescrever formoterol (ou qualquer LABA) isoladamente sem corticoide inalatório associado (aumento do risco de exacerbações graves e óbito por asma).

Condições: Taquiarritmias graves.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

189. Foscarnet sódico

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução para infusão IV 24 mg/mL (frasco 250 mL = 6 g)

Indicações e Linha de Tratamento

Antiviral análogo de pirofosfato inibidor direto da DNA polimerase viral sem necessidade de fosforilação intracelular. Indicado em infecções graves por Citomegalovírus (CMV) e vírus Herpes Simplex resistentes ao ganciclovir/aciclovir em pacientes imunocomprometidos e pós-transplante.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Infecção / Retinite por CMV Resistente (IV)	Indução: 60 mg/kg a cada 8 horas (ou 90 mg/kg a cada 12h) em infusão lenta de 2 horas por 14 a 21 dias.	Manutenção: 90 a 120 mg/kg uma vez ao dia. Pré-hidratação vigorosa obrigatória com 10 a 20 mL/kg de SF0,9% para minimizar nefrotoxicidade.

Contraindicações, restrições e monitorização

Toxicidade Renal e Eletrolítica: Alto risco de nefrotoxicidade aguda grave e distúrbios eletrolíticos profundos (hipocalcemia grave com convulsões, hipomagnesemia e hipofosfatemia).

Condições: Insuficiência renal prévia grave.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

190. Fosfomicina trometamol / dissódica

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Granulado para solução oral em sachê de 3 g (trometamol)

Pó para solução injetável IV frasco-ampola 1 g e 4 g (dissódica)

Indicações e Linha de Tratamento

Antimicrobiano bactericida derivado do ácido fosfônico que inibe a síntese inicial do peptidoglicano bacteriano. Indicado no tratamento de Infecções do Trato Urinário baixas (cistites não complicadas) e infecções sistêmicas hospitalares graves causadas por bactérias multirresistentes (KPC, MRSA, VRE) em terapia combinada.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Cistite não complicada — Crianças > 6 anos e Adolescentes (VO)	Crianças de 6 a 11 anos: 2 g em dose única. Crianças ≥ 12 anos e Adolescentes: 3 g (1 sachê) em dose única.	Dissolver o sachê em meio copo de água e tomar à noite ao deitar com a bexiga vazia.
Infecções Graves por Bactérias Multirresistentes (IV)	100 a 200 mg/kg/dia dividido a cada 6 a 8 horas em infusão lenta de 60 minutos (Máx: 12 a 24 g/dia)	Sempre associado a outro antimicrobiano ativo.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Insuficiência renal grave (ClCr < 10 mL/min).

Sobrecarga de Sódio: A formulação intravenosa contém aproximadamente 14,4 mEq de sódio por grama de fosfomicina (monitorar balanço hídrico e hipernatremia/hipocalemia).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

191. Furosemida

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Gotas/solução oral 10 mg/mL

Comprimidos 40 mg

Solução injetável 10 mg/mL (ampola 2 mL = 20 mg)

Indicações e Linha de Tratamento

Diurético de alça inibidor do cotransportador Na⁺/K⁺/2Cl⁻ no ramo ascendente espesso da alça de Henle com potente efeito natriurético e venodilatador rápido. Primeira linha no Edema Agudo de Pulmão, sobrecarga hídrica, insuficiência cardíaca congestiva, síndrome nefrótica e insuficiência renal oligúrica.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Edema / Sobrecarga Hídrica / Insuficiência Cardíaca (IV/IM)	0,5 a 2 mg/kg/dose em bolus lento em 2 a 5 minutos (Dose máxima inicial: 2 mg/kg; pode titular até 4 a 6 mg/kg/dia em refratariedade ou infusão contínua de 0,1 a 0,4 mg/kg/hora em UTI).	Início de ação em 5 minutos; duração de 2 horas.
Tratamento Oral de Manutenção (VO)	1 a 2 mg/kg/dia em dose única matinal ou dividida a cada 12 horas (Máx: 6 mg/kg/dia ou 40 a 80 mg/dia)	Administrar pela manhã

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Anúria não responsiva a dose-teste, hipovolemia/desidratação grave, hipocalemia grave e hiponatremia severa.

Ototoxicidade: Risco de perda auditiva transitória ou permanente em injeção IV rápida de altas doses ou coadministração com aminoglicosídeos.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

192. Gabapentina

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Cápsulas 300 mg e 400 mg

Comprimidos 600 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Análogo do GABA modulador da subunidade alfa-2-delta dos canais de cálcio voltagem-dependentes. Primeira linha no tratamento da Dor Neuropática crônica na infância, irritabilidade neurológica/distonia em paralisia cerebral grave e terapia adjuvante em crises epiléticas focais a partir de 3 anos.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Dor Neuropática / Irritabilidade Neurológica (VO)	Inicial: 5 a 10 mg/kg/dia ao deitar. Titular a cada 3 a 5 dias até 15 a 35 mg/kg/dia (Dose máxima habitual: 35 a 50 mg/kg/dia ou 1800 a 2400 mg/dia).	Dividido a cada 8 horas com ou sem alimentos.
Epilepsia Focal — Crianças ≥ 3 anos (VO)	Dia 1: 10 mg/kg/dia. Dia 2: 20 mg/kg/dia. Dia 3: 30 a 45 mg/kg/dia dividido a cada 8h.	Dividido a cada 8 horas

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipersensibilidade à gabapentina.

Desmame: Evitar suspensão abrupta (desmame gradual em 1 a 2 semanas para evitar insônia e ansiedade rebote).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

193. Galsulfase

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução concentrada para infusão 1 mg/mL (frasco 5 mL = 5 mg)

Indicações e Linha de Tratamento

Terapia de reposição enzimática (N-acetilgalactosamina-4-sulfatase humana recombinante / arilsulfatase B). Indicada no tratamento a longo prazo da Mucopolissacaridose Tipo VI (MPS VI / Síndrome de Maroteaux-Lamy) para melhorar a capacidade de marcha e função pulmonar.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Mucopolissacaridose Tipo VI (IV)	1 mg/kg uma vez por semana em infusão intravenosa contínua.	Pré-medicação obrigatória com anti-histamínicos e/ou antipiréticos 30 a 60 minutos antes da infusão para prevenir reações anafilactoides.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipersensibilidade grave à galsulfase.

Monitorização: Avaliar risco de obstrução aguda de vias aéreas superiores e apneia do sono durante a infusão.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

194. Ganciclovir sódico

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó liofilizado para solução injetável frasco-ampola 500 mg

Gel oftálmico 0,15%

Indicações e Linha de Tratamento

Antiviral análogo de nucleosídeo inibidor da DNA polimerase do Citomegalovírus (CMV). Primeira linha no tratamento da Infecção Congênita Sintomática por CMV no recém-nascido (para prevenção de perda auditiva neurossensorial e sequelas no neurodesenvolvimento) e infecções invasivas por CMV em imunodeprimidos.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
CMV Congênito Sintomático Neonatal (IV)	6 mg/kg/dose a cada 12 horas em infusão intravenosa lenta de 60 minutos por 6 semanas (frequentemente transicionado para valganciclovir oral para completar 6 meses de tratamento total).	Infusão lenta em 60 minutos. Acesso venoso seguro devido ao pH alcalino e risco de flebite.
Tratamento de CMV em Imunodeprimidos / Pós-Transplante (IV)	Indução: 5 mg/kg/dose a cada 12 horas por 14 a 21 dias. Manutenção: 5 mg/kg uma vez ao dia.	Infusão lenta em 1 hora.

Contraindicações, restrições e monitorização

Mielotoxicidade Grave: Black box warning para neutropenia grave ($ANC < 500/mm^3$), trombocitopenia e anemia; realizar hemograma 2 vezes por semana.

Potencial Mutagênico e Teratogênico: Cautela e manuseio como droga potencialmente tóxica.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

195. Gentamicina (sulfato)

Auditoria documental Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável 10 mg/mL, 20 mg/mL, 40 mg/mL e 80 mg/2 mL (ampolas de 1 mL e 2 mL)

Colírio/pomada oftálmica 0,3%

Indicações e Linha de Tratamento

Antimicrobiano bactericida aminoglicosídeo padrão. Primeira linha no esquema empírico da Sepse Neonatal precoce e tardia (associada a ampicilina), infecções urinárias complicadas (pielonefrite aguda), sepse abdominal e endocardite infecciosa por enterococo/estreptococo.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Sepse Neonatal — Dose Estendida por Idade Gestacional (IV/IM)	Prematuro < 30 sem: 5 mg/kg a cada 48h. 30 a 34 sem: 4,5 mg/kg a cada 36h. ≥ 35 sem e Termo: 4 a 5 mg/kg a cada 24h.	Infundir em 30 a 60 minutos. Nível sérico de vale alvo: < 1 mcg/mL; pico: 5 a 10 mcg/mL.
Lactentes e Crianças > 1 mês (IV/IM)	7,5 mg/kg uma vez ao dia (Dose diária única preferencial) ou 2 a 2,5 mg/kg a cada 8 horas (Máx: 300 mg/dia)	Duração habitual de 7 a 10 dias.
Conjuntivite Bacteriana (Oftálmico)	1 a 2 gotas no olho afetado a cada 4 a 6 horas por 5 a 7 dias	Uso tópico

Contraindicações, restrições e monitorização

Toxicidade: Risco de ototoxicidade coclear/vestibular irreversível e nefrotoxicidade tubular aguda; monitorar função renal e níveis séricos.

Condições: Miastenia gravis e uso concomitante de bloqueadores neuromusculares.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

196. Glicerina (Glicerol)

Auditoria documental Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução retal em enema/clister 12%

Supositórios retais pediátricos (1 g a 1,5 g) e adultos (2,5 g)

Indicações e Linha de Tratamento

Laxativo hiperosmótico e lubrificante por via retal. Primeira linha no alívio agudo da constipação intestinal distal, desimpactação de fezes endurecidas em ampola retal e auxílio na eliminação de mecônio em recém-nascidos prematuros.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Constipação Aguda / Desimpactação Retal — Lactentes e Crianças (Retal)	Supositório Pediátrico: Introduzir 1 supositório por via retal e reter por alguns minutos.	Efeito evacuatório rápido em 15 a 30 minutos.
Clister / Enema de Glicerina a 12% (Retal)	5 a 10 mL/kg (Máx: 100 a 250 mL) por via retal com sonda lubrificada	Uso pontual de resgate na emergência

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Suspeita de abdome agudo cirúrgico, apendicite, perfuração intestinal e fissura anal dolorosa com sangramento ativo.

Uso Contínuo: Não utilizar como tratamento de manutenção crônica da constipação funcional.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

197. Glicose hipertônica

Auditoria documental Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável concentrada 25% (250 mg/mL = 0,25 g/mL) e 50% (500 mg/mL = 0,5 g/mL) em ampolas de 10 mL e 20 mL

Indicações e Linha de Tratamento

Solução de carboidrato concentrado para correção emergencial de hipoglicemia sintomática com alteração neurológica e componente de preparo de soluções de infusão contínua com Taxa de Infusão de Glicose (TIG).

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Hipoglicemia Aguda Neonatal (Glicemia < 45-50 mg/dL) (IV)	2 mL/kg de Soro Glicosado a 10% (SG10% = 200 mg/kg de glicose) em bolus lento em 2 a 3 minutos.	Seguido imediatamente de infusão contínua com TIG de 6 a 8 mg/kg/minuto.
Hipoglicemia Aguda em Lactentes e Crianças (Glicemia < 60 mg/dL) (IV/IO)	2 a 4 mL/kg de Soro Glicosado a 10% (ou 1 a 2 mL/kg de SG25%; Máx: 25 g = 100 mL de SG25%) em bolus lento em 3 a 5 minutos.	Rechegar glicemia capilar em 15 a 30 minutos.

Contraindicações, restrições e monitorização

CONCENTRAÇÃO PERIFÉRICA MÁXIMA: Em veias periféricas, nunca infundir soluções com concentração de glicose superior a 12,5% (risco gravíssimo de flebite química e necrose por extravasamento). A concentração de 25% ou 50% deve ser diluída para 10% antes do uso periférico.

Condições: Hemorragia intracraniana e anúria.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

198. Glucagon

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó liofilizado para solução injetável frasco-ampola 1 mg (1 UI) com seringa de diluente de 1 mL

Indicações e Linha de Tratamento

Hormônio polipeptídico hiperglicemiante que mobiliza os estoques de glicogênio hepático. Primeira linha de resgate na Hipoglicemia Grave com inconsciência/convulsões em pacientes com Diabetes Mellitus Tipo 1 na ausência de acesso venoso, e antídoto para intoxicação por betabloqueadores e bloqueadores de canal de cálcio.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Hipoglicemia Grave sem Acesso Venoso — DM1 (SC/IM)	Crianças com peso < 25 kg (ou < 6 anos): 0,5 mg (0,5 mL). Crianças com peso ≥ 25 kg (ou ≥ 6 anos): 1,0 mg (1,0 mL).	Injeção SC ou IM no vasto lateral ou deltoide. Resposta glicêmica esperada em 10 a 15 minutos. Administrar carboidratos orais assim que recuperar a consciência.
Intoxicação por Betabloqueador (IV)	50 a 100 mcg/kg em bolus em 1 min, seguido de infusão contínua de 20 a 70 mcg/kg/hora.	Inotrópico independente de receptor adrenérgico.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Feocromocitoma (estimula liberação maciça de catecolaminas) e insulinoma.

Ineficácia: Ineficaz em estados de depleção profunda de glicogênio hepático (desnutrição calórico-proteica grave, jejum prolongado, insuficiência hepática terminal).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

199. Gluconato de cálcio 10%

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável 100 mg/mL (10%, ampola 10 mL = 1 g / contém 9 mg de Ca elementar/mL = 0,45 mEq/mL)

Indicações e Linha de Tratamento

Sal orgânico de cálcio parenteral padrão para uso em veias periféricas na pediatria. Primeira linha para Estabilização de Membrana Miocárdica na Hipercalcemia Grave com alterações eletrocardiográficas (ondas T apiculadas, alargamento de QRS), hipocalcemia aguda sintomática (tetania, convulsões, laringoespasmo), hipermagnesemia e ressuscitação na parada cardíaca por hipocalcemia.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Hipercalcemia Grave com Alteração no ECG (IV/IO)	0,5 a 1,0 mL/kg de Gluconato de Cálcio 10% (50 a 100 mg/kg; Máx: 10 a 20 mL = 1 a 2 g) infundido em 3 a 5 minutos sob monitorização cardíaca contínua.	Efeito cardioprotetor imediato em 1 a 3 minutos com duração de 30 a 60 minutos; pode repetir após 5 a 10 min se alterações no ECG persistirem.
Hipocalcemia Sintomática / Tetania / Convulsão (IV)	1 a 2 mL/kg (100 a 200 mg/kg) infundido lentamente em 10 a 20 minutos diluído a 50% em SG5% ou SF0,9%.	Seguido de infusão contínua de 200 a 800 mg/kg/dia se necessário.

Contraindicações, restrições e monitorização

INTOXICAÇÃO DIGITÁLICA: Contraindicado na vigência de toxicidade digitálica (pode precipitar arritmias ventriculares fatais em 'pedra de cálcio').

Incompatibilidades: Incompatível e insolúvel com soluções contendo bicarbonato de sódio ou fosfatos (precipitação imediata de sais insolúveis).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

200. Griseofulvina

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos 500 mg (forma micronizada)

Indicações e Linha de Tratamento

Antifúngico fungistático oral que se liga aos microtúbulos fúngicos e queratina precursora. Primeira linha clássica no tratamento da Tinea Capitis (tinha do couro cabeludo) causada por *Microsporum canis* e *Trichophyton tonsurans* em crianças ≥ 2 anos.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Tinea Capitis — Crianças ≥ 2 anos (VO)	Forma Micronizada: 15 a 20 mg/kg/dia (até 25 mg/kg/dia para <i>Microsporum</i>) em dose única diária ou dividida a cada 12 horas por 6 a 12 semanas (Máx: 1000 mg/dia).	OBRIGATÓRIO administrar com alimentos gordurosos (leite integral, queijo, manteiga) para aumentar a absorção gastrointestinal.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Porfíria aguda, insuficiência hepática grave, lúpus eritematoso sistêmico e gravidez.

Monitorização: Monitorar hemograma e função hepática em cursos superiores a 8 semanas.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

201. Haloperidol

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Gotas 2 mg/mL (1 gota = 0,1 mg)

Comprimidos 1 mg e 5 mg

Solução injetável 5 mg/mL (ampola 1 mL)

Indicações e Linha de Tratamento

Antipsicótico típico de alta potência (bloqueador dopaminérgico D2). Indicado no controle agudo do Delírium Hiperativo em UTI pediátrica, agitação psicomotora grave com risco de auto/heteroagressão, Síndrome de Tourette com tiques motores/vocais severos e Coreia de Sydenham refratária.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Delirium Hiperativo em UTI / Agitação Grave (IV/IM)	0,025 a 0,05 mg/kg/dose a cada 8 a 12 horas (Máx: 0,15 mg/kg/dia ou 5 mg/dose em adolescentes).	Infundir IV lentamente em 15 a 30 minutos sob monitorização contínua de ECG e QTc.
Síndrome de Tourette / Tiques (VO)	Crianças ≥ 3 anos: Inicial 0,025 mg/kg/dia (ou 0,25 a 0,5 mg/dia). Titular semanalmente até 0,05 a 0,075 mg/kg/dia (Máx: 3 a 5 mg/dia).	Dividido a cada 8 ou 12 horas

Contraindicações, restrições e monitorização

Cardiotoxicidade: Black box warning para prolongamento do intervalo QTc e Torsades de pointes (especialmente via IV).

Sintomas Extrapiramidais: Alta incidência de distonias agudas, acatisia e risco de Síndrome Neuroléptica Maligna.

Condições: Doença de Parkinson e depressão severa do SNC.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

202. Heparina não fracionada (sódica)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável 5.000 UI/mL (frasco 5 mL = 25.000 UI)

Solução injetável 5.000 UI/0,25 mL (via SC)

Indicações e Linha de Tratamento

Anticoagulante parenteral padrão que potencializa a antitrombina III. Primeira linha no tratamento do Tromboembolismo Venoso ou Arterial agudo em pacientes instáveis ou com alto risco de sangramento/necessidade de procedimentos (meia-vida curta e reversão rápida com protamina), manutenção de patência de cateteres arteriais/venosos e anticoagulação em circulação extracorpórea (CEC) e ECMO.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Tratamento de Trombose Sistêmica (IV Contínuo)	Dose de Ataque: 75 a 100 UI/kg em bolus IV em 10 minutos (omitir se sangramento ativo). Manutenção Contínua: Lactentes < 1 ano: 25 a 30 UI/kg/hora. Crianças > 1 ano: 18 a 20 UI/kg/hora.	Ajustar a velocidade de infusão para manter o Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada (TTPa) entre 60 e 85 segundos (1,5 a 2,5 vezes o controle) ou nível de anti-Xa entre 0,35 e 0,7 UI/mL.
Lavagem / Manutenção de Cateteres (Heparinização)	1 a 5 UI/mL para cateteres arteriais; 10 a 100 UI/mL (volume do lúmen) para cateteres venosos centrais.	Prevenção de oclusão

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Sangramento ativo maior incontrolável, plaquetopenia grave (< 50.000/mm³) e histórico de Trombocitopenia Induzida por Heparina (HIT Tipo II).

Monitorização: Coletar plaquetas a cada 2 a 3 dias e TTPa a cada 4 a 6 horas até estabilização.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

203. Hidralazina (cloridrato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos/drágeas 25 mg e 50 mg

Solução injetável 20 mg/mL (ampola 1 mL)

Indicações e Linha de Tratamento

Vasodilatador arterial direto potente com redução expressiva da pós-carga. Primeira linha na Emergência Hipertensiva na Glomerulonefrite Difusa Aguda (GNDA) pós-estreptocócica em pediatria e hipertensão arterial grave.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Emergência Hipertensiva na GNDA / Urgência (IV/IM)	0,1 a 0,2 mg/kg/dose (Máx: 20 mg/dose) administrado em injeção IV lenta em 5 minutos ou IM profunda.	Início de ação em 10 a 20 minutos; pode repetir a cada 4 a 6 horas conforme PA.
Tratamento Oral de Manutenção (VO)	Inicial: 0,75 mg/kg/dia dividido a cada 6 a 8 horas. Titular até 3 a 5 mg/kg/dia (Máx: 200 mg/dia).	Dividido a cada 6 a 8 horas com alimentos.

Contraindicações, restrições e monitorização

Efeitos: Taquicardia reflexa intensa, retenção hidrossalina e cefaleia pulsátil (frequentemente associada a betabloqueadores e diuréticos de alça).

Condições: Lúpus eritematoso sistêmico (risco de síndrome lúpica induzida por fármaco) e taquicardia ventricular.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

204. Hidroclorotiazida

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos 25 mg e 50 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Diurético tiazídico inibidor do cotransportador Na⁺/Cl⁻ no túbulo contorcido distal. Indicado no controle da Hipertensão Arterial pediátrica, tratamento da Hipercalcúria Idiopática (prevenção de nefrocalcinose e litíase cálcica), Diabetes Insipidus Nefrogênico e adjuvante em edemas crônicos.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Hipertensão Arterial / Edema (VO)	1 a 2 mg/kg/dia em dose única diária matinal ou dividida a cada 12 horas (Máx: 50 mg/dia em crianças e 100 mg/dia em adolescentes)	Tomar pela manhã com alimentos
Hipercalcúria Idiopática / Diabetes Insipidus Nefrogênico (VO)	1 a 2 mg/kg/dia (titular até 2 a 3 mg/kg/dia no DI nefrogênico)	Dose única ou a cada 12 horas

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Anúria, insuficiência renal grave (ClCr < 30 mL/min - ineficaz, preferir diuréticos de alça), hipocalemia grave e hiponatremia refratária.

Monitorização: Eletrólitos (risco de hipocalemia, hiponatremia, hipomagnesemia e hipercalcemia).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

205. Hidrocortisona (succinato sódico / acetato / butirato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó liofilizado para solução injetável frasco-ampola 100 mg e 500 mg (succinato)

Comprimidos 10 mg e 20 mg

Creme/pomada dermatológica 10 mg/g (1%)

Indicações e Linha de Tratamento

Glicocorticoide de curta ação de estrutura idêntica ao cortisol endógeno com atividade glicocorticoide e mineralocorticoide balanceada. Primeira linha de escolha na Crise Adrenal Aguda, reposição fisiológica na Insuficiência Adrenal / Hiperplasia Adrenal Congênita, Choque Séptico Refratário a catecolaminas (insuficiência adrenal relativa) e asma grave.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Crise Adrenal Aguda / Choque Refratário a Catecolaminas (IV)	Dose de Ataque: 50 a 100 mg/m ² (ou 2 mg/kg; Máx: 100 mg) em bolus IV imediato. Manutenção: 50 a 100 mg/m ² /dia dividido a cada 6 horas (ou infusão contínua em bomba em UTI).	Infusão lenta em 5 a 10 min.
Reposição Fisiológica de Manutenção na Insuficiência Adrenal (VO)	8 a 12 mg/m ² /dia dividido em 3 tomadas diárias (maior fração pela manhã para mimetizar o ritmo circadiano). Em situações de estresse febril/cirurgia, triplicar a dose.	Dividido a cada 8 horas
Dermatite Atópica Leve / Face e Dobras (Tópico)	Aplicar fina camada 1 a 2 vezes ao dia por 1 a 2 semanas	Excelente perfil de segurança na infância.

Contraindicações, restrições e monitorização

Emergência: Sem contraindicações na suspeita de Crise Adrenal aguda salvadora de vidas.

Tópico: Infecções cutâneas virais, fúngicas ou bacterianas não tratadas.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

206. Hidroxicloroquina (sulfato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos revestidos 400 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Antimalárico e imunomodulador modificador do curso da doença (DMARD). Primeira linha no tratamento do Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) pediátrico, Lúpus Neonatal, Artrite Idiopática Juvenil e dermatomiosite juvenil.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Lúpus Eritematoso Sistêmico / AIJ (VO)	3 a 5 mg/kg/dia de hidroxicloroquina base (Máx: 5 mg/kg/dia de peso real ou 400 mg/dia)	Dose única diária junto às refeições ou com leite.

Contraindicações, restrições e monitorização

Retinopatia Macular: Black box warning para toxicidade retiniana dose-dependente irreversível (maculopatia em 'olho de boi'). Avaliação oftalmológica basal com campo visual e tomografia de coerência óptica (OCT) anual obrigatória.

Condições: Maculopatia preexistente e hipersensibilidade a derivados da 4-aminoquinolina.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

207. Hidróxido de alumínio + Hidróxido de magnésio

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Suspensão oral 35,6 mg/mL + 37 mg/mL

Comprimidos mastigáveis

Indicações e Linha de Tratamento

Antiácido gástrico neutralizante balanceado (o magnésio previne a constipação do alumínio e o alumínio previne a diarreia do magnésio). Indicado no alívio sintomático rápido de pirose, dispepsia ácida e dor epigástrica.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Dispepsia / Pirose — Crianças de 2 a 12 anos (VO)	0,5 a 1 mL/kg/dose (ou 5 a 10 mL) 1 a 3 horas após as refeições e ao deitar (Máx: 4 vezes ao dia)	Agitar bem antes de usar; uso pontual sintomático.
Crianças > 12 anos e Adolescentes (VO)	10 a 20 mL (ou 1 a 2 comprimidos mastigáveis) 1 a 3h após as refeições	Sintomático

Contraindicações, restrições e monitorização

Insuficiência Renal: Contraindicado em pacientes com insuficiência renal (risco de intoxicação por alumínio com encefalopatia e hipermagnesemia grave).

Idade: Não recomendado para lactentes < 2 anos (risco de bezoar e distúrbios hidroeletrólíticos).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

208. Hidróxido férrico em sacarose (Sacarato de hidróxido férrico)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável para infusão IV 20 mg/mL de ferro elementar (ampola 5 mL = 100 mg)

Indicações e Linha de Tratamento

Complexo coloidal de ferro parenteral para administração intravenosa. Primeira linha no tratamento da Anemia Ferropriva grave refratária ou com intolerância/má absorção aos sais de ferro orais, doença inflamatória intestinal ativa, doença renal crônica em diálise e síndrome do intestino curto.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Tratamento de Anemia Ferropriva Grave (IV)	Dose cumulativa total de ferro calculada pela Fórmula de Ganzoni: Deficit total de Ferro (mg) = Peso (kg) x (Hb alvo - Hb atual em g/dL) x 2,4 + Depósito de ferro (15 mg/kg em < 35 kg ou 500 mg em > 35 kg).	Dose por aplicação: 3 a 5 mg de ferro elementar/kg/dose (Máx: 100 a 200 mg/sessão) diluído em SF0,9% e infundido lentamente em 30 a 60 minutos, 2 a 3 vezes por semana até completar o deficit.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Sobrecarga de ferro orgânica (hemocromatose), anemia hemolítica e infecções bacterianas agudas ativas graves.

Preparo: Diluição exclusiva em SF0,9% (nunca em água ou soluções glicosadas).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

209. Hidroxizina (dicloridrato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução oral/xarope 2 mg/mL (10 mg/5 mL)

Comprimidos 25 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Anti-histamínico de primeira geração derivado da piperazina com potente ação antipruriginosa, sedativa e ansiolítica central. Primeira linha no controle do prurido intenso associado a Dermatite Atópica, urticária aguda/crônica e ansiedade pré-procedimento a partir de 6 meses de vida.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Prurido e Urticária — 6 meses a 6 anos (VO)	0,5 a 1 mg/kg/dose a cada 6 a 8 horas (Dose diária: 1,5 a 2,5 mg/kg/dia; Máx: 50 mg/dia)	Preferencialmente à noite devido à sonolência.
Crianças > 6 anos e Adolescentes (VO)	15 a 25 mg a cada 6 a 8 horas (Máx: 100 mg/dia)	Dividido a cada 6 a 8 horas

Contraindicações, restrições e monitorização

Cardiotoxicidade: Risco de prolongamento do intervalo QTc e arritmias ventriculares (evitar coadministração com outros depressores de condução cardíaca).

Idade: Contraindicado para menores de 6 meses e prematuros.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

210. Hidroxocobalamina (Vitamina B12)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável 1.000 mcg/mL e 5.000 mcg/2 mL (ampolas IM)

Indicações e Linha de Tratamento

Forma de cobalamina essencial para a síntese de mielina e eritropoiese, e antídoto de primeira linha de escolha para Intoxicação Aguda por Cianeto (queimaduras com inalação de fumaça em incêndios e infusão prolongada de nitroprussiato).

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Intoxicação Aguda por Cianeto / Inalação de Fumaça (IV)	70 mg/kg (Máx: 5 g) administrado em infusão intravenosa lenta em 15 minutos.	Pode repetir uma segunda dose de 70 mg/kg em 2 horas se persistência de acidose láctica e instabilidade hemodinâmica.
Deficiência Grave de Vitamina B12 / Anemia Megaloblástica (IM)	1.000 mcg (ou 50 a 100 mcg/kg) em dias alternados por 1 a 2 semanas, seguido de 1.000 mcg mensal de manutenção.	Injeção IM profunda

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Atrofia óptica hereditária de Leber (risco de perda visual rápida e irreversível).

Coloração: Causa coloração avermelhada intensa benigna da pele e urina por até 48 horas e interfere transitoriamente em exames laboratoriais colorimétricos.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

211. Ibuprofeno

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Gotas 50 mg/mL (1 gota = 2,5 mg) e 100 mg/mL (1 gota = 5 mg)

Suspensão oral 20 mg/mL (100 mg/5 mL) e 30 mg/mL

Comprimidos 200 mg, 300 mg, 400 mg e 600 mg

Solução injetável IV 10 mg/mL (ampola 2 mL = 20 mg)

Indicações e Linha de Tratamento

Anti-inflamatório não esteroide (AINE) derivado do ácido propiônico de primeira linha em pediatria. Padrão-ouro para controle de febre, dor inflamatória leve a moderada (otite, faringite, dor osteomuscular), fechamento farmacológico do Canal Arterial Patente em prematuros e Artrite Idiopática Juvenil.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Febre e Dor Inflamatória — Crianças ≥ 6 meses (VO)	5 a 10 mg/kg/dose (Dose padrão mais utilizada: 10 mg/kg/dose ou 1 gota/kg/dose da formulação 100 mg/mL ou 2 gotas/kg/dose da formulação 50 mg/mL)	A cada 6 a 8 horas com alimentos (Dose máxima diária: 40 mg/kg/dia ou 2400 mg/dia).
Fechamento do Canal Arterial em Prematuros (IV)	Dia 1: 10 mg/kg em infusão lenta de 15 min. Dia 2 e Dia 3: 5 mg/kg/dia a cada 24 horas (Ciclo de 3 doses).	Infusão intravenosa lenta em UTI neonatal.
Artrite Idiopática Juvenil (VO)	30 a 40 mg/kg/dia dividido a cada 6 a 8 horas	Uso contínuo com protetor gástrico.

Contraindicações, restrições e monitorização

Idade: Contraindicado para menores de 6 meses (salvo uso endovenoso neonatal exclusivo para fechamento de canal arterial sob monitorização).

Condições: Suspeita de Dengue (risco de hemorragia), desidratação moderada a grave (alto risco de insuficiência renal aguda por vasoconstrição glomerular), úlcera péptica e asma induzida por AINES.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

212. Idursulfase

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução concentrada para infusão 2 mg/mL (frasco 3 mL = 6 mg)

Indicações e Linha de Tratamento

Terapia de reposição enzimática (iduronato-2-sulfatase humana recombinante). Indicada para o tratamento a longo prazo da Mucopolissacaridose Tipo II (MPS II / Síndrome de Hunter) para melhorar a capacidade funcional e reduzir o volume hepatoesplênico.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Mucopolissacaridose Tipo II (Síndrome de Hunter) (IV)	0,5 mg/kg uma vez por semana em infusão intravenosa lenta em 3 horas (diluído em SF0,9%).	Pré-medicação com anti-histamínicos e/ou corticoides 30 a 60 minutos antes da infusão.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Risco elevado de reações anafiláticas e broncoespasmo durante a infusão (exige suporte de emergência imediato).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

213. Iloprost

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução para inalação 10 mcg/mL e 20 mcg/mL (ampolas 1 mL)

Indicações e Linha de Tratamento

Análogo sintético da prostaciclina (PGI₂) administrado por via inalatória para vasodilatação pulmonar seletiva. Indicada no tratamento da Hipertensão Arterial Pulmonar idiopática ou associada a cardiopatias congênitas em crianças ≥ 2 anos.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Hipertensão Pulmonar Pediátrica (Inalatória)	Dose inicial: 1,25 a 2,5 mcg por inalação, titulada conforme tolerância até 5 mcg por inalação.	6 a 9 inalações por dia (a cada 2 a 3 horas enquanto acordado) através de nebulizador ultrassônico dedicado.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipotensão sistêmica severa, hemorragia pulmonar ativa e insuficiência cardíaca esquerda grave.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

214. Imiglucerase

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó liofilizado para solução injetável frasco-ampola 200 UI e 400 UI

Indicações e Linha de Tratamento

Terapia de reposição enzimática (beta-glicocerebrosidase humana recombinante). Primeira linha padrão-ouro no tratamento a longo prazo da Doença de Gaucher Tipo 1 e Tipo 3 com manifestações hematológicas, viscerais e ósseas.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Doença de Gaucher (IV)	Inicial: 30 a 60 UI/kg a cada 2 semanas (infundido em 1 a 2 horas diluído em SF0,9%).	Titular a cada 6 a 12 meses conforme normalização de plaquetas, hemoglobina e redução da hepatoesplenomegalia.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipersensibilidade grave à imiglucerase; monitorar formação de anticorpos IgG neutralizantes.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

215. Imipenem + Cilastatina

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó liofilizado para solução injetável frasco-ampola 500 mg + 500 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Antimicrobiano carbapenêmico de amplo espectro bactericida associado a inibidor da desidropeptidase renal I. Indicado em infecções intra-abdominais graves, sepse hospitalar grave por Gram-negativos produtores de ESBL e infecções polimicrobianas complexas.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Infecções Pediátricas Sistêmicas Graves (IV)	60 a 100 mg/kg/dia da combinação (calculado sobre imipenem)	Dividido a cada 6 horas em infusão lenta de 30 a 60 minutos (Máx: 4 g/dia)

Contraindicações, restrições e monitorização

CONTRAINDICAÇÃO RELATIVA EM MENINGITE / CONVULSÕES: Maior potencial epileptogênico e convulsivante que o meropenem; desaconselhado em infecções do SNC ou crianças com histórico de crises epiléticas (preferir meropenem).

Condições: Alergia grave a carbapenêmicos.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

216. Imipramina (cloridrato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos/drágeas 10 mg, 25 mg e 75 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Antidepressivo tricíclico inibidor da recaptação de noradrenalina e serotonina com potente efeito anticolinérgico. Indicado no tratamento de segunda linha da Enurese Noturna Monossintomática em crianças ≥ 6 anos após falha de alarme e desmopressina.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Enurese Noturna — Crianças ≥ 6 anos (VO)	6 a 10 anos: 10 a 25 mg/dia ao deitar (0,5 a 1 mg/kg/dia). > 10 anos: 25 a 50 mg/dia ao deitar (Máx: 2,5 mg/kg/dia ou 50 mg/dia).	Administrar 1 hora antes de dormir. Limitar a cursos de 3 meses com desmame progressivo.

Contraindicações, restrições e monitorização

Cardiotoxicidade: Black box warning para prolongamento do intervalo QTc e risco fatal de arritmias ventriculares em superdosagem acidental; ECG basal prévio obrigatório.

Idade: Contraindicado para menores de 6 anos.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

217. Imunoglobulina humana anti-hepatite B

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável em frasco-ampola 100 UI, 500 UI e 1000 UI

Indicações e Linha de Tratamento

Imunoglobulina específica hiperimune com altos títulos de anticorpos anti-HBs. Primeira linha profilática mandatória pós-exposição para Recém-nascidos de mães HBsAg positivas (prevenção da transmissão vertical da hepatite B) e acidentes com material biológico.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Profilaxia da Transmissão Vertical Neonatal (IM)	100 a 200 UI (ou 0,5 mL) em dose única intramuscular no vasto lateral da coxa nas primeiras 12 horas de vida (idealmente logo após o parto).	Administrar em sítio anatômico diferente da vacina hepatite B (que deve ser aplicada simultaneamente).

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Deficiência seletiva de IgA com anticorpos anti-IgA (risco de anafilaxia).

Via: Injeção intramuscular exclusiva (nunca IV).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

218. Imunoglobulina humana antirrábica

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável 150 UI/mL (frasco-ampola 2 mL = 300 UI e 5 mL = 750 UI)

Indicações e Linha de Tratamento

Imunoglobulina específica hiperimune contra o vírus da raiva. Primeira linha na profilaxia pós-exposição antirrábica em acidentes graves por animais transmissores suspeitos ou confirmados (mordeduras profundas, múltiplas, em face/mãos ou por morcegos/animais silvestres).

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Profilaxia Pós-Exposição Antirrábica (Infiltração Local / IM)	20 UI/kg em dose única no Dia 0 do atendimento.	Infiltrar o máximo volume possível dentro e ao redor de todas as feridas/mordeduras; o restante do volume deve ser aplicado IM profundo longe do local da vacina antirrábica.

Contraindicações, restrições e monitorização

Prazo Limite: Não deve ser administrada após o 7º dia do início da vacinação antirrábica (pois pode interferir na resposta imune ativa induzida pela vacina).

Precauções: Suporte para reações anafiláticas.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

219. Imunoglobulina humana antitetânica

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável em frasco-ampola ou seringa preenchida 250 UI e 500 UI

Indicações e Linha de Tratamento

Imunoglobulina hiperimune contendo anticorpos neutralizantes da toxina tetânica (tetanospasmina). Indicada na profilaxia do tétano em ferimentos graves de alto risco em pacientes não imunizados ou com esquema incompleto, e no tratamento do Tétano Acidental e Neonatal.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Profilaxia Pós-Exposição em Ferimento de Alto Risco (IM)	250 UI em dose única intramuscular profunda (aumentar para 500 UI se ferimento com mais de 24h, grande destruição tecidual ou queimadura grave).	Aplicar em membro diferente da vacina com toxoide tetânico.

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Tratamento do Tétano Clínico / Neonatal (IM/IV)	3.000 a 6.000 UI dividido em múltiplos sítios intramusculares profundos	Dose terapêutica única hospitalar

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Deficiência grave de IgA.

Via: Injeção intramuscular profunda.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

220. Imunoglobulina humana intravenosa (IGIV)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução estéril para infusão IV 5 g/100 mL (5%) e 10 g/100 mL (10%) em frascos de 50 mL, 100 mL e 200 mL

Indicações e Linha de Tratamento

Pool de imunoglobulinas policlonais IgG humanas com potente ação imunomoduladora e anti-inflamatória. Primeira linha padrão-ouro absoluta na Doença de Kawasaki aguda (prevenção de aneurismas de artérias coronárias), Púrpura Trombocitopênica Imunológica (PTI) aguda com sangramento ativo, Síndrome de Guillain-Barré, Doença Hemolítica Perinatal por incompatibilidade Rh/ABO e Imunodeficiências Primárias.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Doença de Kawasaki — Fase Aguda (IV)	2 g/kg em dose única administrado em infusão intravenosa contínua lenta de 10 a 12 horas (iniciar a 0,5 mL/kg/h e progredir a cada 30 min até máx 4 mL/kg/h).	Associar a AAS em dose anti-inflamatória. Idealmente administrar nos primeiros 10 dias de febre.
PTI Aguda com Sangramento Grave (IV)	0,8 a 1 g/kg em dose única (pode repetir no dia 2 se plaquetas < 20.000/mm ³ persistirem) ou 400 mg/kg/dia por 5 dias.	Resposta plaquetária rápida em 24 a 48 horas.
Síndrome de Guillain-Barré (IV)	2 g/kg administrado em dose total dividida em 2 dias (1 g/kg/dia) ou 5 dias (400 mg/kg/dia)	Infusão lenta em bomba.
Doença Hemolítica Perinatal (IV)	0,5 a 1 g/kg em infusão de 2 a 4 horas	Reduz indicação de exsanguineotransfusão.

Contraindicações, restrições e monitorização

Deficiência de IgA: Alto risco de anafilaxia fulminante por anticorpos anti-IgA (usar formulações com baixíssimo teor de IgA se estritamente necessário).

Vacinas Vivas: Adiar vacinas de vírus vivos atenuados (sarampo, caxumba, rubéola, varicela) por 9 a 11 meses após o uso de IGIV em altas doses.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

221. Indometacina

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Cápsulas 25 mg e 50 mg

Pó liofilizado para solução injetável frasco-ampola 1 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Anti-inflamatório não esteroide potente inibidor não seletivo da COX-1 e COX-2 que reduz a síntese de prostaglandina E2. Primeira linha no fechamento farmacológico do Canal Arterial Patente hemodinamicamente significativo em recém-nascidos prematuros e tratamento do Diabetes Insipidus Nefrogênico.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Fechamento do Canal Arterial Neonatal (IV)	Ciclo de 3 doses a cada 12 a 24 horas conforme idade pós-natal: Idade < 48h: 1ª dose 0,2 mg/kg, 2ª e 3ª doses 0,1 mg/kg. Idade 2 a 7 dias: 0,2 mg/kg em todas as 3 doses. Idade > 7 dias: 1ª dose 0,2 mg/kg, 2ª e 3ª doses 0,25 mg/kg.	Infundir lentamente em 20 a 30 minutos.
Diabetes Insipidus Nefrogênico (VO)	1,5 a 3 mg/kg/dia dividido a cada 8 a 12 horas	Associado a hidroclorotiazida

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições Neonatais Críticas: Hemorragia intracraniana ativa (grau II a IV), enterocolite necrosante (NEC), perfuração intestinal, trombocitopenia (< 50.000/mm³) e insuficiência renal oligúrica (débito < 0,6 mL/kg/h).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

222. Insulina Asparte

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável ultrarrápida 100 UI/mL em frasco 10 mL e carpule/caneta preenchida 3 mL

Indicações e Linha de Tratamento

Análogo de insulina humana de ação ultrarrápida (início em 10 a 15 min, pico em 1 a 2h, duração de 3 a 5h). Primeira linha para cobertura prandial de carboidratos e correção de hiperglicemias agudas no Diabetes Mellitus Tipo 1 em pediatria.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Controle Prandial e Correção no DM1 (SC)	Dose calculada pela Contagem de Carboidratos (Relação Insulina:Carboidrato - ex: 1 UI para cada 10 a 20g de CHO) + Fator de Sensibilidade à Insulina (FSI - ex: 1 UI para cada 50 a 100 mg/dL acima da glicemia alvo).	Administrar imediatamente antes das refeições ou logo após em lactentes e crianças pequenas com ingestão imprevisível.

Contraindicações, restrições e monitorização

Hipoglicemia: Contraindicada durante episódios de hipoglicemia ativa.

Vias: Administração primária por via subcutânea; em bombas de infusão contínua de insulina (SICI).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

223. Insulina Degludeca

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável ultralonga 100 UI/mL em caneta preenchida 3 mL

Indicações e Linha de Tratamento

Análogo de insulina basal de duração ultraprolongada (> 42 horas) com perfil plano e baixíssima variabilidade glicêmica diária. Indicada no controle basal do Diabetes Mellitus Tipo 1 em crianças ≥ 1 ano.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Controle Glicêmico Basal no DM1 (SC)	Administrar uma vez ao dia a qualquer hora do dia (preferencialmente no mesmo horário, com flexibilidade no horário de aplicação). Dose individualizada correspondente a 40-50% da dose total diária de insulina.	Injeção subcutânea única diária

Contraindicações, restrições e monitorização

Idade: Aprovada a partir de 1 ano de idade.

Via IV: NUNCA administrar por via intravenosa.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

224. Insulina Detemir

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável longa 100 UI/mL em caneta preenchida 3 mL

Indicações e Linha de Tratamento

Análogo de insulina basal solúvel com cadeia lateral lipídica que se liga à albumina plasmática (duração de 18 a 24 horas). Indicada no tratamento basal do DM1 em crianças ≥ 2 anos.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Controle Basal no DM1 (SC)	0,2 a 0,5 UI/kg/dia administrado em dose única noturna ou dividida a cada 12 horas (manhã e noite) conforme perfil glicêmico.	Injeção subcutânea

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipoglicemia.

Preparo: Não misturar com outras insulinas na mesma seringa.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

225. Insulina Glargina

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável longa 100 UI/mL em frasco 10 mL e carpule/caneta 3 mL, e 300 UI/mL em caneta 1,5 mL

Indicações e Linha de Tratamento

Análogo de insulina basal de ação prolongada sem pico plasmático significativo e duração de 24 horas (precipita microprecipitados no pH neutro subcutâneo). Primeira linha no controle basal de DM1 a partir de 2 anos.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Controle Basal no DM1 — Crianças ≥ 2 anos (SC)	Dose inicial habitual: 0,2 a 0,4 UI/kg uma vez ao dia no mesmo horário todos os dias (ao deitar ou pela manhã), correspondente a aprox. 40-50% da dose diária total.	Injeção subcutânea exclusiva

Contraindicações, restrições e monitorização

VIA INTRAVENOSA PROIBIDA: Estritamente contraindicada via IV (risco de hipoglicemia severa fulminante).

Mistura Proibida: Não misturar na mesma seringa com nenhuma outra insulina (pH ácido precipita outras insulinas).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

226. Insulina Glulisina

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável ultrarrápida 100 UI/mL em frasco 10 mL e carpule/caneta 3 mL

Indicações e Linha de Tratamento

Análogo de insulina humana de ação ultrarrápida sem zinco. Indicada no controle glicêmico prandial em crianças ≥ 4 anos e adolescentes com DM1.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Controle Prandial no DM1 (SC)	Administrar 15 minutos antes da refeição ou até 20 minutos após o início da alimentação conforme contagem de carboidratos e correção.	Subcutânea

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipoglicemia.

Idade: Não recomendada para < 4 anos.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

227. Insulina Lispro

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável ultrarrápida 100 UI/mL em frasco 10 mL e carpule/caneta 3 mL

Indicações e Linha de Tratamento

Análogo de insulina humana de ação ultrarrápida (início em 10 a 15 min, pico em 60 min). Primeira linha no controle prandial de DM1 em crianças e adolescentes e bombas de infusão contínua.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Controle Prandial no DM1 (SC)	Calculado por contagem de carboidratos e fator de sensibilidade; aplicar imediatamente antes ou logo após a refeição.	Subcutânea

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipoglicemia.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

228. Insulina NPH (Humana)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Suspensão injetável intermediária 100 UI/mL em frasco 10 mL e carpule/caneta 3 mL

Indicações e Linha de Tratamento

Insulina humana isófana de ação intermediária com protamina (início em 1 a 2h, pico em 4 a 8h, duração de 12 a 18h). Utilizada no controle basal do Diabetes Mellitus Tipo 1 e Tipo 2 na rede pública do SUS.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Controle Basal no DM1 (SC)	0,5 a 1,0 UI/kg/dia de dose total diária (NPH representando 60 a 70% do total, dividida em 2 a 3 aplicações: 2/3 pela manhã antes do desjejum e 1/3 ao deitar/jantar).	Homogeneizar suavemente o frasco rolando-o entre as mãos 10 a 20 vezes antes da aplicação (não agitar bruscamente).

Contraindicações, restrições e monitorização

VIA INTRAVENOSA ESTRITAMENTE CONTRAINDICADA: Risco gravíssimo de anafilaxia e choque hipoglicêmico devido aos cristais de protamina.

Condições: Hipoglicemia.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

229. Insulina Regular (Humana)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável rápida 100 UI/mL em frasco 10 mL e carpule/caneta 3 mL

Indicações e Linha de Tratamento

Insulina humana idêntica à endógena de ação rápida e única aprovada para uso intravenoso. Primeira linha padrão-ouro absoluta na Cetoacidose Diabética (CAD) pediátrica e hipercalcemia grave.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Cetoacidose Diabética (CAD) — Infusão Contínua (IV)	0,05 a 0,1 UI/kg/hora em infusão contínua em bomba sem bolus inicial (iniciar 1 a 2 horas após início da expansão volêmica e reposição de potássio).	Diluição padrão: 100 UI em 100 mL de SF0,9% (1 UI/mL). Purgar os primeiros 20 mL no equipo para saturar sítios de adesão. Manter queda da glicemia $\leq$ 50 a 100 mg/dL/hora para prevenir Edema Cerebral.
Hipercalcemia Grave com Alteração no ECG (IV)	0,1 UI/kg de insulina regular combinada com 0,5 g/kg de glicose (2 mL/kg de SG25% ou 5 mL/kg de SG10%) infundido em 30 minutos.	Desloca o potássio para o intracelular.

Contraindicações, restrições e monitorização

CAD sem Reposição Prévia de Potássio: NUNCA iniciar insulina se potássio sérico $<$ 3,3 a 3,5 mEq/L (risco fatal de arritmias cardíacas por hipocalcemia profunda).

Bolus IV na CAD: Contraindicado o bolus IV inicial na CAD pediátrica pelo risco de edema cerebral fulminante.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

230. Iodeto de potássio

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução oral/xarope 20 mg/mL e 100 mg/mL (solução saturada de iodeto de potássio - SSKI)

Indicações e Linha de Tratamento

Agente bloqueador da tireoide e mucolítico. Indicado no bloqueio agudo da captação tireoidiana de iodo radioativo em emergências nucleares radiológicas, crise tireotóxica/tempestade tireoidiana (efeito Wolff-Chaikoff) e preparo cirúrgico pré-tireoidectomia na Doença de Graves.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Proteção da Tireoide em Emergência Radiológica Nuclear (VO)	Neonatos e Lactentes $<$ 1 mês: 16 mg em dose única. Crianças de 1 mês a 3 anos: 32 mg em dose única. Crianças de 3 a 12 anos: 65 mg em dose única. Crianças $>$ 12 anos e Adolescentes: 130 mg em dose única.	Administrar o mais precocemente possível antes ou logo após a exposição.
Crise Tireotóxica (VO)	1 a 2 gotas de SSKI (50 a 100 mg) a cada 8 horas (iniciar 1 hora após antitireoidiano)	Dividido a cada 8 horas

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipersensibilidade ao iodo, dermatite herpetiforme e vasculite hipocomplementêmica.

Neonatos: Risco de hipotireoidismo congênito transitório; monitorar TSH.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

231. Isavuconazol (sulfato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Cápsulas 100 mg

Pó liofilizado para solução injetável frasco-ampola 200 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Antifúngico triazólico de amplo espectro de última geração com excelente perfil de segurança e menor toxicidade hepática. Indicado no tratamento de Aspergilose Invasiva e Mucormicose em crianças ≥ 1 ano.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Aspergilose Invasiva / Mucormicose — Crianças ≥ 1 ano (IV/VO)	Carga: 10 mg/kg a cada 8 horas por 6 doses (primeiras 48 horas; Máx: 200 mg/dose). Manutenção: 10 mg/kg uma vez ao dia (Máx: 200 mg/dia).	Infusão intravenosa lenta em pelo menos 60 minutos com filtro de linha de 0,2 a 1,2 micra.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipersensibilidade a azóis e Síndrome do QT Curto Congênito (o isavuconazol encurta o intervalo QTc, ao contrário de outros azóis).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

232. Isoflurano

Auditoria documental Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Líquido volátil para inalação em frascos de 100 mL e 240 mL

Indicações e Linha de Tratamento

Anestésico geral inalatório halogenado. Indicado na indução e manutenção de anestesia geral e terapia de resgate extremo no Estado de Mal Asmático refratário com falha de ventilação mecânica em UTI pediátrica.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Manutenção Anestésica Cirúrgica (Inalatória)	Concentração alveolar mínima (CAM): 1,0 a 1,6% titulada em vaporizador calibrado	Administração por anesthesiologista.
Broncoespasmo Refratário Extremo em UTI (Inalatória)	0,5 a 1,5% administrado em circuito fechado de ventilador	Broncodilatação potente imediata.

Contraindicações, restrições e monitorização

HIPERTERMIA MALIGNA: Contraindicação absoluta em pacientes com suscetibilidade genética conhecida à Hipertermia Maligna.

Condições: Cautela em pacientes com risco de hipertensão intracraniana.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

233. Isoniazida

Auditoria documental Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos 100 mg e 300 mg

Comprimidos em dose fixa combinada (RH / RHZE)

Indicações e Linha de Tratamento

Antituberculoso sintético de primeira linha bactericida essencial (inibidor da síntese de ácidos micólicos da parede celular). Primeira linha obrigatória no tratamento da Tuberculose ativa (fase intensiva e de manutenção) e no Tratamento da Infecção Latente pelo Mycobacterium tuberculosis (ILTB) em pediatria.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Tratamento da Tuberculose Ativa (VO)	10 mg/kg/dia (Faixa: 7 a 15 mg/kg/dia; Máx: 300 mg/dia)	Dose única diária matinal em jejum por 6 meses.

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Tratamento da Infecção Latente por TB (ILTB) (VO)	Esquema 9H: 10 mg/kg/dia (Máx: 300 mg/dia) por 270 doses diárias (9 meses). Esquema 3HP: Associado a rifapentina semanal por 12 semanas em ≥ 2 anos.	Dose única diária em jejum

Contraindicações, restrições e monitorização

Hepatotoxicidade: Black box warning para hepatite medicamentosa aguda grave e esteatose; suspender se transaminases > 3-5 vezes o limite superior com sintomas.

Suplementação com Piridoxina (Vitamina B6): OBRIGATÓRIA suplementação com piridoxina (5 a 10 mg/dia) em lactentes em aleitamento materno, desnutridos e crianças infectadas pelo HIV para prevenir neuropatia periférica e convulsões.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

234. Isoprenalina (Isoproterenol)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável 0,2 mg/mL (ampola 1 mL e 5 mL)

Indicações e Linha de Tratamento

Agonista adrenérgico sintético puro beta-1 e beta-2 (cronotrópico e inotrópico positivo potente com vasodilatação sistêmica). Indicado na Bradicardia Grave Sintomática refratária à atropina e bloqueio atrioventricular de alto grau congênito ou pós-cirúrgico antes do implante de marca-passo temporário.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Bradicardia Grave / Bloqueio AV Congênito (IV Contínuo)	0,05 a 0,1 mcg/kg/minuto em infusão contínua em bomba de seringa. Titular gradualmente em incrementos de 0,05 mcg/kg/min até frequência cardíaca alvo (Máx: 1 a 2 mcg/kg/min).	Diluição em SG5% ou SF0,9% sob monitorização de ECG contínua.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Taquiarritmias ventriculares, angina, intoxicação digitálica.

Efeitos: Aumento excessivo do consumo miocárdico de oxigênio e risco de hipotensão por vasodilatação beta-2.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

235. Isossorbida (mononitrato / dinitrato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos sublinguais 5 mg (dinitrato)

Comprimidos 10 mg, 20 mg e 40 mg (mononitrato)

Solução injetável 1 mg/mL

Indicações e Linha de Tratamento

Vasodilatador venoso e arterial doador de óxido nítrico (redução da pré-carga e pós-carga). Indicado na insuficiência cardíaca congestiva pediátrica refratária com hipertensão venocapilar pulmonar e pós-operatório de cirurgia cardíaca.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Insuficiência Cardíaca Congestiva Pediátrica (VO)	Mononitrato: Inicial 0,2 a 0,5 mg/kg/dia dividido a cada 12 horas. Titular até 1 a 2 mg/kg/dia (Máx: 40 a 60 mg/dia).	Garantir intervalo livre de nitrato de 10 a 12 horas por dia para prevenir tolerância farmacológica.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Choque cardiogênico com baixas pressões de enchimento, estenose aórtica severa e uso concomitante de inibidores da fosfodiesterase-5 (sildenafil).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

236. Itraconazol

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução oral 10 mg/mL

Cápsulas 100 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Antifúngico triazólico com excelente cobertura contra fungos dimórficos e dermatófitos. Primeira linha no tratamento da Paracoccidioidomicose, Histoplasmose e Esporotricose em pediatria, e alternativa na Aspergilose broncopulmonar alérgica (ABPA) na fibrose cística.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Histoplasmose / Paracoccidioidomicose / Esporotricose (VO)	5 a 10 mg/kg/dia dividido a cada 12 ou 24 horas por 6 a 12 meses (Máx: 200 a 400 mg/dia).	Cápsulas: Ingerir OBRIGATORIAMENTE logo após refeição completa para absorção ácida. Solução Oral: Tomar em jejum (possui maior biodisponibilidade que as cápsulas).

Contraindicações, restrições e monitorização

Hepatotoxicidade: Black box warning para disfunção hepática; dosagem periódica de ALT/AST obrigatória.

Interações: Potente inibidor do CYP3A4; contraindicado com cisaprida, pimozida e alcaloides do ergot.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

237. Ivermectina

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos 6 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Antiparasitário semi-sintético da classe das avermectinas que atua nos canais de cloro dependentes de glutamato. Primeira linha padrão-ouro no tratamento de Estrongiloidíase (*Strongyloides stercoralis*), Escabiose crostosa (sarna norueguesa) e escabiose refratária em crianças ≥ 15 kg.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Estrongiloidíase Intestinal (VO)	200 mcg/kg (0,2 mg/kg) em dose única diária por 2 dias consecutivos em jejum com água	Peso 15-24 kg: 1/2 comp (3 mg); 25-35 kg: 1 comp (6 mg); 36-50 kg: 1 e 1/2 comp (9 mg); > 50 kg: 2 comp (12 mg).
Escabiose Refratária / Sarna Crostosa (VO)	200 mcg/kg em dose única no Dia 1, repetindo obrigatoriamente a mesma dose no Dia 14.	Repetição em 14 dias para erradicar novos parasitas.

Contraindicações, restrições e monitorização

PESO E IDADE: ESTRITAMENTE CONTRAINDICADA EM CRIANÇAS COM PESO INFERIOR A 15 KG OU MENORES DE 2 ANOS de idade (risco de neurotoxicidade por imaturidade da barreira hematoencefálica com sonolência, ataxia e coma).

Condições: Meningite bacteriana ou doenças que alterem a barreira hematoencefálica.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

238. Labetalol (cloridrato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos 100 mg e 200 mg

Solução injetável 5 mg/mL (frasco-ampola 20 mL = 100 mg)

Indicações e Linha de Tratamento

Bloqueador combinado alfa-1 e beta adrenérgico não seletivo (relação de bloqueio alfa:beta de 1:7 na via IV). Primeira linha internacional para o controle da Emergência Hipertensiva pediátrica (encefalopatia hipertensiva, glomerulonefrite aguda) sem causar taquicardia reflexa acentuada.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Emergência Hipertensiva — Bolus Intermitente (IV)	0,2 a 1,0 mg/kg/dose (Máx: 20 a 40 mg/dose) administrado em injeção IV lenta em 2 a 5 minutos. Pode repetir a cada 10 a 15 minutos se necessário.	Seguido de infusão contínua se hipertensão refratária.
Emergência Hipertensiva — Infusão Contínua (IV)	0,25 a 3,0 mg/kg/hora em infusão em bomba sob monitorização de PA	Titular para queda da PA $\leq$ 25% nas primeiras 8 horas.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Asma brônquica grave descompensada, bloqueio atrioventricular de 2º ou 3º grau, bradicardia grave e choque cardiogênico.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

239. Lacosamida

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução oral 10 mg/mL

Comprimidos 50 mg, 100 mg, 150 mg e 200 mg

Solução para infusão IV 10 mg/mL (frasco 20 mL = 200 mg)

Indicações e Linha de Tratamento

Antiepiléptico de terceira geração que atua na inativação lenta dos canais de sódio dependentes de voltagem. Indicado no tratamento de crises epilépticas focais (com ou sem generalização) e terapia adjuvante no Estado de Mal Epiléptico refratário a partir de 1 mês de vida.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Crises Focais — Lactentes e Crianças (VO/IV)	Inicial: 1 a 2 mg/kg/dia dividido a cada 12 horas. Titular semanalmente até dose de manutenção de 6 a 12 mg/kg/dia (Máx: 300 a 400 mg/dia).	Infundir IV em 15 a 30 minutos.
Estado de Mal Epiléptico Refratário — Carga (IV)	6 a 10 mg/kg em infusão rápida de 15 minutos	Excelente tolerabilidade hemodinâmica.

Contraindicações, restrições e monitorização

Cardiotoxicidade: Prolongamento dose-dependente do intervalo PR no ECG; cautela em pacientes com bloqueio AV de 1º grau ou cardiopatias.

Condições: Hipersensibilidade à lacosamida.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

240. Lactulose

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução oral/xarope 667 mg/mL (66,7%)

Indicações e Linha de Tratamento

Dissacarídeo sintético não absorvível de ação osmótica e prebiótica. Primeira linha no tratamento de manutenção da Constipação Intestinal Funcional Crônica na infância e no tratamento e profilaxia da Encefalopatia Hepática na insuficiência hepática.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Constipação Intestinal Funcional (VO)	Lactentes: 2,5 a 5 mL/dia (ou 1 mL/kg/dia). Crianças de 1 a 6 anos: 5 a 10 mL/dia. Crianças > 6 anos e Adolescentes: 10 a 20 mL/dia (titular até 1 a 3 mL/kg/dia se necessário para obter 1 a 2 evacuações pastosas/dia).	Dose diária única matinal ou dividida a cada 12 horas com água ou suco.
Encefalopatia Hepática (VO)	1 a 3 mL/kg/dia dividido em 3 a 4 tomadas para obter 2 a 3 evacuações ácidas diárias	Acidifica o cólon e reduz amônia.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Galactosemia congênita, obstrução intestinal mecânica e suspeita de abdome agudo cirúrgico.

Efeitos: Meteorismo, flatulência e cólicas nos primeiros dias de uso.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

241. Lamotrigina

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos dispersíveis/mastigáveis 5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg e 200 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Antiepilético bloqueador de canais de sódio e inibidor da liberação pré-sináptica de glutamato. Primeira linha em crises focais, epilepsia generalizada idiopática, crises de ausência e Síndrome de Lennox-Gastaut em crianças ≥ 2 anos.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Epilepsia Pediátrica — Monoterapia (VO)	Semanas 1-2: 0,15 mg/kg/dia. Semanas 3-4: 0,3 mg/kg/dia. Manutenção: 1 a 5 mg/kg/dia a cada 12h.	Titulação obrigatoriamente lenta para prevenir farmacodermia grave.
Adjuvante com Valproato (Inibidor Enzimático) (VO)	Semanas 1-2: 0,15 mg/kg/dia em dias alternados. Semanas 3-4: 0,15 mg/kg/dia. Manutenção: 1 a 3 mg/kg/dia a cada 12h.	Doses reduzidas à metade pelo valproato.
Adjuvante com Indutores (Carbamazepina/Fenitoína) (VO)	Semanas 1-2: 0,6 mg/kg/dia. Semanas 3-4: 1,2 mg/kg/dia. Manutenção: 5 a 15 mg/kg/dia a cada 12h.	Doses aumentadas.

Contraindicações, restrições e monitorização

SÍNDROME DE STEVENS-JOHNSON / DRESS: Black box warning para erupções cutâneas graves fatais. Suspender IMEDIATAMENTE ao primeiro sinal de rash ou lesão mucosa.

Condições: Hipersensibilidade à lamotrigina.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

242. Lansoprazol

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Cápsulas com microgrânulos gastrorresistentes 15 mg e 30 mg

Comprimidos orodispersíveis 15 mg e 30 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Inibidor da Bomba de Prótons (IBP). Indicado no tratamento de Doença do Refluxo Gastroesofágico com esofagite erosiva, úlcera gastroduodenal e componente do esquema de erradicação de *H. pylori* a partir de 1 ano de idade.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
DRGE / Esofagite Erosiva — 1 a 11 anos (VO)	Peso ≤ 30 kg: 15 mg uma vez ao dia pela manhã 30 minutos antes do desjejum. Peso > 30 kg: 30 mg uma vez ao dia.	Comprimidos orodispersíveis se dissolvem rapidamente na língua ou em pequena quantidade de água.
Crianças ≥ 12 anos e Adolescentes (VO)	30 mg uma vez ao dia por 4 a 8 semanas	Tomar em jejum

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipersensibilidade a benzimidazóis.

Preparo: Não mastigar nem esmagar os microgrânulos das cápsulas.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

243. Laronidase

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução concentrada para infusão 0,58 mg/mL (frasco 5 mL = 2,9 mg)

Indicações e Linha de Tratamento

Terapia de reposição enzimática (alfa-L-iduronidase humana recombinante). Indicada para o tratamento a longo prazo das manifestações não neurológicas da Mucopolissacaridose Tipo I (MPS I / Síndrome de Hurler, Hurler-Scheie e Scheie).

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Mucopolissacaridose Tipo I (IV)	0,58 mg/kg (100 UI/kg) uma vez por semana em infusão intravenosa lenta contínua em 3 a 4 horas diluído em SF0,9%.	Pré-medicação com anti-histamínicos e antipiréticos 60 minutos antes da infusão.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Reações anafilactoides graves; manter suporte avançado de vias aéreas durante a aplicação.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

244. Levamisol (cloridrato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos 80 mg e 150 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Anti-helmíntico imidazotiazólico e imunomodulador estimulante de células T. Indicado no tratamento de Ascaridíase intestinal e como agente poupador de corticoides na Síndrome Nefrótica Córdico-Dependente recidivante frequente em nefrologia pediátrica.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Ascaridíase (VO)	2,5 mg/kg em dose única (Máx: 150 mg)	Tomar com água após refeição.
Síndrome Nefrótica Córdico-Dependente (VO)	2,5 mg/kg em dias alternados por 6 a 12 meses sob acompanhamento nefrológico.	Monitorar hemograma quinzenalmente.

Contraindicações, restrições e monitorização

Agranulocitose / Vasculite: Risco de neutropenia grave, agranulocitose imunomediada e vasculite leucocitoclástica com necrose cutânea auricular (suspender imediatamente se febre ou leucopenia).

Condições: Doença hepática grave.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

245. Levetiracetam

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução oral 100 mg/mL

Comprimidos revestidos 250 mg, 500 mg, 750 mg e 1000 mg

Solução para infusão IV 100 mg/mL (frasco-ampola 5 mL = 500 mg)

Indicações e Linha de Tratamento

Antiepiléptico de amplo espectro que se liga seletivamente à proteína da vesícula sináptica SV2A. Primeira linha moderna no tratamento do Estado de Mal Epiléptico Pediátrico refratário a benzodiazepínicos, crises focais e generalizadas da infância e convulsões neonatais.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Estado de Mal Epiléptico — Dose de Ataque (IV)	40 a 60 mg/kg (Máx: 3000 a 4500 mg) administrado em infusão intravenosa rápida em 5 a 10 minutos.	Excelente estabilidade hemodinâmica (sem risco de hipotensão ou arritmias).
Epilepsia Pediátrica — Manutenção (VO/IV)	Inicial: 20 mg/kg/dia dividido a cada 12 horas. Aumentar a cada 1 a 2 semanas em 10 a 20 mg/kg/dia até dose de manutenção de 40 a 60 mg/kg/dia (Máx: 3000 mg/dia).	Dividido a cada 12 horas.

Contraindicações, restrições e monitorização

Efeitos Psiquiátricos e Comportamentais: Pode desencadear irritabilidade intensa, agressividade, alterações de humor e psicose em crianças com transtornos neuropsiquiátricos prévios.

Ajustes: Reduzir dose em insuficiência renal (eliminação 66% inalterada na urina).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

246. Levocetirizina (dicloridrato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Gotas 5 mg/mL (1 gota = 0,25 mg)

Solução oral 0,5 mg/mL

Comprimidos revestidos 5 mg

Indicações e Linha de Tratamento

R-enantiômero puro ativo da cetirizina (anti-histamínico de segunda geração de alta potência e afinidade H1). Indicado no controle da Rinite Alérgica persistente e Urticária Crônica a partir de 6 meses de idade com menor taxa de sedação residual.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Rinite Alérgica e Urticária — 6 meses a 5 anos (VO)	1,25 mg (5 gotas ou 2,5 mL da solução oral) uma vez ao dia à noite	Dose única diária noturna
Crianças de 6 a 11 anos (VO)	2,5 mg (10 gotas ou 5 mL da solução) uma vez ao dia à noite	Dose única diária
Crianças ≥ 12 anos e Adolescentes (VO)	5 mg (1 comprimido ou 20 gotas) uma vez ao dia à noite	Dose única diária

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Insuficiência renal terminal (CICr < 10 mL/min) e pacientes em hemodiálise.

Idade: Não indicado para menores de 6 meses.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

247. Levodopa + Benserazida / Carbidopa

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos dispersíveis 50 mg + 12,5 mg

Comprimidos 100 mg + 25 mg e 200 mg + 50 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Precursor da dopamina associado a inibidor da dopa-descarboxilase periférica. Primeira linha padrão-ouro diagnóstica e terapêutica na Distonia Responsiva a Dopamina (Síndrome de Segawa / deficiência de GTP-ciclohidrolase I) e distonias dopa-responsivas na infância.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Distonia de Segawa / Distonia Responsiva a Levodopa (VO)	Inicial: 0,5 a 1 mg de levodopa/kg/dia dividido a cada 8 horas. Titular gradualmente até resposta motora completa (Dose habitual de manutenção: 3 a 10 mg/kg/dia; Máx: 200 a 400 mg/dia).	Administrar 30 minutos antes ou 1 hora após refeições ricas em proteínas.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Glaucoma de ângulo fechado, melanoma maligno suspeito e uso concomitante de IMAO não seletivos.

Interação Dietética: Dietas hiperproteicas competem pela absorção intestinal de aminoácidos neutros.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

248. Levodropropizina

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; concentrações simples checadas: OK

Apresentações Disponíveis

Xarope 30 mg/5 mL (6 mg/mL)

Gotas 60 mg/mL

Indicações e Linha de Tratamento

Antitussígeno não opioide de ação periférica nos nervos sensoriais das vias aéreas (inibe a liberação de neuropeptídeos inflamatórios). Indicado no alívio sintomático da tosse seca e irritativa em crianças ≥ 2 anos.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Tosse Seca e Irritativa — Crianças de 2 a 12 anos (VO)	1 mg/kg/dose (ou 3 mg/kg/dia dividido em 3 tomadas a cada 6 a 8 horas; Máx: 30 mg/dose)	Administrar entre as refeições por no máximo 7 dias.
Crianças > 12 anos e Adolescentes (VO)	60 mg (10 mL do xarope) 3 vezes ao dia	A cada 8 horas

Contraindicações, restrições e monitorização

Idade: Contraindicado para menores de 2 anos.

Condições: Hipersecreção brônquica produtiva, bronquiectasias e insuficiência hepática severa.

Checagem matemática automatizada

OK - 30 mg/5 mL = 6 mg/mL; declarado 6 mg/mL

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

249. Levofloxacin

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução oral

Comprimidos revestidos 250 mg, 500 mg e 750 mg

Solução para infusão IV 5 mg/mL (bolsa 100 mL = 500 mg)

Colírio oftálmico 0,5%

Indicações e Linha de Tratamento

Fluoroquinolona respiratória de terceira geração (L-isômero do ofloxacino) com potente atividade pneumocócica e antipseudomonas. Indicado em Pneumonias graves por bactérias multirresistentes, Tuberculose multirresistente (MDR-TB) e infecções bacterianas graves quando outras opções são inviáveis.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Pneumonia Grave / MDR-TB — 6 meses a 5 anos (VO/IV)	16 a 20 mg/kg/dia dividido a cada 12 horas (8 a 10 mg/kg/dose a cada 12h; Máx: 500 mg/dia)	Infundir IV lentamente em 60 minutos.
Crianças ≥ 5 anos e Adolescentes (VO/IV)	10 mg/kg/dia uma vez ao dia a cada 24 horas (Máx: 500 a 750 mg/dia)	Dose única diária

Contraindicações, restrições e monitorização

Restrição Pediátrica: Reservado para situações clínicas com indicação específica documentada pelo risco de artropatia.

Cardiotoxicidade: Risco de prolongamento de QTc e tendinopatia.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

250. Levomepromazina

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Gotas 40 mg/mL (1 gota = 1 mg)

Comprimidos 25 mg e 100 mg

Solução injetável 25 mg/5 mL

Indicações e Linha de Tratamento

Antipsicótico fenotiazínico sedativo de baixa potência com potente ação analgésica central e ansiolítica. Indicado no controle da agitação psicomotora grave, insônia rebelde e dor refratária em cuidados paliativos pediátricos.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Agitação Psicomotora / Cuidados Paliativos — Crianças ≥ 2 anos (VO)	Inicial: 0,25 a 0,5 mg/kg/dia dividido em 2 a 3 tomadas (maior fração ao deitar). Titular até 1 a 2 mg/kg/dia (Máx: 40 mg/dia em crianças pequenas).	Administrar preferencialmente à noite.

Contraindicações, restrições e monitorização

Idade: Contraindicado para menores de 2 anos de idade.

Condições: Risco de hipotensão postural severa por bloqueio alfa-1, sedação excessiva e depressão respiratória.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

251. Levosimendana

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução concentrada para infusão 2,5 mg/mL (frasco-ampola 5 mL = 12,5 mg)

Indicações e Linha de Tratamento

Sensibilizador de cálcio miofibrilar e abridor de canais de potássio dependentes de ATP (inodilatador não adrenérgico). Indicado no choque cardiogênico refratário, disfunção miocárdica pós-operatória de cirurgia cardíaca pediátrica e Síndrome de Baixo Débito Cardíaco em UTI.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Disfunção Miocárdica / Baixo Débito Pediátrico (IV Contínuo)	Dose de Ataque (opcional): 6 a 12 mcg/kg em 10 a 20 minutos (omitir se PAS no limite inferior). Manutenção Contínua: 0,05 a 0,2 mcg/kg/minuto por 24 a 48 horas.	Diluição exclusiva em SG5% por cateter venoso central sob monitorização hemodinâmica contínua.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipotensão arterial grave não corrigida, obstrução mecânica grave do enchimento/ejeção ventricular e insuficiência renal grave (ClCr < 30 mL/min).

Efeitos: Vasodilatação sistêmica com risco de hipotensão e taquiarritmias.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

252. Levotiroxina sódica

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Gotas 100 mcg/mL

Comprimidos 12,5 mcg, 25 mcg, 37,5 mcg, 50 mcg, 62,5 mcg, 75 mcg, 88 mcg, 100 mcg, 112 mcg, 125 mcg, 137 mcg, 150 mcg, 175 mcg e 200 mcg

Indicações e Linha de Tratamento

Hormônio tireoidiano sintético idêntico à tiroxina endógena (T4). Primeira linha padrão-ouro mandatória para o tratamento imediato do Hipotireoidismo Congênito (triagem neonatal - teste do pezinho) e Hipotireoidismo Adquirido na infância e adolescência.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Hipotireoidismo Congênito Neonatal (VO)	10 a 15 mcg/kg/dia em dose única matinal em jejum (iniciar nos primeiros 14 dias de vida para prevenir déficit cognitivo irreversível).	Triturar o comprimido em pequena colher com água ou leite materno (não dissolver em fórmulas de soja ou com ferro/cálcio).
Hipotireoidismo Adquirido Pediátrico (VO)	Crianças de 1 a 5 anos: 4 a 6 mcg/kg/dia. Crianças de 6 a 12 anos: 3 a 4 mcg/kg/dia. Adolescentes: 2 a 3 mcg/kg/dia (ou 50 a 100 mcg/dia).	Dose única diária matinal 30 a 60 minutos antes do desjejum.

Contraindicações, restrições e monitorização

Interações de Absorção: Sulfato ferroso, carbonato de cálcio, fórmulas de soja e colestiramina quelam a levotiroxina (espaçar em pelo menos 4 horas).

Condições: Tireotoxicose e insuficiência adrenal não tratada (tratar a insuficiência adrenal primeiro para evitar crise adrenal aguda).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

253. Lidocaína (cloridrato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável 1% e 2% sem vasoconstritor (ampolas e frascos 20 mL)

Spray tópico 10%

Gel/pomada tópica 2% e 5%

Indicações e Linha de Tratamento

Anestésico local do grupo amida e antiarrítmico de classe Ib. Primeira linha na anestesia infiltrativa local para suturas e procedimentos, analgesia tópica de mucosas, pré-medicação para intubação em trauma crânioencefálico (atenuação do reflexo de tosse e elevação da PIC) e antiarrítmico de segunda linha para Taquicardia Ventricular / Fibrilação Ventricular na PCR pediátrica.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Infiltração Anestésica Local (Infiltrativo)	Solução a 1% sem vasoconstritor: Máximo de 4,5 mg/kg (0,45 mL/kg de lidocaína 1%). Com epinefrina: Máximo de 7 mg/kg (0,7 mL/kg).	Aspiração prévia obrigatória antes de cada injeção para evitar injeção intravascular inadvertida.
PCR (FV/TV sem pulso) / Taquiarritmias Ventriculares (IV/IO)	1 mg/kg em bolus IV rápido. Manutenção: 20 a 50 mcg/kg/minuto em infusão contínua.	PALS 2025
Atenuação da PIC na Intubação em TCE (IV)	1 a 1,5 mg/kg administrado 2 a 3 minutos antes da laringoscopia	Uso hospitalar

Contraindicações, restrições e monitorização

LAST (Toxicidade Sistêmica): Sinais precoces incluem dormência perioral, gosto metálico, zumbido, seguidos de convulsões, arritmias e parada cardíaca.

Soluções com Vasoconstritor: ESTRITAMENTE CONTRAINDICADAS em extremidades e regiões terminais (dedos, ponta do nariz, orelhas, pênis) pelo risco de necrose isquêmica.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

254. Linezolida

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; concentrações simples checadas: OK

Apresentações Disponíveis

Solução para infusão IV 2 mg/mL (bolsa 300 mL = 600 mg)

Comprimidos 600 mg

Pó para suspensão oral 100 mg/5 mL (20 mg/mL)

Indicações e Linha de Tratamento

Antimicrobiano oxazolidinona sintético inibidor da síntese proteica na subunidade ribossômica 50S com biodisponibilidade oral de 100%. Primeira linha no tratamento de Pneumonia nosocomial e infecções de pele/partes moles graves por *Staphylococcus aureus* resistente à meticilina (MRSA) e *Enterococcus* resistente à vancomicina (VRE).

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Infecções Graves por MRSA / VRE — Neonatos e Crianças < 12 anos (IV/VO)	10 mg/kg/dose a cada 8 horas (Dose máxima: 600 mg a cada 8h)	Infundir IV lentamente em 30 a 60 minutos ou administrar via oral.
Crianças ≥ 12 anos e Adolescentes (IV/VO)	600 mg a cada 12 horas	Transição oral direta sem ajuste de dose.

Contraindicações, restrições e monitorização

Mielossupressão / Toxicidade: Black box warning para trombocitopenia, anemia e leucopenia em tratamentos > 14 dias; neuropatia óptica e periférica em uso > 28 dias. Hemograma semanal obrigatório.

Síndrome Serotoninérgica: Inibidor fraco da monoaminoxidase (MAO); contraindicado uso concomitante com ISRS e alimentos ricos em tiramina.

Checagem matemática automatizada

OK - 100 mg/5 mL = 20 mg/mL; declarado 20 mg/mL

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

255. Lisdexanfetamina (dimesilato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Cápsulas 30 mg, 50 mg e 70 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Pró-fármaco estimulante do SNC (d-anfetamina ligada covalentemente à L-lisina, ativada por hidrólise enzimática nos eritrócitos com duração de ação de 12 a 14 horas). Primeira linha padrão-ouro no tratamento do Transtorno do Déficit de Atenção com

Hiperatividade (TDAH) em crianças ≥ 6 anos e adolescentes.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
TDAH — Crianças ≥ 6 anos e Adolescentes (VO)	Inicial: 30 mg uma vez ao dia pela manhã (ou 20 mg em crianças menores). Titular semanalmente em incrementos de 10 a 20 mg até dose ideal de eficácia (Máx: 70 mg/dia).	Tomar pela manhã com ou sem alimentos. O conteúdo da cápsula pode ser aberto e dissolvido completamente em água, iogurte ou suco de laranja.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Cardiopatias congênicas estruturais graves, cardiomiopatias, arritmias graves, hipertensão moderada a grave, hipertireoidismo e glaucoma.

Monitorização: Avaliar pressão arterial, frequência cardíaca, curva de peso e estatura regularmente.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

256. Lítio (carbonato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos 300 mg

Comprimidos de liberação prolongada 450 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Estabilizador do humor padrão-ouro. Indicado no tratamento e profilaxia de episódios maníacos e mistos no Transtorno Bipolar do Humor em crianças ≥ 7 a 12 anos e adolescentes.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Transtorno Bipolar — Crianças ≥ 7 anos (VO)	Inicial: 300 mg 2 a 3 vezes ao dia (15 a 30 mg/kg/dia). Titular rigorosamente para manter litemia sérica terapêutica entre 0,8 e 1,2 mEq/L na fase aguda (e 0,6 a 0,8 mEq/L na manutenção).	Administrar junto com as refeições. Coletar litemia 12 horas após a última dose noturna a cada 3 a 6 dias na fase de ajuste.

Contraindicações, restrições e monitorização

Toxicidade Grave: Janela terapêutica estreita; toxicidade ($> 1,5$ mEq/L) causa ataxia, tremores grosseiros, vômitos, convulsões e coma.

Monitorização: Função renal (ureia, creatinina), função tireoidiana (TSH) e eletrólitos a cada 3 a 6 meses.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

257. Loperamida (cloridrato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos 2 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Opióide sintético agonista dos receptores mu-gastrointestinais periféricos que inibe o peristaltismo e aumenta o tônus do esfíncter anal. Uso restrito em adolescentes para diarreia crônica funcional após exclusão de causas infecciosas.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Diarreia Crônica em Adolescentes ≥ 12 anos (VO)	Inicial: 2 mg após a primeira evacuação líquida, seguido de 2 mg após cada evacuação solta subsequente (Máx: 8 mg/dia).	Limitar uso a 48 horas.

Contraindicações, restrições e monitorização

CONTRAINDICAÇÃO ABSOLUTA EM GASTROENTERITE AGUDA E MENORES DE 2 ANOS: Totalmente contraindicada em gastroenterite infecciosa aguda (diarreia aguda por *Salmonella*, *Shigella*, *E. coli* enteroinvasiva) devido ao alto risco fatal de Íleo Paralítico, megacólon tóxico, sepse bacteriana por translocação e morte.

Idade: Contraindicada para menores de 6 anos.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

258. Loratadina

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Xarope 1 mg/mL (5 mg/5 mL)

Comprimidos 10 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Anti-histamínico de segunda geração de longa ação sem efeito sedativo significativo. Primeira linha no tratamento da Rinite Alérgica e Urticária Aguda e Crônica a partir de 2 anos de idade.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Rinite Alérgica e Urticária — 2 a 5 anos (peso ≤ 30 kg) (VO)	5 mg (5 mL do xarope) uma vez ao dia	Dose única diária matinal
Crianças ≥ 6 anos e Peso > 30 kg (VO)	10 mg (10 mL do xarope ou 1 comprimido de 10 mg) uma vez ao dia	Dose única diária

Contraindicações, restrições e monitorização

Idade: Não recomendada para menores de 2 anos de idade.

Condições: Insuficiência hepática grave (iniciar com metade da dose ou em dias alternados).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

259. Lorazepam

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos 1 mg e 2 mg

Solução injetável 2 mg/mL e 4 mg/mL (ampolas 1 mL)

Indicações e Linha de Tratamento

Benzodiazepínico potente de ação intermediária com alta afinidade GABA-A e longa permanência no SNC (baixa redistribuição lipídica). Primeira linha padrão-ouro internacional no tratamento agudo do Estado de Mal Epiléptico na emergência pediátrica.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Estado de Mal Epiléptico — Primeira Linha (IV/IO)	0,1 mg/kg (Máx: 4 mg por dose) administrado em injeção intravenosa lenta em 2 minutos.	Pode repetir uma segunda dose de 0,05 a 0,1 mg/kg em 5 a 10 minutos se as convulsões persistirem.

Contraindicações, restrições e monitorização

Depressão Respiratória: Risco de apneia, depressão respiratória e hipotensão; manter suporte ventilatório disponível.

Diluyente: As formulações injetáveis contêm propilenoglicol (risco de acidose láctica e hiperosmolaridade em infusões contínuas prolongadas).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

260. Losartana potássica

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos 25 mg, 50 mg e 100 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Bloqueador dos Receptores de Angiotensina II (BRA) do subtipo AT1. Primeira linha no tratamento da Hipertensão Arterial pediátrica em crianças ≥ 6 anos (especialmente com intolerância a IECAs por tosse seca) e nefroproteção na proteinúria crônica.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Hipertensão Arterial Pediátrica — Crianças ≥ 6 anos (VO)	Inicial: 0,7 mg/kg/dia em dose única diária (Máx inicial: 50 mg/dia). Titular conforme resposta da PA até 1,4 mg/kg/dia (Máx: 100 mg/dia).	Tomar uma vez ao dia com ou sem alimentos.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Estenose bilateral de artéria renal, hipercalemia grave ($> 5,5$ mEq/L) e gravidez (fetotoxicidade grave).

Monitorização: Dosar potássio e creatinina séricos periodicamente.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

261. Macrogol 3350 / 4000 (Polietilenoglicol - PEG)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó para solução oral em sachês de 4 g, 5 g, 8 g, 10 g, 14 g, 17 g ou a granel (sem eletrólitos)

Indicações e Linha de Tratamento

Laxativo osmótico polimérico inerte de alto peso molecular que retém água no lúmen intestinal por pontes de hidrogênio (sem fermentação bacteriana, gases ou absorção sistêmica). Primeira linha padrão-ouro absoluta de consenso internacional (ESPGHAN/NASPGHAN/SBP) para Desimpactação Fecal e Tratamento de Manutenção da Constipação Intestinal Funcional Crônica em pediatria.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Desimpactação Fecal na Emergência (VO)	1 a 1,5 g/kg/dia diluído em água/suco por 3 a 6 dias consecutivos (Máx: 100 g/dia)	Dividido em 1 a 2 tomadas diárias até desimpactação completa.
Tratamento de Manutenção da Constipação Crônica (VO)	0,4 a 0,8 g/kg/dia em dose única diária matinal (titular para obter 1 a 2 evacuações tipo 3-4 de Bristol por dia).	Dissolver o sachê em 100 a 150 mL de água, suco ou leite. Manter tratamento por no mínimo 2 a 6 meses.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Obstrução intestinal mecânica, perfuração gastrointestinal, megacólon tóxico e doença inflamatória intestinal ativa grave.

Palatabilidade: Sem sabor e odor; excelente adesão na infância.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

262. Mebendazol

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Suspensão oral 20 mg/mL (100 mg/5 mL)

Comprimidos 100 mg e 500 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Anti-helmíntico benzimidazol de amplo espectro inibidor da polimerização de tubulina dos parasitas. Indicado no tratamento de infecções intestinais por Enterobius vermicularis (oxiuríase), Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura e ancilostomídeos.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Oxiúriase (Enterobíase) — Crianças ≥ 1 ano (VO)	100 mg em dose única. Repetir OBRIGATORIAMENTE após 14 dias para tratar novas formas eclodidas dos ovos.	Dose única
Ascaridíase, Tricuríase e Ancilostomíase (VO)	100 mg (5 mL) a cada 12 horas por 3 dias consecutivos (ou 500 mg em dose única).	Tomar com água independente das refeições.

Contraindicações, restrições e monitorização

Idade: Contraindicado para menores de 1 ano de idade (risco aumentado de convulsões).

Condições: Hipersensibilidade a benzimidazóis e gravidez.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

263. Meloxicam

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos 7,5 mg e 15 mg

Solução injetável 15 mg/1,5 mL

Indicações e Linha de Tratamento

Anti-inflamatório não esteroide derivado do ácido enólico com inibição preferencial da COX-2 em baixas doses. Indicado no tratamento sintomático da Artrite Idiopática Juvenil (AIJ) em crianças ≥ 2 anos.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Artrite Idiopática Juvenil — Crianças ≥ 2 anos (VO)	0,125 mg/kg uma vez ao dia (titular até máx 0,25 mg/kg/dia ou 7,5 mg/dia; 15 mg/dia em adolescentes > 50 kg)	Dose única diária junto com alimentos.

Contraindicações, restrições e monitorização

Idade: Não recomendado para menores de 2 anos.

Condições: Úlcera péptica ativa, insuficiência renal grave e asma induzida por AINEs.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

264. Meropenem (tri-hidratado)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó liofilizado para solução injetável frasco-ampola 500 mg e 1 g

Indicações e Linha de Tratamento

Antimicrobiano carbapenêmico bactericida ultra-ampla com excelente penetração no SNC e baixo potencial epileptogênico. Primeira linha para Meningite Bacteriana hospitalar/por Gram-negativos resistentes, Sepses Graves / Choque Séptico em UTI, infecções intra-abdominais complicadas e exacerbações graves em Fibrose Cística.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Sepses Graves / Infecções Hospitalares Gerais (IV)	60 mg/kg/dia (20 mg/kg/dose a cada 8 horas; Máx: 3 g/dia)	Infusão intravenosa lenta em 30 minutos (ou infusão estendida em 3 horas para otimizar T>MIC).
Meningite Bacteriana / Fibrose Cística / Infecções por Pseudomonas (IV)	120 mg/kg/dia (40 mg/kg/dose a cada 8 horas; Máx: 2 g a cada 8h = 6 g/dia)	Infundir em 3 horas.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipersensibilidade grave mediada por IgE a carbapenêmicos.

Interação Grave com Valproato: Reduz os níveis séricos de ácido valproico em 80-90% em 24h, precipitando Estado de Mal Epiléptico (evitar associação estritamente).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

265. Mesalazina

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos e sachês de liberação prolongada 400 mg, 500 mg, 800 mg, 1000 mg e 1200 mg

Supositórios 250 mg, 500 mg e 1000 mg

Enema 1 g e 3 g

Indicações e Linha de Tratamento

Agente anti-inflamatório intestinal tópico (ácido 5-aminossalicílico / 5-ASA). Primeira linha para indução e manutenção da remissão na Retocolite Ulcerativa leve a moderada e Doença de Crohn cólica em crianças ≥ 5 anos.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Retocolite Ulcerativa — Fase Ativa de Indução (VO)	40 a 60 mg/kg/dia dividido em 2 a 3 tomadas (Máx: 2,4 a 4,8 g/dia)	Ingerir os comprimidos inteiros sem mastigar para preservar a liberação entérica.
Manutenção da Remissão (VO)	20 a 30 mg/kg/dia em dose única ou a cada 12 horas (Máx: 2 g/dia)	Uso contínuo prolongado
Proctite / Retossigmoidite Distal (Tópico Retal)	Supositório: 20 a 30 mg/kg/dia ao deitar (ou 500 a 1000 mg). Enema: 1 g ao deitar.	Uso noturno

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipersensibilidade a salicilatos (AAS) e insuficiência renal grave.

Monitorização: Creatinina sérica basal e periódica (risco de nefrite intersticial).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

266. Metadona (cloridrato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos 5 mg e 10 mg

Solução injetável 10 mg/mL (ampola 1 mL)

Indicações e Linha de Tratamento

Agonista opioide sintético mu de longa meia-vida e antagonista dos receptores NMDA. Primeira linha no protocolo de desmame e prevenção da Síndrome de Abstinência de Opioides em crianças pós-sedação prolongada em UTI pediátrica e dor oncológica neuropática complexa.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Desmame de Opioides em UTI Pediátrica (VO/IV)	Calcular a dose diária total de opioide prévio convertida para equivalente de morfina oral e multiplicar por 0,1 a 0,2 para obter a dose diária de metadona. Administrar a cada 6 a 12 horas.	Reduzir 10 a 20% da dose a cada 2 a 5 dias conforme escores de abstinência (WAT-1).

Contraindicações, restrições e monitorização

Cardiotoxicidade: Black box warning para prolongamento do intervalo QTc e Torsades de pointes (ECG basal e seriado obrigatório).

Acúmulo Farmacocinético: Meia-vida longa e variável (15 a 60 horas) com alto risco de acúmulo e sedação tardia.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

267. Metformina (cloridrato)

Auditoria documental Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos 500 mg, 850 mg e 1000 mg

Comprimidos de liberação prolongada XR 500 mg, 750 mg e 1000 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Anti-hiperglicemiante biguanida sensibilizador da insulina periférica e inibidor da gliconeogênese hepática. Primeira linha padrão-ouro no tratamento do Diabetes Mellitus Tipo 2 em crianças e adolescentes ≥ 10 anos e Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP).

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Diabetes Mellitus Tipo 2 — Crianças ≥ 10 anos (VO)	Inicial: 500 mg uma vez ao dia com a principal refeição (ou 500 mg a cada 12h). Aumentar em 500 mg a cada 1 a 2 semanas até dose alvo de 1.500 a 2.000 mg/dia (Máx: 2.000 mg/dia).	Administrar durante ou após as refeições para minimizar náuseas e dor abdominal; preferir formulações XR à noite.

Contraindicações, restrições e monitorização

Acidose Lática: Black box warning para acidose láctica grave; suspender se sepse, choque, desidratação grave ou insuficiência renal (TFG < 30 mL/min).

Contraste Iodado: Suspender 48h antes e após procedimentos com contraste radiológico iodado.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

268. Metilfenidato (cloridrato)

Auditoria documental Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos de liberação imediata 10 mg (duração 3 a 4h)

Cápsulas de liberação modificada 10 mg, 20 mg, 30 mg e 40 mg (duração 8h)

Comprimidos de liberação osmótica prolongada (OROS) 18 mg, 27 mg, 36 mg e 54 mg (duração 12h)

Indicações e Linha de Tratamento

Estimulante do SNC inibidor da recaptação pré-sináptica de dopamina e noradrenalina. Primeira linha padrão-ouro no tratamento do Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e Narcolepsia em crianças ≥ 6 anos e adolescentes.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
TDAH — Liberação Imediata (VO)	Inicial: 0,3 mg/kg/dia (ou 5 mg) pela manhã e almoço. Titular semanalmente até 0,5 a 1,0 mg/kg/dia (Máx: 2 mg/kg/dia ou 60 mg/dia divididos em 2 a 3 tomadas).	Tomar 30 minutos antes das refeições (evitar doses após as 16h para prevenir insônia).
TDAH — Liberação Prolongada (OROS / LA) (VO)	Iniciar com 18 a 20 mg uma vez ao dia pela manhã (titular até máx 54 mg/dia para OROS ou 60 mg/dia para LA).	Engolir inteiro pela manhã sem mastigar ou triturar.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Glaucoma, ansiedade grave, histórico de dependência, cardiopatias congênicas graves, arritmias e uso concomitante de IMAO.

Monitorização: Pressão arterial, frequência cardíaca, curva de ganho ponderoestatural e triagem para tiques.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

269. Metilprednisolona (succinato sódico / acetato)

Auditoria documental Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó liofilizado para solução injetável frasco-ampola 125 mg, 500 mg e 1000 mg (succinato sódico, IV)

Suspensão injetável de depósito 40 mg/mL e 80 mg/mL (acetato, intra-articular/IM)

Comprimidos 4 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Glicocorticoide sintético de alta potência com mínima atividade mineralocorticoide. Primeira linha para Pulsoterapia Imunossupressora na Nefrite Lúpica grave, Glomerulonefrite Crescêntica, Síndrome Nefrótica Córdico-Resistente, Neurite Óptica, Rejeição Aguda de Transplantes e crise asmática grave em UTI.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Pulsoterapia Imunossupressora em Nefrologia/Reumatologia (IV)	30 mg/kg/dia (Máx: 1000 mg/dia) administrado em dias alternados ou 3 dias consecutivos.	Infundir OBRIGATORIAMENTE em 1 a 2 horas diluído em SG5% ou SF0,9% sob monitorização cardíaca contínua.
Crise Asmática Grave em UTI (IV)	Ataque: 1 a 2 mg/kg. Manutenção: 0,5 a 1 mg/kg a cada 6 horas.	Infusão lenta em 15 a 30 minutos.

Contraindicações, restrições e monitorização

VELOCIDADE DE INFUSÃO NA PULSOTERAPIA: A infusão em bolus rápido (< 30 min) está formalmente contraindicada pelo alto risco fatal de parada cardíaca, arritmias ventriculares fulminantes e colapso cardiovascular.

Condições: Infecções sistêmicas ativas graves e hipertensão arterial grave não controlada.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

270. Metoclopramida (cloridrato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Gotas 4 mg/mL (1 gota = 0,2 mg)

Solução oral 1 mg/mL

Comprimidos 10 mg

Solução injetável 5 mg/mL (ampola 2 mL = 10 mg)

Indicações e Linha de Tratamento

Antiemético e pró-cinético antagonista dopaminérgico D2 com passagem pela barreira hematoencefálica. Indicado em náuseas e vômitos refratários associados a migrânea e procedimentos sob estrito controle.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Náuseas e Vômitos — Crianças ≥ 1 ano (VO/IV/IM)	0,1 a 0,15 mg/kg/dose a cada 8 horas (Máx: 0,5 mg/kg/dia ou 10 mg/dose em adolescentes).	Infundir IV lentamente em pelo menos 3 a 5 minutos. Duração máxima de tratamento de 5 dias.

Contraindicações, restrições e monitorização

CONTRAINDICAÇÃO ESTRITA EM MENORES DE 1 ANO: Totalmente contraindicada em menores de 1 ano devido ao altíssimo risco de reações extrapiramidais graves (distonias agudas, crises oculógiras, opistótono) e metaemoglobinemia neonatal.

Condições: Feocromocitoma, epilepsia, obstrução mecânica ou perfuração intestinal.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

271. Metoprolol (tartarato / succinato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos 25 mg, 50 mg e 100 mg (tartarato)

Comprimidos de liberação prolongada 25 mg, 50 mg e 100 mg (succinato)

Solução injetável 1 mg/mL (ampola 5 mL = 5 mg)

Indicações e Linha de Tratamento

Betabloqueador seletivo beta-1 cardioseletivo. Indicado no tratamento da Hipertensão Arterial pediátrica, Taquicardias Supraventriculares e Insuficiência Cardíaca Crônica com disfunção sistólica estável em crianças a partir de 6 anos.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Hipertensão e Insuficiência Cardíaca — Succinato (VO)	Inicial: 0,5 a 1,0 mg/kg/dia em dose única diária matinal. Titular gradualmente até 2 mg/kg/dia (Máx: 200 mg/dia).	Engolir o comprimido inteiro de liberação prolongada sem mastigar.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Bradicardia sinusal severa, bloqueio AV de 2º ou 3º grau, choque cardiogênico e asma brônquica grave descompensada.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

272. Metronidazol / Benzoilmetronidazol

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Suspensão oral 40 mg/mL (200 mg/5 mL de benzoilmetronidazol)

Comprimidos 250 mg e 400 mg

Solução para infusão IV 5 mg/mL (bolsa 100 mL = 500 mg)

Gel vaginal 0,8%

Indicações e Linha de Tratamento

Antiparasitário e antimicrobiano bactericida com potente atividade contra protozoários e bactérias anaeróbias estritas (*Bacteroides fragilis*, *Clostridioides difficile*). Primeira linha na Amebíase invasiva, Giardíase, infecções intra-abdominais anaeróbicas (associado a aminoglicosídeo ou cefalosporina) e colite pseudomembranosa.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Giardíase (VO)	15 a 20 mg/kg/dia dividido a cada 8 horas por 5 dias consecutivos (Máx: 750 mg/dia)	Administrar junto com as refeições.
Amebíase Intestinal / Abscesso Hepático Amebiano (VO/IV)	35 a 50 mg/kg/dia dividido a cada 8 horas por 7 a 10 dias (Máx: 2.250 mg/dia)	Dividido a cada 8 horas
Infecções Anaeróbicas Graves / Sepses Abdominal (IV)	30 a 40 mg/kg/dia dividido a cada 8 horas em infusão lenta de 30 a 60 minutos (Máx: 1,5 a 2 g/dia)	Infusão intravenosa lenta.

Contraindicações, restrições e monitorização

Efeito Dissulfiram: Evitar produtos contendo álcool durante e até 48h após o término do tratamento.

Condições: Doença neurológica ativa grave e primeiro trimestre da gestação.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

273. Micafungina sódica

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó liofilizado para solução injetável frasco-ampola 50 mg e 100 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Antifúngico da classe das equinocandinas. Primeira linha no tratamento da Candidíase Invasiva, candidemia, candidíase esofágica e profilaxia de infecções fúngicas em transplante de medula óssea a partir do período neonatal.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Candidíase Invasiva em Neonatos e Lactentes < 4 meses (IV)	4 a 10 mg/kg/dia em dose única diária em infusão intravenosa de 60 minutos (doses mais altas necessárias devido ao maior clearance neonatal).	Infundir em 60 minutos diluído em SF0,9% ou SG5%.
Candidíase Invasiva em Crianças ≥ 4 meses (IV)	Peso ≤ 40 kg: 2 mg/kg/dia (titular até 4 mg/kg/dia se SNC/endocardite; Máx: 100 mg/dia). Peso > 40 kg: 100 mg uma vez ao dia.	Dose única diária
Profilaxia Antifúngica em Transplante (IV)	1 mg/kg/dia em dose única diária (Máx: 50 mg/dia)	Dose única diária

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipersensibilidade a equinocandinas e insuficiência hepática grave.

Vantagem Neonatal: Excelente segurança e eficácia comprovada no recém-nascido prematuro.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

274. Miconazol (nitrato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Gel oral 20 mg/g (2%)

Creme dermatológico 20 mg/g (2%)

Loção tópica 20 mg/mL (2%)

Creme vaginal 20 mg/g

Indicações e Linha de Tratamento

Antifúngico imidazólico de uso tópico e oral luminal. Indicado no tratamento de Candidíase Oral (sapinho) em lactentes e crianças, dermatite de fraldas por Candida e tineas superficiais.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Candidíase Oral / Sapinho — Lactentes > 4 meses (Gel Oral)	1,25 mL (1/4 da colher-medida) aplicado com o dedo limpo nas bochechas e língua 4 vezes ao dia após as mamadas por 7 a 14 dias.	Manter na boca o máximo de tempo antes de engolir; não colocar no fundo da garganta para evitar engasgo.
Micoses Cutâneas (Creme Tópico)	Aplicar fina camada sobre as lesões 2 vezes ao dia por 2 a 4 semanas	Higiene local prévia

Contraindicações, restrições e monitorização

Idade: Contraindicado para menores de 4 meses pelo risco mecânico de asfixia por deglutição do gel viscoso.

Interação Sistêmica: Potente inibidor do CYP2C9/CYP3A4 se absorvido (aumenta risco de sangramento com varfarina).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

275. Midazolam (cloridrato / maleato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução oral/xarope 2 mg/mL

Comprimidos 7,5 mg e 15 mg

Solução injetável 1 mg/mL (ampola 5 mL = 5 mg) e 5 mg/mL (ampolas 3 mL = 15 mg e 10 mL = 50 mg)

Indicações e Linha de Tratamento

Benzodiazepínico de ação ultracurta e alta potência com propriedades sedativas, amnésicas e anticonvulsivantes rápidas. Primeira linha no controle do Estado de Mal Epiléptico sem acesso venoso (vias intranasal, bucal e intramuscular), sedação

pré-procedimento e sedação contínua pós-intubação em UTI.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Estado de Mal Epiléptico — Via Intranasal / Bucal (Intranasal/Bucal)	0,2 a 0,3 mg/kg (usar a solução injetável de 5 mg/mL com dispositivo atomizador MAD ou instilação bucal; Máx: 10 mg)	Início em 2 a 3 minutos; primeira escolha na ausência de acesso venoso na emergência.
Estado de Mal Epiléptico — Via Intravenosa / Intraóssea (IV/IO)	0,1 a 0,2 mg/kg em bolus IV lento em 2 minutos (Máx: 5 a 10 mg)	Pode repetir após 5 minutos.
Sedação Contínua em UTI Pediátrica pós-IOT (IV)	Carga: 0,1 a 0,2 mg/kg. Manutenção contínua: 0,05 a 0,3 mg/kg/hora (1 a 5 mcg/kg/min) em bomba de infusão.	Titular por escalas COMFORT-B / SBS.
Sedação Pré-Procedimento / Pré-Anestésica (VO)	0,5 a 0,75 mg/kg (Máx: 15 a 20 mg) administrado 20 a 30 minutos antes do procedimento.	Oral

Contraindicações, restrições e monitorização

Depressão Respiratória: Alto risco de apneia, hipoventilação e dessaturação; manter monitorização contínua de SpO₂, suporte ventilatório pronto e flumazenil disponível.

Condições: Glaucoma de ângulo fechado e choque descompensado sem reposição volêmica.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

276. Milrinona (lactato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável 1 mg/mL (ampolas de 10 mL = 10 mg e 20 mL = 20 mg)

Indicações e Linha de Tratamento

Inibidor seletivo da fosfodiesterase III miocárdica e vascular (inodilatador inotrópico positivo e vasodilatador pulmonar/sistêmico potente sem aumento do consumo de oxigênio). Primeira linha na prevenção e tratamento da Síndrome de Baixo Débito Cardíaco pós-operatório de cirurgia cardíaca e Choque Cardiogênico com alta resistência vascular sistêmica.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Baixo Débito Cardíaco / Choque Cardiogênico (IV/IO Contínuo)	Dose de Ataque (opcional): 50 mcg/kg em infusão lenta de 15 a 30 minutos (omitir se PAS limitrofe). Manutenção Contínua: 0,25 a 0,75 mcg/kg/minuto em bomba de infusão.	Diluição em SF0,9% ou SG5% por cateter venoso central sob monitorização hemodinâmica contínua.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipotensão grave não corrigida, choque hipovolêmico e estenose aórtica/pulmonar grave.

Ajustes: Reduzir dose em insuficiência renal (excreção renal 85%). Risco de trombocitopenia e arritmias ventriculares.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

277. Minociclina (cloridrato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos 100 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Antimicrobiano tetraciclínico lipofílico com excelente penetração tecidual e sebácea. Indicado no tratamento de Acne vulgar inflamatória moderada a grave em adolescentes ≥ 8 a 12 anos e infecções por MRSA comunitário suscetível.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Acne Vulgar Inflamatória em Adolescentes (VO)	50 a 100 mg a cada 12 horas (ou 100 mg em dose única diária) por 6 a 12 semanas	Tomar com copo cheio de água para evitar esofagite; não deitar por 30 minutos.

Contraindicações, restrições e monitorização

Idade: Contraindicada para menores de 8 anos (risco de pigmentação dentária acinzentada permanente e hipoplasia de esmalte).

Efeitos Raros: Risco de hiperpigmentação cutânea/mucosa, síndrome lúpica induzida por fármaco e hipertensão intracraniana benigna.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

278. Mometasona (furoato)

Auditoria documental Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Spray nasal aquoso 50 mcg/dose

Pó inalatório 200 mcg e 400 mcg/dose

Creme e pomada dermatológica 1 mg/g (0,1%)

Indicações e Linha de Tratamento

Corticoide tópico e nasal de média a alta potência com baixíssima biodisponibilidade sistêmica (< 0,1%). Primeira linha no tratamento da Rinite Alérgica persistente em crianças ≥ 2 anos, hipertrofia de adenoide e dermatite atópica moderada a grave.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Rinite Alérgica / Hipertrofia de Adenoide — 2 a 11 anos (Spray Nasal)	1 jato (50 mcg) em cada narina uma vez ao dia (Dose total diária: 100 mcg)	Dose única matinal
Crianças ≥ 12 anos e Adolescentes (Spray Nasal)	2 jatos (100 mcg) em cada narina uma vez ao dia (200 mcg/dia)	Dose única diária
Dermatite Atópica / Eczema (Tópico)	Aplicar fina camada sobre as lesões uma vez ao dia por 1 a 2 semanas	Excelente posologia cômoda diária única.

Contraindicações, restrições e monitorização

Idade: Não indicado para menores de 2 anos na rinite nasal.

Condições: Lesões cutâneas infectadas não tratadas e perfuração septal nasal.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

279. Montelukaste de sódio

Auditoria documental Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Grânulos orais em sachê 4 mg

Comprimidos mastigáveis 4 mg e 5 mg

Comprimidos revestidos 10 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Antagonista dos receptores de leucotrienos CysLT1 com potente ação anti-inflamatória brônquica e nasal. Indicado como terapia adjuvante no controle da Asma Persistente, prevenção da broncoconstrição induzida por exercício e controle da Rinite Alérgica em crianças a partir de 6 meses de vida.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Asma / Rinite Alérgica — 6 meses a 5 anos (VO)	4 mg (1 sachê de grânulos ou 1 comprimido mastigável de 4 mg) uma vez ao dia à noite	Os grânulos podem ser administrados direto na boca ou misturados em pequena porção de alimento pastoso frio (papinha/iogurte).

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Crianças de 6 a 14 anos (VO)	5 mg (1 comprimido mastigável de 5 mg) uma vez ao dia à noite	Dose única noturna
Crianças ≥ 15 anos e Adolescentes (VO)	10 mg (1 comprimido revestido de 10 mg) uma vez ao dia à noite	Dose única noturna

Contraindicações, restrições e monitorização

Black Box Warning Neuropsiquiátrico: Alerta da FDA e ANVISA para risco de alterações de humor, pesadelos vívidos, agressividade, sonambulismo e ideação suicida (orientar pais a suspender o uso se surgirem alterações comportamentais).

Condições: Hipersensibilidade aos componentes; não é droga de resgate para crise aguda de asma.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

280. Morfina (sulfato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução oral 10 mg/mL (gotas)

Comprimidos 10 mg e 30 mg

Comprimidos de liberação prolongada 30 mg e 60 mg

Solução injetável sem conservantes 0,1 mg/mL e 0,2 mg/mL (ampolas 1 mL)

Solução injetável 1 mg/mL (ampola 2 mL) e 10 mg/mL (ampolas 1 mL)

Indicações e Linha de Tratamento

Opioide agonista mu padrão-ouro no controle da Dor Intensa Aguda (crises álgicas falciformes, queimaduras graves, dor pós-operatória severa, trauma), analgesia em cuidados paliativos oncológicos e alívio de crises de hipóxia (Tet spells) na Tetralogia de Fallot.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Dor Aguda Intensa / Crise Falciforme (IV/IO)	0,05 a 0,1 mg/kg/dose (50 a 100 mcg/kg) infundido em 5 a 10 minutos (Máx: 5 a 10 mg/dose inicial).	Pode titular a cada 2 a 4 horas conforme escalas de dor.
Crise de Cianose na Tetralogia de Fallot (SC/IM/IV)	0,1 a 0,2 mg/kg/dose (acalma o paciente e reduz o espasmo infundibular pulmonar)	Dose de resgate imediata
Infusão Contínua em UTI / Pós-Operatório (IV)	10 a 30 mcg/kg/hora em infusão contínua em bomba dedicada	Titular rigorosamente por escala FLACC/NIPS.
Tratamento Oral em Dor Crônica / Oncológica (VO)	0,2 a 0,5 mg/kg/dose a cada 4 horas (forma de liberação imediata)	Prescrever laxativo osmótico profilático concomitante.

Contraindicações, restrições e monitorização

Depressão Respiratória: Alto risco de hipoventilação e apneia dose-dependentes; dispor de Naloxona imediata.

Condições: Depressão respiratória grave não ventilada, íleo paralítico e asma aguda grave.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

281. Moxifloxacino (cloridrato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos 400 mg

Solução para infusão IV 400 mg/250 mL

Colírio oftálmico 0,5%

Indicações e Linha de Tratamento

Fluoroquinolona respiratória de quarta geração de amplo espectro com potente atividade contra bactérias atípicas, Gram-positivos e anaeróbios. Indicado no tratamento de Tuberculose Multirresistente (MDR-TB) em regimes especializados e colírio de primeira linha para úlceras de córnea bacterianas graves e conjuntivite bacteriana.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Tuberculose Multirresistente — Crianças e Adolescentes (VO/IV)	7,5 a 10 mg/kg/dia em dose única diária (Máx: 400 mg/dia)	Uso restrito sob supervisão de pneumologia pediátrica.
Conjuntivite / Úlcera de Córnea (Oftálmico)	1 gota no olho afetado 3 vezes ao dia por 7 dias	Uso tópico

Contraindicações, restrições e monitorização

Cardiotoxicidade: Risco de prolongamento do intervalo QTc.

Restrição Pediátrica: Uso sistêmico estritamente reservado para MDR-TB e infecções sem alternativa terapêutica viável.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

282. Mupirocina

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pomada dermatológica 20 mg/g (2%)

Indicações e Linha de Tratamento

Antibacteriano tópico inibidor da isoleucil-tRNA sintetase com potente ação contra Staphylococcus aureus (incluindo MRSA) e Streptococcus pyogenes. Primeira linha no tratamento do Impetigo crostoso/bolhoso localizado, foliculite e descolonização nasal de MRSA.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Impetigo Localizado / Lesões Cutâneas Infectadas (Tópico)	Aplicar fina camada sobre as lesões 3 vezes ao dia por 7 a 10 dias após remoção suave das crostas com água morna.	Pode cobrir com gaze estéril.
Descolonização Nasal de MRSA (Tópico Nasal)	Aplicar pequena quantidade no interior de cada narina 2 vezes ao dia por 5 dias consecutivos	Protocolo de controle de infecção

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipersensibilidade à mupirocina ou ao polietilenoglicol da base.

Aplicação Ocular: Não utilizar nos olhos ou mucosas profundas.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

283. Naloxona (cloridrato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável 0,4 mg/mL (ampola 1 mL)

Indicações e Linha de Tratamento

Antagonista opioide puro competitivo nos receptores mu, kappa e delta. Antídoto de emergência padrão-ouro para reversão imediata de Depressão Respiratória Grave / Parada Cardiorrespiratória induzida por superdosagem de opioides (morfina, fentanila, metadona, codeína).

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Reversão de Overdose Aguda com Parada Respiratória / Coma (IV/IO/IM/SC/IN)	Crianças < 5 anos ou peso < 20 kg: 0,1 mg/kg em bolus rápido. Crianças ≥ 5 anos ou peso ≥ 20 kg: 2 mg em bolus rápido.	Resposta clínica esperada em 1 a 2 minutos. Pode repetir a cada 2 a 3 minutos se necessário.

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Reversão Titulada de Depressão Respiratória Pós-Operatória (IV)	0,001 a 0,005 mg/kg (1 a 5 mcg/kg) titulado a cada 2 a 3 minutos até reversão da depressão respiratória sem reverter a analgesia.	Titulação cautelosa para não precipitar crise algica aguda.

Contraindicações, restrições e monitorização

Abstinência Aguda: Em pacientes dependentes crônicos de opioides, pode desencadear síndrome de abstinência aguda grave (dor intensa, taquicardia, hipertensão, edema pulmonar e convulsões).

Monitorização: Observar ressadação após 30 a 60 minutos (meia-vida da naloxona é inferior à de muitos opioides).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

284. Naproxeno / Naproxeno sódico

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Suspensão oral 25 mg/mL (125 mg/5 mL)

Comprimidos 250 mg e 500 mg

Comprimidos revestidos 275 mg e 550 mg (naproxeno sódico)

Indicações e Linha de Tratamento

Anti-inflamatório não esteroide derivado do ácido propiônico de longa meia-vida (12 a 15 horas). Primeira linha no tratamento da Artrite Idiopática Juvenil (AIJ), dismenorrea primária em adolescentes e profilaxia/tratamento de cefaleia tensional e migrânea.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Artrite Idiopática Juvenil — Crianças ≥ 2 anos (VO)	10 a 15 mg/kg/dia dividido a cada 12 horas com alimentos (Máx: 20 mg/kg/dia ou 1000 mg/dia)	Dividido a cada 12 horas
Dor Aguda / Dismenorrea / Enxaqueca (VO)	5 a 7 mg/kg/dose a cada 8 a 12 horas (Máx: 1000 mg/dia)	Administrar com leite ou refeições.

Contraindicações, restrições e monitorização

Idade: Não recomendado para menores de 2 anos de idade.

Condições: Úlcera péptica ativa, insuficiência renal moderada a grave e asma induzida por AINEs.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

285. Neomicina + Bacitracina

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pomada dermatológica e oftálmica com sulfato de neomicina 5 mg/g + bacitracina zíncica 250 UI/g

Indicações e Linha de Tratamento

Associação de antibacterianos tópicos bactericidas (aminoglicosídeo + polipeptídeo). Indicada no tratamento e prevenção de infecções bacterianas cutâneas superficiais (impetigo superficial, escoriações infectadas, queimaduras de 1º grau e foliculite).

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Infecções Cutâneas Superficiais (Tópico)	Aplicar fina camada sobre a área afetada 2 a 5 vezes ao dia após limpeza com água e sabão.	Tratamento por 5 a 7 dias.

Contraindicações, restrições e monitorização

Pele Extensamente Queimada / Lesada: ESTRITAMENTE CONTRAINDICADA em feridas extensas, queimaduras de 2º/3º grau e úlceras profundas devido ao risco de absorção sistêmica maciça de neomicina com ototoxicidade e nefrotoxicidade irreversíveis.

Alergias: Alto potencial de dermatite de contato alérgica por hipersensibilidade à neomicina.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

286. Neostigmina (metilsulfato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável 0,5 mg/mL (ampola 1 mL)

Indicações e Linha de Tratamento

Inibidor reversível da acetilcolinesterase quaternário de ação periférica. Primeira linha na reversão do bloqueio neuromuscular não despolarizante pós-cirúrgico (associada obrigatoriamente à atropina) e no tratamento da Miastenia Gravis.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Reversão de Bloqueio Neuromuscular Pós-Anestésico (IV)	0,03 a 0,07 mg/kg (Máx: 2,5 a 5 mg) administrado em injeção intravenosa lenta.	OBRIGATÓRIO administrar juntamente com Atropina (0,02 mg/kg) ou Glicopirrolato para bloquear os efeitos colinérgicos muscarínicos adversos (bradicardia severa, assistolia, broncoespasmo e hipersecreção).
Miastenia Gravis — Crise Miastênica / Tratamento (IV/IM)	0,01 a 0,04 mg/kg a cada 2 a 4 horas conforme necessidade	Hospitalar

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Obstrução mecânica do trato gastrointestinal ou urinário e asma brônquica grave descompensada.

Coadministração de Atropina: NUNCA administrar neostigmina isolada sem anticolinérgico prévio/simultâneo.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

287. Nicardipino (cloridrato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável concentrada 25 mg/10 mL

Indicações e Linha de Tratamento

Bloqueador dos canais de cálcio di-hidropiridínico de segunda geração para infusão contínua com potente ação vasodilatadora arterial seletiva. Primeira linha internacional no manejo da Emergência Hipertensiva pediátrica pós-cirurgia cardíaca ou transplante renal.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Emergência Hipertensiva Pediátrica (IV Contínuo)	Dose inicial: 0,5 a 1,0 mcg/kg/minuto em infusão contínua em bomba. Titular a cada 15 a 30 minutos em incrementos de 0,5 mcg/kg/min até controle da PA (Dose de manutenção habitual: 1 a 3 mcg/kg/min; Máx: 4 a 5 mcg/kg/min).	Diluição em SF0,9% ou SG5% por acesso central ou periférico calibroso.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Estenose aórtica severa e choque cardiogênico.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

288. Niclosamida

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos mastigáveis 500 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Anti-helmíntico tenicida não absorvível que inibe a fosforilação oxidativa anaeróbica mitocondrial do parasita. Indicado no tratamento de infecções intestinais por *Taenia solium*, *Taenia saginata* e *Hymenolepis nana*.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Teníase (T. solium / T. saginata) (VO)	Crianças de 2 a 6 anos: 1 g (2 comprimidos) em dose única. Crianças > 6 anos: 2 g (4 comprimidos) em dose única pela manhã em jejum.	Mastigar completamente os comprimidos e engolir com pequena quantidade de água; administrar laxativo 2h após para eliminar proglotes íntegras.
Himenolepiase (H. nana) (VO)	Dia 1: Dose plena de teníase. Dias 2 a 7: Metade da dose diária por mais 6 dias consecutivos.	Tratamento de 7 dias

Contraindicações, restrições e monitorização

Idade: Não recomendado para menores de 2 anos.

Risco em T. solium: Administrar laxativo após o tratamento para evitar lise de ovos no lúmen e risco teórico de neurocisticercose secundária.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

289. Nifedipino

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Cápsulas 10 mg e 20 mg

Comprimidos de liberação retardada/prolongada (Retard/OROS) 10 mg, 20 mg, 30 mg e 60 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Bloqueador dos canais de cálcio di-hidropiridínico arterial. Indicado no tratamento crônico da Hipertensão Arterial pediátrica (formulações de liberação prolongada) e emergência hipertensiva em nefrologia pediátrica.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Hipertensão Arterial Crônica — Comprimidos de Liberação Retardada (VO)	0,25 a 0,5 mg/kg/dia dividido a cada 12 ou 24 horas (titular até máx 1 a 2 mg/kg/dia ou 60 mg/dia)	Engolir o comprimido inteiro sem mastigar.
Urgência Hipertensiva (VO)	0,25 a 0,5 mg/kg/dose (Máx: 10 mg/dose)	Administração oral (NÃO usar via sublingual com cápsula furada).

Contraindicações, restrições e monitorização

VIA SUBLINGUAL COM CÁPSULA PUNCIONADA ESTÁ CONTRAINDICADA: Alto risco de queda tensional abrupta incontrolável, isquemia cerebral e taquicardia reflexa grave.

Condições: Choque cardiogênico e estenose aórtica severa.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

290. Nimesulida

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Gotas 50 mg/mL (1 gota = 2,5 mg)

Suspensão oral 10 mg/mL (50 mg/5 mL)

Comprimidos 100 mg (para > 12 anos)

Indicações e Linha de Tratamento

Anti-inflamatório não esteroide inibidor preferencial da COX-2. Indicado no alívio de dor inflamatória aguda e febre refratária em adolescentes a partir de 12 anos.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Dor e Inflamação Aguda — Adolescentes ≥ 12 anos (VO)	50 a 100 mg a cada 12 horas (ou 2 a 3 mg/kg/dia dividido a cada 12h) após as refeições	Duração máxima estrita de 5 a 7 dias.

Contraindicações, restrições e monitorização

CONTRAINDICAÇÃO PEDIÁTRICA ABSOLUTA EM MENORES DE 12 ANOS (ANVISA / EMA): Estritamente contraindicada para crianças menores de 12 anos de idade devido ao risco elevado e imprevisível de Hepatotoxicidade Fulminante Aguda fatal com necrose hepática maciça.

Condições: Insuficiência hepática, hepatopatias prévias e suspeita de dengue.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

291. Nistatina

Auditoria documental	Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática
-----------------------------	--

Apresentações Disponíveis

Suspensão oral 100.000 UI/mL

Creme dermatológico 100.000 UI/g

Creme vaginal 25.000 UI/g

Indicações e Linha de Tratamento

Antifúngico polieno tópico não absorvível pelo trato gastrointestinal. Primeira linha no tratamento e profilaxia da Candidíase Oral (monilíase / sapinho) em recém-nascidos e lactentes, e dermatite de fraldas por Candida albicans.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Candidíase Oral (Sapinho) — Recém-Nascidos e Lactentes (VO)	100.000 a 200.000 UI (1 a 2 mL) 4 vezes ao dia (a cada 6 horas) após as mamadas por 7 a 14 dias.	Instilar metade da dose em cada lado da boca com conta-gotas e bochechar/espalhar na mucosa oral. Manter por 48h após o desaparecimento dos sintomas.
Crianças Maiores e Imunodeprimidos (VO)	400.000 a 600.000 UI (4 a 6 mL) 4 vezes ao dia	Bochechar e reter na boca antes de engolir.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipersensibilidade à nistatina.

Segurança: Ausência total de absorção sistêmica gastrointestinal; excelente perfil de tolerabilidade no neonato.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

292. Nistatina + Óxido de zinco

Auditoria documental	Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática
-----------------------------	--

Apresentações Disponíveis

Pomada dermatológica 100.000 UI/g + 200 mg/g

Indicações e Linha de Tratamento

Associação de antifúngico tópico não absorvível com agente protetor de barreira e cicatrizante adstringente. Primeira linha padrão-ouro no tratamento da Dermatite das Fraldas Complicada por Candidíase (eritema confluyente vermelho-vivo com lesões satélites papulopustulosas e acometimento de dobras).

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Dermatite de Fraldas com Candidíase (Tópico)	Aplicar camada generosa sobre toda a área afetada e dobras a cada troca de fraldas após higiene cuidadosa com água morna e secagem sem fricção.	Manter o tratamento por 7 a 10 dias (mínimo 3 dias após a cura clínica completa).

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

Aplicação: Uso tópico exclusivo na pele (não usar em mucosas orais ou oftálmicas).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

293. Nitazoxanida

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó para suspensão oral 20 mg/mL (100 mg/5 mL)

Comprimidos revestidos 500 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Antiparasitário sintético de amplo espectro da classe das tiazolidas (inibe a enzima piruvato-ferredoxina oxidoreductase). Primeira linha no tratamento da Criptosporídiase (*Cryptosporidium parvum*) em imunocompetentes, Giardíase e parasitoses intestinais múltiplas (*Ascaris*, *Giardia*, *Entamoeba*, *Enterobius*) em crianças ≥ 1 ano.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Parasitoses Múltiplas / Giardíase / Criptosporídiase (VO)	Crianças de 1 a 3 anos: 100 mg (5 mL) a cada 12 horas por 3 dias consecutivos. Crianças de 4 a 11 anos: 200 mg (10 mL) a cada 12 horas por 3 dias. Crianças ≥ 12 anos e Adolescentes: 500 mg (1 comprimido) a cada 12 horas por 3 dias.	OBRIGATÓRIO administrar junto com alimentos para garantir absorção adequada e reduzir náuseas.

Contraindicações, restrições e monitorização

Idade: Contraindicado para menores de 1 ano de idade.

Condições: Doença hepática ou renal grave.

Coloração: Pode causar coloração amarelada intensa ou esverdeada benigna da urina e escleras.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

294. Nitrofurantoína

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; concentrações simples checadas: OK

Apresentações Disponíveis

Suspensão oral 25 mg/5 mL (5 mg/mL)

Cápsulas 100 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Antimicrobiano bactericida sintético urinário com múltiplos mecanismos intracelulares e baixa taxa de resistência. Primeira linha no tratamento e quimioprofilaxia de Infecções do Trato Urinário baixas (Cistites não complicadas) causadas por *E. coli* e *Enterococos* a partir de 1 mês de vida.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Cistite Bacteriana Aguda (VO)	5 a 7 mg/kg/dia dividido a cada 6 horas por 7 dias (Máx: 400 mg/dia)	Administrar junto com as refeições ou leite para melhorar a tolerabilidade e absorção.
Quimioprofilaxia de ITU Recorrente (VO)	1 a 2 mg/kg/dia em dose única diária noturna ao deitar	Manutenção por 6 a 12 meses conforme indicação urológica/nefrológica.

Contraindicações, restrições e monitorização

CONTRAINDICAÇÃO NEONATAL E DEFICIÊNCIA DE G6PD: Contraindicada em menores de 1 mês de idade e em portadores de deficiência de G6PD devido ao alto risco de anemia hemolítica por imaturidade enzimática eritrocitária.

Ineficácia na Pielonefrite: ESTRITAMENTE CONTRAINDICADA NO TRATAMENTO DE PIELONEFRITE OU SEPSE URINÁRIA (não atinge níveis terapêuticos no parênquima renal ou corrente sanguínea).

Checagem matemática automatizada

OK - 25 mg/5 mL = 5 mg/mL; declarado 5 mg/mL

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

295. Nitroglicerina

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável concentrada para infusão 5 mg/mL (ampolas 5 mL = 25 mg e 10 mL = 50 mg)

Comprimidos sublinguais 0,4 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Vasodilatador venoso predominante doador de óxido nítrico (reduz a pré-carga cardíaca e a pressão capilar pulmonar). Primeira linha no Edema Agudo de Pulmão Cardiogênico com hipertensão arterial, insuficiência cardíaca congestiva descompensada e pós-operatório de cirurgia cardíaca pediátrica.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Edema Pulmonar Cardiogênico / Insuficiência Cardíaca (IV Contínuo)	0,25 a 0,5 mcg/kg/minuto em infusão contínua em bomba. Titular a cada 5 a 10 minutos conforme PA e débito urinário até 1 a 5 mcg/kg/minuto (Máx: 10 mcg/kg/min).	Preparo exclusivo em frasco de vidro ou polietileno com equipo especial sem PVC (o PVC adsorve até 80% do fármaco).

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipotensão arterial grave (PAS < percentil 5 para idade), choque cardiogênico com hipovolemia, hipertensão intracraniana e uso concomitante de inibidores da PDE-5 (sildenafil).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

296. Nitroprussiato de sódio

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó liofilizado para solução injetável frasco-ampola 50 mg com diluente estéril

Indicações e Linha de Tratamento

Vasodilatador arterial e venoso direto potente de ação imediata (segundos) e ultracurta. Primeira linha no tratamento da Emergência Hipertensiva pediátrica grave (encefalopatia hipertensiva, crise renal da esclerodermia, dissecação aórtica) e redução imediata de pós-carga em choque cardiogênico grave.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Emergência Hipertensiva Pediátrica (IV Contínuo)	0,3 a 0,5 mcg/kg/minuto em infusão contínua em bomba dedicada. Titular gradualmente a cada 5 minutos até a meta de pressão arterial (Dose habitual: 1 a 3 mcg/kg/min; Máx estrito: 5 a 8 mcg/kg/min por tempo limitado).	Diluição obrigatória em SG5% protegida da luz com capa opaca (o fármaco é fotossensível e se degrada em cianeto quando exposto à luz).

Contraindicações, restrições e monitorização

TOXICIDADE POR CIANETO E TIOCIANATO: Risco de intoxicação fatal por acúmulo de cianeto em infusões > 4 mcg/kg/min por mais de 24 a 48h ou em insuficiência renal/hepática (manifestada por acidose láctica inexplicada, taquicardia, confusão mental e deterioração hemodinâmica). Monitorar gasometria e lactato seriados; antídoto: hidroxocobalamina.

Condições: Shunt arteriovenoso congênito e coarctação da aorta.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

297. Noradrenalina (Hemitartarato de norepinefrina)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável concentrada para infusão 2 mg/mL hemitartrato (1 mg/mL norepinefrina base, ampola 4 mL = 8 mg hemitartrato / 4 mg base)

Indicações e Linha de Tratamento

Agonista adrenérgico potente com forte ação alfa-1 vasoconstritora e modesta ação inotrópica beta-1. Primeira linha padrão-ouro absoluta de consenso internacional (Surviving Sepsis Campaign Pediátrica) no Choque Séptico Distributivo Vasoplégico (choque quente com baixa RVS e extremidades quentes/pressão de pulso ampla) e choque anafilático refratário.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Choque Séptico Vasoplégico / Hipotensão Refratária (IV/IO Contínuo)	Doses em Norepinefrina Base: Iniciar com 0,05 a 0,1 mcg/kg/minuto em infusão contínua em bomba dedicada. Titular a cada 2 a 5 minutos até atingir e manter a Pressão Arterial Média (PAM) acima do percentil 50 para a idade e lactato em queda (Faixa habitual: 0,1 a 1,0 mcg/kg/min; doses até 2 mcg/kg/min em choque refratário).	Diluição preferencial em SG5% ou SF0,9%. Administração preferencialmente por cateter venoso central (em emergência, usar veia periférica calibrosa transitoriamente enquanto se obtém acesso definitivo).

Contraindicações, restrições e monitorização

Extravasamento Periférico: O extravasamento periférico causa isquemia tecidual e necrose grave (tratar imediatamente com infiltração local de fentolamina 0,1 a 0,2 mg/kg diluída).

Hipovolemia: Corrigir a volemia previamente com cristaloides antes ou simultaneamente ao vasopressor.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

298. Nortriptilina (cloridrato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Cápsulas 10 mg, 25 mg, 50 mg e 75 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Antidepressivo tricíclico (metabólito ativo da amitriptilina) com menor efeito anticolinérgico e sedativo. Indicado no tratamento da dor neuropática crônica, profilaxia de migrânea resistente e enurese noturna em crianças ≥ 6 anos.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Dor Neuropática / Enxaqueca / Enurese (VO)	Crianças ≥ 6 anos: Inicial 0,25 a 0,5 mg/kg/dia ao deitar (ou 10 mg/dia). Titular gradualmente até 1 mg/kg/dia conforme resposta clínica e tolerabilidade (Máx: 25 a 50 mg/dia).	Dose única noturna ao deitar.

Contraindicações, restrições e monitorização

Cardiotoxicidade: Prolongamento do intervalo QTc e risco de arritmias ventriculares em superdosagem; ECG basal obrigatório.

Idade: Não recomendado para menores de 6 anos.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

299. Octreotida (acetato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável 0,05 mg/mL, 0,1 mg/mL e 0,5 mg/mL (ampolas 1 mL)

Suspensão injetável de liberação prolongada LAR 10 mg, 20 mg e 30 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Análogo sintético da somatostatina de longa ação que inibe a secreção de hormônios gastrointestinais e reduz o fluxo sanguíneo esplâncnico. Primeira linha na Hemorragia Digestiva Alta por Varizes Esofágicas em hipertensão portal pediátrica, Quilotórax pós-operatório e hiperinsulinismo congênito refratário ao diazóxido.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Hemorragia por Varizes Esofágicas na Emergência (IV)	Dose de Ataque: 1 a 2 mcg/kg (Máx: 50 mcg) em bolus IV lento em 5 minutos. Manutenção Contínua: 1 a 2 mcg/kg/hora em infusão contínua em bomba por 48 a 72 horas.	Manter até 24 horas após cessar o sangramento e controle endoscópico.
Quilotórax Pós-Cirúrgico (SC/IV)	1 a 4 mcg/kg/hora em infusão contínua ou 2 a 10 mcg/kg/dia dividido SC a cada 8h por 7 a 14 dias	Associar dieta com triglicerídeos de cadeia média (TCM).

Contraindicações, restrições e monitorização

Efeitos Gastrointestinais e Biliares: Risco de colelitíase, hiperglicemia ou hipoglicemia e enterocolite necrosante em neonatos.

Monitorização: Glicemia capilar periódica durante a infusão.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

300. Olanzapina

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos revestidos 2,5 mg, 5 mg e 10 mg

Comprimidos orodispersíveis 5 mg e 10 mg

Pó liofilizado para solução injetável 10 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Antipsicótico atípico de segunda geração antagonista dos receptores serotoninérgicos 5-HT_{2A} e dopaminérgicos D₂. Indicado no tratamento de episódios maníacos agudos e mistos no Transtorno Bipolar, Esquizofrenia em adolescentes ≥ 13 anos e náuseas/vômitos refratários em quimioterapia oncológica e cuidados paliativos.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Transtorno Bipolar / Esquizofrenia — Adolescentes ≥ 13 anos (VO)	Inicial: 2,5 a 5 mg uma vez ao dia à noite. Titular a cada 1 a 2 semanas até dose de manutenção de 10 a 20 mg/dia.	Dose única diária noturna
Antiemético em Quimioterapia de Alto Risco / Paliativos (VO)	0,1 mg/kg/dia (ou 2,5 a 5 mg/dia) administrado à noite nos dias de quimioterapia	Comprimido orodispersível

Contraindicações, restrições e monitorização

Síndrome Metabólica e Ganho Ponderal: Alto risco de ganho de peso acelerado marcante, dislipidemia grave, resistência insulínica e diabetes mellitus tipo 2.

Monitorização: IMC, circunferência abdominal, glicemia de jejum e perfil lipídico basais e a cada 3 meses.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

301. Óleo mineral (Petrolato líquido)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Emulsão oral 100%

Emulsão oral associada a fenolftaleína

Indicações e Linha de Tratamento

Laxativo lubrificante e emoliente fecal que retém água no bolo fecal e amolece fezes ressecadas. Indicado no tratamento de manutenção da constipação intestinal funcional crônica em crianças ≥ 1 ano.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Constipação Intestinal Funcional — Crianças ≥ 1 ano (VO)	1 a 3 mL/kg/dia administrado em dose única diária ou dividida em 2 tomadas (Máx: 30 a 45 mL/dia)	Administrar gelado ou misturado em suco de frutas/iogurte para melhorar a palatabilidade. Administrar à tarde ou ao deitar.

Contraindicações, restrições e monitorização

PNEUMONIA LIPOIDE (ASPIRAÇÃO FATAL): ESTRITAMENTE CONTRAINDICADO EM LACTENTES MENORES DE 1 ANO, crianças com distúrbios da deglutição, disfagia, refluxo gastroesofágico grave ou neuropatias (o óleo mineral inibe o reflexo de tosse e a aspiração pulmonar causa pneumonia lipóide crônica grave irreversível com fibrose pulmonar).

Interações: O uso contínuo pode diminuir a absorção de vitaminas lipossolúveis (A, D, E, K); administrar afastado das refeições principais.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

302. Omalizumabe

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó liofilizado para solução injetável 75 mg e 150 mg

Solução injetável em seringa preenchida 75 mg e 150 mg SC

Indicações e Linha de Tratamento

Anticorpo monoclonal humanizado anti-IgE que se liga à IgE livre circulante impedindo sua fixação aos receptores Fc-épsilon-RI dos mastócitos e basófilos. Primeira linha como terapia biológica imunológica na Asma Alérgica Grave Não Controlada (Etapa 5 do GINA) e Urticária Crônica Espontânea refratária em crianças ≥ 6 anos.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Asma Alérgica Grave Não Controlada — Crianças ≥ 6 anos (SC)	75 a 600 mg a cada 2 ou 4 semanas em injeção subcutânea profunda.	Dose e intervalo calculados OBRIGATORIAMENTE através da Tabela Padronizada oficial com base no peso corporal (kg) e nível sérico basal de IgE total (UI/mL) antes do tratamento.
Urticária Crônica Espontânea (≥ 12 anos) (SC)	150 a 300 mg a cada 4 semanas	Dose fixa subcutânea

Contraindicações, restrições e monitorização

Anafilaxia Pós-Aplicação: Black box warning para anafilaxia aguda ou tardia (pode ocorrer até 24h após a injeção); manter observação médica obrigatória por 2 horas nas primeiras 3 aplicações.

Condições: Hipersensibilidade grave ao omalizumabe.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

303. Omeprazol (magnésico / sódico)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó para suspensão oral em sachês de 20 mg e 40 mg

Cápsulas com microgrânulos gastrorresistentes 10 mg, 20 mg e 40 mg

Pó liofilizado para solução injetável IV frasco-ampola 40 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Inibidor da Bomba de Prótons gástrica (H⁺/K⁺-ATPase) padrão. Primeira linha no tratamento da Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE) com esofagite erosiva, úlcera péptica ativa, profilaxia de úlcera de estresse em UTI pediátrica e componente do esquema de erradicação de H. pylori.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
DRGE / Esofagite Erosiva / Doença Péptica (VO/IV)	Lactentes e Crianças < 20 kg: 1 mg/kg/dia (titular até 2 mg/kg/dia se esofagite grave). Crianças ≥ 20 kg e Adolescentes: 20 a 40 mg uma vez ao dia.	Administrar pela manhã 30 minutos antes do desjejum. Abrir a cápsula e administrar os microgrânulos intactos em líquido ácido (suco de maçã/laranja) sem mastigar ou triturar.
Hemorragia Digestiva Alta / Úlcera Sangrante (IV)	Ataque: 1 mg/kg em bolus IV lento. Manutenção: 1 a 2 mg/kg/dia a cada 12h ou infusão contínua em UTI.	Infundir em 20 a 30 minutos.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipersensibilidade a derivados benzimidazólicos.

Uso Crônico Prolongado: Risco de hipomagnesemia, hipocloridria com supercrescimento bacteriano entérico e deficiência de vitamina B12 e ferro.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

304. Ondansetrona (cloridrato)

Auditoria documental Presente nos dois anexos; concentrações simples checadas: OK

Apresentações Disponíveis

Solução oral 2 mg/5 mL (0,4 mg/mL)

Gotas 2 mg/mL

Comprimidos revestidos 4 mg e 8 mg

Comprimidos orodispersíveis 4 mg e 8 mg

Filme orodispersível 4 mg e 8 mg

Solução injetável 2 mg/mL (ampolas 2 mL = 4 mg e 4 mL = 8 mg)

Indicações e Linha de Tratamento

Antagonista potente e altamente seletivo dos receptores serotoninérgicos 5-HT₃ periféricos e centrais. Primeira linha padrão-ouro absoluta no manejo de vômitos na Gastroenterite Aguda Pediátrica (facilita e viabiliza a Terapia de Reidratação Oral - Plano B do Ministério da Saúde/OMS), náuseas e vômitos induzidos por quimioterapia oncológica e vômitos pós-operatórios.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Gastroenterite Aguda / Vômitos na Emergência — VO/SL (Dose por Peso)	0,15 mg/kg/dose (Faixas práticas por peso: Peso 8 a 15 kg: 2 mg; Peso 15 a 30 kg: 4 mg; Peso > 30 kg: 8 mg).	Dose oral única na emergência (comprimido orodispersível na língua ou solução oral), aguardar 15 a 30 minutos e iniciar Soro de Reidratação Oral (SRO). Pode repetir a cada 8 horas se vômitos persistirem.
Prevenção de Náuseas e Vômitos em Quimioterapia (IV/VO)	0,15 mg/kg/dose (5 mg/m ² /dose; Máx: 8 mg/dose) administrado 30 minutos antes da quimioterapia e a cada 8 horas.	Infundir IV em 15 minutos.
Pós-Operatório — Prevenção e Tratamento (IV)	0,1 mg/kg/dose (Máx: 4 mg) ao final da cirurgia ou na recuperação	Injeção IV lenta em 2 a 5 minutos.

Contraindicações, restrições e monitorização

Cardiotoxicidade: Risco de prolongamento do intervalo QTc e arritmias ventriculares (evitar em pacientes com Síndrome do QT Longo Congênito).

Idade: Uso seguro e amplamente validado a partir de 1 mês de vida.

Condições: Obstrução intestinal mecânica e uso concomitante de apomorfina.

Checagem matemática automatizada

OK - 2 mg/5 mL = 0.4 mg/mL; declarado 0.4 mg/mL

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

305. Oseltamivir (fosfato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó para suspensão oral 6 mg/mL (frasco 60 mL = 360 mg)

Cápsulas 30 mg, 45 mg e 75 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Inibidor seletivo da neuraminidase dos vírus Influenza A e B. Primeira linha padrão-ouro do Ministério da Saúde e OMS no tratamento da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Influenza e tratamento de gripe em pacientes pediátricos com fatores de risco para complicações (asma, cardiopatias, neuropatias, desnutrição, imunodeprimidos, < 2 anos).

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Tratamento da Influenza / SRAG — Doses por Peso (VO por 5 dias)	Neonatos a termo < 9 meses: 3,0 mg/kg/dose a cada 12h. Lactentes 9 a 11 meses: 3,5 mg/kg/dose a cada 12h. Peso ≤ 15 kg: 30 mg a cada 12h. Peso > 15 a 23 kg: 45 mg a cada 12h. Peso > 23 a 40 kg: 60 mg a cada 12h. Peso > 40 kg e Adolescentes: 75 mg a cada 12h.	Iniciar idealmente nas primeiras 48h de sintomas (na SRAG grave hospitalizada, iniciar em qualquer momento). Duração estrita de 5 dias consecutivos. Administrar com alimentos para reduzir náuseas.
Quimioprofilaxia Pós-Exposição (VO por 10 dias)	Mesmas doses por faixa de peso administradas UMA VEZ AO DIA (a cada 24 horas) por 10 dias.	Iniciar nas primeiras 48h pós-exposição.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipersensibilidade ao oseltamivir.

Ajustes: Reduzir a dose na insuficiência renal moderada a grave com base no clearance de creatinina.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

306. Oxacilina sódica

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó para solução injetável frasco-ampola 500 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Penicilina semissintética isoxazólica resistente à penicilinase estafilocócica (antiestafilocócica bactericida). Primeira linha padrão-ouro absoluta para infecções graves causadas por Staphylococcus aureus sensível à meticilina (MSSA): Celulite grave, Osteomielite aguda, Artrite séptica, Pneumonia estafilocócica com derrame/pneumatocelos, Endocardite e Sepsis estafilocócica.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Infecções Sistêmicas Graves por MSSA / Osteomielite (IV)	150 a 200 mg/kg/dia dividido a cada 6 horas (Máx: 8 a 12 g/dia)	Infusão intravenosa lenta em 30 a 60 minutos.
Meningite Estafilocócica por MSSA (IV)	200 mg/kg/dia dividido a cada 4 a 6 horas (Máx: 12 g/dia)	Infusão lenta
Sepsis Neonatal por MSSA (IV)	Neonato ≤ 7 dias: 50 a 100 mg/kg/dia dividido a cada 12h. Neonato > 7 dias: 100 a 150 mg/kg/dia dividido a cada 8h.	Ajuste por idade neonatal.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Alergia grave conhecida a penicilinas.

Efeitos: Risco de nefrite intersticial aguda alérgica, elevação transitória de transaminases hepáticas e flebite em infusão periférica rápida (diluição adequada recomendada).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

307. Oxcarbazepina

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Suspensão oral 60 mg/mL (6%)

Comprimidos revestidos 300 mg e 600 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Antiepiléptico cetó-análogo da carbamazepina (pró-fármaco do derivado 10-mono-hidróxi MHD) que bloqueia canais de sódio dependentes de voltagem sem formar metabólito epóxido tóxico nem causar autoindução enzimática hepática. Primeira linha em crises epilépticas focais (com ou sem generalização secundária) e crises tônico-clônicas generalizadas a partir de 1 mês de vida.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Epilepsia Pediátrica — Crises Focais (VO)	Inicial: 8 a 10 mg/kg/dia dividido a cada 12 horas. Aumentar semanalmente em incrementos de 5 a 10 mg/kg/dia até dose de manutenção de 30 a 45 mg/kg/dia (Máx: 60 mg/kg/dia ou 2400 mg/dia).	Dividido a cada 12 horas com ou sem alimentos. Agitar bem a suspensão oral antes do uso.

Contraindicações, restrições e monitorização

Hiponatremia: Monitorar sódio sérico periodicamente pelo risco de hiponatremia por SIADH-símile.

Reações Cruzadas: Cerca de 25 a 30% dos pacientes com alergia prévia a carbamazepina apresentam hipersensibilidade cruzada à oxcarbazepina.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

308. Óxido de zinco

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pasta d'água 25%

Pomada dermatológica associada a vitaminas A e D

Indicações e Linha de Tratamento

Protetor cutâneo mineral adstringente, secativo, anti-inflamatório e barreira física contra umidade e fezes/urina. Primeira linha na prevenção e tratamento da Dermatite das Fraldas não complicada (assaduras simples) e brotoejas (miliária).

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Prevenção e Tratamento de Assaduras Simples (Tópico)	Aplicar camada espessa sobre a pele limpa e seca a cada troca de fraldas.	Uso contínuo; não remover à força a camada residual de pasta na troca seguinte para não friccionar a pele irritada.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipersensibilidade aos componentes; não aplicar sobre feridas cirúrgicas abertas ou lesões exsudativas infectadas profundas.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

309. Oxitocina

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável 5 UI/mL e 10 UI/mL (ampolas 1 mL)

Indicações e Linha de Tratamento

Hormônio nonapeptídeo uterotônico. Indicado no manejo e prevenção da hemorragia pós-parto e indução do parto em adolescentes obstétricas.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Prevenção e Manejo da Hemorragia Pós-Parto (IV/IM)	Profilaxia: 10 UI IM em dose única após o desprendimento do ombro fetal anterior ou 20 a 40 UI/L em infusão contínua de SF0,9%.	Tratamento de atonia uterina: infusão intravenosa contínua sob controle obstétrico.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Desproporção cefalopélvica, hipertonia uterina, sofrimento fetal agudo e descolamento prematuro da placenta.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

310. Palivizumabe

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável frasco-ampola 50 mg (0,5 mL) e 100 mg (1,0 mL)

Indicações e Linha de Tratamento

Anticorpo monoclonal humanizado direcionado contra a proteína F de fusão do Vírus Sincicial Respiratório (VSR). Primeira linha profilática mandatória (Ministério da Saúde e SBP) para Prevenção de Doença Grave do Trato Respiratório Inferior por VSR (bronquiolite viral aguda e pneumonia) em grupos pediátricos de altíssimo risco durante o período de sazonalidade viral.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Profilaxia contra VSR — Critérios do Ministério da Saúde / SBP (IM)	15 mg/kg em injeção intramuscular profunda no músculo vasto lateral da coxa uma vez ao mês (a cada 30 dias) durante o período de sazonalidade regional do VSR (máximo de 5 doses mensais consecutivas).	Indicações SUS: 1) Prematuros nascidos com idade gestacional $\leq$ 28 semanas e 6 dias com menos de 1 ano de vida no início da sazonalidade; 2) Crianças com Cardiopatia Congênita com repercussão hemodinâmica com menos de 2 anos; 3) Crianças com Doença Pulmonar Crônica da Prematuridade (Displasia Broncopulmonar) em tratamento nos últimos 6 meses com menos de 2 anos.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipersensibilidade grave ao palivizumabe ou a proteínas murinas.

Não é Droga Terapêutica: ESTRITAMENTE INEFICAZ E NÃO INDICADO PARA O TRATAMENTO DE BRONQUIOLITE JÁ ESTABELECIDO (uso exclusivamente preventivo).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

311. Pantoprazol sódico

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos gastrorresistentes 20 mg e 40 mg

Pó liofilizado para solução injetável IV frasco-ampola 40 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Inibidor da Bomba de Prótons de alta estabilidade e menor interação medicamentosa enzimática com o citocromo P450 que o omeprazol. Primeira linha na Hemorragia Digestiva Alta por úlcera péptica/gastrite erosiva, esofagite erosiva grave e profilaxia de úlcera de estresse em UTI pediátrica a partir de 5 anos.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Hemorragia Digestiva Alta Grave (IV)	Dose de Ataque: 1 mg/kg (Máx: 40 a 80 mg) em bolus lento de 5 a 10 min. Manutenção: 1 mg/kg/dia a cada 12 horas ou infusão contínua em UTI de 0,1 a 0,2 mg/kg/hora.	Manter por 48 a 72 horas até controle endoscópico.
DRGE / Esofagite Erosiva — Crianças $\geq$ 5 anos (VO/IV)	Peso 15 a 40 kg: 20 mg uma vez ao dia pela manhã. Peso > 40 kg: 40 mg uma vez ao dia.	Comprimidos inteiros sem mastigar 30 min antes do café da manhã.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipersensibilidade a benzimidazóis substituídos.

Vantagem Farmacocinética: Menor interação com clopidogrel e anticonvulsivantes.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

312. Paracetamol (Acetaminofeno)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Gotas 200 mg/mL (1 gota = 10 mg a 15 mg conforme fabricante; no Brasil frasco padrão 1 gota = 10 mg)

Solução oral 32 mg/mL (160 mg/5 mL)

Comprimidos 500 mg e 750 mg

Comprimidos mastigáveis 80 mg e 160 mg

Supositórios 150 mg e 250 mg

Solução para infusão IV 10 mg/mL (bolsa 100 mL = 1000 mg)

Indicações e Linha de Tratamento

Analgésico e antipirético não opioide de ação central (inibidor da síntese de prostaglandinas no SNC) padrão-ouro em pediatria desde o período neonatal. Primeira linha de escolha para controle de Febre e Dor de intensidade leve a moderada em recém-nascidos, lactentes, crianças e pacientes com contraindicação a AINES (dengue, úlcera péptica, asma).

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Febre e Dor — Lactentes e Crianças (VO)	10 a 15 mg/kg/dose (Dose padrão mais utilizada: 15 mg/kg/dose ou 1 a 1,5 gotas/kg/dose da formulação 200 mg/mL)	A cada 4 a 6 horas conforme necessidade (Dose máxima diária: 60 a 75 mg/kg/dia em crianças ou máx 4 g/dia; em recém-nascidos e prematuros limitar a máx 40 a 60 mg/kg/dia).
Via Intravenosa na Emergência / Pós-Operatório (IV)	Lactentes e Crianças ≤ 10 kg: 7,5 a 10 mg/kg/dose a cada 6h (Máx: 30 mg/kg/dia). Crianças 10 a 50 kg: 15 mg/kg/dose a cada 6h (Máx: 60 mg/kg/dia ou 2 g/dia). Adolescentes > 50 kg: 1 g a cada 6h (Máx: 4 g/dia).	Infundir em 15 minutos em SF0,9% ou SG5%.
Via Retal (Supositório)	15 a 20 mg/kg/dose a cada 6 a 8 horas	Absorção mais lenta e variável

Contraindicações, restrições e monitorização

HEPATOTOXICIDADE POR SUPERDOSAGEM: Doses agudas superiores a 150 mg/kg causam necrose hepática centrolobular fulminante por acúmulo do metabólito tóxico NAPQI (antídoto de emergência: N-Acetilcisteína).

Condições: Insuficiência hepática grave descompensada e hepatite aguda.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

313. Penicilamina

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Cápsulas 250 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Agente quelante de cobre, chumbo e cistina derivado da penicilina com grupo sulfidril livre. Primeira linha padrão-ouro no tratamento crônico da Doença de Wilson (degeneração hepatolenticular) e Cistinúria grave com litíase recorrente em crianças.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Doença de Wilson — Crianças e Adolescentes (VO)	Inicial: 5 a 10 mg/kg/dia em 2 a 3 tomadas diárias. Titular a cada 1 a 2 meses até dose de manutenção de 20 mg/kg/dia (Máx: 1000 a 1500 mg/dia).	Administrar em jejum rigoroso (1 hora antes ou 2 horas após as refeições) e com suplementação diária obrigatória de Piridoxina 25 a 50 mg/dia.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Alergia grave a penicilinas, insuficiência renal prévia, lúpus induzido e agranulocitose.

Monitorização: Hemograma e proteinúria de 24h a cada 2 semanas nos primeiros meses.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

314. Periciazina

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Gotas 10 mg/mL (1% pediátrico - 1 gota = 0,25 mg) e 40 mg/mL (4%)

Comprimidos 10 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Antipsicótico fenotiazínico com pronunciada ação sedativa e reguladora do comportamento e agressividade ('neuroléptico moderador de conduta'). Indicado no controle da agressividade severa, impulsividade patológica e distúrbios de conduta graves em crianças ≥ 3 anos.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Distúrbios de Conduta / Agressividade Grave (VO)	Crianças de 3 a 6 anos: 0,25 a 1 mg/kg/dia (Inicial: 1 a 2 gotas de 10 mg/mL ao deitar, aumentando gradualmente conforme necessidade). Crianças > 6 anos: Inicial 2,5 a 5 mg/dia dividido em 2 tomadas (maior fração à noite).	Administrar com alimentos ou água.

Contraindicações, restrições e monitorização

Idade: Contraindicado para menores de 3 anos de idade.

Condições: Risco de sedação profunda, hipotensão ortostática e sintomas extrapiramidais.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

315. Permetrina

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Loção tópica 1% e 5%

Xampu 1%

Indicações e Linha de Tratamento

Piretroide sintético neurotóxico seletivo para canais de sódio de artrópodes. Primeira linha padrão-ouro absoluta de consenso internacional e SBP para o tratamento de Escabiose (Sarna - loção 5%) e Pediculose (Piolho da cabeça - loção/xampu 1%) a partir de 2 meses de vida.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Escabiose (Sarna) — Crianças ≥ 2 meses (Loção 5%) (Tópico)	Aplicar a loção a 5% em todo o corpo (do pescoço para baixo em crianças maiores; em lactentes < 2 anos incluir couro cabeludo, face, orelhas e pescoço, protegendo olhos e boca) à noite após banho morno. Deixar agir por 8 a 14 horas e enxaguar pela manhã. Repetir OBRIGATORIAMENTE a mesma aplicação após 7 a 14 dias.	Tratar simultaneamente todos os contatos domiciliares próximos assintomáticos e lavar roupas de cama em água quente.
Pediculose (Piolho da Cabeça) — Loção/Xampu 1% (Tópico)	Aplicar no cabelo lavado e seco com toalha, deixar agir por 10 minutos e enxaguar. Passar pente fino para remoção de lêndeas. Repetir em 7 a 10 dias.	Uso tópico

Contraindicações, restrições e monitorização

Idade: Contraindicado para recém-nascidos e lactentes menores de 2 meses de vida.

Condições: Hipersensibilidade a piretroides ou crisântemos; evitar contato com mucosas e olhos.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

316. Picossulfato de sódio

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Gotas 7,5 mg/mL (1 gota = 0,5 mg)

Cápsulas 5 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Laxativo estimulante de contato ativado exclusivamente no cólon por sulfatases bacterianas da microbiota intestinal. Indicado no alívio de curto prazo da constipação intestinal aguda severa e preparo de exames endoscópicos.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Constipação Intestinal Aguda — Crianças de 2 a 5 anos (VO)	0,25 a 0,5 mg/kg/dia (ou 5 a 10 gotas = 2,5 a 5 mg) em dose única noturna	Efeito evacuatório em 6 a 12 horas.
Crianças de 6 a 10 anos (VO)	5 a 10 mg (10 a 20 gotas) em dose única noturna ao deitar	Dose noturna
Crianças > 10 anos e Adolescentes (VO)	10 a 15 mg (20 a 30 gotas) uma vez ao dia	Uso pontual

Contraindicações, restrições e monitorização

Idade: Não recomendado para menores de 2 anos de idade.

Condições: Abdome agudo cirúrgico, apendicite, obstrução mecânica e desidratação grave.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

317. Pilocarpina (cloridrato / nitrato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução oftálmica/colírio 1%, 2% e 4%

Indicações e Linha de Tratamento

Agonista colinérgico parassimpaticomimético direto com ação miótica e estimulante da secreção exócrina. Indicado no controle emergencial da pressão intraocular no glaucoma de ângulo fechado agudo e como teste do suor na triagem de Fibrose Cística (iontoforese com pilocarpina).

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Glaucoma Pediátrico / Miose (Oftálmico)	1 gota no olho afetado 2 a 4 vezes ao dia (a cada 6 a 12 horas)	Comprimir o ponto lacrimal por 1 minuto para evitar efeitos colinérgicos sistêmicos (sudorese, cólicas, bradicardia).

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Uveíte anterior aguda, asma brônquica grave descompensada.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

318. Pimecrolimo

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Creme dermatológico 10 mg/g (1%)

Indicações e Linha de Tratamento

Inibidor tópico da calcineurina não esteroideal com potente ação anti-inflamatória seletiva sobre linfócitos T cutâneos (sem causar atrofia dérmica, telangiectasias ou estrias). Primeira linha no tratamento da Dermatite Atópica leve a moderada em face, pálpebras, pescoço e dobras em crianças a partir de 2 anos (ou 3 meses sob especialista).

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Dermatite Atópica em Face e Áreas Sensíveis (Tópico)	Aplicar fina camada sobre as lesões 2 vezes ao dia ao primeiro sinal de eritema ou prurido, mantendo até o desaparecimento completo das lesões.	Excelente para terapia proativa e prevenção de recidivas sem risco de atrofia corticoide-símile.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Lesões cutâneas infectadas ativas (herpes simples, eczema herpético de Kaposi, molusco contagioso) e imunodeficiências primárias.

Proteção Solar: Orientar fotoproteção durante o tratamento.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

319. Piperacilina + Tazobactam

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó liofilizado para solução injetável frasco-ampola 2,25 g (2 g piperacilina + 0,25 g tazobactam) e 4,5 g (4 g piperacilina + 0,5 g tazobactam)

Indicações e Linha de Tratamento

Associação de ureidopenicilina antipseudomonas de amplo espectro com inibidor de beta-lactamase. Primeira linha de escolha no tratamento da Neutropenia Febril de alto risco em oncologia pediátrica, Sepses Abdominal hospitalar grave por Gram-negativos e anaeróbios, pneumonia associada à ventilação mecânica e infecções graves por Pseudomonas aeruginosa.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Infecções Hospitalares Graves / Neutropenia Febril — Crianças > 2 meses (IV)	240 a 300 mg/kg/dia da combinação (calculado sobre 300 mg/kg/dia de piperacilina + 37,5 mg/kg/dia de tazobactam = 337,5 mg/kg/dia total) dividido a cada 6 ou 8 horas (Máx: 16 g piperacilina / 2 g tazobactam = 18 g/dia).	Infundir em 30 a 60 minutos (ou infusão estendida em 3 a 4 horas em UTI para maximizar o tempo acima da MIC).
Lactentes ≤ 2 meses (IV)	150 a 200 mg/kg/dia dividido a cada 6 a 8 horas	Infusão lenta

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Alergia grave conhecida a penicilinas e inibidores de beta-lactamase.

Interação com Vancomicina: A associação com vancomicina aumenta expressivamente a incidência de Lesão Renal Aguda (LRA) nefrotóxica sinérgica (monitorar creatinina e débito urinário diariamente).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

320. Pirantel (pamoato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Suspensão oral 50 mg/mL (250 mg/5 mL)

Comprimidos 250 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Anti-helmíntico despolarizante que causa bloqueio neuromuscular espástico no parasita. Primeira linha alternativa no tratamento de Enterobíase (Oxiúriase), Ascaridíase e Ancilostomíase.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Oxiúriase / Ascaridíase / Ancilostomíase (VO)	10 mg/kg de pirantel base em dose única diária (Máx: 1000 mg)	Na oxiúriase, repetir obrigatoriamente a mesma dose após 14 dias.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Insuficiência hepática grave.

Interações: Efeito antagônico se associado à piperazina.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

321. Pirazinamida

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Suspensão oral 30 mg/mL (150 mg/5 mL)

Comprimidos 500 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Antituberculoso esterilizante sintético de primeira linha essencial que atua no bacilo em ambiente ácido intracelular nos macrófagos (componente obrigatório do esquema básico RHZE do Ministério da Saúde). Indicada na fase de ataque intensiva da Tuberculose ativa.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Fase Intensiva da Tuberculose (Primeiros 2 meses) (VO)	35 mg/kg/dia (Faixa: 30 a 40 mg/kg/dia; Máx: 1500 mg/dia em < 50 kg e 2000 mg/dia em ≥ 50 kg)	Dose única diária matinal em jejum combinada a rifampicina e isoniazida por 2 meses.

Contraindicações, restrições e monitorização

Hepatotoxicidade Grave: É o fármaco mais hepatotóxico do esquema antituberculoso; dosar transaminases e bilirrubinas na presença de vômitos ou icterícia.

Condições: Insuficiência hepática grave e hiperuricemia com gota aguda.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

322. Piridostigmina (brometo)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos 60 mg e comprimidos de liberação prolongada 180 mg

Xarope 12 mg/mL (60 mg/5 mL)

Indicações e Linha de Tratamento

Inibidor reversível da acetilcolinesterase periférica de longa duração. Primeira linha padrão-ouro no tratamento sintomático da Miastenia Gravis congênita, juvenil e neonatal transitória.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Miastenia Gravis Juvenil / Congênita (VO)	Neonatos: 5 mg a cada 4 a 6 horas (30 a 60 minutos antes das mamadas). Crianças: Inicial 1 a 2 mg/kg/dose a cada 4 a 6 horas (titular até 5 a 10 mg/kg/dia dividido em 4 a 6 tomadas; Máx: 360 a 600 mg/dia).	Administrar 30 a 45 minutos antes das refeições para facilitar a mastigação e deglutição.

Contraindicações, restrições e monitorização

Crise Colinérgica: Cuidado para diferenciar crise miastênica (falta de droga) de crise colinérgica por sobredosagem (fraqueza, fasciculações, sudorese, miose e broncorreia).

Condições: Obstrução mecânica gastrointestinal ou urinária.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

323. Piridoxina (Vitamina B6)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos 40 mg, 50 mg e 100 mg

Solução injetável 100 mg/mL (ampola 1 mL)

Indicações e Linha de Tratamento

Cofator enzimático essencial na síntese de GABA, serotonina e hemoglobina. Primeira linha diagnóstica e terapêutica mandatória na Epilepsia Dependente de Piridoxina neonatal (convulsões neonatais refratárias a anticonvulsivantes), antídoto para intoxicação aguda por Isoniazida e prevenção de neuropatia periférica por isoniazida.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Epilepsia Dependente de Piridoxina — Teste Diagnóstico Neonatal (IV)	50 a 100 mg em injeção IV lenta sob monitorização contínua de EEG	Cessaç�o imediata das crises e normaliza��o do EEG em minutos confirma o diagn�stico.
Epilepsia Dependente de Piridoxina — Manuten��o (VO)	15 a 30 mg/kg/dia (ou 50 a 200 mg/dia) em dose �nica ou dividida a cada 12h	Tratamento cont�nuo por toda a vida.
Ant�doto na Intoxica��o por Isoniazida (IV)	Dose grama a grama igual � quantidade de isoniazida ingerida (se desconhecida: 70 mg/kg; M�x: 5 g) em 10 minutos.	Infundir lentamente.
Profilaxia de Neuropatia em Tratamento com Isoniazida (VO)	1 a 2 mg/kg/dia (ou 10 a 25 mg/dia)	Dose di�ria �nica

Contraindicações, restrições e monitorização

Uso Cr nico em Megadoses: Doses excessivas prolongadas (> 200 a 500 mg/dia) podem causar neuropatia sensorial perif rica com ataxia revers vel.

Valida  o antes do uso: confirmar indica  o individual, peso/idade, alergias, fun  o renal/hep tica, intera   es, apresenta  o dispon vel e fonte cl nica/regulat ria vigente. Alta vigil ncia: dupla confer ncia independente.

324. Poliestirenosulfonato de c lcio

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem convers o simples detect vel para auditoria autom tica

Apresenta  es Dispon veis

P  para suspens o oral e retal em envelopes de 30 g (Sorcal)

Indica   es e Linha de Tratamento

Resina de troca cati nica que troca   ns c lcio por pot ssio no c lon. Indicado no tratamento e controle subagudo da Hipercalemia moderada a grave em crian as com doen a renal cr nica ou les o renal aguda.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Hipercalcemia Pediátrica (VO)	0,5 a 1,0 g/kg/dose a cada 6 a 8 horas diluído em água ou solução glicosada a 10% (Máx: 15 a 30 g/dose).	Administrar diluído por via oral ou sonda gástrica.
Via Retal — Enema de Retenção (Retal)	1 g/kg/dose diluído em água ou solução isotônica (reter por pelo menos 30 a 60 minutos)	Lavar o cólon após o procedimento.

Contraindicações, restrições e monitorização

NECROSE INTESTINAL / PREMATUROS: NUNCA administrar em associação com sorbitol (alto risco de necrose colônica isquêmica e perfuração). Contraindicado em neonatos com motilidade intestinal reduzida ou prematuros.

Condições: Hipercalcemia e hipocalcemia.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

325. Polimixina B (sulfato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó liofilizado para solução injetável frasco-ampola 500.000 UI

Indicações e Linha de Tratamento

Antimicrobiano bactericida de ação na membrana externa bacteriana. Droga de resgate de última linha para infecções sistêmicas hospitalares graves causadas por bacilos Gram-negativos multirresistentes (*Acinetobacter baumannii*, *Pseudomonas aeruginosa* e *Klebsiella pneumoniae* produtora de KPC/NDM).

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Infecções Graves por Bactérias Multirresistentes (IV)	Carga: 20.000 a 25.000 UI/kg em infusão de 60 min. Manutenção: 15.000 a 25.000 UI/kg/dia dividido a cada 12 horas (Máx: 1.500.000 UI/dia).	Infundir em 60 minutos diluído em SG5% ou SF0,9%. Não requer ajuste de dose para insuficiência renal.

Contraindicações, restrições e monitorização

Toxicidade: Alto risco de nefrotoxicidade tubular aguda e neurotoxicidade com bloqueio neuromuscular e parestesias.

Condições: Miastenia gravis.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

326. Polimixina B + Neomicina + Fluocinolona + Lidocaína

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Gotas otológicas / suspensão otológica

Indicações e Linha de Tratamento

Associação de antimicrobianos bactericidas com corticoide anti-inflamatório e anestésico local. Primeira linha no tratamento da Otite Externa Aguda difusa bacteriana (ouvido de nadador).

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Otite Externa Aguda com Membrana Timpânica Íntegra (Otológico)	Instilar 3 a 4 gotas no conduto auditivo afetado 3 a 4 vezes ao dia por 7 dias	Manter a criança deitada com o ouvido afetado para cima por 3 a 5 minutos após a instilação.

Contraindicações, restrições e monitorização

PERFURAÇÃO TIMPÂNICA: ESTRITAMENTE CONTRAINDICADO SE HOUVER SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE PERFURAÇÃO DA MEMBRANA TIMPÂNICA ou tubo de ventilação (a neomicina e polimixina tópicas são ototóxicas para o ouvido interno).

Condições: Infecções virais ou fúngicas do conduto auditivo.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

327. Polivitamínicos pediátricos com minerais

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Gotas orais

Suspensão oral

Comprimidos mastigáveis

Indicações e Linha de Tratamento

Suplemento nutricional contendo vitaminas lipossolúveis, hidrossolúveis e oligoelementos essenciais. Indicado em estados de desnutrição energético-proteica, síndromes de má absorção intestinal, pós-operatório de cirurgia bariátrica em adolescentes e carências nutricionais múltiplas.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Suplementação Nutricional Pediátrica (VO)	Lactentes: 1 mL (ou 20 a 24 gotas) ao dia. Crianças de 1 a 6 anos: 2,5 a 5 mL ao dia. Crianças > 6 anos: 5 a 10 mL ou 1 comprimido mastigável ao dia.	Administrado junto com uma das refeições principais.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipervitaminose prévia de vitaminas A ou D e hemocromatose.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

328. Poractanto alfa (Surfactante pulmonar porcino)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Suspensão intratraqueal 80 mg/mL (frascos 1,5 mL = 120 mg e 3,0 mL = 240 mg de fosfolipídios)

Indicações e Linha de Tratamento

Surfactante pulmonar exógeno natural fracionado de origem porcina com alta concentração de fosfolipídios e proteínas SP-B e SP-C. Primeira linha padrão-ouro no tratamento de resgate da Síndrome do Desconforto Respiratório (SDR / Membrana Hialina) em recém-nascidos prematuros.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
SDR Neonatal / Membrana Hialina (Intratraqueal)	Dose Inicial de Resgate: 200 mg/kg (2,5 mL/kg) em alíquota única ou dividida por cânula traqueal ou técnica minimamente invasiva (LISA / MIST / InSurE).	Doses subsequentes: 100 mg/kg (1,25 mL/kg) a cada 12 horas se mantiver necessidade de FiO ₂ > 0,30 e suporte ventilatório (Máx: 3 doses).

Contraindicações, restrições e monitorização

Cuidados: Monitorização contínua de saturação e mecânica pulmonar imediata (rápida melhora da complacência pulmonar exige redução imediata das pressões inspiratórias para evitar volutrauma e pneumotórax).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

329. Posaconazol

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Suspensão oral 40 mg/mL

Comprimidos de liberação retardada 100 mg

Solução injetável IV 300 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Antifúngico triazólico de segunda geração de espectro estendido ativo contra fungos filamentosos (*Aspergillus*, *Fusarium*) e Mucorales. Primeira linha na profilaxia de infecções fúngicas invasivas em leucemia mieloide aguda e Doença do Enxerto contra Hospedeiro (GVHD) em transplante de medula óssea a partir de 2 anos.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Profilaxia / Tratamento de Micoses Invasivas — Crianças ≥ 2 anos (VO/IV)	Comprimidos Revestidos / IV: Carga no Dia 1: 6 mg/kg a cada 12h (Máx: 300 mg a cada 12h). Manutenção: 6 mg/kg uma vez ao dia (Máx: 300 mg/dia). Suspensão Oral: 4,5 a 6 mg/kg a cada 8 horas com refeições gordurosas.	Monitorar nível sérico de vale (> 0,7 mcg/mL na profilaxia e > 1,0 a 1,5 mcg/mL no tratamento).

Contraindicações, restrições e monitorização

Interações: Inibidor potente do CYP3A4.

Cardiotoxicidade: Prolongamento do intervalo QTc.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

330. Pralidoxima (mesilato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó liofilizado para solução injetável frasco-ampola 200 mg e 1000 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Reativador da enzima acetilcolinesterase (oxima). Antídoto específico de primeira linha associado à atropina na Intoxicação Aguda Grave por Inseticidas Organofosforados para reversão da fraqueza muscular esquelética, fasciculações e paralisia respiratória.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Intoxicação Grave por Organofosforados (IV)	Dose de Ataque: 20 a 50 mg/kg (Máx: 1 a 2 g) infundido em 15 a 30 minutos diluído em SF0,9%. Seguido de infusão contínua: 10 a 20 mg/kg/hora por 24 a 48 horas (ou bolus repetidos a cada 4 a 6 horas).	Iniciar o mais precocemente possível antes do 'envelhecimento' irreversível da enzima acetilcolinesterase fosforilada.

Contraindicações, restrições e monitorização

Intoxicação por Carbamatos: Contraindicada na intoxicação isolada por inseticidas carbamatos (a inibição é reversível espontaneamente e a pralidoxima pode aumentar a toxicidade).

Velocidade IV: Infusão rápida pode causar taquicardia, rigidez muscular e laringoespasma.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

331. Praziquantel

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos 600 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Anti-helmíntico pirazinoisoquinolínico de amplo espectro que aumenta a permeabilidade ao cálcio na membrana do parasita. Primeira linha padrão-ouro no tratamento da Esquistossomose Mansônica (*Schistosoma mansoni*), Neurocisticercose e infecções por Cestódeos/Trematódeos.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Esquistossomose Mansônica (VO)	Crianças ≥ 2 anos: 50 a 60 mg/kg em dose única diária (ou dividida em 2 tomadas com intervalo de 4 horas)	Ingerir com água após refeição para reduzir náuseas e tontura.
Neurocisticercose Pediátrica (VO)	50 mg/kg/dia dividido a cada 8 horas por 14 a 21 dias (sempre precedido e acompanhado por corticoterapia com dexametasona para prevenir edema cerebral por lise dos cistos).	Dividido a cada 8 horas com alimentos.

Contraindicações, restrições e monitorização

Cisticercose Ocular: Contraindicado na cisticercose ocular ativa (a destruição do parasita no olho pode causar descolamento de retina e cegueira permanente).

Idade: Não recomendado para menores de 2 anos.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

332. Prednisolona (fosfato sódico / acetato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução oral 3 mg/mL (equivalente a 4,02 mg/mL de fosfato sódico) e 1 mg/mL

Comprimidos 5 mg, 20 mg e 40 mg

Colírio oftálmico 1%

Indicações e Linha de Tratamento

Glicocorticoide sintético padrão-ouro na pediatria oral com potente ação anti-inflamatória e imunossupressora (forma ativa da prednisona, dispensando metabolização hepática inicial). Primeira linha na Exacerbação Aguda de Asma, Crise de Sibilância no lactente, Síndrome Nefrótica Idiopática da infância e Doenças Autoimunes.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Crise Aguda de Asma / Sibilância (VO)	1 a 2 mg/kg/dia (Dose habitual: 1 mg/kg/dose 1x ao dia ou a cada 12h; Máx: 40 a 60 mg/dia) por 3 a 5 dias consecutivos sem necessidade de desmame.	Administrar pela manhã junto com o desjejum para minimizar desconforto gástrico e mimetizar o pico de cortisol.
Síndrome Nefrótica — Fase de Ataque (VO)	60 mg/m ² /dia (ou 2 mg/kg/dia; Máx: 60 mg/dia) em dose única matinal por 4 a 6 semanas consecutivas.	Seguido de fase de manutenção em dias alternados (40 mg/m ² em dias alternados) por mais 4 a 6 semanas com desmame lento.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Infecções fúngicas sistêmicas não tratadas, vacinas de vírus vivos durante o uso em doses imunossupressoras (> 2 mg/kg/dia por > 14 dias).

Efeitos: Aumento de apetite, irritabilidade, fácies cushingoide e hipertensão em uso prolongado.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

333. Prednisona

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos 5 mg e 20 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Glicocorticoide sintético pró-fármaco convertido hepaticamente em prednisolona. Indicado no tratamento anti-inflamatório e imunossupressor em crianças maiores capazes de deglutir comprimidos.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Asma Aguda / Alergias Sistêmicas — Crianças Maiores (VO)	1 a 2 mg/kg/dia em dose única matinal por 3 a 5 dias (Máx: 60 mg/dia)	Tomar pela manhã com alimentos.

Contraindicações, restrições e monitorização

Insuficiência Hepática: Em hepatopatias graves, preferir a prednisolona (que não depende de conversão hepática).

Condições: Infecções sistêmicas ativas graves.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

334. Pregabalina

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Cápsulas 25 mg, 50 mg, 75 mg e 150 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Análogo do GABA ligante da subunidade alfa-2-delta dos canais de cálcio voltagem-dependentes no SNC com rápida absorção e alta biodisponibilidade. Indicada no tratamento da Dor Neuropática crônica, fibromialgia juvenil e crises epiléticas focais refratárias em adolescentes.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Dor Neuropática em Crianças e Adolescentes (VO)	Inicial: 1,5 a 2,5 mg/kg/dia dividido a cada 12 horas. Titular semanalmente até dose de manutenção de 3 a 6 mg/kg/dia (Máx: 300 a 600 mg/dia).	Dividido a cada 12 horas com ou sem alimentos.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipersensibilidade à pregabalina.

Desmame: Reduzir gradualmente ao longo de 1 a 2 semanas para evitar síndrome de abstinência e insônia.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

335. Primidona

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos 100 mg e 250 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Antiepiléptico barbitúrico pró-fármaco metabolizado em fenobarbital e feniletilmalonamida (PEMA). Indicado no controle de crises epiléticas focais e generalizadas resistentes e tremor essencial congênito/familiar.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Epilepsia Refratária / Tremor Essencial (VO)	Crianças < 8 anos: Inicial 50 mg ao deitar, aumentando a cada 3 dias até 10 a 20 mg/kg/dia dividido a cada 8h. Crianças ≥ 8 anos: Inicial 100 mg ao deitar, aumentando até 15 a 25 mg/kg/dia (Máx: 750 a 1500 mg/dia).	Dividido a cada 8 horas com alimentos.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Porfíria aguda intermitente e hipersensibilidade a barbitúricos.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

336. Probióticos pediátricos (Lactobacillus reuteri / rhamnosus / Saccharomyces boulardii)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Gotas orais (L. reuteri DSM 17938)

Sachês/pó liofilizado para suspensão oral (S. boulardii 100 mg e 200 mg, L. rhamnosus GG)

Cápsulas

Indicações e Linha de Tratamento

Microrganismos vivos com evidência clínica comprovada para restauração da microbiota entérica e modulação imune. Primeira linha na Redução da Duração da Diarreia Aguda Infecciosa (reduz em ~24 horas a duração), prevenção de Diarreia Associada a Antibióticos e manejo da Cólica do Lactente.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Diarreia Aguda Infecciosa / Pós-Antibiótico — S. boulardii (VO)	100 a 200 mg (1 a 2 sachês) 1 a 2 vezes ao dia por 5 a 7 dias	Diluir em água, leite, suco ou soro em temperatura ambiente (não misturar em líquidos quentes).
Cólica do Lactente em Aleitamento Materno — L. reuteri (VO)	5 gotas (1 x 10 ¹¹ UFC) uma vez ao dia por 21 a 28 dias	Administrar diretamente na boca ou na colher.

Contraindicações, restrições e monitorização

IMUNODEPRIMIDOS E CATETER CENTRAL: Contraindicado o uso de Saccharomyces boulardii em pacientes com cateter venoso central, imunodeficiências graves ou prematuros extremos devido ao risco documentado de fungemia invasiva por contaminação aérea durante abertura do sachê.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

337. Prometazina (cloridrato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Xarope/solução oral 1 mg/mL (5 mg/5 mL)

Comprimidos 25 mg

Solução injetável 25 mg/mL (ampola 2 mL = 50 mg)

Indicações e Linha de Tratamento

Anti-histamínico de primeira geração da classe das fenotiazinas com potente ação sedativa, antiemética e anticolinérgica. Indicado no tratamento sintomático de reações alérgicas graves e náuseas em crianças maiores de 2 anos.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Reações Alérgicas / Prurido — Crianças ≥ 2 anos (VO)	0,1 a 0,5 mg/kg/dose a cada 6 a 8 horas (Máx: 25 mg/dose)	Administrar preferencialmente à noite.
Via Parenteral de Urgência (IM Profunda)	0,25 a 0,5 mg/kg/dose (Máx: 25 mg)	Injeção intramuscular profunda exclusiva.

Contraindicações, restrições e monitorização

BLACK BOX WARNING — MORTE POR DEPRESSÃO RESPIRATÓRIA EM MENORES DE 2 ANOS: ESTRITAMENTE CONTRAINDICADA EM QUALQUER DOSE OU VIA EM MENORES DE 2 ANOS DE IDADE (risco fatal de apnéia súbita, depressão respiratória fulminante e óbito).

VIA INTRAVENOSA: A via IV apresenta alto risco de tromboflebite química grave, necrose tecidual e gangrena; via IM profunda preferencial.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

338. Propiltiouracila

Auditoria documental Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos 100 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Antitireoidiano tionamida que inibe a síntese de hormônios tireoidianos e bloqueia a conversão periférica de T4 em T3. Indicado na Crise Tireotóxica aguda na emergência.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Crise Tireotóxica / Tempestade Tireoidiana (VO)	5 a 10 mg/kg/dia dividido a cada 6 a 8 horas (Dose inicial em adolescentes: 150 a 300 mg a cada 8h)	Dividido a cada 6 a 8 horas

Contraindicações, restrições e monitorização

HEPATOTOXICIDADE FULMINANTE: Black box warning da FDA para necrose hepática aguda grave e insuficiência hepática fulminante fatal em crianças (o metimazol/tiamazol é a primeira linha absoluta de manutenção crônica em pediatria; a propiltiouracila fica restrita à crise aguda).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

339. Propofol

Auditoria documental Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Emulsão injetável 1% (10 mg/mL, ampolas 20 mL = 200 mg e frascos 50 mL e 100 mL) e 2% (20 mg/mL)

Indicações e Linha de Tratamento

Anestésico intravenoso de ação ultracurta derivado do alquilfenol. Primeira linha na indução anestésica cirúrgica e sedação profunda de curta duração para procedimentos diagnósticos dolorosos na emergência pediátrica.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Indução Anestésica / Procedimento de Curta Duração (IV)	Crianças de 1 a 3 anos: 3 a 4 mg/kg em bolus IV lento. Crianças > 3 anos: 2 a 3 mg/kg.	Início de ação em 30 segundos; duração de 5 a 10 minutos. Titular com bolus de 0,5 a 1 mg/kg.

Contraindicações, restrições e monitorização

SÍNDROME DA INFUSÃO DO PROPOFOL (PRIS): ESTRITAMENTE CONTRAINDICADA INFUSÃO CONTÍNUA PROLONGADA (> 48h) OU EM DOSES ELEVADAS (> 4-5 mg/kg/h) PARA SEDAÇÃO EM UTI PEDIÁTRICA (risco de acidose láctica fulminante, rabdomiólise, hipercalcemia, colapso cardiovascular e óbito).

Alergias Alimentares: Emulsão formulada em óleo de soja e lecitina de ovo.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

340. Propranolol (cloridrato)

Auditoria documental Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução oral 2 mg/mL e 4 mg/mL

Comprimidos 10 mg, 40 mg e 80 mg

Solução injetável 1 mg/mL (ampola 1 mL)

Indicações e Linha de Tratamento

Betabloqueador não seletivo lipofílico. Primeira linha padrão-ouro mundial para o tratamento de Hemangioma Infantil Proliferativo (reduz angiogênese e induz apoptose endotelial), profilaxia de crises de hipóxia na Tetralogia de Fallot e profilaxia de enxaqueca.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Hemangioma Infantil Proliferativo — Protocolo Padrão SBP (VO)	Semana 1: 1 mg/kg/dia dividido a cada 12 horas. Semana 2: 2 mg/kg/dia. Manutenção: 2 a 3 mg/kg/dia dividido a cada 12 horas.	Administrar OBRIGATORIAMENTE durante ou logo após as mamadas/refeições para prevenir hipoglicemia grave. Manter até 12 a 18 meses de idade.
Profilaxia de Crises de Cianose na Tetralogia de Fallot (VO)	1 a 2 mg/kg/dia dividido a cada 6 a 8 horas (titular até máx 4 a 5 mg/kg/dia)	Dose regular fracionada
Profilaxia de Enxaqueca / Hipertensão (VO)	0,5 a 1 mg/kg/dia dividido a cada 8 a 12 horas (Máx: 2 a 4 mg/kg/dia)	Dividido em 2 a 3 tomadas

Contraindicações, restrições e monitorização

HIPOGLICEMIA GRAVE: Bloqueia a glicogenólise e mascara os sinais autonômicos de alarme da hipoglicemia (taquicardia, sudorese); orientar suspensão em caso de recusa alimentar ou diarreia.

Condições: Asma brônquica / broncoespasmo ativo, bloqueio AV de 2º/3º grau e choque cardiogênico.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

341. Protamina (cloridrato / sulfato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável 10 mg/mL (1000 UI anti-heparina/mL, ampola 5 mL = 50 mg)

Indicações e Linha de Tratamento

Proteína catiônica rica em arginina que neutraliza a heparina formando um sal estável inativo. Antídoto de primeira linha para Reversão Imediata da Heparina Não Fracionada (HNF) e reversão parcial da Heparina de Baixo Peso Molecular (enoxaparina) em sangramentos graves ou pós-CEC.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Reversão de Heparina Não Fracionada (IV)	1 mg de protamina neutraliza aproximadamente 100 UI de heparina administrada nas últimas 2 horas (reduzir a dose proporcionalmente ao tempo decorrido desde a interrupção da heparina; Máx: 50 mg por dose).	Infundir em pelo menos 10 minutos (velocidade ≤ 5 mg/minuto).
Reversão de Enoxaparina (IV)	1 mg de protamina para cada 1 mg de enoxaparina administrada nas últimas 8 horas	Infundir lentamente em 10 minutos.

Contraindicações, restrições e monitorização

Hipotensão e Anafilaxia: A administração IV rápida causa hipotensão grave súbita, bradicardia, broncoespasmo e hipertensão pulmonar catastrófica.

Condições: Alergia prévia a peixes (derivada de esperma de salmão) e uso prévio de insulina NPH (sensibilização a protamina).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

342. Quetiapina (fumarato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos 25 mg, 100 mg, 200 mg e 300 mg

Comprimidos de liberação prolongada 50 mg, 200 mg e 300 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Antipsicótico atípico antagonista dos receptores 5-HT_{2A} e D₂ com baixa afinidade por receptores dopaminérgicos estriatais (baixo risco extrapiramidal). Indicada no tratamento do Transtorno Bipolar (mania/depressão) e Esquizofrenia em adolescentes ≥ 13 anos.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Transtorno Bipolar / Esquizofrenia em Adolescentes (VO)	Dia 1: 50 mg/dia. Dia 2: 100 mg/dia. Dia 3: 200 mg/dia. Dia 4: 300 mg/dia. Titular até dose alvo de 400 a 800 mg/dia.	Dividido a cada 12 horas ou dose única noturna ao deitar (formulações XR).

Contraindicações, restrições e monitorização

Monitorização: Avaliar sonolência acentuada, ganho de peso, perfil lipídico e intervalo QTc no ECG.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

343. Racecadotril

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Grânulos para suspensão oral em sachês de 10 mg (lactentes) e 30 mg (crianças)

Cápsulas 100 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Inibidor periférico da encefalinase intestinal que reduz a hipersecreção de água e eletrólitos na mucosa entérica sem alterar a motilidade gástrica nem causar proliferação bacteriana. Indicado como terapia adjuvante à Reidratação Oral na Diarreia Aguda Aquosa a partir de 3 meses de vida.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Diarreia Aguda — Crianças de 3 a 9 meses (peso < 9 kg) (VO)	10 mg (1 sachê infantil) 3 vezes ao dia junto com SRO até cessarem as evacuações líquidas (Máx: 5 a 7 dias)	Dissolver os grânulos em água, suco ou alimento pastoso.
Crianças de 9 a 30 meses (peso 9 a 13 kg) (VO)	20 mg (2 sachês de 10 mg) 3 vezes ao dia	A cada 8 horas
Crianças de 30 meses a 9 anos (peso 13 a 27 kg) (VO)	30 mg (1 sachê de 30 mg) 3 vezes ao dia	A cada 8 horas
Crianças > 9 anos (peso > 27 kg) (VO)	60 mg (2 sachês de 30 mg) 3 vezes ao dia	A cada 8 horas

Contraindicações, restrições e monitorização

Idade: Contraindicado para menores de 3 meses de idade.

Condições: Diarreia com fezes sanguinolentas/disenteria e insuficiência renal ou hepática.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

344. Ranitidina (cloridrato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Xarope/solução oral 15 mg/mL (75 mg/5 mL)

Comprimidos 150 mg e 300 mg

Solução injetável 25 mg/mL (ampola 2 mL = 50 mg)

Indicações e Linha de Tratamento

Antagonista competitivo dos receptores H2 de histamina nas células parietais gástricas. Utilizada historicamente no tratamento do refluxo gastroesofágico e úlcera péptica.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Uso Histórico de Referência (VO/IV)	VO: 4 a 8 mg/kg/dia dividido a cada 12 horas (Máx: 300 mg/dia). IV: 2 a 4 mg/kg/dia dividido a cada 6 a 8 horas.	Infundir IV em 15 a 20 minutos.

Contraindicações, restrições e monitorização

ALERTA SANITÁRIO E RECOLHIMENTO (ANVISA / FDA): Medicamento descontinuado e recolhido do mercado por agências regulatórias internacionais devido à contaminação com a impureza N-nitrosodimetilamina (NDMA), uma substância potencialmente carcinogênica. Preferir Inibidores da Bomba de Prótons (omeprazol, esomeprazol) ou outros anti-H2.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

345. Remifentanila (cloridrato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó liofilizado para solução injetável frasco-ampola 1 mg, 2 mg e 5 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Opioide sintético agonista μ de ação ultracurta metabolizado por esterases plasmáticas e teciduais inespecíficas (meia-vida de contexto de 3 a 5 minutos sem acúmulo). Primeira linha na anestesia geral balanceada e analgesia de procedimentos invasivos rápidos em UTI e centro cirúrgico pediátrico.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Analgesia e Anestesia Cirúrgica Pediátrica (IV Contínuo)	Indução: 0,5 a 1 mcg/kg em bolus lento em 1 minuto. Manutenção Contínua: 0,1 a 0,5 mcg/kg/minuto em bomba de infusão exclusiva sob ventilação mecânica.	Recuperação ultrarrápida em 5 a 10 minutos após o término da infusão. Planejar analgesia de transição pós-operatória antecipadamente.

Contraindicações, restrições e monitorização

Rigidez Torácica e Apneia: Bolus rápido provoca rigidez muscular torácica grave e apneia imediata.

Condições: Ausência de via aérea artificial avançada e ventilação garantida.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

346. Retinol (Vitamina A / Palmitato de retinol)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Gotas 50.000 UI/mL, 100.000 UI/mL e 200.000 UI/mL

Cápsulas 50.000 UI e 100.000 UI

Ampolas injetáveis IM

Indicações e Linha de Tratamento

Vitamina lipossolúvel essencial para diferenciação epitelial, imunidade e ciclo visual. Primeira linha mandatória do Ministério da Saúde e OMS no Tratamento do Sarampo Pediátrico (reduz mortalidade em 50% e previne cegueira), xeroftalmia/cegueira noturna e suplementação periódica (Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A).

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Tratamento do Sarampo Pediátrico — Protocolo OMS/SBP (VO)	Lactentes < 6 meses: 50.000 UI no Dia 1 e Dia 2. Lactentes de 6 a 11 meses: 100.000 UI no Dia 1 e Dia 2. Crianças $\geq$ 12 meses: 200.000 UI no Dia 1 e Dia 2 (se houver sinais de xeroftalmia, repetir uma 3ª dose após 2 a 4 semanas).	Administrar por via oral em dose única diária imediata no diagnóstico.
Programa Nacional de Suplementação (Prevenção) (VO)	6 a 11 meses: 100.000 UI em dose única a cada 6 meses. 12 a 59 meses: 200.000 UI a cada 6 meses.	Dose semestral

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipervitaminose A prévia e hipertensão intracraniana idiopática.

Efeitos em Megadose: Abaulamento transitório de fontanela em lactentes (benigno) e vômitos.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

347. Ribavirina

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Cápsulas 250 mg

Solução oral

Indicações e Linha de Tratamento

Antiviral análogo sintético de guanosina. Indicada no tratamento da Hepatite C crônica em crianças ≥ 3 anos associada a antivirais de ação direta ou interferon peguilado.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Hepatite C Crônica em Crianças ≥ 3 anos (VO)	15 mg/kg/dia dividido a cada 12 horas com alimentos gordurosos (Máx: 1000 a 1200 mg/dia)	Duração conforme genótipo viral sob protocolo especializado.

Contraindicações, restrições e monitorização

Anemia Hemolítica Grave: Causa anemia hemolítica dose-dependente acentuada; monitorar hemograma quinzenalmente.

Teratogenicidade: Extrema teratogenicidade; contraindicada em gestantes e adolescentes sem contracepção dupla.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

348. Rifampicina

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Suspensão oral 20 mg/mL (100 mg/5 mL)

Cápsulas 300 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Antimicrobiano rifamicina bactericida potente (inibidor da RNA polimerase bacteriana). Primeira linha essencial no Esquema Básico de Tratamento da Tuberculose ativa (RHZE), Quimioprofilaxia de Contatos de Doença Meningocócica e infecções graves por *Staphylococcus aureus* com biofilme (osteomielite, próteses).

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Tratamento da Tuberculose Ativa (VO)	15 mg/kg/dia (Faixa: 10 a 20 mg/kg/dia; Máx: 600 mg/dia)	Dose única diária matinal em jejum estrito (1h antes ou 2h após café da manhã) por 6 meses.
Quimioprofilaxia de Doença Meningocócica (VO)	Neonatos < 1 mês: 5 mg/kg a cada 12 horas por 2 dias. Crianças ≥ 1 mês: 10 mg/kg/dose a cada 12 horas por 2 dias (Máx: 600 mg/dose).	Esquema curto de 4 doses em 2 dias.

Contraindicações, restrições e monitorização

Coloração Vermelho-Alaranjada: Alerta obrigatório aos pais de que a rifampicina colore lágrimas, saliva, suor e urina de vermelho-alaranjado intenso (mancha lentes de contato).

Interações Hepáticas: Potente indutor do citocromo P450 (CYP3A4); reduz níveis séricos de anticoncepcionais, corticosteroides e anticonvulsivantes.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

349. Risperidona

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução oral 1 mg/mL (1 gota = 0,05 mg)

Comprimidos revestidos 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 2 mg e 3 mg

Comprimidos orodispersíveis 0,5 mg, 1 mg e 2 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Antipsicótico atípico antagonista dos receptores 5-HT_{2A} e D₂. Primeira linha padrão-ouro aprovada pela FDA e ANVISA para o tratamento da Irritabilidade, Agressividade e Autoagressão no Transtorno do Espectro Autista (TEA) em crianças ≥ 5 anos, Transtorno de Conduta e Síndrome de Tourette.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Irritabilidade no Autismo (TEA) — Crianças ≥ 5 anos (VO)	Peso < 20 kg: Iniciar com 0,25 mg (0,25 mL ou 5 gotas) ao deitar. Titular após 2 semanas para 0,5 mg/dia (Máx: 1,0 a 1,5 mg/dia). Peso ≥ 20 kg: Iniciar com 0,5 mg ao deitar. Titular até 1,0 a 2,5 mg/dia (Máx: 3,0 mg/dia).	Dose única noturna ou dividida a cada 12 horas.
Tiques / Síndrome de Tourette (VO)	Inicial: 0,25 a 0,5 mg/dia. Titular até 1 a 2 mg/dia.	Dose noturna

Contraindicações, restrições e monitorização

Hiperprolactinemia e Síndrome Metabólica: Causa elevação marcante de prolactina (ginecomastia, galactorreia), ganho de peso acentuado e aumento do apetite.

Monitorização: Peso, circunferência abdominal, glicemia de jejum e prolactina sérica periodicamente.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

350. Rufenamida

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos 200 mg e 400 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Antiepiléptico derivado do triazol que prolonga o estado de inativação dos canais de sódio dependentes de voltagem. Primeira linha como terapia adjuvante no tratamento de crises epilépticas associadas à Síndrome de Lennox-Gastaut (especialmente crises atônicas e quedas súbitas) em crianças ≥ 1 ano.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Síndrome de Lennox-Gastaut — Crianças ≥ 1 ano (VO)	Inicial: 10 mg/kg/dia dividido a cada 12 horas. Titular a cada 2 dias em incrementos de 10 mg/kg/dia até dose de manutenção de 45 mg/kg/dia (Máx: 3200 mg/dia).	Administrar OBRIGATORIAMENTE junto com alimentos (alimentos aumentam a absorção e biodisponibilidade).

Contraindicações, restrições e monitorização

Cardiotoxicidade: Encurtamento do intervalo QTc no ECG; contraindicada em pacientes com Síndrome do QT Curto Congênito.

Interações: Níveis reduzidos por indutores enzimáticos (carbamazepina/fenitoína) e aumentados por valproato.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

351. Rupatadina (fumarato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução oral 1 mg/mL

Comprimidos 10 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Anti-histamínico de segunda geração com dupla ação bloqueadora: antagonista dos receptores H₁ de histamina e antagonista dos receptores do Fator de Ativação Plaquetária (PAF). Indicada no tratamento da Rinite Alérgica e Urticária Crônica Espontânea em

crianças $\geq$ 2 anos.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Rinite Alérgica / Urticária — 2 a 11 anos (peso 10 a 25 kg) (VO)	2,5 mg (2,5 mL da solução oral) uma vez ao dia	Tomar uma vez ao dia com ou sem alimentos.
Crianças de 2 a 11 anos (peso $\geq$ 25 kg) (VO)	5 mg (5 mL da solução oral) uma vez ao dia	Dose única diária
Crianças $\geq$ 12 anos e Adolescentes (VO)	10 mg (1 comprimido de 10 mg) uma vez ao dia	Dose única diária

Contraindicações, restrições e monitorização

Idade: Não recomendada para menores de 2 anos.

Interações: Evitar associação com suco de toranja (grapefruit) e inibidores potentes do CYP3A4.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

352. Sais de Reidratação Oral (SRO)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó para solução oral em envelopes de 27,9 g (para 1000 mL de água) ou sachês pediátricos para 200 mL e 500 mL

Solução pronta para uso oral (45 mEq/L e 75 mEq/L de sódio)

Indicações e Linha de Tratamento

Solução balanceada de glicose e eletrólitos de osmolaridade reduzida (fórmula padrão OMS/Ministério da Saúde: 75 mEq/L Na⁺, 20 mEq/L K⁺, 65 mEq/L Cl⁻, 10 mEq/L citrato, 75 mmol/L glicose = 245 mOsm/L). Primeira linha padrão-ouro absoluta na Prevenção e Tratamento da Desidratação por Doença Diarreica Aguda (Planos A e B do Ministério da Saúde).

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Plano A — Prevenção da Desidratação no Domicílio (VO)	Oferecer após cada evacuação líquida: < 1 ano: 50 a 100 mL; 1 a 10 anos: 100 a 200 mL; > 10 anos: volume que aceitar.	Oferecer com colher ou copo lentamente após as perdas diarreicas.
Plano B — Tratamento da Desidratação Leve a Moderada na Unidade de Saúde (VO)	50 a 100 mL/kg administrado continuamente na unidade em um período de 4 a 6 horas sob supervisão.	Oferecer pequenas alíquotas com colher ou copo a cada 1 a 2 minutos. Se vômitos persistirem, pausar 10 min e reiniciar em velocidade mais lenta ou administrar ondansetrona oral.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições para Via Oral: Desidratação grave com choque hipovolêmico (indicação de hidratação venosa rápida - Plano C), íleo paraltico, abdome agudo cirúrgico, alteração profunda da consciência e vômitos incoercíveis refratários a antieméticos.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

353. Salbutamol (sulfato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; concentrações simples checadas: OK

Apresentações Disponíveis

Xarope 2 mg/5 mL (0,4 mg/mL)

Solução para nebulização/gotas 5 mg/mL

Aerossol inalatório pressurizado (spray) 100 mcg/puff

Solução injetável 0,5 mg/mL (ampola 1 mL)

Indicações e Linha de Tratamento

Broncodilatador agonista seletivo beta-2 adrenérgico de curta ação (SABA). Primeira linha padrão-ouro absoluta de consenso mundial (GINA/SBP) para Alívio e Resgate Imediato do Broncoespasmo Agudo na Crise Asmática, exacerbação de sibilância

pós-bronquiolite e broncoespasmo induzido por exercício.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Crise Asmática Leve a Moderada — Spray com Espaçador Valvulado (Inalatória)	Crianças < 6 anos: 2 a 4 jatos (200 a 400 mcg). Crianças ≥ 6 anos: 4 a 8 jatos (400 a 800 mcg).	Administrar com espaçador valvulado a cada 20 minutos na primeira hora (até 3 ciclos) e depois a cada 3 a 4 horas conforme resposta clínica.
Crise Asmática Grave / UTI — Nebulização Contínua ou Intermitente (Inalatória)	Intermitente: 0,15 mg/kg/dose (0,03 mL/kg/dose de solução 5 mg/mL; Mín: 1,25 mg = 0,25 mL; Máx: 5 mg = 1 mL) a cada 20 min. Contínua em UTI: 0,3 a 0,5 mg/kg/hora em nebulizador de alto fluxo.	Nebulização com fluxo de O2 de 6 a 8 L/min.
Broncoespasmo Induzido por Exercício (Inalatória)	2 jatos (200 mcg) com espaçador 10 a 15 minutos antes da atividade física	Prevenção pontual

Contraindicações, restrições e monitorização

VIA ORAL (XAROPE): O uso do xarope oral está formalmente desaconselhado nas diretrizes de asma devido ao início de ação lento e alta incidência de efeitos adversos sistêmicos (taquicardia, tremores, agitação).

Condições: Taquiarritmias graves e hipersensibilidade ao salbutamol.

Checagem matemática automatizada

OK - 2 mg/5 mL = 0.4 mg/mL; declarado 0.4 mg/mL

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

354. Salmeterol (xinafoato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Aerossol inalatório pressurizado 25 mcg/puff

Pó para inalação 50 mcg/dose

Associado a fluticasona (25/50 mcg, 25/125 mcg, 25/250 mcg, 50/100 mcg, 50/250 mcg e 50/500 mcg)

Indicações e Linha de Tratamento

Broncodilatador agonista beta-2 adrenérgico de longa ação (LABA) com duração de 12 horas. Indicado na terapia de manutenção da Asma Persistente Moderada a Grave em associação obrigatória fixa com corticoide inalatório (fluticasona) em crianças a partir de 4 anos.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Manutenção da Asma Moderada/Grave — Salmeterol/Fluticasona (Inalatória)	Crianças de 4 a 11 anos: 1 inalação de 50/100 mcg (ou 2 jatos de 25/50 mcg com espaçador) a cada 12 horas. Adolescentes ≥ 12 anos: 50/250 mcg a cada 12 horas.	Dividido a cada 12 horas. Enxaguar a boca após o uso.

Contraindicações, restrições e monitorização

MONOTERAPIA CONTRAINDICADA: ESTRITAMENTE CONTRAINDICADO O USO DE SALMETEROL ISOLADO SEM CORTICOIDE INALATÓRIO (risco de morte por asma).

Não é Droga de Resgate: Início de ação lento (15 a 30 minutos); não usar para crises agudas.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

355. Secnidazol

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó para suspensão oral 450 mg e 900 mg em frasco para reconstituição

Comprimidos revestidos 500 mg e 1000 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Antiparasitário nitroimidazólico de longa meia-vida (~25 horas). Primeira linha em dose única para o tratamento de Giardíase (*Giardia lamblia*) e Amebíase intestinal não complicada (*Entamoeba histolytica*).

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Giardíase e Amebíase Intestinal (VO)	30 mg/kg em DOSE ÚNICA diária junto com uma das refeições principais (Máx: 2 g)	Administrar com pequena quantidade de líquido após refeição.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Primeiro trimestre da gravidez, discrasias sanguíneas e hipersensibilidade a nitroimidazóis.

Efeito Antabuse: Evitar bebidas ou medicamentos com álcool por 48 horas após a dose.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

356. Sertralina (cloridrato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Gotas/solução oral 20 mg/mL

Comprimidos revestidos 25 mg, 50 mg e 100 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Inibidor seletivo da recaptação de serotonina (ISRS). Primeira linha padrão-ouro aprovada pela FDA para o tratamento do Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) em crianças ≥ 6 anos, Transtorno Depressivo Maior, Transtorno de Ansiedade Social e Transtorno de Pânico em adolescentes.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
TOC — Crianças de 6 a 12 anos (VO)	Inicial: 25 mg uma vez ao dia pela manhã ou à noite. Aumentar após 1 a 2 semanas para 50 mg/dia (titular semanalmente até máx 200 mg/dia).	Dose única diária matinal ou noturna com alimentos.
TOC / Depressão — Adolescentes ≥ 13 anos (VO)	Inicial: 50 mg uma vez ao dia. Titular até 100 a 200 mg/dia conforme resposta clínica.	Dose única diária

Contraindicações, restrições e monitorização

Black Box Warning: Monitoramento clínico obrigatório para ideação suicida nas primeiras 2 a 4 semanas de tratamento em jovens.

Condições: Uso concomitante com IMAO (intervalo mínimo de 14 dias) e pimozida.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

357. Sevelamer (carbonato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos 800 mg

Sachês de pó para suspensão oral 800 mg e 2,4 g

Indicações e Linha de Tratamento

Quelante de fósforo polimérico não absorvível livre de cálcio e alumínio. Primeira linha no controle da Hiperfosfatemia em crianças com Doença Renal Crônica (DRC) em estágios 4 e 5D para prevenir hipercalemia e calcificação vascular.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Hiperfosfatemia na Doença Renal Crônica (VO)	Crianças ≥ 6 anos: Fósforo sérico 5,5 a 7,5 mg/dL: 800 mg 3 vezes ao dia com as refeições. Fósforo > 7,5 mg/dL: 1.600 mg 3 vezes ao dia.	Administrar OBRIGATORIAMENTE durante as refeições principais.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipofosfatemia e obstrução intestinal mecânica.

Preparo: Os comprimidos devem ser engolidos inteiros sem mastigar ou partir.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

358. Sevoflurano

Auditoria documental	Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática
----------------------	--

Apresentações Disponíveis

Líquido volátil para inalação em frascos de 100 mL e 250 mL

Indicações e Linha de Tratamento

Anestésico geral inalatório halogenado de baixa solubilidade sanguínea e odor não pungente agradável. Padrão-ouro na Indução Anestésica Inalatória suave por máscara em pediatria e manutenção de anestesia cirúrgica.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Indução Anestésica Inalatória Pediátrica (Inalatória)	Concentração titulada de 1% até 6 a 8% com oxigênio e óxido nitroso através de máscara facial	Início de indução suave em 1 a 2 minutos sem irritação de vias aéreas.
Manutenção Anestésica (Inalatória)	CAM (Concentração Alveolar Mínima): 1,5 a 3% titulada conforme plano cirúrgico	Administração por anesthesiologista.

Contraindicações, restrições e monitorização

HIPERTERMIA MALIGNA: Contraindicação absoluta em pacientes com suscetibilidade hereditária comprovada à Hipertermia Maligna.

Agitação do Despertar: Frequente delirium e agitação transitória no pós-operatório imediato de crianças pequenas.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

359. Sildenafil (citrato)

Auditoria documental	Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática
----------------------	--

Apresentações Disponíveis

Pó para suspensão oral 10 mg/mL

Comprimidos 20 mg, 25 mg, 50 mg e 100 mg

Solução para infusão IV 0,8 mg/mL (frasco 12,5 mL = 10 mg)

Indicações e Linha de Tratamento

Inibidor seletivo da fosfodiesterase tipo 5 (PDE-5) que potencializa o óxido nítrico e causa vasodilatação pulmonar seletiva. Primeira linha no tratamento da Hipertensão Arterial Pulmonar (HAP) crônica, Hipertensão Pulmonar Persistente do Recém-Nascido (HPPRN) refratária e desmame de óxido nítrico inalatório.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Hipertensão Pulmonar Pediátrica — Dose Padronizada por Peso (VO)	Peso ≤ 20 kg: 10 mg a cada 8 horas (30 mg/dia). Peso > 20 kg: 20 mg a cada 8 horas (60 mg/dia). (Faixa em lactentes: 0,5 a 1 mg/kg/dose a cada 6 a 8h; Máx: 2 mg/kg/dose a cada 8h).	Dividido a cada 8 horas com ou sem alimentos.

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
HPPRN / Desmame de Óxido Nítrico em UTI Neonatal (IV)	Ataque: 0,4 mg/kg em 3 horas. Manutenção contínua: 1,6 mg/kg/dia em infusão contínua.	Monitorar PA sistêmica continuamente.

Contraindicações, restrições e monitorização

COADMINISTRAÇÃO DE NITRATOS: Contraindicado o uso concomitante com doadores de óxido nítrico/nitratos (risco de vasodilatação maciça e colapso circulatório fatal).

Condições: Hipotensão sistêmica severa e doença veno-oclusiva pulmonar.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

360. Simeticona (Dimeticona)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Gotas emulsão oral 75 mg/mL (1 gota = 2,5 mg a 3 mg)

Gotas concentradas 150 mg/mL

Comprimidos 40 mg

Cápsulas gelatinosas 125 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Agente antiflatulento antiespumante de ação física que altera a tensão superficial das bolhas gasosas facilitando sua coalescência e eliminação. Indicado no alívio de desconforto abdominal por excesso de gases, meteorismo e preparo de exames de ultrassonografia abdominal.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Excesso de Gases e Distensão Abdominal — Lactentes até 2 anos (VO)	15 a 30 mg (ou 5 a 10 gotas da formulação 75 mg/mL) 3 a 4 vezes ao dia junto com as mamadas (Máx: 120 mg/dia)	Administrar com as mamadas ou água.
Crianças de 2 a 12 anos (VO)	40 mg (ou 10 a 15 gotas) 3 a 4 vezes ao dia (Máx: 240 mg/dia)	A cada 6 a 8 horas
Crianças > 12 anos e Adolescentes (VO)	40 a 125 mg 3 a 4 vezes ao dia após as refeições	Sintomático

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Suspeita de obstrução ou perfuração intestinal.

Segurança: Inerte e não absorvida sistemicamente; perfil de segurança impecável.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

361. Somatropina (Hormônio do crescimento recombinante - rhGH)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó liofilizado para solução injetável ou canetas preenchidas multidose de 4 UI (1,33 mg), 12 UI (4 mg), 15 UI (5 mg), 16 UI (5,3 mg), 24 UI (8 mg), 30 UI (10 mg) e 36 UI (12 mg)

Indicações e Linha de Tratamento

Hormônio de crescimento humano recombinante. Primeira linha padrão-ouro no tratamento da Baixa Estatura por Deficiência do Hormônio de Crescimento (DGH), Síndrome de Turner, Síndrome de Prader-Willi, Crianças Nascidas Pequenas para Idade Gestacional (PIG) sem recuperação estatural e Insuficiência Renal Crônica.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Deficiência de GH (DGH) (SC)	0,025 a 0,035 mg/kg/dia (0,07 a 0,1 UI/kg/dia) em injeção subcutânea diária única à noite antes de dormir.	Injeção subcutânea noturna diária no tecido adiposo de abdome, coxas ou braços (rodízio obrigatório de sítios para evitar lipoatrofia).
Síndrome de Turner / Crianças PIG / DRC (SC)	0,045 a 0,050 mg/kg/dia (0,14 UI/kg/dia) em injeção diária noturna	Dose mais alta

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições Absolutas: Neoplasia maligna ativa não controlada, epífises ósseas fechadas (após término do crescimento) e hipertensão intracraniana ativa.

Monitorização: Avaliar IGF-1 sérico a cada 3 a 6 meses, glicemia e triagem para Epifisiólise da Cabeça Femoral (dor no quadril/coxa).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

362. Soro antiaracnídico

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável heteróloga frasco-ampola 5 mL (imunoglobulinas equinas purificadas neutralizantes de venenos de Loxosceles, Phoneutria e Tityus)

Indicações e Linha de Tratamento

Imunobiológico hiperimune heterólogo. Primeira linha no tratamento de Acidentes Graves por Aranha-Armadeira (Phoneutria) e Loxoscelismo cutâneo-visceral hemolítico grave (Loxosceles / aranha-marrom) ou formas cutâneas extensas.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Acidente Moderado a Grave por Loxosceles / Phoneutria (IV)	Loxoscelismo Cutâneo-Visceral ou Phoneutrismo Grave: 5 a 10 frascos-ampola administrados em infusão intravenosa lenta em 20 a 60 minutos.	A dose de antiveneno é IGUAL para crianças e adultos (o veneno inoculado é independente do peso da vítima). Diluir em 50 a 100 mL de SF0,9%.

Contraindicações, restrições e monitorização

Emergência: Não existem contraindicações no envenenamento grave.

Reações Anafilactoides: Ter suporte de emergência com adrenalina e corticoides pronto para reações imediatas ao soro heterólogo.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

363. Soro antibotrópico (pentavalente)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável heteróloga frasco-ampola 10 mL

Indicações e Linha de Tratamento

Imunoglobulina equina neutralizante do veneno de serpentes do gênero Bothrops (jararaca, jararacuçu, urutu, cotiara). Primeira linha no Envenenamento Botrópico com manifestações locais graves e coagulopatia sistêmica.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Acidente Botrópico Leve (IV)	2 a 4 frascos-ampola IV em infusão de 20 a 60 min	Dose idêntica para crianças e adultos.
Acidente Botrópico Moderado (IV)	4 a 8 frascos-ampola IV em infusão de 20 a 60 min	Infusão lenta
Acidente Botrópico Grave (IV)	12 frascos-ampola IV em infusão de 20 a 60 min diluído em SF0,9%	Dose máxima recomendada

Contraindicações, restrições e monitorização

Emergência: Não existem contraindicações no envenenamento botrópico comprovado.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

364. Soro antibotulínico (AB bivalente / trivalente)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável heteróloga frasco-ampola 10 mL

Indicações e Linha de Tratamento

Imunoglobulina equina neutralizante das neurotoxinas de Clostridium botulinum tipos A e B. Primeira linha mandatória no tratamento precoce do Botulismo Infantil e alimentar.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Tratamento do Botulismo Pediátrico (IV)	1 frasco-ampola em infusão intravenosa lenta diluído em SF0,9% em 30 a 60 minutos o mais precocemente possível.	Dose única neutralizante.

Contraindicações, restrições e monitorização

Emergência: Sem contraindicações em vigência de paralisia flácida descendente aguda por botulismo.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

365. Soro anticrotálico

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável heteróloga frasco-ampola 10 mL

Indicações e Linha de Tratamento

Imunoglobulina equina neutralizante do veneno de serpentes do gênero Crotalus (cascavel - veneno neurotóxico, miotóxico e coagulante). Primeira linha no Envenenamento Crotálico.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Acidente Crotálico Leve (IV)	5 frascos-ampola IV em infusão de 20 a 60 min	Dose idêntica à de adultos.
Acidente Crotálico Moderado (IV)	10 frascos-ampola IV em infusão de 20 a 60 min	Infusão lenta diluída em SF0,9%.
Acidente Crotálico Grave (fácies miastênica precoce, urina escura/rabdomiólise) (IV)	20 frascos-ampola IV em infusão contínua em 60 min	Prevenção de insuficiência renal aguda mioglobinúrica.

Contraindicações, restrições e monitorização

Emergência: Sem contraindicações em acidentes crotálicos.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

366. Soro antidiftérico

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável heteróloga frasco-ampola 10 mL (10.000 UI)

Indicações e Linha de Tratamento

Imunoglobulina equina neutralizante da toxina de Corynebacterium diphtheriae. Primeira linha imediata na suspeita clínica de Difteria faríngea, laringotraqueal ou cutânea.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Difteria Faríngea / Laríngea Leve a Moderada (IV)	20.000 a 40.000 UI (2 a 4 frascos) em infusão intravenosa lenta em 60 min	Dose única.
Difteria Grave / Maligna / Extensa (IV)	80.000 a 100.000 UI (8 a 10 frascos) em infusão IV lenta de 60 a 120 min	Neutraliza apenas a toxina livre circulante; iniciar imediatamente.

Contraindicações, restrições e monitorização

Emergência: Sem contraindicações na suspeita clínica de difteria.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

367. Soro antielapídico (bivalente)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável heteróloga frasco-ampola 10 mL

Indicações e Linha de Tratamento

Imunoglobulina equina neutralizante do veneno de serpentes do gênero *Micrurus* (coral verdadeira - veneno neurotóxico pré-sináptico e pós-sináptico). Primeira linha no Envenenamento Elapídico.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Acidente Elapídico (Qualquer gravidade é considerada potencialmente grave) (IV)	10 frascos-ampola IV administrados em infusão lenta de 30 a 60 minutos diluído em SF0,9%.	Dose única imediata. Manter vigilância rigorosa para insuficiência respiratória por paralisia diafragmática.

Contraindicações, restrições e monitorização

Emergência: Sem contraindicações.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

368. Soro antiescorpiônico

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável heteróloga frasco-ampola 5 mL

Indicações e Linha de Tratamento

Imunoglobulina equina neutralizante do veneno de escorpiões do gênero *Tityus* (*Tityus serrulatus* / escorpião amarelo). Primeira linha mandatória no Envenenamento Escorpiônico Moderado e Grave em crianças (manifestações sistêmicas com vômitos profusos, sudorese, taquicardia/bradicardia, choque cardiogênico e edema agudo de pulmão).

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Escorpionismo Moderado (vômitos ocasionais, sudorese, taquicardia) (IV)	2 a 3 frascos-ampola IV em infusão lenta de 20 a 30 minutos diluído em SF0,9%	Dose idêntica para crianças e adultos.
Escorpionismo Grave (vômitos profusos incoercíveis, choque, arritmias, EAP) (IV)	4 a 6 frascos-ampola IV em infusão lenta imediata em 20 minutos diluído em SF0,9%	Dose imediata na emergência pediátrica.

Contraindicações, restrições e monitorização

Acidente Leve: Contraindicado o uso de soro no escorpionismo leve (apenas dor local e eritema), onde se indica apenas bloqueio anestésico local e analgesia simples.

Emergência Moderada/Grave: Sem contraindicações no acidente sistêmico.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

369. Soro antilaquético

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável heteróloga frasco-ampola 10 mL

Indicações e Linha de Tratamento

Imunoglobulina equina neutralizante do veneno de serpentes do gênero Lachesis (surucucu-pico-de-jaca - veneno proteolítico, hemorrágico, coagulante e vagal com bradicardia e diarreia profusa). Primeira linha no Envenenamento Laquético.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Acidente Laquético Moderado a Grave (IV)	10 a 20 frascos-ampola IV em infusão lenta em 30 a 60 minutos diluído em SF0,9%	Dose única hospitalar.

Contraindicações, restrições e monitorização

Emergência: Sem contraindicações.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

370. Soro antitetânico

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável heteróloga frasco-ampola 5 mL (5.000 UI)

Indicações e Linha de Tratamento

Imunoglobulina heteróloga equina contra a toxina tetânica. Indicada na profilaxia do tétano em ferimentos graves de alto risco e tratamento do Tétano Acidental quando a imunoglobulina humana antitetânica (IGHAT) não está disponível.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Profilaxia Pós-Exposição (IM)	5.000 UI IM em dose única em sítio diferente do toxoide tetânico	Uso profilático.
Tratamento do Tétano Acidental Clínico (IV/IM)	10.000 a 20.000 UI dividido em infusão IV lenta e intramuscular	Hospitalar

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Preferir sempre a Imunoglobulina Humana (IGHAT) por menor risco de choque anafilático e doença do soro.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

371. Succinato de metoprolol

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos de liberação prolongada 25 mg, 50 mg e 100 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Betabloqueador seletivo beta-1 de liberação osmótica prolongada com níveis plasmáticos constantes por 24 horas. Primeira linha no tratamento crônico da Insuficiência Cardíaca Pediátrica estável e Hipertensão Arterial a partir de 6 anos.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Hipertensão Arterial e Insuficiência Cardíaca (VO)	Inicial: 0,5 a 1,0 mg/kg/dia uma vez ao dia pela manhã. Titular gradualmente a cada 1 a 2 semanas até dose alvo de 2 mg/kg/dia (Máx: 200 mg/dia).	Tomar pela manhã; o comprimido pode ser partido na ranhura, mas NUNCA mastigado ou triturado.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Insuficiência cardíaca descompensada aguda, bradicardia sinusal, bloqueio AV de 2º/3º grau e choque cardiogênico.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

372. Succinilcolina (Cloreto de suxametônio)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó liofilizado para solução injetável frasco-ampola 100 mg e 500 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Bloqueador neuromuscular despolarizante de início ultrarrápido (30 a 45 segundos) e curtíssima duração (4 a 6 minutos). Agente clássico para Sequência Rápida de Intubação (SRI) em vias aéreas difíceis na emergência pediátrica sob critérios de segurança rigorosos.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Sequência Rápida de Intubação (SRI) (IV)	Lactentes < 1 ano: 2 mg/kg em bolus IV rápido. Crianças ≥ 1 ano e Adolescentes: 1 a 1,5 mg/kg em bolus IV rápido.	Em crianças menores de 1 ano, SEMPRE pré-medicação com Atropina (0,02 mg/kg; min 0,1 mg) para prevenir bradicardia sinusal grave e assistolia vagal reflexa.

Contraindicações, restrições e monitorização

PARADA CARDÍACA POR HIPERCALEMIA FULMINANTE: Black box warning para hipercalemia maciça fatal em crianças com miopatias não diagnosticadas (Distrofia Muscular de Duchenne), queimaduras > 24-48h, grandes traumas por esmagamento, desnervação e lesões medulares. Preferir Rocurônio na emergência pediátrica.

HIPERTERMIA MALIGNA: Principal gatilho farmacológico conhecido.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

373. Sucralfato

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Suspensão oral 200 mg/mL (1 g/5 mL)

Comprimidos mastigáveis 1 g

Indicações e Linha de Tratamento

Complexo de hidróxido de alumínio e sacarose sulfatada que se liga a proteínas exsudativas em lesões ulceradas formando barreira física protetora contra ácido e pepsina. Indicado no tratamento de úlceras gástricas/duodenais, mucosite oral induzida por quimioterapia e profilaxia de úlcera de estresse.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Úlcera Péptica / Doença Erosiva (VO)	Crianças: 40 a 80 mg/kg/dia dividido a cada 6 horas (1 hora antes das refeições e ao deitar; Máx: 4 g/dia). Adolescentes: 1 g 4 vezes ao dia.	Administrar em jejum com o estômago vazio.
Mucosite Oral por Quimioterapia (Tópico Oral / Bochecho)	Bochechar 5 mL da suspensão por 2 minutos e cuspir (ou engolir) 4 vezes ao dia	Ação protetora tópica

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Insuficiência renal grave (risco de acúmulo e intoxicação por alumínio).

Interações: Reduz a absorção de outros medicamentos administrados por via oral (espaçar em 2 horas).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

374. Sufentanila (citrato)

Auditoria documental Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável 5 mcg/mL (ampolas 2 mL = 10 mcg e 5 mL = 25 mcg) e 50 mcg/mL (ampolas 1 mL = 50 mcg e 5 mL = 250 mcg)

Indicações e Linha de Tratamento

Opioide sintético ultralipofílico de altíssima potência (5 a 10 vezes mais potente que a fentanila e 500 a 1000 vezes mais que a morfina) com excelente estabilidade hemodinâmica. Primeira linha na anestesia geral para cirurgia cardíaca congênita pediátrica de alta complexidade e analgesia epidural/caudal.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Anestesia Cirúrgica Cardíaca Pediátrica (IV)	Indução e Manutenção: 0,5 a 2 mcg/kg em bolus lento sob ventilação mecânica controlada (doses até 5 a 10 mcg/kg em cirurgias cardíacas de grande porte).	Infusão intravenosa lenta exclusiva por anesthesiologista.

Contraindicações, restrições e monitorização

Rigidez Torácica e Apneia: Alto risco de rigidez torácica e depressão respiratória profunda em injeção rápida.

Condições: Ausência de suporte ventilatório avançado.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

375. Sugamadex

Auditoria documental Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável 100 mg/mL (frasco-ampola 2 mL = 200 mg e 5 mL = 500 mg)

Indicações e Linha de Tratamento

Ciclodextrina gama modificada quelante seletiva que encapsula e inativa irreversivelmente os bloqueadores neuromusculares aminosteroides (rocurônio e vecurônio). Primeira linha padrão-ouro para Reversão Imediata do Bloqueio Neuromuscular induzido por Rocurônio (rotina e resgate na via aérea difícil 'não intubo, não ventilo') a partir de 2 anos (ou recém-nascidos sob protocolo).

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Reversão de Rotina do Rocurônio pós-cirurgia (IV)	Reaparecimento de T2 no TOF (bloqueio moderado): 2 mg/kg em bolus IV rápido em 10 segundos. Reaparecimento de 1-2 respostas pós-tetânicas (bloqueio profundo): 4 mg/kg em bolus IV rápido.	Recuperação completa da função neuromuscular e respiração espontânea em 2 a 3 minutos.
Reversão Imediata de Resgate ('Não Intubo, Não Ventilo') (IV)	16 mg/kg em bolus IV rápido imediato (administrado 3 minutos após dose de 1,2 mg/kg de rocurônio)	Reverte o relaxamento muscular em aprox. 90 segundos.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Insuficiência renal terminal (CICr < 30 mL/min) e hipersensibilidade ao sugamadex.

Inespecificidade: Ineficaz contra bloqueadores benzilisoquinolínicos (cisatracúrio, atracúrio).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

376. Sulfadiazina

Auditoria documental Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos 500 mg

Suspensão oral 500 mg/5 mL

Indicações e Linha de Tratamento

Sulfonamida sintética bacteriostática inibidora da di-hidropteroato sintase. Primeira linha padrão-ouro no Esquema Clássico do Ministério da Saúde para o Tratamento da Toxoplasmose Congênita no recém-nascido e lactente (associada obrigatoriamente a Pirimetamina e Ácido Folínico por 12 meses) e profilaxia secundária de febre reumática.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Toxoplasmose Congênita — Protocolo MS / SBP (VO por 12 meses)	100 mg/kg/dia dividido a cada 12 horas (50 mg/kg/dose a cada 12h) durante todo o primeiro ano de vida (12 meses).	Administrado obrigatoriamente associado a Pirimetamina (1 mg/kg/dia) e Ácido Folínico (5 a 10 mg 3x/semana). Garantir hidratação abundante para prevenir cristalúria.

Contraindicações, restrições e monitorização

KERNICTERUS NEONATAL: Contraindicada em neonatos nas primeiras 2 a 4 semanas de vida se icterícia/hiperbilirrubinemia não controlada (desloca a bilirrubina da albumina).

Condições: Deficiência de G6PD (risco de crise hemolítica grave), hipersensibilidade a sulfas e insuficiência renal grave.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

377. Sulfadiazina de prata

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Creme dermatológico 10 mg/g (1%)

Indicações e Linha de Tratamento

Antimicrobiano tópico de amplo espectro contendo prata iônica com potente atividade contra Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus. Primeira linha na prevenção e tratamento de infecções em Queimaduras de 2º e 3º grau e úlceras cutâneas em crianças ≥ 2 meses.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Queimaduras de 2º e 3º Grau (Tópico)	Aplicar camada estéril de 1 a 2 mm de espessura sobre as áreas queimadas 1 a 2 vezes ao dia após limpeza e debridamento cuidadosa.	Cobrir com curativo oclusivo estéril ou manter técnica aberta conforme protocolo de queimados.

Contraindicações, restrições e monitorização

Idade: ESTRITAMENTE CONTRAINDICADA EM NEONATOS E LACTENTES MENORES DE 2 MESES DE VIDA devido ao risco de absorção sistêmica de sulfá e Kernicterus neonatal.

Condições: Deficiência de G6PD e hipersensibilidade a sulfonamidas.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

378. Sulfametoxazol + Trimetoprima (Co-trimoxazol)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Suspensão oral pediátrica 200+40 mg/5 mL (proporção 5:1)

Suspensão oral forte 400+80 mg/5 mL

Comprimidos 400+80 mg e 800+160 mg (Forte)

Solução para infusão IV 400+80 mg (ampola 5 mL)

Indicações e Linha de Tratamento

Associação sinérgica bactericida de sulfonamida com inibidor da di-hidrofolato redutase. Primeira linha padrão-ouro no Tratamento e Profilaxia da Pneumonia por Pneumocystis jirovecii (PCP) em pacientes imunodeprimidos/HIV, infecções cutâneas e osteoarticulares por CA-MRSA comunitário, Isosporíase e infecções urinárias suscetíveis.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Tratamento de Pneumocistose (PCP) (IV/VO)	Cálculo baseado no Trimetoprima (TMP): 15 a 20 mg de TMP/kg/dia (com 75 a 100 mg de SMX/kg/dia) dividido a cada 6 ou 8 horas por 21 dias consecutivos.	Infundir IV lentamente em 60 a 90 minutos (cada ampola de 5 mL diluída em pelo menos 75 a 125 mL de SG5%).
Quimioprofilaxia de PCP em Imunodeprimidos / HIV (VO)	5 mg de TMP/kg/dia (com 25 mg de SMX/kg/dia) em dose única diária por 3 dias na semana (ex: seg, qua, sex) ou diariamente.	Dose única diária
Infecções Bacterianas Gerais / CA-MRSA / ITU (VO)	8 a 10 mg de TMP/kg/dia dividido a cada 12 horas por 7 a 14 dias (Máx: 320 mg TMP/dia)	Dividido a cada 12 horas

Contraindicações, restrições e monitorização

CONTRAINDICAÇÃO NEONATAL ABSOLUTA: Contraindicado em menores de 6 semanas (1,5 mês) de vida devido ao deslocamento de bilirrubina da albumina e risco de Kernicterus.

Condições: Deficiência grave de G6PD (risco de crise hemolítica maciça) e histórico de Síndrome de Stevens-Johnson / DRESS por sulfas.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

379. Sulfassalazina

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos gastroresistentes 500 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Pró-fármaco que combina sulfapiridina e ácido 5-aminossalicílico (5-ASA) clivado pelas bactérias colônicas. Primeira linha no tratamento da Artrite Idiopática Juvenil (AIJ) com acometimento oligoarticular estendido ou poliarticular e Doença Inflamatória Intestinal (Retocolite Ulcerativa) a partir de 2 anos.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Artrite Idiopática Juvenil / Retocolite Ulcerativa (VO)	Inicial: 10 a 15 mg/kg/dia dividido a cada 12 horas. Titular semanalmente até dose de manutenção de 30 a 50 mg/kg/dia (Máx: 2 a 3 g/dia).	Administrar junto com as refeições; ingerir os comprimidos inteiros sem mastigar com copo cheio de água.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipersensibilidade a sulfonamidas ou salicilatos, obstrução intestinal/urinária e porfíria.

Monitorização: Hemograma e transaminases a cada 2 semanas nos primeiros 3 meses.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

380. Sulfato de magnésio

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável concentrada 10% (100 mg/mL = 0,8 mEq Mg/mL) e 50% (500 mg/mL = 0,5 g/mL = 4 mEq Mg/mL, ampolas 10 mL = 5 g)

Indicações e Linha de Tratamento

Eletrólito essencial com ação broncodilatadora sobre a musculatura lisa brônquica por bloqueio dos canais de cálcio e antiarrítmico de membrana. Primeira linha na Crise Asmática Grave Aguda refratária na emergência pediátrica, Torsades de Pointes / Hipomagnesemia sintomática e Eclâmpsia em adolescentes.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Crise Asmática Grave Aguda na Emergência (IV)	40 a 50 mg/kg (Máx: 2000 mg = 2 g) infundido em 20 a 30 minutos diluído em SF0,9% ou SG5% sob monitorização contínua de PA e oximetria.	Promove broncodilatação rápida e reduz necessidade de intubação traqueal.
Torsades de Pointes / Hipomagnesemia Grave (IV/IO)	25 a 50 mg/kg (Máx: 2 g) em bolus IV lento em 10 a 20 minutos (em PCR infundir em 2 a 5 minutos).	Monitorar ECG continuamente.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Bloqueio atrioventricular total, miastenia gravis e insuficiência renal anúrica grave.

Toxicidade por Hipermagnesemia: Sinais de sobredosagem incluem perda precoce dos reflexos osteotendíneos profundos (patelar), hipotensão e depressão respiratória (antídoto imediato: Gluconato de Cálcio 10% IV).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

381. Sulfato de zinco / Bisglicinato de zinco

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Gotas 2 mg/gota e 4 mg/mL de zinco elementar

Xarope/solução oral 10 mg/mL e 20 mg/5 mL de zinco elementar

Comprimidos dispersíveis 10 mg e 20 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Oligoelemento essencial cofator de centenas de enzimas metabólicas e mediador de integridade da mucosa intestinal e imunidade celular. Primeira linha obrigatória do Ministério da Saúde e OMS no Tratamento da Doença Diarreica Aguda (reduz gravidade, duração e previne novos episódios nos 3 meses seguintes) e Acrodermatite Enteropática.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Tratamento da Diarreia Aguda — Protocolo Ministério da Saúde / OMS (VO)	Lactentes < 6 meses: 10 mg de zinco elementar uma vez ao dia por 10 a 14 dias consecutivos. Crianças de 6 meses a 5 anos: 20 mg de zinco elementar uma vez ao dia por 10 a 14 dias consecutivos.	Administrar o curso completo de 10 a 14 dias mesmo após a cessação da diarreia para restauração epitelial completa.
Acrodermatite Enteropática (VO)	1 a 3 mg/kg/dia de zinco elementar em dose única diária contínua	Dose terapêutica

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

Tolerabilidade: Administrar afastado das refeições ricas em fitatos; se causar náusea, administrar com pequena porção de alimento.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

382. Sulfato ferroso

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Gotas 125 mg/mL (25 mg de ferro elementar/mL - aprox. 1,25 mg de ferro elementar por gota; 20 gotas = 25 mg)

Xarope 250 mg/5 mL (50 mg de ferro elementar/5 mL = 10 mg/mL)

Comprimidos revestidos 200 mg (40 mg de ferro elementar) e 300 mg (60 mg de ferro elementar)

Indicações e Linha de Tratamento

Sal inorgânico de ferro bivalente solúvel padrão do Sistema Único de Saúde (SUS). Primeira linha clássica para Suplementação Profilática e Tratamento da Anemia Ferropriva na infância (Diretrizes SBP e Ministério da Saúde).

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Profilaxia da Anemia Ferropriva (SBP / MS) (VO)	Lactentes a termo em AME ou fórmula: 1 mg de ferro elementar/kg/dia a partir dos 3 a 6 meses de vida até 24 meses. Prematuros < 1500g: 3 a 4 mg/kg/dia a partir do 30º dia de vida por 1 ano.	Administrar preferencialmente 30 a 60 minutos antes do almoço ou jantar com suco cítrico (vitamina C).
Tratamento da Anemia Ferropriva Confirmada (VO)	3 a 5 mg de ferro elementar/kg/dia dividido em 1 a 2 tomadas por 3 a 6 meses consecutivos.	Manter por 2 a 3 meses após a normalização da hemoglobina para reposição dos estoques medulares de ferritina.

Contraindicações, restrições e monitorização

Interações e Administração: NÃO administrar com leite materno, fórmulas infantis, derivados do leite, chá ou antiácidos (o cálcio inibe a absorção do ferro bivalente).

Efeitos: Fezes escuras benignas, náuseas, constipação/diarreia e pigmentação dentária transitória (prevenida administrando no fundo da boca e escovando os dentes pós-dose).

Condições: Anemias não ferroprivas e hemocromatose.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

383. Sulpirida

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Cápsulas 50 mg

Comprimidos 200 mg

Solução oral

Indicações e Linha de Tratamento

Antipsicótico benzamídico antagonista seletivo dos receptores dopaminérgicos D2 e D3. Indicada no tratamento de distúrbios graves do comportamento com agitação e impulsividade em crianças ≥ 6 anos e Síndrome de Tourette.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Distúrbios de Conduta / Tiques Graves (VO)	Crianças ≥ 6 anos: 5 a 10 mg/kg/dia dividido a cada 8 ou 12 horas (Dose inicial habitual: 50 a 100 mg/dia).	Dividido a cada 12 horas

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Feocromocitoma, prolactinoma, tumores dependentes de prolactina e menores de 6 anos.

Efeitos: Hiperprolactinemia e sintomas extrapiramidais.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

384. Tacrolimo

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pomada dermatológica 0,03% (pediátrica para ≥ 2 anos) e 0,1%

Cápsulas 0,5 mg, 1 mg e 5 mg

Solução injetável 5 mg/mL

Indicações e Linha de Tratamento

Imunossupressor inibidor da calcineurina da classe dos macrolídeos. Primeira linha na prevenção e tratamento de rejeição em transplantes de órgãos sólidos pediátricos (fígado, rim, coração) e pomada a 0,03% de primeira linha no controle de crises e terapia proativa na Dermatite Atópica moderada a grave em face, pescoço e dobras em crianças ≥ 2 anos.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Dermatite Atópica Moderada a Grave — Pomada 0,03% (Tópico)	Fase de Crise: Aplicar fina camada sobre as lesões 2 vezes ao dia até cicatrização completa. Manutenção Proativa: Aplicar 2 vezes por semana nas áreas habitualmente afetadas para prevenir recidivas.	Não ocluir a área tratada; sensação transitória de queimação/ardência nos primeiros dias de aplicação é comum e autolimitada.
Pós-Transplante de Órgãos — Manutenção (VO)	Inicial: 0,15 a 0,3 mg/kg/dia dividido a cada 12 horas em jejum. Titular estritamente para manter nível sérico de vale alvo (C0: 5 a 15 ng/mL).	Dose a cada 12 horas no mesmo horário.

Contraindicações, restrições e monitorização

Nefrotoxicidade e Neurotoxicidade: Monitorar função renal, PA e níveis séricos rigorosamente na terapia sistêmica.

Tópico: Contraindicado em menores de 2 anos, infecções virais ativas na pele (eczema herpético) e Síndrome de Netherton.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

385. Tadalafila

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos revestidos 5 mg e 20 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Inibidor potente e seletivo da fosfodiesterase tipo 5 (PDE-5) de longa meia-vida (~17,5 horas). Indicada no tratamento da Hipertensão Arterial Pulmonar (HAP) em crianças e adolescentes com a conveniência de posologia diária única.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Hipertensão Arterial Pulmonar Pediátrica (VO)	Peso < 25 kg: 1 mg/kg em dose única diária (Máx: 20 mg/dia). Peso 25 a 40 kg: 20 mg uma vez ao dia. Peso > 40 kg: 40 mg uma vez ao dia.	Dose única diária matinal com ou sem alimentos.

Contraindicações, restrições e monitorização

COADMINISTRAÇÃO DE NITRATOS: Estritamente contraindicada com qualquer doador de óxido nítrico ou nitrato (risco fatal de hipotensão grave).

Condições: Insuficiência hepática grave.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

386. Teicoplanina

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó liofilizado para solução injetável frasco-ampola 200 mg e 400 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Antimicrobiano glicopeptídeo bactericida de longa meia-vida contra bactérias Gram-positivas multirresistentes. Primeira linha no tratamento de infecções hospitalares graves causadas por *Staphylococcus aureus* resistente à metilicina (MRSA) e *Enterococcus faecalis* sensível com menor taxa de nefrotoxicidade e sem necessidade de infusão prolongada.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Infecções Graves por MRSA / Sepse / Osteomielite (IV/IM)	Doses de Carga (Primeiras 3 doses a cada 12 horas): 10 a 12 mg/kg/dose a cada 12 horas por 3 doses. Manutenção: 10 a 12 mg/kg uma vez ao dia (a cada 24 horas; Máx: 800 mg/dia).	Injeção em bolus IV lento em 3 a 5 minutos ou IM profunda.
Neonatos (IV)	Carga: 16 mg/kg em dose única. Manutenção: 8 mg/kg uma vez ao dia.	Dose única diária

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipersensibilidade a glicopeptídeos.

Vantagem: Menor nefrotoxicidade que a vancomicina e não causa a Síndrome do Homem Vermelho.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

387. Teofilina

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Cápsulas de liberação prolongada 100 mg, 200 mg e 300 mg

Xarope 50 mg/5 mL

Indicações e Linha de Tratamento

Metilxantina broncodilatadora oral. Indicada como terapia adjuvante de manutenção na Asma Crônica Grave refratária e controle de apneia sob estrita monitorização dos níveis séricos.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Asma Crônica de Difícil Controle (VO)	Inicial: 10 mg/kg/dia dividido a cada 8 a 12 horas. Titular gradualmente até dose de manutenção de 10 a 16 mg/kg/dia (Máx: 400 a 600 mg/dia).	Nível sérico terapêutico alvo estreito: 5 a 15 mcg/mL.

Contraindicações, restrições e monitorização

Janela Terapêutica Estreita: Risco de taquiarritmias ventriculares, vômitos incoercíveis e convulsões intratáveis se nível sérico > 20 mcg/mL.

Condições: Úlcera péptica ativa e arritmias cardíacas.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

388. Terbinafina (cloridrato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Creme dermatológico 10 mg/g (1%)

Comprimidos 125 mg e 250 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Antifúngico alilamina fungicida inibidor da esqualeno epoxidase. Primeira linha padrão-ouro no tratamento da Tinea Capitis por Trichophyton tonsurans, Onicomicose infantil e tinea corporais extensas em crianças ≥ 2 anos.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Tinea Capitis por Trichophyton (VO)	Peso < 20 kg: 62,5 mg (1/2 comprimido de 125 mg) uma vez ao dia por 4 a 6 semanas. Peso 20 a 40 kg: 125 mg uma vez ao dia por 4 a 6 semanas. Peso > 40 kg: 250 mg uma vez ao dia por 4 a 6 semanas.	Tomar uma vez ao dia com alimentos.
Onicomicose Pediátrica (VO)	Mesmas doses por peso durante 6 semanas para unhas das mãos e 12 semanas para unhas dos pés	Tratamento prolongado
Tinea Corporis / Cruris / Pedis (Creme Tópico)	Aplicar sobre as lesões 1 a 2 vezes ao dia por 1 a 2 semanas	Uso tópico

Contraindicações, restrições e monitorização

Hepatotoxicidade: Black box warning para disfunção hepática grave; dosar transaminases basais antes de iniciar terapia oral.

Condições: Doença hepática ativa ou crônica grave e insuficiência renal severa (ClCr < 50 mL/min).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

389. Terbutalina (sulfato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Xarope 0,3 mg/mL (1,5 mg/5 mL)

Solução injetável 0,5 mg/mL (ampola 1 mL)

Pó para inalação Turbuhaler 0,5 mg/dose

Indicações e Linha de Tratamento

Agonista seletivo beta-2 adrenérgico parenteral e inalatório. Primeira linha na Crise Asmática Grave Aguda Refratária com falha de resposta à via inalatória na emergência e UTI pediátrica via subcutânea ou infusão intravenosa contínua.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Crise Asmática Grave Refratária — Via Subcutânea (SC)	0,005 a 0,01 mg/kg/dose (5 a 10 mcg/kg; Máx: 0,25 a 0,4 mg) a cada 15 a 20 minutos por até 3 doses consecutivas.	Injeção SC no deltoide na emergência.
Infusão Intravenosa Contínua em UTI Pediátrica (IV)	Carga: 2 a 10 mcg/kg em 10 minutos. Manutenção contínua: 0,1 a 4 mcg/kg/minuto em bomba dedicada sob monitorização contínua de ECG e potássio sérico.	Titular por escore de desconforto respiratório.

Contraindicações, restrições e monitorização

Cardiotoxicidade: Risco de taquicardia sinusal intensa, arritmias miocárdicas, hipocalemia grave e isquemia miocárdica em doses elevadas.

Condições: Cardiopatias congênitas com obstrução de via de saída ventricular.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

390. Tiabendazol

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Suspensão oral 500 mg/5 mL

Comprimidos 500 mg

Pomada/loção tópica 50 mg/g (5%)

Indicações e Linha de Tratamento

Anti-helmíntico benzimidazol. Primeira linha no tratamento tópico da Larva Migrans Cutânea (bicho geográfico) localizada e tratamento oral em infecções extensas ou Larva Migrans Visceral (Toxocaríase).

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Larva Migrans Cutânea — Tratamento Tópico (Tópico)	Aplicar a pomada/loção a 5% sobre a lesão e trajeto serpiginoso 3 vezes ao dia por 10 a 14 dias	Tratamento de escolha sem efeitos sistêmicos.
Toxocaríase / Infecções Sistêmicas (VO)	25 a 50 mg/kg/dia dividido a cada 12 horas por 5 a 7 dias (Máx: 3 g/dia)	Administrar após as refeições.

Contraindicações, restrições e monitorização

Efeitos Sistêmicos: Alta frequência de náuseas, vômitos, tontura e odor urinário característico semelhante a aspargos.

Condições: Insuficiência hepática ou renal grave.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

391. Tiamazol (Metimazol)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos 5 mg, 10 mg e 20 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Antitireoídico tionamida inibidor da tireoperoxidase. Primeira linha padrão-ouro absoluta no tratamento farmacológico de manutenção do Hipertireoidismo (Doença de Graves) na infância e adolescência.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Doença de Graves / Hipertireoidismo Pediátrico (VO)	Inicial: 0,4 a 0,7 mg/kg/dia (titular até 1 mg/kg/dia em hipertireoidismo grave; Máx: 30 a 60 mg/dia) em dose única diária ou dividido a cada 12 horas por 4 a 8 semanas até eutireoidismo.	Dose de Manutenção: Reduzir para 0,2 a 0,4 mg/kg/dia em dose única diária.

Contraindicações, restrições e monitorização

Agranulocitose: Risco raro de agranulocitose fulminante imunomediada (orientar pais a suspender IMEDIATAMENTE e realizar hemograma urgente se surgirem febre ou odinofagia).

Condições: Neutropenia grave prévia e hepatopatia.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

392. Tiamina (Vitamina B1)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos 100 mg e 300 mg

Solução injetável 100 mg/mL (ampola 1 mL)

Indicações e Linha de Tratamento

Cofator da piruvato desidrogenase e transcetolase essencial no metabolismo glicídico aeróbico neuronal. Primeira linha no tratamento e prevenção do Beribéri cardíaco/neurológico infantil, Encefalopatia de Wernicke e suporte em acidose láctica congênita.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Beribéri Grave / Encefalopatia de Wernicke Pediátrica (IV/IM)	10 a 50 mg/dia (até 100 mg em adolescentes) em injeção IV lenta em 15 minutos por 3 a 7 dias consecutivos, seguido de manutenção oral com 10 a 50 mg/dia.	Administrar OBRIGATORIAMENTE ANTES de qualquer infusão de soluções glicosadas para evitar precipitação aguda de acidose láctica e deterioração neurológica irreversível.

Contraindicações, restrições e monitorização

Via IV: Risco de anafilaxia em injeção intravenosa rápida direta sem diluição.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

393. Tiaprida (cloridrato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos 100 mg

Solução injetável 100 mg/2 mL

Indicações e Linha de Tratamento

Antipsicótico benzamídico atípico antagonista seletivo dos receptores dopaminérgicos D2/D3 estriatais e límbicos. Indicado no controle de tiques motores e vocais na Síndrome de Tourette e distúrbios graves do comportamento com agitação em crianças ≥ 6 anos.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Síndrome de Tourette / Distúrbios de Conduta (VO)	Crianças ≥ 6 anos: 3 a 6 mg/kg/dia (Inicial: 50 a 100 mg/dia dividido a cada 8 a 12 horas; titular até máx 300 mg/dia).	Dividido em 2 a 3 tomadas diárias.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Feocromocitoma e tumores prolactino-dependentes.

Idade: Não recomendado para menores de 6 anos.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

394. Tigeciclina

Auditoria documental Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó liofilizado para solução injetável frasco-ampola 50 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Antimicrobiano glicilciclina bactericida/bacteriostático de amplo espectro que supera mecanismos de efluxo e proteção ribossômica. Indicada em infecções intra-abdominais complicadas e infecções complexas de pele por bactérias multirresistentes (*Acinetobacter baumannii*, KPC, MRSA, VRE) em crianças ≥ 8 anos.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Infecções Graves por Bactérias Multirresistentes — Crianças de 8 a 11 anos (IV)	1,2 mg/kg/dose a cada 12 horas em infusão lenta de 30 a 60 minutos (Máx: 50 mg a cada 12h).	Infusão intravenosa lenta.
Adolescentes ≥ 12 anos (IV)	Ataque: 100 mg no Dia 1. Manutenção: 50 mg a cada 12 horas.	Infusão em 60 min.

Contraindicações, restrições e monitorização

Black Box Warning de Mortalidade: Aumento da mortalidade por todas as causas em ensaios clínicos; reservar para situações de extrema necessidade sem alternativas.

Idade: Contraindicada para menores de 8 anos (pigmentação dentária e alteração óssea).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

395. Timolol (maleato)

Auditoria documental Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução oftálmica/colírio 0,25% e 0,5%

Gel oftálmico 0,1%

Indicações e Linha de Tratamento

Betabloqueador não seletivo de uso tópico ocular que reduz a produção de humor aquoso. Primeira linha no tratamento do Glaucoma Pediátrico primário e secundário sob controle oftalmológico.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Glaucoma Pediátrico (Oftálmico)	1 gota da solução a 0,25% no olho afetado 1 a 2 vezes ao dia	Oclusão do ponto lacrimal por 2 minutos imediatamente após a instilação para prevenir absorção sistêmica.

Contraindicações, restrições e monitorização

EFEITOS SISTÊMICOS GRAVES EM LACTENTES: A absorção sistêmica pode causar bradicardia severa, bloqueio AV, hipotensão e broncoespasmo grave com apneia.

Condições: Asma brônquica, bronquite asmática e bloqueio cardíaco.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

396. Tinidazol

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos revestidos 500 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Antiparasitário nitroimidazólico de segunda geração com excelente penetração tecidual e menor incidência de náuseas que o metronidazol. Primeira linha no tratamento de Giardíase, Amebíase intestinal/hepática e Tricomoníase em crianças ≥ 3 anos.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Giardíase e Amebíase Intestinal — Crianças ≥ 3 anos (VO)	50 mg/kg em DOSE ÚNICA diária junto com alimentos por 1 a 3 dias (Máx: 2 g/dia)	Administrar com alimentos para reduzir sabor metálico e náuseas.

Contraindicações, restrições e monitorização

Idade: Não recomendado para menores de 3 anos.

Condições: Discrasias sanguíneas e hipersensibilidade a nitroimidazóis.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

397. Tobramicina

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução para inalação 300 mg/5 mL (ampola 5 mL)

Solução oftálmica/colírio 0,3%

Pomada oftálmica 0,3%

Solução injetável 75 mg/1,5 mL

Indicações e Linha de Tratamento

Antimicrobiano aminoglicosídeo com potente atividade bactericida antipseudomonas. Primeira linha na Erradicação e Tratamento da Infecção Pulmonar Crônica por Pseudomonas aeruginosa na Fibrose Cística em crianças ≥ 6 anos (via inalatória) e infecções oculares bacterianas.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Fibrose Cística com Colonização por P. aeruginosa (Inalatória)	300 mg (1 ampola de 5 mL) a cada 12 horas inalado em nebulizador específico por ciclos de 28 dias 'ON' seguidos de 28 dias 'OFF' (sem medicação).	Inalar imediatamente após a fisioterapia respiratória de desobstrução.
Conjuntivite Bacteriana (Oftálmico)	1 a 2 gotas a cada 4 a 6 horas por 5 a 7 dias	Uso tópico

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Hipersensibilidade a aminoglicosídeos.

Monitorização: Avaliar espirometria (risco de broncoespasmo pós-inalação) e função auditiva e renal.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

398. Tocoferol (Acetato de racealfatocoferol / Vitamina E)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Gotas 100 mg/mL e 400 mg/mL

Cápsulas gelatinosas 400 UI

Indicações e Linha de Tratamento

Vitamina lipossolúvel antioxidante essencial protetora de membranas celulares. Indicada na prevenção e tratamento da anemia hemolítica e retinopatia da prematuridade em recém-nascidos prematuros, e suplementação na Colestase Crônica e Fibrose Cística.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Prematuros e Recém-Nascidos de Baixo Peso (VO)	5 a 25 UI/dia (ou 10 a 25 mg/kg/dia) em dose única diária	Dose diária profilática
Colestase Crônica / Fibrose Cística (VO)	100 a 400 UI/dia (ou 15 a 25 UI/kg/dia)	Titular para manter relação vitamina E/lipídios séricos normal.

Contraindicações, restrições e monitorização

Enterocolite Necrosante: Doses excessivas em prematuros extremos associadas a risco aumentado de sepse tardia e enterocolite necrosante.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

399. Topiramato

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Cápsulas com microgrânulos (sprinkle) 15 mg e 25 mg

Comprimidos revestidos 25 mg, 50 mg, 100 mg e 200 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Antiepiléptico de múltiplos mecanismos (bloqueio de canais de sódio, potencialização de GABA, antagonismo de receptores AMPA/kainato e inibição fraca da anidrase carbônica). Primeira linha na Profilaxia da Enxaqueca Crônica na infância e adolescência (≥ 6 a 12 anos), Síndrome de Lennox-Gastaut, crises focais e generalizadas refratárias e Síndrome de West.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Profilaxia de Enxaqueca — Crianças ≥ 6 a 12 anos (VO)	Inicial: 0,5 a 1 mg/kg/dia (ou 15 a 25 mg) ao deitar. Titular a cada 1 a 2 semanas até dose alvo de 2 a 3 mg/kg/dia (Máx: 100 mg/dia dividido em 2 tomadas).	Dose noturna ou a cada 12 horas com bastante água.
Epilepsia Pediátrica (VO)	Inicial: 1 a 3 mg/kg/dia ao deitar. Titular gradualmente até dose de manutenção de 5 a 9 mg/kg/dia (Máx: 400 mg/dia).	Dividido a cada 12 horas. As cápsulas sprinkle podem ser abertas e polvilhadas sobre alimento pastoso sem mastigar.

Contraindicações, restrições e monitorização

ANIDROSE E HIPERtermia: Inibe a sudorese (hipoidrose/anidrose) em crianças pequenas com alto risco de hipertermia e insolação em dias quentes (garantir hidratação abundante e evitar exposição ao calor excessivo).

Nefrolitíase e Glaucoma: Risco de litíase renal por cálculo de fosfato de cálcio e glaucoma agudo de ângulo fechado por efusão cílio-coroidal.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

400. Tramadol (cloridrato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Gotas 100 mg/mL (1 gota = 2,5 mg ou 1 gota = 5 mg conforme fabricante)

Cápsulas 50 mg

Comprimidos de liberação prolongada 50 mg e 100 mg

Solução injetável 50 mg/mL (ampolas 1 mL = 50 mg e 2 mL = 100 mg)

Indicações e Linha de Tratamento

Opióide atípico sintético com duplo mecanismo: agonista fraco dos receptores μ e inibidor da recaptação de serotonina e noradrenalina. Indicado no controle da Dor Moderada a Grave pós-operatória ou musculoesquelética em adolescentes a partir de 12 anos.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Dor Moderada a Grave — Adolescentes $\geq$ 12 anos (VO/IV/SC)	1 a 2 mg/kg/dose a cada 6 a 8 horas (Máx: 100 mg por dose e 400 mg/dia)	Infundir IV lentamente em pelo menos 15 a 20 minutos diluído em SF0,9% para reduzir náuseas e vômitos.

Contraindicações, restrições e monitorização

BLACK BOX WARNING — FDA / ANVISA EM MENORES DE 12 ANOS: ESTRITAMENTE CONTRAINDICADO PARA CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE, e em menores de 18 anos submetidos a tonsilectomia/adenoidectomia pelo risco fatal de depressão respiratória aguda imprevisível em metabolizadores ultrarrápidos do CYP2D6.

Condições: Epilepsia não controlada e uso concomitante de IMAO ou antidepressivos serotoninérgicos (risco de convulsões e Síndrome Serotoninérgica).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

401. Triancinolona acetona

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Spray nasal aquoso 55 mcg/dose

Pomada bucal/orabase 1 mg/g (0,1%)

Suspensão injetável intra-articular/IM 40 mg/mL (ampola 1 mL)

Indicações e Linha de Tratamento

Glicocorticoide sintético de média/alta potência. Primeira linha no alívio de Aftas e Úlceras Orais Dolorosas (pomada orabase), Rinite Alérgica a partir de 2 anos e infiltração intra-articular na Artrite Idiopática Juvenil oligoarticular.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Estomatite Aftosa / Úlceras Orais (Orabase Bucal)	Aplicar pequena quantidade sobre a afta sem friccionar (formando película protetora adesiva) 2 a 3 vezes ao dia após as refeições e ao deitar.	Uso tópico
Rinite Alérgica — Crianças de 2 a 11 anos (Spray Nasal)	1 jato (55 mcg) em cada narina uma vez ao dia (110 mcg/dia)	Dose única matinal
Infiltração Intra-articular na AIJ (Intra-articular)	Grandes articulações (joelho): 20 a 40 mg. Pequenas: 5 a 10 mg.	Procedimento especializado estéril.

Contraindicações, restrições e monitorização

Orabase: Contraindicada em lesões fúngicas (candidíase oral) e herpéticas ativas na mucosa oral.

Injeção IM: Não recomendada injeção IM rotineira em pediatria pelo risco de atrofia cutânea e supressão adrenal prolongada.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

402. Trimebutina (maleato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Suspensão oral 20 mg/mL

Comprimidos 200 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Modulador e regulador da motilidade gastrointestinal que atua como agonista periférico dos receptores encefalonérgicos intestinais (antiespasmódico e pró-cinético fisiológico). Indicada no tratamento da Síndrome do Intestino Irritável, dor abdominal funcional e cólicas intestinais em pediatria.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Dor Abdominal Funcional / Intestino Irritável (VO)	Crianças de 1 a 5 anos: 5 a 10 mg/kg/dia dividido em 3 tomadas (ou 1,5 a 3 mL da suspensão a cada 8h). Crianças de 6 a 12 anos: 100 a 200 mg/dia dividido a cada 8 a 12h. Adolescentes: 200 mg 2 a 3 vezes ao dia.	Administrar antes das principais refeições.

Contraindicações, restrições e monitorização

Idade: Não recomendada para menores de 1 ano.

Condições: Hipersensibilidade à trimebutina.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

403. Urapidil

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável 5 mg/mL (ampolas 5 mL = 25 mg e 10 mL = 50 mg)

Indicações e Linha de Tratamento

Anti-hipertensivo de ação dupla: bloqueador seletivo dos receptores alfa-1 adrenérgicos periféricos e agonista dos receptores 5-HT_{1A} centrais (previne taquicardia reflexa). Primeira linha na Emergência Hipertensiva pediátrica grave e controle pressórico no pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca e transplante renal.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Emergência Hipertensiva Pediátrica (IV)	Bolus Intermitente: 0,1 a 0,5 mg/kg em injeção IV lenta em 2 a 5 minutos. Infusão Contínua em UTI: 2 a 8 mcg/kg/minuto (0,1 a 0,5 mg/kg/hora) titulada conforme alvos de PA.	Infundir em bomba dedicada sob monitorização contínua de PA invasiva ou automática.

Contraindicações, restrições e monitorização

Condições: Estenose aórtica severa e fístula arteriovenosa (exceto fístula para hemodiálise em diálise crônica).

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

404. Valaciclovir (cloridrato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos revestidos 500 mg e 1000 mg

Indicações e Linha de Tratamento

L-valil éster pró-fármaco do aciclovir com biodisponibilidade oral de 55% (3 a 5 vezes superior ao aciclovir oral). Primeira linha no tratamento do Herpes Zoster, Herpes Genital e profilaxia de infecções por Citomegalovírus (CMV) pós-transplante em crianças ≥ 2 a 12 anos.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Varicela / Herpes Zoster — Crianças ≥ 2 anos (VO)	20 mg/kg/dose a cada 8 horas por 5 a 7 dias (Máx: 1000 mg por dose = 3000 mg/dia)	Iniciar nas primeiras 48h do início das lesões cutâneas.
Herpes Labial Recorrente em Adolescentes (VO)	2 g a cada 12 horas por 1 dia (Ciclo de 2 doses no Dia 1)	Iniciar aos primeiros pródromos.

Contraindicações, restrições e monitorização

PTT / SHU em Imunodeprimidos: Risco de Púrpura Trombocitopênica Trombótica / Síndrome Hemolítico-Urêmica em pacientes com HIV avançado ou pós-TMO em doses muito elevadas e prolongadas.

Ajustes: Reduzir a dose na insuficiência renal.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

405. Valganciclovir (cloridrato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó para solução oral 50 mg/mL

Comprimidos revestidos 450 mg

Indicações e Linha de Tratamento

L-valil éster pró-fármaco do ganciclovir oral com alta biodisponibilidade. Primeira linha padrão-ouro absoluta de consenso internacional para o Tratamento Prolongado do Citomegalovírus (CMV) Congênito Sintomático no recém-nascido e lactente (previne progressão da perda auditiva neurosensorial e melhora o neurodesenvolvimento) e profilaxia de CMV pós-transplante de órgãos.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
CMV Congênito Sintomático Neonatal / Lactentes (VO)	16 mg/kg/dose a cada 12 horas administrado por via oral com leite ou alimentos por um período total de 6 meses consecutivos.	Dose calculada rigorosamente pelo peso atualizado semanalmente. Administrar com as mamadas.
Profilaxia de CMV Pós-Transplante em Crianças (VO)	Dose diária calculada pela fórmula: Dose (mg) = 7 x Superfície Corpórea (m²) x Clearance de Creatinina de Schwartz (mL/min/1,73m²; Máx: 900 mg/dia).	Dose única diária com alimentos por 100 a 200 dias.

Contraindicações, restrições e monitorização

Mielossupressão Severa: Black box warning para neutropenia grave (ANC < 500/mm³), anemia e trombocitopenia. Hemograma completo a cada 1 a 2 semanas no primeiro mês e mensal a seguir.

Manuseio Seguro: Evitar contato direto da solução ou pó com a pele e mucosas.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

406. Vancomicina (cloridrato)

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó liofilizado para solução injetável frasco-ampola 500 mg e 1 g

Indicações e Linha de Tratamento

Antimicrobiano glicopeptídeo bactericida padrão-ouro contra Gram-positivos multirresistentes. Primeira linha absoluta para Meningite Bacteriana comunitária empírica (associada a ceftriaxona para cobertura de pneumococo resistente), Sepse Hospitalar grave, pneumonia nosocomial, osteomielite e infecções de corrente sanguínea por Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA) e infecções por cateter.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Infecções Sistêmicas Graves por MRSA / Sepse (IV)	Lactentes e Crianças: 45 a 60 mg/kg/dia dividido a cada 6 ou 8 horas (15 mg/kg/dose a cada 6h ou 8h; Máx: 2 a 4 g/dia).	Infundir OBRIGATORIAMENTE em pelo menos 60 minutos (ou velocidade ≤ 10 mg/minuto) diluído em SF0,9% ou SG5% (concentração máxima periférica: 5 mg/mL).
Meningite Bacteriana Aguda (IV)	60 mg/kg/dia dividido a cada 6 horas	Infundir em 60 min. Manter nível sérico de vale (vancomicinemia) entre 15 e 20 mcg/mL.
Colite Pseudomembranosa por C. difficile (VO)	40 mg/kg/dia da solução injetável administrada por via oral dividido a cada 6 horas por 10 a 14 dias (Máx: 500 mg/dia)	Não é absorvida via oral; ação luminal exclusiva.

Contraindicações, restrições e monitorização

SÍNDROME DO HOMEM VERMELHO (RED MAN SYNDROME): Reação anafilactoide mediada por liberação direta de histamina induzida por infusão rápida IV (< 60 min), com rubor facial/torácico intenso, prurido, hipotensão e broncoespasmo. Tratar diminuindo a velocidade de infusão para 90 a 120 minutos e diluindo a concentração.

Nefrotoxicidade e Ototoxicidade: Monitorar creatinina sérica e vancomicinemia de vale rigorosamente.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

407. Varfarina sódica

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos 1 mg, 2,5 mg e 5 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Anticoagulante oral antagonista da vitamina K (inibe a síntese hepática dos fatores II, VII, IX e X). Primeira linha na anticoagulação crônica de pacientes com Próteses Valvares Cardíacas Mecânicas, prevenção de tromboembolismo em circulação de Fontan, hipertensão pulmonar primária e trombofilias graves.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Anticoagulação Oral Pediátrica de Manutenção (VO)	Dose inicial de indução: 0,1 a 0,2 mg/kg uma vez ao dia (Máx inicial: 5 mg). Titular a cada 2 a 4 dias conforme o Índice Internacional Normalizado (RNI / INR): Alvo habitual de INR: 2,0 a 3,0 (ou 2,5 a 3,5 em próteses valvares mecânicas mitrais).	Administrar uma vez ao dia no mesmo horário (preferencialmente às 18h em jejum).

Contraindicações, restrições e monitorização

Hemorragia Grave: Black box warning para sangramentos maiores; monitorar INR regularmente (antídoto de reversão: Vitamina K1 e Complexo Protrombínico).

Condições: Diátese hemorrágica ativa, úlcera gastrointestinal sangrante e gravidez.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

408. Vasopressina

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Solução injetável 20 UI/mL (ampola 1 mL)

Indicações e Linha de Tratamento

Hormônio antidiurético exógeno potente agonista dos receptores V1a vasculares e V2 renais. Primeira linha no Choque Séptico Refratário a altas doses de catecolaminas (vasoplegia profunda), Parada Cardiorrespiratória refratária e Diabetes Insipidus Central agudo pós-neurocirurgia.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Choque Séptico Vasoplégico Refratário em UTI (IV/IO Contínuo)	0,0003 a 0,002 UI/kg/minuto (0,3 a 2 mUI/kg/min) em infusão contínua em bomba de seringa dedicada.	Diluição em SF0,9% por cateter venoso central sob monitorização hemodinâmica contínua.
Diabetes Insipidus Central Pós-Cirúrgico (IV Contínuo)	0,0005 a 0,002 UI/kg/hora em infusão contínua titulada	Titular por débito urinário e densidade urinária.

Contraindicações, restrições e monitorização

Isquemia Miocárdica e Mesentérica: Doses elevadas (> 0,002 UI/kg/min) podem causar vasoconstrição coronariana, isquemia esplâncnica e necrose isquêmica de extremidades.

Condições: Doença arterial coronariana e hiponatremia com hipervolemia.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

409. Verapamil (cloridrato)

Auditoria documental Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos revestidos 80 mg e 120 mg

Solução injetável 2,5 mg/mL (ampola 2 mL = 5 mg)

Indicações e Linha de Tratamento

Bloqueador dos canais de cálcio fenilalquilamínico de classe IV com potente ação dromotrópica e inotrópica negativa. Indicado no controle crônico de taquiarritmias supraventriculares e hipertensão arterial em crianças maiores de 1 ano.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Taquicardia Supraventricular em Crianças > 1 ano (IV de Exceção)	0,1 a 0,2 mg/kg (Máx: 5 mg) em infusão IV lenta em pelo menos 2 a 3 minutos sob monitorização contínua de ECG	Uso hospitalar estrito em maiores de 1 ano.
Tratamento Oral de Manutenção (VO)	4 a 8 mg/kg/dia dividido a cada 8 horas (Máx: 360 mg/dia)	Dividido a cada 8 horas com alimentos.

Contraindicações, restrições e monitorização

CONTRAINDICAÇÃO ABSOLUTA EM LACTENTES MENORES DE 1 ANO: ESTRITAMENTE CONTRAINDICADO POR VIA INTRAVENOSA EM MENORES DE 1 ANO DE IDADE devido ao alto risco fatal de colapso cardiovascular súbito, bradicardia intratável, choque cardiogênico refratário e parada cardíaca em assistolia por imaturidade do retículo sarcoplasmático neonatal.

Condições: Síndrome de Wolff-Parkinson-White com FA e insuficiência cardíaca descompensada.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

410. Vigabatrina

Auditoria documental Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Comprimidos 500 mg

Granulado/sachê para solução oral 500 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Inibidor irreversível da enzima GABA-transaminase (GABA-T) que aumenta expressivamente os níveis cerebrais de GABA. Primeira linha padrão-ouro absoluta no tratamento dos Espasmos Infantis (Síndrome de West) associados ao Complexo da Esclerose Tuberosa em lactentes.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Espasmos Infantis / Síndrome de West (VO)	Inicial: 50 mg/kg/dia dividido a cada 12 horas. Titular a cada 3 a 5 dias em incrementos de 25 a 50 mg/kg/dia até dose de manutenção de 100 a 150 mg/kg/dia (Máx: 150 mg/kg/dia ou 3000 mg/dia).	Dissolver o sachê em água ou leite. Efeito terapêutico avaliado por eletroencefalograma (desaparecimento da hipsarritmia).

Contraindicações, restrições e monitorização

PERDA DE CAMPO VISUAL IRREVERSÍVEL (RETINOTOXICIDADE): Black box warning para constrição concêntrica permanente do campo visual periférico em 30 a 40% dos pacientes em uso crônico. Avaliação oftalmológica com eletrorretinograma (ERG) basal e a cada 3 meses obrigatória.

Condições: Hipersensibilidade aos componentes.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

411. Voriconazol

Auditoria documental Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó para suspensão oral 40 mg/mL

Comprimidos revestidos 50 mg e 200 mg

Pó liofilizado para solução injetável IV 200 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Antifúngico triazólico de amplo espectro de segunda geração. Primeira linha padrão-ouro internacional no tratamento da Aspergilose Invasiva (*Aspergillus fumigatus*) e infecções fúngicas graves por *Scedosporium apiospermum* e *Fusarium* em crianças ≥ 2 anos.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Aspergilose Invasiva — Crianças de 2 a 11 anos e < 50 kg (IV)	Carga no Dia 1: 9 mg/kg a cada 12 horas por 2 doses. Manutenção: 8 mg/kg a cada 12 horas a partir do Dia 2 em infusão lenta de 1 a 2 horas.	Manter nível sérico de vale entre 1,5 e 5,5 mcg/mL.
Manutenção Oral — Crianças de 2 a 11 anos (VO)	9 mg/kg a cada 12 horas (Máx: 350 mg a cada 12h) em jejum (1h antes ou 1h após as refeições)	Tomar em jejum
Adolescentes ≥ 12 anos e Peso ≥ 50 kg (IV/VO)	IV: Carga 6 mg/kg a cada 12h no Dia 1, depois 4 mg/kg a cada 12h. VO: 200 mg a cada 12 horas.	Dose padrão do adulto

Contraindicações, restrições e monitorização

Toxicidade Visual e Fotossensibilidade: Distúrbios visuais transitórios reversíveis (fotopsias, visão borrada, alterações de cores) em 30% dos pacientes e fototoxicidade cutânea severa (usar protetor solar).

Interações e Cardiotoxicidade: Inibidor potente do CYP2C19/CYP3A4 e risco de prolongamento do intervalo QTc.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

412. Zanamivir

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Pó para inalação oral em discos (Rotadisks) 5 mg/blister com dispositivo inalador Diskhaler

Indicações e Linha de Tratamento

Inibidor da neuraminidase dos vírus Influenza A e B administrado por via inalatória direta nas vias aéreas. Primeira linha no tratamento e quimioprofilaxia da Influenza em crianças ≥ 5 a 7 anos capazes de utilizar o inalador, especialmente em casos de suspeita ou confirmação de resistência viral ao oseltamivir.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Tratamento da Influenza — Crianças ≥ 7 anos (Inalatória Oral)	10 mg (2 inalações de 5 mg) a cada 12 horas por 5 dias consecutivos	Iniciar nas primeiras 48h do início dos sintomas gripais.
Quimioprofilaxia Pós-Exposição (≥ 5 anos) (Inalatória Oral)	10 mg (2 inalações de 5 mg) uma vez ao dia por 10 dias consecutivos	Dose única diária

Contraindicações, restrições e monitorização

BRONCOESPASMO GRAVE / ASMA: Black box warning para broncoespasmo agudo grave, declínio súbito da função pulmonar e óbito em pacientes com asma brônquica ou hiper-reatividade de vias aéreas (ter broncodilatador de resgate disponível imediatamente).

Idade: Contraindicado para menores de 5 anos.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

413. Zonisamida

Auditoria documental

Presente nos dois anexos; sem conversão simples detectável para auditoria automática

Apresentações Disponíveis

Cápsulas 25 mg, 50 mg e 100 mg

Indicações e Linha de Tratamento

Antiepiléptico sulfonamídico de múltiplos mecanismos (bloqueio de canais de sódio e cálcio tipo T e inibição da anidrase carbônica). Indicada como terapia adjuvante no tratamento de crises epilépticas focais (com ou sem generalização secundária) e crises mioclônicas em crianças ≥ 6 anos.

Posologia e cálculo de dose

Condição / Faixa Etária / Via	Dose Recomendada	Frequência / Duração e Notas
Crises Focais e Generalizadas — Crianças ≥ 6 anos (VO)	Inicial: 1 a 2 mg/kg/dia dividido a cada 12 ou 24 horas. Aumentar a cada 1 a 2 semanas em 1 a 2 mg/kg/dia até dose de manutenção de 4 a 8 mg/kg/dia (Máx: 12 mg/kg/dia ou 400 a 500 mg/dia).	Administrar com alimentos ou água em dose única ou dividida em 2 vezes.

Contraindicações, restrições e monitorização

Anidrose e Oligoidrose em Crianças: Risco de hipoidrose com hipertermia e insolação em pediatria (assegurar hidratação adequada e evitar superaquecimento).

Condições: Hipersensibilidade a sulfonamidas e nefrolitíase ativa por cálculos de cálcio.

Validação antes do uso: confirmar indicação individual, peso/idade, alergias, função renal/hepática, interações, apresentação disponível e fonte clínica/regulatória vigente. Alta vigilância: dupla conferência independente.

Apêndice - checklist de uso seguro

Antes de utilizar qualquer monografia: confirmar diagnóstico/indicação; idade e peso atuais; alergias; função renal/hepática quando relevante; medicamentos concomitantes; concentração exata do produto; dose por kg e dose absoluta; máximo por dose e por dia; intervalo e duração; via; necessidade de diluição/velocidade; contraindicações; interações; monitorização; e status off-label. Para medicamentos de alta vigilância, realizar conferência independente por segundo profissional.

Este documento é material de apoio à decisão e não substitui bula oficial, protocolo institucional, diretriz vigente ou julgamento clínico.